Dicono di averli usati

DR. ENZO PASCIUTI

Dicono di averli usati

La psicologia nascosta della collaborazione con gli allineatori e i protocolli clinici che fanno funzionare il trattamento

ENZO PASCIUTI ACADEMY

© 2026 Enzo Pasciuti
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Prima edizione.

Indice

	Introduzione: Perché ho scritto questo libro	**1**
1	**Il giorno in cui ho capito che non bastava saper spostare i denti**	**3**
	Partiamo dall'inizio	4
	Alla ricerca della risposta	5
	Il problema dovevo essere io	6
	La risposta era davanti a me	8
	Cominciare a guardare le persone	10
2	**Capire chi abbiamo davanti**	**13**
	Il paziente Dominante	15
	Il paziente Influente	17
	Il paziente Stabile	18
	Il paziente Coscienzioso	19
	Una mappa, non un'etichetta	20
3	**Il paziente mente?**	**23**
	La memoria ricostruttiva	25
	La dissonanza cognitiva	25
	La desiderabilità sociale	26
	Il self-serving bias	27
	Il confirmation bias	27
	L'ottimismo irrealistico e il temporal discounting	28
	Quindi il paziente mente?	29
4	**Il costo invisibile della scarsa collaborazione**	**33**
	Quanto collaborano davvero i nostri pazienti?	34
	Non tutte le rifiniture sono uguali	37
	Il vero prezzo della mancata collaborazione	40

5 **Introduzione ai protocolli** 43
Prima dei protocolli: progettare la collaborazione 44
Le tre leve della collaborazione 46
La struttura fondamentale del protocollo 47
1. Ridurre la difensività 48
2. Preservare l'immagine senza preservare il comportamento 50
3. Rendere concrete le conseguenze 51
4. Ridurre l'ambiguità del comportamento futuro 54
5. Facilitare il comportamento e verificarne l'effetto 56
Responsabilità condivisa, ruoli distinti 57
Un protocollo deve appartenere allo studio 58
Dai principi alle strategie 59

6 **Il paziente che non usa gli allineatori** 63
Il comportamento che dobbiamo modificare 65
L'errore che facevo: cercare di convincere il paziente 65
La paziente alla quale non credevo 66
Non in tutti i pazienti i denti si muovono alla stessa velocità 67
Non devo dimostrare che il paziente sta mentendo 70
In questa fase la leva più potente è il Tempo 72
Una strategia che funziona in entrambi gli scenari 73
La confessione non muove i denti 74

7 **Il paziente che usa gli allineatori, ma non gli elastici** 81
Quando gli allineatori funzionano e gli elastici no 82
Gli elastici funzionano se vengono utilizzati come prescritti 86
Prima di motivare, cerco di capire perché non li utilizza 87
Il paziente vede i denti dritti, non vede la II Classe 88

8 **La rifinitura fisiologica** 95
L'80% 98
Il paradosso della rifinitura 99

9 **Le conseguenze diseducative della rifinitura** 109
Il caso di Alessandro 110
Quando una seconda possibilità diventa una regola 112
Dal racconto del paziente a un risultato verificabile 114

10 **Il paziente che sparisce** 123
L'equivoco dei cinque anni 125
Quando torna, non sappiamo ancora se sta continuando 126
Il paziente va avvertito mentre sta sparendo 128
Quando il paziente ricompare 129

11 **Il paziente mai soddisfatto** 135
Quando migliorare non basta 136
Quando cambia il punto di riferimento 137
Quando le spiegazioni non bastano 141

12 **Il paziente al 95%** 149
Definire l'obiettivo prima di iniziare 151
Preservare il 95% 156

13 **Quando finire non significa aver finito** 161
Nove mesi che prima non esistevano 163

14 **La consegna della contenzione** 173
Dieci ore, tutte le notti 175
Quando una contenzione viene persa o rotta 178

15 **Un appuntamento virtuale a settimana** 185
Ricostruire il momento in cui si è perso il tracking 188
Il protocollo durante la fase attiva 191
Il monitoraggio durante la contenzione 192

16 **Quando bisogna finire davvero** 199

17 **Il costo che non avevamo ancora contato** 209
Ecco perché esistono i protocolli di questo libro 213

Protocolli in sintesi

Consultazione rapida: per ogni protocollo, la pagina dello script operativo e del riquadro di sintesi.

6	**Il paziente che non usa gli allineatori**	SCRIPT **75**	PROTOCOLLO **79**
7	**Il paziente che usa gli allineatori, ma non gli elastici**	SCRIPT **90**	PROTOCOLLO **94**
8	**La rifinitura fisiologica**	SCRIPT **102**	PROTOCOLLO **108**
9	**Le conseguenze diseducative della rifinitura**	SCRIPT **118**	PROTOCOLLO **122**
10	**Il paziente che sparisce**	SCRIPT **130**	PROTOCOLLO **134**
11	**Il paziente mai soddisfatto**	SCRIPT **143**	PROTOCOLLO **147**
12	**Il paziente al 95%**	SCRIPT **157**	PROTOCOLLO **160**
13	**Quando finire non significa aver finito**	SCRIPT **167**	PROTOCOLLO **171**
14	**La consegna della contenzione**	SCRIPT **179**	PROTOCOLLO **184**

15 **Un appuntamento virtuale a settimana** SCRIPT **193** PROTOCOLLO **198**

16 **Quando bisogna finire davvero** SCRIPT **200** PROTOCOLLO **208**

INTRODUZIONE

Perché ho scritto questo libro

C'è un momento, durante un trattamento con allineatori, in cui ci accorgiamo che il problema non è il movimento programmato. Il paziente non utilizza gli allineatori quanto concordato, salta gli elastici o interrompe la contenzione. Possiamo spiegargli ancora una volta cosa dovrebbe fare. Ma se quella spiegazione non ha funzionato finora, perché dovrebbe funzionare proprio oggi?

Ho scritto questo libro per rispondere a una domanda che mi accompagna da anni: **che cosa posso fare, concretamente, quando un paziente non collabora?** Volevo andare oltre la constatazione del problema e trovare un modo per affrontarlo durante la visita, quando ho il paziente davanti e devo decidere quali parole usare e quale passo proporre.

Per un certo periodo ho pensato che le difficoltà che incontravo dipendessero soprattutto da me. Forse non sapevo comunicare nel modo giusto. In Italia, almeno nelle conversazioni con altri ortodontisti a cui mi capitava di partecipare, si parlava molto di movimenti, protocolli e risultati clinici, ma poco di cosa dire quando il paziente non collaborava.

Poi ho scoperto *Aligner Insider*, il gruppo Facebook di Barry Glaser. Leggendo i suoi post, quelli di Adam Goodman e le discussioni tra colleghi con molta più esperienza di me, mi sono accorto che anche loro affrontavano gli stessi problemi. Molti lavoravano negli Stati Uniti, dove la comunicazione con il paziente riceve grande attenzione. Eppure cercavano, proprio come me, parole e strategie migliori. Insomma, *tutto il mondo è paese*. Quella scoperta mi ha fatto sentire meno solo e mi ha spinto a condividere ciò che, negli anni, ha funzionato nella mia pratica.

Gli script che leggerete nascono da diciotto anni di esperienza con gli allineatori. Non sono frasi inventate a tavolino. Sono il risultato di conversazioni reali, tentativi riusciti e tentativi falliti. Nel tempo ho cambiato domande, spiegazioni e modi di presentare le conseguenze di una scelta, cercando di capire che cosa aiutasse davvero un paziente a riprendere la collaborazione.

Mi sono accorto anche che molte di quelle conversazioni si ripetevano. Cambiavano i pazienti e le loro spiegazioni, ma io mi trovavo spesso davanti agli stessi problemi e dovevo decidere nuovamente come affrontarli. Ho iniziato quindi a mettere ordine nelle risposte che avevano funzionato, cercando di capire non soltanto quali parole utilizzare, ma in quale momento dirle, che cosa verificare e come comportarmi al controllo successivo. È così che gli script sono diventati parte di protocolli: percorsi che aiutano me e il mio team a mantenere una direzione comune. Non eliminano la necessità di valutare ogni singolo caso, ma ci permettono di affrontarlo con un punto di partenza più chiaro e con meno decisioni lasciate alla stanchezza o alla fretta della giornata.

In queste pagine troverete anche alcuni espedienti comunicativi. A volte uso quella che, con sincerità, definirei una *bugia bianca*: una motivazione semplice, capace di fare leva su ciò che conta per quel paziente, pur non essendo una spiegazione scientifica del problema. Ho scelto di dichiararlo apertamente, perché non voglio che quelle frasi vengano scambiate per evidenze cliniche. Non devono mai servire a nascondere un rischio, alterare una diagnosi o impedire al paziente di scegliere in modo consapevole. Il loro scopo è aiutarlo a compiere un'azione utile che conosce già, ma che fatica a mantenere nel tempo.

Nessuno script funziona sempre con tutti, e nessuno garantisce la collaborazione al cento per cento. Le strategie proposte vanno scelte e adattate al contesto sociale e culturale in cui lavoriamo. Non occorre utilizzarle tutte, né ripeterle parola per parola: possono offrirci uno spunto per affrontare una situazione che, fino a quel momento, non siamo riusciti a sbloccare.

Vorrei che questo libro fosse uno strumento da tenere vicino alla pratica quotidiana: una raccolta di idee da scegliere, adattare e mettere alla prova. **L'obiettivo è uscire dalla visita con una possibilità in più di aiutare il paziente a collaborare e portare il trattamento a una conclusione condivisa.**

CAPITOLO

1

Il giorno in cui ho capito che non bastava saper spostare i denti

«Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi.»

— MARCEL PROUST

Se hai deciso di leggere questo libro, probabilmente utilizzi già gli allineatori trasparenti o stai pensando di inserirli seriamente nella tua pratica clinica. In entrambi i casi, prima di raccontarti la mia storia, vorrei farti una domanda.

Ti è mai capitato di tornare a casa dopo una giornata di lavoro con un caso che continuava a girarti in testa?

Magari era un trattamento che avevi pianificato con estrema attenzione. Avevi dedicato ore alla progettazione, controllato ogni dettaglio, modificato il setup più volte e, quando avevi finalmente premuto il pulsante di approvazione, eri convinto

di aver fatto un ottimo lavoro. Poi il paziente torna dopo qualche mese, gli chiedi come sta andando e lui ti risponde con quella frase che ogni ortodontista sente almeno una decina di volte al giorno:

«Benissimo, dottore.»

Lo fai accomodare sulla poltrona, inizi la visita e nel giro di pochi secondi capisci che qualcosa non torna. Quella sensazione l'ho provata anch'io, molte volte. Per anni, però, davanti a situazioni come quella, la mia reazione è stata sempre la stessa: cercare una spiegazione tecnica. Pensavo di aver commesso un errore nella pianificazione, di aver sottovalutato un movimento, scelto un attachment poco efficace o impostato una biomeccanica non abbastanza raffinata. Ero convinto che, studiando ancora, avrei trovato la risposta.

Non sapevo che la domanda giusta fosse un'altra.

Partiamo dall'inizio

Quando ripenso al ragazzo che ero più di vent'anni fa, mi rendo conto che avevo una convinzione tanto semplice quanto rassicurante: per diventare un bravo ortodontista bastava continuare a imparare. Non era un pensiero ingenuo né superficiale; al contrario, rappresentava il motore di tutto ciò che facevo. Mi dava una straordinaria sensazione di controllo, perché significava che il mio futuro dipendeva quasi esclusivamente dall'impegno che ero disposto a mettere nella mia formazione.

Se qualcosa non funzionava come avevo previsto, la spiegazione mi sembrava sempre la stessa: non avevo ancora acquisito tutte le conoscenze necessarie. Se incontravo una difficoltà, significava che c'era un libro che non avevo ancora letto, un congresso a cui non avevo partecipato o un collega dal quale potevo ancora imparare qualcosa. Persino quando vedevo altri ottenere risultati migliori dei miei mi convincevo che avessero semplicemente scoperto qualcosa che io ancora ignoravo e che, prima o poi, anch'io sarei arrivato a comprenderlo.

Ripensandoci oggi, mi accorgo che quella convinzione mi ha accompagnato per gran parte della mia carriera e, in fondo, continua ad accompagnarmi ancora. Credo infatti che dedicare tempo allo studio sia uno dei più grandi atti di rispetto che un ortodontista possa compiere nei confronti dei propri pazienti. Quello che è cambiato nel tempo non è il valore che attribuisco alla formazione, ma il significato stesso della parola imparare. All'inizio ero convinto che imparare significasse accumulare conoscenze tecniche; ci sarebbero voluti molti anni prima di capire che esisteva un altro tipo di apprendimento, forse ancora più importante, del quale nessuno mi aveva mai parlato.

Quando muovevo i primi passi nella professione, l'ortodonzia stava attraversando una trasformazione profonda. Tra tutte le novità di quegli anni ce n'era una che catturò completamente la mia attenzione: gli allineatori trasparenti. C'era chi li osservava con curiosità, chi con estrema diffidenza e chi li considerava poco più di un'alternativa estetica al social-six con i brackets. Io, invece, ebbi subito la sensazione che stesse accadendo qualcosa di molto più importante. Per la prima volta non cambiava soltanto uno strumento terapeutico: cambiava il modo stesso di ragionare dell'ortodontista.

Con l'apparecchio fisso era possibile correggere continuamente il percorso durante il trattamento; con gli allineatori, invece, bisognava immaginare il risultato ancora prima di iniziare. Era un cambio di prospettiva radicale, che costringeva a progettare il futuro anziché limitarsi a gestire il presente, ed è stata probabilmente questa sfida intellettuale a farmene innamorare fin da subito.

In fondo, sono sempre stato attratto dalle cose difficili. Non perché mi piacesse complicarmi la vita, ma perché ogni volta che incontravo qualcosa che sembrava impossibile dentro di me nasceva spontanea la stessa domanda: *«Come posso farla funzionare?»*

Alla ricerca della risposta

Fu proprio quella curiosità a spingermi a immergermi completamente nel mondo degli allineatori. Ogni articolo scientifico finiva sottolineato, ogni libro veniva letto con la matita in mano e ogni congresso diventava un'occasione da non perdere. Se sentivo parlare di un collega che aveva sviluppato una biomeccanica interessante o di un relatore capace di affrontare un problema da una prospettiva diversa, iniziavo subito a informarmi, ovunque si trovasse. Negli anni ho attraversato una parte importante del mondo con questo spirito. Non mi interessava collezionare attestati da appendere al muro: volevo tornare a casa con almeno un'intuizione che, il lunedì mattina, potesse rendere anche un solo trattamento migliore di quello che avrei realizzato il venerdì precedente.

Ogni viaggio rappresentava un investimento di tempo, energie e denaro. Significava lasciare lo studio, riorganizzare il lavoro, rinunciare al tempo con la famiglia, passare ore negli aeroporti, affrontare voli interminabili e spesso rientrare la domenica sera per essere di nuovo in studio il lunedì mattina. Eppure non ho mai vissuto tutto questo come un sacrificio. Era semplicemente il prezzo che ero felice di pagare per continuare a crescere.

Dentro di me ero convinto che, continuando a raccogliere tutti quei frammenti di esperienza, prima o poi sarei riuscito a completare il puzzle. Pensavo davvero che, da qualche parte, esistesse una formula capace di rendere ogni trattamento perfettamente predicibile e che il mio compito fosse semplicemente quello di trovarla.

Poi iniziai a vivere un'esperienza che credo accomuni tutte le persone sinceramente innamorate del proprio lavoro: più imparavo, più aumentavano le domande. Ogni risposta ne apriva inevitabilmente una nuova, ogni certezza veniva messa in discussione dal paziente successivo e ogni volta che pensavo di aver finalmente compreso fino in fondo un argomento arrivava un caso capace di costringermi a rimettere tutto in discussione.

Naturalmente, allora non vivevo tutto questo con la serenità che ho oggi. Ogni volta che un trattamento prendeva una direzione diversa da quella che avevo immaginato, la mia reazione era quasi automatica: ero convinto che l'errore fosse mio. Se il risultato non coincideva con ciò che avevo progettato, significava che mi mancava ancora qualche competenza. La soluzione, nella mia mente, era sempre la stessa: studiare di più, seguire un altro corso, leggere un altro libro, salire su un altro aereo per ascoltare qualcuno che, forse, aveva già trovato la risposta che io stavo ancora cercando.

Quella convinzione mi aveva permesso di crescere, ma nascondeva anche un piccolo inganno: pensavo che ogni problema avesse necessariamente una soluzione tecnica. Senza rendermene conto, stavo cercando risposte biomeccaniche anche a domande che appartenevano a un mondo completamente diverso.

Il problema dovevo essere io

Nel frattempo la mia attività cresceva, i casi diventavano sempre più numerosi e complessi e arrivarono anche i primi inviti a parlare ai congressi. Insegnare mi piaceva enormemente, perché preparare una lezione mi costringeva a rimettere ordine nelle idee e a comprendere ancora meglio ciò che facevo. Eppure, proprio mentre dall'esterno la mia carriera sembrava darmi sempre più conferme, dentro di me continuava a esistere una sensazione difficile da spiegare.

La prima volta che qualcuno le diede un nome non mi trovavo in uno studio medico, a un congresso o durante una seduta con uno psicologo. Ero a casa mia, a cena con due amici.

Alice e Federico sono i fondatori di Geldis, un'azienda nata da un'intuizione molto vicina al mio mondo: creare un gel specifico per la pulizia quotidiana degli allinea-

tori. Nel tempo, però, il nostro rapporto era andato ben oltre il lavoro ed eravamo diventati amici.

Non ricordo come cominciò esattamente il discorso. Probabilmente stavamo parlando di lavoro, di corsi o di uno dei tanti congressi ai quali partecipavo come relatore. A un certo punto raccontai loro qualcosa che, fino ad allora, avevo sempre considerato una stranezza del mio carattere.

Spiegai che, nonostante gli anni di esperienza, continuavo a non sentirmi completamente a mio agio quando salivo su un palco. Non era paura di parlare in pubblico e non era nemmeno insicurezza sui contenuti: preparavo ogni relazione con un'attenzione quasi ossessiva e conoscevo profondamente gli argomenti che affrontavo. Era qualcosa di diverso.

Potevo trovarmi davanti a mille o duemila persone venute per ascoltarmi, colleghi che avevano pagato un corso, affrontato un viaggio e dedicato una giornata della loro vita per imparare qualcosa da me. Durante le pause mi fermavano, mi facevano domande e mi raccontavano quanto una mia indicazione avesse cambiato il loro modo di progettare i trattamenti. Eppure, dentro di me, una parte continuava a domandarsi se meritassi davvero di essere lì. Quando finii di raccontarlo, Alice mi guardò come se la spiegazione fosse evidente.

«Enzo, tu hai la sindrome dell'impostore.»

Quelle parole mi colpirono perché avevo sempre pensato all'impostore come a qualcuno che inganna deliberatamente gli altri, si attribuisce competenze che non possiede o occupa un posto che non gli appartiene. Io non stavo cercando di ingannare nessuno. Studiavo, lavoravo e preparavo ogni intervento con una cura quasi maniacale. Alice, però, non stava dicendo che fossi un impostore. Stava dicendo che, nonostante tutte le prove del contrario, una parte di me continuava a temere di esserlo.

Nei giorni successivi cominciai a informarmi. Scoprii che il fenomeno era stato descritto alla fine degli anni Settanta dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Imes in donne brillanti, preparate e professionalmente affermate che, nonostante i risultati raggiunti, faticavano a riconoscerli come conseguenza delle proprie capacità. I successi potevano essere attribuiti alla fortuna, al momento favorevole, all'aiuto ricevuto o allo sforzo eccezionale impiegato per compensare presunte carenze, mentre le difficoltà assumevano un peso sproporzionato e sembravano confermare immediatamente l'inadeguatezza temuta.

Riconobbi immediatamente quel meccanismo. Un invito a un congresso poteva dipendere dal rapporto con un'azienda; una lecture riuscita bene, dalla preparazio-

ne quasi maniacale con cui l'avevo costruita; i complimenti dei colleghi, dalla loro generosità. Riuscivo sempre a trovare una spiegazione che ridimensionasse i risultati. Una difficoltà clinica, invece, non aveva bisogno di interpretazioni: nella mia mente era colpa mia.

Oggi la letteratura preferisce parlare di fenomeno dell'impostore, perché non si tratta di una malattia né di una diagnosi psichiatrica, ma di un modo ricorrente di interpretare se stessi. È stato osservato anche tra medici, dentisti e altri professionisti sanitari, ambienti nei quali standard elevati e responsabilità concrete rendono indispensabile mettersi continuamente in discussione.

Quella disposizione aveva avuto anche un lato positivo. Mi aveva spinto a studiare, viaggiare, confrontarmi con professionisti più esperti e non accontentarmi delle prime risposte. Il problema compariva quando l'autocritica smetteva di aiutarmi a comprendere una difficoltà e diventava un giudizio sulla mia identità professionale.

Esiste una differenza enorme tra domandarsi perché un movimento non si sia realizzato e chiedersi se siamo davvero capaci di utilizzare gli allineatori. La prima è una domanda clinica: permette di raccogliere informazioni, esaminare le cause e correggere il percorso. La seconda trasforma un episodio circoscritto in una sentenza sull'intero valore del professionista.

Fu allora che compresi quanto quella sensazione avesse condizionato anche il mio lavoro in studio. Quando un trattamento non procedeva come previsto, concentravo quasi tutta l'attenzione su ciò che potevo controllare direttamente: il mio lavoro. Il racconto del paziente rimaneva sullo sfondo come un dato acquisito e, se mi diceva di aver seguito tutte le indicazioni, la conclusione sembrava inevitabile: avevo sbagliato io.

Era come valutare l'efficacia di un farmaco senza sapere se fosse stato assunto. Nella pratica quotidiana rischiavo di cambiare la cura prima di aver verificato quella premessa.

La risposta era davanti a me

Fu proprio questa consapevolezza a farmi osservare con maggiore attenzione alcuni casi che continuavano a non tornare. Più aumentava la mia esperienza, più mi rendevo conto che i trattamenti inspiegabili non erano quasi mai quelli più complessi. Mi capitava di affrontare malocclusioni estremamente difficili che procedevano esattamente come avevo pianificato, mentre trattamenti apparentemente semplici sembravano incepparsi senza una spiegazione logica.

All'inizio liquidai tutto come una serie di coincidenze. Poi iniziai a prestare maggiore attenzione e, quasi senza accorgermene, cominciai a spostare lo sguardo. Per anni avevo osservato quasi esclusivamente i denti, le scansioni, gli attachment, la biomeccanica e i movimenti programmati. Tutta la mia attenzione era concentrata lì, perché ero convinto che fosse lì che si nascondessero tutte le risposte. Mi resi conto, invece, che la variabile che continuavo a cercare non era sul monitor del computer; era seduta sulla poltrona, proprio davanti a me.

Non erano i denti. Erano le persone.

Ricordo perfettamente una mattina in cui avevo in agenda due controlli consecutivi. Due ragazzi pressoché coetanei, con una malocclusione molto simile, un piano di trattamento quasi identico e lo stesso intervallo di tempo trascorso dall'ultima visita. Dal punto di vista clinico sembravano due casi fotocopiati.

Entrò il primo. Mi salutò con entusiasmo e, ancora prima che gli chiedessi come stesse andando, tirò fuori dalla tasca una bustina di elastici.

> «*Doc, credo di averne consumati più del previsto. Me ne può dare qualche confezione in più?*»

Lo visitai e trovai esattamente ciò che mi aspettavo di vedere. Il trattamento stava procedendo secondo i piani. Pochi minuti dopo entrò il secondo ragazzo. Anche lui educato, anche lui sorridente. Alla stessa domanda rispose con la stessa sicurezza:

> «*Tutto benissimo. Gli elastici li utilizzo sempre.*»

Lo visitai e mi bastarono pochi secondi per vedere che il trattamento non stava procedendo come mi aspettavo. Questo, naturalmente, non dimostrava che non stesse utilizzando gli elastici: potevano esserci diverse spiegazioni. Fino a quel momento, però, la mia mente sarebbe partita automaticamente alla ricerca di una causa biomeccanica. Quella volta mi sorpresi a formulare una domanda diversa: e se il problema non fosse la pianificazione del trattamento?

Non cercai subito una risposta. Continuai semplicemente a osservare e, nei mesi successivi, iniziai a riconoscere situazioni simili con una frequenza sorprendente. Cambiavano i volti, le età e le malocclusioni, ma certi atteggiamenti sembravano ripetersi. C'erano pazienti estremamente precisi e altri incapaci di ricordare un'indicazione ricevuta poco tempo prima; persone che facevano domande finché non avevano capito esattamente cosa fare e altre che annuivano durante la visita, salvo poi tornare al controllo successivo senza aver seguito le indicazioni; genitori che trasformavano il trattamento del figlio in un progetto condiviso e altri che, dopo il primo appuntamento, sembravano disinteressarsi completamente di come stesse andando.

Fu allora che iniziai a comprendere che fiducia e verifica non erano due atteggiamenti incompatibili. Il rapporto tra medico e paziente si fonda necessariamente sulla fiducia e non possiamo trasformare ogni appuntamento in un interrogatorio, ma verificare non significa accusare. Una decisione clinica rigorosa non può dipendere soltanto da un'informazione che non abbiamo avuto la possibilità di verificare.

Piccoli episodi cominciarono così ad assumere un significato diverso: un allineatore che mi aspettavo fosse stato utilizzato per settimane e che sembrava nuovo, una confezione di elastici ancora chiusa, un paziente che non ricordava quale mascherina stesse usando o che arrivava al controllo senza averla con sé. Nessuno di quei dettagli bastava, da solo, a stabilire come il paziente avesse seguito le indicazioni, ma osservati nel loro insieme mi costrinsero a chiedermi quante volte avessi cercato una soluzione biomeccanica a un problema comportamentale.

Cominciare a guardare le persone

Da quel momento iniziai a osservare i pazienti con occhi diversi. Continuavo naturalmente ad analizzare fotografie, scansioni, rapporti occlusali e movimenti programmati, ma una parte sempre più grande della mia attenzione si stava spostando altrove.

Mi accorsi che persone alle quali fornivo esattamente le stesse indicazioni reagivano in modi completamente differenti. Alcune volevano conoscere ogni dettaglio, altre sembravano infastidite da spiegazioni troppo lunghe; alcune avevano bisogno di sentirsi rassicurate, altre volevano soprattutto sapere quanto tempo sarebbe servito e che cosa sarebbe successo se qualcosa non avesse funzionato. C'era chi seguiva le indicazioni con precisione quasi maniacale e chi, pur avendole comprese perfettamente, le adattava alla propria vita fino a trasformarle in qualcosa di molto diverso da ciò che avevo prescritto.

Durante gli anni dell'università e della specializzazione avevo studiato anatomia, biomeccanica, crescita cranio-facciale, diagnosi, cefalometria, materiali e pianificazione. Avevo imparato a misurare angoli con una precisione quasi maniacale e a discutere per ore dell'inclinazione di una radice o della programmazione di uno spostamento di pochi decimi di millimetro. Nessuno, però, mi aveva mai insegnato a riconoscere il paziente che avrebbe annuito durante tutta la visita per poi seguire soltanto metà delle indicazioni ricevute, né a capire perché due persone alle quali avevo spiegato esattamente la stessa cosa potessero comportarsi in maniera completamente diversa.

Era come se tutta la nostra formazione si interrompesse esattamente sulla soglia dello studio. Da quel momento in poi iniziava un territorio lasciato quasi completamente all'esperienza personale, fatto di tentativi, errori e intuizioni.

Fu allora che iniziai a sospettare quella che, in quel momento, mi sembrò quasi un'eresia: forse la predicibilità di un trattamento non dipende soltanto dalla qualità della sua pianificazione. Forse esiste una variabile che nessun software è in grado di calcolare, che non compare in una cefalometria, non si misura con un calibro e non può essere progettata davanti a uno schermo, eppure è presente in ogni singolo trattamento che affrontiamo.

Quella variabile era seduta ogni giorno davanti a me. Aveva un volto, una storia, un carattere, delle convinzioni, delle paure e un modo tutto suo di interpretare ciò che le accadeva. In altre parole, aveva una mente.

Avevo passato anni cercando di rendere sempre più predicibile la biomeccanica dei miei trattamenti. Ora cominciavo a capire che avevo osservato soltanto una parte del problema. Potevo progettare con estrema precisione ciò che avrei voluto ottenere dai denti, ma tra quel progetto e il risultato finale continuava a esserci una persona che, ogni giorno, avrebbe dovuto prendere decisioni capaci di favorirlo, rallentarlo o modificarlo.

Questa consapevolezza non mi diede immediatamente delle risposte. Mi diede qualcosa di più importante: un nuovo campo da esplorare. Per anni, davanti a un trattamento che non procedeva, la mia prima domanda era stata *«Che cosa ho sbagliato?»*. Quella domanda continua ancora oggi a far parte della mia analisi, perché sarebbe pericoloso smettere di porsela, ma non può essere l'unica e soprattutto non può precederne una ancora più importante:

Che cosa è successo davvero?

Soltanto dopo aver ricostruito ciò che è accaduto possiamo stabilire quale parte della responsabilità appartenga alla progettazione, quale alla biologia e quale, eventualmente, al comportamento del paziente.

Avevo trascorso anni a studiare il movimento dei denti. Ora avevo finalmente capito che, per comprendere davvero ciò che accade durante un trattamento, avrei dovuto iniziare a studiare anche le persone che quei trattamenti li vivono ogni giorno.

Ed era un mondo molto più complesso di quanto immaginassi.

BIBLIOGRAFIA

Clance PR, Imes SA. *The imposter phenomenon in high achieving women: dynamics and therapeutic intervention.* Psychotherapy. 1978;15(3):241–247.

Gottlieb M, Chung A, Battaglioli N, Sebok-Syer SS, Kalantari A. *Impostor syndrome among physicians and physicians in training: a scoping review.* Med Educ. 2020;54(2):116–124.

Bravata DM, Watts SA, Keefer AL, Madhusudhan DK, Taylor KT, Clark DM, Nelson RS, Cokley KO, Hagg HK. *Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: a systematic review.* J Gen Intern Med. 2020;35(4):1252–1275.

CAPITOLO

2

Capire chi abbiamo davanti

«Quando abbiamo a che fare con le persone, ricordiamoci che non abbiamo a che fare con creature logiche, ma con creature emotive.»

— DALE CARNEGIE

Ero abituato a parlare a pazienti molto diversi utilizzando quasi sempre le stesse parole. Spiegavo il trattamento, illustravo gli obiettivi e fornivo indicazioni precise. Se avevano capito, consideravo concluso il mio compito.

Con il passare del tempo ho capito che comprendere un'informazione non significa attribuirle lo stesso valore. Se persone diverse ascoltano, decidono e reagiscono in modi diversi, perché avrebbero dovuto collaborare tutte allo stesso modo?

Alcuni pazienti desiderano conoscere ogni dettaglio, mentre altri si sentono sopraffatti quando ricevono troppe informazioni. C'è chi prende una decisione rapidamente e chi, prima di scegliere, ha bisogno di tempo, rassicurazioni e conferme.

Alcune persone vogliono soprattutto sapere quanto durerà il trattamento; altre chiedono di vedere fotografie, simulazioni e radiografie; altre ancora sembrano interessate soprattutto a come quella terapia entrerà nella loro vita quotidiana.

La comunicazione efficace, quindi, non consiste soltanto nel sapere che cosa dire. Consiste anche nel comprendere come dirlo alla persona che abbiamo davanti.

Nel corso del tempo psicologi, studiosi del comportamento, esperti di management e formatori hanno sviluppato numerosi modelli per descrivere queste differenze. Alcuni sono nati dalla ricerca scientifica sulla personalità, altri sono stati creati come strumenti pratici per migliorare la leadership, il lavoro di squadra, la vendita o la gestione delle relazioni.

Nessuno di questi modelli può racchiudere completamente la complessità dell'essere umano. Siamo il risultato della nostra storia, dell'educazione ricevuta, delle esperienze vissute, del contesto nel quale ci troviamo, delle emozioni del momento e delle persone con cui stiamo interagendo. Lo stesso individuo può comportarsi in maniera molto diversa al lavoro, a casa, durante una trattativa economica o quando si trova seduto sulla poltrona di uno studio dentistico.

Pensare di suddividere tutti gli esseri umani in caselle rigide sarebbe quindi semplicistico. Eppure, proprio la capacità di semplificare rappresenta anche il punto di forza di alcuni modelli comportamentali. Non servono per stabilire chi sia realmente una persona né per formulare una diagnosi psicologica, ma possono aiutarci a riconoscere alcune tendenze prevalenti e a scegliere più rapidamente il linguaggio, il ritmo e la quantità di informazioni più adatti all'interlocutore.

Tra questi modelli, uno dei più conosciuti e utilizzati è il DISC.

Le sue origini vengono generalmente ricondotte allo psicologo americano William Moulton Marston, che nel 1928 pubblicò *Emotions of Normal People*, un libro nel quale analizzava le modalità con cui gli individui reagiscono all'ambiente che percepiscono intorno a loro.

Le persone possono tendere a rispondere in maniera più attiva o più riflessiva, orientandosi prevalentemente verso il risultato oppure verso la relazione e ricercando, in misura differente, controllo, consenso, stabilità o precisione. Da queste tendenze derivano quattro modalità oggi comunemente indicate con le lettere D, I, S e C: Dominanza, Influenza, Stabilità e Coscienziosità.

Il DISC è stato progressivamente utilizzato nella selezione del personale, nella leadership, nella formazione dei gruppi, nella vendita e nella gestione dei conflitti, ma non deve essere considerato una verità assoluta sulla personalità umana: è piuttosto una mappa pratica degli stili comportamentali e comunicativi.

La psicologia moderna infatti non riconosce una classificazione universale in quattro tipi di personalità. Il modello con il maggior supporto scientifico è il **Big Five**, che descrive le persone attraverso cinque grandi dimensioni: estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo o instabilità emotiva e apertura all'esperienza. La differenza fondamentale è che il Big Five non assegna ogni persona a una categoria rigida: ognuno di noi possiede tutte queste dimensioni in quantità differenti ed è la loro combinazione a contribuire alla costruzione del profilo individuale.

Il Big Five possiede quindi basi scientifiche più solide per descrivere la personalità. Il DISC, invece, offre un linguaggio più immediato per osservare l'interazione, ed è proprio questo l'aspetto che ci interessa. Il nostro obiettivo non è realizzare una valutazione psicologica completa del paziente né somministrargli un questionario prima di ogni visita ortodontica. Abbiamo bisogno di una lente semplice che possa aiutarci a riconoscere alcune modalità comunicative e ad adattare il nostro colloquio.

Una persona, infatti, raramente corrisponde in maniera pura a uno solo dei quattro profili. Più spesso mostra una combinazione di caratteristiche, con uno o due stili prevalenti, e il comportamento può modificarsi in base alla situazione. Un paziente normalmente socievole può diventare estremamente analitico quando deve affrontare un intervento chirurgico; una persona abitualmente prudente può mostrarsi dominante quando ritiene che il trattamento di suo figlio stia procedendo troppo lentamente; un paziente molto preciso può diventare improvvisamente emotivo quando gli viene prospettata un'estrazione.

Il nostro compito non è quindi appiccicare un'etichetta, ma osservare. Quali domande pone? Quanto rapidamente desidera arrivare al punto? Ha bisogno soprattutto di dati, rassicurazioni, controllo o relazione? Come manifesta il dubbio? Come formula un'obiezione? La risposta a queste domande può aiutarci a scegliere il modo più efficace per dialogare con lui.

Il paziente Dominante

Il paziente Dominante è orientato al risultato. Ama avere il controllo, decide rapidamente e tende a valutare le situazioni in termini di obiettivi, tempi, costi e conseguenze.

Spesso entra nello studio con un'idea già abbastanza precisa di ciò che vuole. Può aver visitato altri professionisti, letto diverse informazioni o stabilito in anticipo quale risultato considera accettabile. Non è necessariamente aggressivo, ma comu-

nica in modo diretto e può avere poca pazienza per le spiegazioni che percepisce come inutilmente lunghe.

Durante la visita tende ad arrivare rapidamente al punto e può formulare domande come: «*Quanto durerà?*», «*Qual è il sistema più veloce?*», «*Possiamo evitare la chirurgia?*», «*Qual è la soluzione migliore?*», «*Quanto mi costa complessivamente?*» oppure «*Cosa succede se non otteniamo il risultato?*».

Queste domande possono apparire brusche, ma non devono essere interpretate immediatamente come un attacco. Molto spesso rappresentano il suo modo di verificare se il professionista abbia competenza, sicurezza e chiarezza. Il Dominante non vuole soltanto una risposta: vuole capire se la persona davanti a lui sia in grado di guidare il trattamento senza esitazioni.

Con questo paziente è utile iniziare dalla conclusione e spiegare successivamente il ragionamento. Invece di introdurre una lunga descrizione della malocclusione, possiamo dire:

> «*Nel suo caso abbiamo due possibilità realistiche. La prima è più semplice, ma accetta un compromesso sul risultato. La seconda richiede un trattamento più articolato, però ci consente di correggere anche il problema scheletrico. Le spiego rapidamente vantaggi e limiti di entrambe.*»

Il Dominante apprezza alternative chiare. Questo non significa lasciargli scegliere una terapia clinicamente inappropriata, ma renderlo partecipe della decisione distinguendo con precisione ciò che è possibile da ciò che non lo è. Quando possiamo, è utile collegare le indicazioni a conseguenze concrete:

> «*Il trattamento richiederà indicativamente diciotto mesi, a condizione che gli allineatori vengano utilizzati secondo le indicazioni. Se l'utilizzo sarà inferiore, la durata aumenterà e potrebbe essere necessario riprogettare alcune fasi.*»

Una formulazione di questo tipo è generalmente più efficace di un'indicazione vaga come «*deve cercare di utilizzarli il più possibile*», perché la prima collega il comportamento a una conseguenza, mentre la seconda lascia molto più spazio all'interpretazione.

Quando il Dominante formula un'obiezione è importante non entrare in competizione. Alla domanda «*Non esiste un modo per fare più in fretta?*» una risposta difensiva come «*No, perché i tempi biologici sono questi e deve fidarsi*» rischia di trasformare il colloquio in uno scontro. Possiamo invece rispondere:

> «*Possiamo ridurre alcune attese organizzative, ma non possiamo comprimere oltre un certo limite i tempi biologici senza aumentare il rischio. Il modo più*

rapido e sicuro, nel suo caso, è questo. La variabile sulla quale possiamo incidere maggiormente è la regolarità nell'utilizzo degli allineatori.»

In questo modo manteniamo l'autorevolezza senza trasformarla in una prova di forza. Con un paziente di questo tipo è quindi preferibile evitare lunghe premesse, risposte vaghe, promesse assolute e toni paternalistici. Essere diretti non significa diventare freddi; significa rispettare il suo bisogno di chiarezza.

Il paziente Influente

Il paziente Influente è generalmente orientato alle relazioni, alle emozioni e all'esperienza complessiva. Comunica con facilità, racconta episodi della propria vita, condivide sensazioni e tende a creare rapidamente un rapporto personale con il professionista e con il team.

È spesso il paziente che entra sorridendo, parla con la segreteria, commenta l'ambiente e racconta come è arrivato allo studio. Durante la visita può passare rapidamente da un argomento all'altro e lasciarsi coinvolgere dall'entusiasmo.

Le sue domande riguardano spesso non soltanto il trattamento, ma il modo in cui quel trattamento entrerà nella sua vita: «Si vedranno molto?», «Come faccio quando esco a cena?», «Posso fare le foto senza che si notino?», «Riuscirò a parlare normalmente?», «Conoscete altre persone che li hanno utilizzati senza problemi?» oppure «Come sarà il mio sorriso alla fine?».

Il paziente Influente può accettare rapidamente il piano perché si sente coinvolto e si fida del professionista, ma proprio questa facilità iniziale non deve essere confusa con la certezza che abbia assimilato tutte le indicazioni. Una conversazione piacevole può dare a entrambi la sensazione che tutto sia perfettamente chiaro, mentre alcune informazioni importanti rischiano di rimanere sullo sfondo.

Con lui è utile collegare le prescrizioni all'esperienza concreta e al risultato che desidera, utilizzando un linguaggio semplice, esempi facilmente visualizzabili e obiettivi riconoscibili. Possiamo coinvolgerlo, mostrargli fotografie, fargli vedere i progressi e utilizzare il rapporto personale come una risorsa, senza però permettere che la relazione sostituisca la chiarezza.

Se dobbiamo spiegargli l'importanza della regolarità nell'utilizzo degli allineatori, per esempio, potremmo dirgli:

«La cosa più importante per arrivare al sorriso che abbiamo progettato è non perdere continuità. Se gli allineatori vengono utilizzati meno del necessario, i denti possono iniziare a rimanere indietro rispetto alla sequenza e rischiamo di doverci fermare e riprogrammare una parte del percorso.»

Con un Influente è particolarmente utile verificare che l'entusiasmo si sia trasformato in comprensione concreta. Alla fine della spiegazione possiamo chiedergli di riassumere i punti essenziali o fissare poche indicazioni molto chiare, evitando di sovraccaricarlo di dettagli che probabilmente non ricorderà. Il rischio, altrimenti, è scambiare una buona relazione per una buona comunicazione. Sono due cose diverse.

Il paziente Stabile

Il paziente Stabile tende a ricercare sicurezza, continuità e armonia. Generalmente non ama le pressioni, i cambiamenti improvvisi o le situazioni nelle quali sente di dover prendere una decisione troppo rapidamente.

Può essere il paziente che ascolta con attenzione, interrompe poco e appare estremamente collaborativo durante la visita. Spesso è gentile, paziente e rispettoso delle indicazioni del professionista, ma proprio questa disponibilità può portarci a sopravvalutare quanto sia realmente convinto o sereno rispetto a ciò che gli stiamo proponendo.

Di fronte a un dubbio potrebbe non formulare immediatamente un'obiezione. Potrebbe annuire, ringraziare e uscire dallo studio senza aver espresso una preoccupazione che emergerà soltanto successivamente, magari attraverso una telefonata alla segreteria o parlando con un familiare.

Con questo profilo è utile rallentare il ritmo della conversazione, anticipare ciò che accadrà e ridurre l'incertezza. Una frase come:

> *«Oggi non deve decidere nulla. Le spiego quali sono le possibilità e i passaggi del trattamento, poi si prende il tempo necessario per pensarci e, se le viene qualche dubbio, ne parliamo insieme.»*

può essere molto più efficace di una richiesta immediata di decisione.

Durante il trattamento è importante creare uno spazio nel quale il paziente si senta autorizzato a raccontarci anche ciò che non sta andando bene. Domande come «Tutto bene?» favoriscono facilmente una risposta positiva. Può essere più utile chiedere: «Qual è stata la cosa più difficile da gestire questa settimana?» oppure «C'è qualcosa delle indicazioni che le ho dato che è stato più complicato seguire?».

In questo modo non stiamo suggerendo che il paziente abbia sbagliato, ma rendiamo normale la possibilità che abbia incontrato una difficoltà.

Con il paziente Stabile la rassicurazione non deve trasformarsi in minimizzazione. Se una determinata condizione è indispensabile per il trattamento, dobbiamo comunicarla con chiarezza, ma senza creare una pressione inutile. Stabilità non

significa assenza di regole; significa rendere quelle regole comprensibili e prevedibili.

Il paziente Coscienzioso

Il paziente Coscienzioso tende a cercare precisione, logica e coerenza. Vuole comprendere il perché delle decisioni e può porre domande molto dettagliate prima di sentirsi sufficientemente sicuro.

È spesso il paziente che arriva alla prima visita dopo avere letto molto, che porta con sé radiografie o documentazione precedente, che confronta le informazioni ricevute e che desidera conoscere non soltanto che cosa faremo, ma perché abbiamo scelto proprio quella strada.

Le sue domande possono essere estremamente specifiche: «Quanto è prevedibile questo movimento?», «Perché utilizza questo attachment?», «Qual è la probabilità che serva una rifinitura?», «Come possiamo sapere che il dente seguirà esattamente la simulazione?».

Di fronte a queste domande può essere naturale sentirsi messi alla prova, ma spesso non è questo lo scopo. Il Coscienzioso utilizza l'informazione per ridurre l'incertezza. Più percepisce vaghezza, più aumenterà le domande.

Con lui è quindi utile rendere visibile il ragionamento clinico e distinguere chiaramente ciò che sappiamo da ciò che non possiamo prevedere con certezza:

> *«I movimenti più prevedibili sono questi, mentre su questi denti esiste una maggiore possibilità di dover intervenire con una rifinitura. Per questo controlleremo alcuni parametri specifici durante il trattamento.»*

Una risposta del genere può essere più rassicurante di una promessa assoluta, perché non cerca di eliminare artificialmente l'incertezza ma mostra che sappiamo dove potrebbe trovarsi e come intendiamo gestirla. Se domanda:

> *«Come può garantirmi che il risultato sarà esattamente quello della simulazione?»*

una risposta commerciale sarebbe: «*Stia tranquillo, verrà proprio così*». Una risposta più corretta e, probabilmente, più efficace potrebbe essere:

> «*La simulazione rappresenta il risultato pianificato, non una garanzia matematica. La biologia e la collaborazione possono modificare la risposta. Il nostro compito è controllare l'andamento e intervenire quando il movimento reale si discosta da quello progettato.*»

Con il Coscienzioso l'onestà sui limiti aumenta la credibilità. Se non conosciamo la risposta a una domanda molto specifica, è meglio dichiararlo e verificare piuttosto che improvvisare. Sono quindi da evitare risposte approssimative, promesse assolute, dati non verificabili e irritazione davanti alle domande. La precisione comunicativa è particolarmente importante perché questo paziente tende a ricordare ciò che è stato detto e a confrontarlo con ciò che accadrà.

Una mappa, non un'etichetta

Arrivati a questo punto potrebbe sembrare che basti osservare un paziente per pochi minuti, assegnargli una lettera e applicare automaticamente una modalità di comunicazione, ma non è così.

Il DISC non dovrebbe diventare una nuova forma di stereotipo. Il paziente che fa molte domande non è necessariamente Coscienzioso: potrebbe essere semplicemente spaventato. Chi desidera decidere rapidamente non è sempre Dominante: potrebbe avere poco tempo o aver già svolto altre consulenze. La persona che parla molto non è necessariamente Influente e chi rimane in silenzio non appartiene automaticamente al profilo Stabile.

I quattro stili devono essere utilizzati come ipotesi di lavoro, non come diagnosi. Possiamo iniziare il colloquio con un'impostazione e modificarla osservando la risposta del paziente. Se forniamo una sintesi e lui continua a chiedere dettagli, probabilmente desidera un livello di approfondimento maggiore; se iniziamo con una lunga spiegazione e notiamo impazienza, potremmo invece dover arrivare più rapidamente alle conclusioni.

La comunicazione efficace non è quindi un copione immutabile, ma un adattamento continuo: il DISC mi aveva insegnato a spiegare lo stesso concetto in modi differenti, ma mi aveva mostrato anche il proprio limite. Lo stile comunicativo di una persona non permette di prevederne la collaborazione. Un paziente Dominante può seguire le indicazioni con rigore oppure opporsi alle regole; un Coscienzioso può essere impeccabile oppure utilizzare ogni dettaglio per spostare la responsabilità fuori da sé.

Per questo, nelle pagine che seguono, il DISC continuerà ad accompagnarci, ma resterà ciò che deve essere: una mappa della comunicazione, non una classificazione dei pazienti. Ci aiuterà a scegliere le parole, il livello di dettaglio e il ritmo della conversazione; il punto di partenza rimarrà sempre il comportamento che osserviamo.

Possiamo imparare a comunicare meglio, ma nessun modello di personalità può darci una certezza su ciò che il paziente farà quando uscirà dallo studio con una scatola di allineatori in mano e noi non saremo lì a guardarlo.

BIBLIOGRAFIA

Marston WM. Emotions of Normal People. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.; 1928.

McCrae RR, John OP. An introduction to the Five-Factor Model and its applications. J Pers. 1992;60(2):175–215.

Street RL Jr, Makoul G, Arora NK, Epstein RM. How does communication heal? Pathways linking clinician-patient communication to health outcomes. Patient Educ Couns. 2009;74(3):295–301.

CAPITOLO

3

Il paziente mente?

«La fiducia che le persone ripongono nelle proprie convinzioni non misura la qualità delle prove, ma la coerenza della storia costruita dalla mente.»

— DANIEL KAHNEMAN

«Se il paziente mi dice che usa sempre gli allineatori, perché il trattamento non procede come previsto?»

È una domanda che mi sono posto molte volte durante le visite di controllo. Il paziente mi assicurava di aver seguito le indicazioni, ma ciò che osservavo clinicamente raccontava una storia diversa. Per molto tempo, in queste situazioni, la mia prima reazione è stata cercare un errore nel trattamento. Come ho già raccontato, solo con gli anni ho iniziato a considerare un'altra possibilità: che una parte della

spiegazione potesse trovarsi nel comportamento del paziente, oltre che nella biomeccanica.

Ricordo ancora molto bene uno dei casi che contribuì a farmi cambiare prospettiva.

Laura aveva circa trent'anni. Era un'avvocata, una mamma e, all'apparenza, una paziente molto precisa. Avevamo iniziato insieme un percorso con l'obiettivo di correggere una seconda classe attraverso la distalizzazione superiore e l'uso degli elastici.

Durante il trattamento gli allineatori lavoravano bene: l'affollamento anteriore si stava risolvendo e il fitting era ottimo. La seconda classe, però, non migliorava. A ogni controllo chiedevo a Laura se usasse gli elastici e lei mi rispondeva: «*Sì, assolutamente. Sempre.*»

Per quasi due anni non ottenemmo alcuna correzione significativa della seconda classe. Io continuavo a cercare la spiegazione nel trattamento: rivedevo la biomeccanica, modificavo la progettazione e arrivai a fare quattro rifiniture. Nel frattempo, gli incisivi superiori continuavano a spostarsi in avanti. Poi, ad un controllo, trovai Laura finalmente in prima classe. Le chiesi che cosa fosse cambiato. Mi raccontò che si sarebbe sposata nove mesi dopo e che voleva terminare il trattamento prima del matrimonio. Per questo aveva deciso di usare gli elastici *davvero*. Solo allora mi spiegò che fino a quel momento li aveva usati soprattutto di notte e pochissimo durante il giorno.

Quell'ammissione, per me, fu più importante della correzione della seconda classe. Avevo cercato a lungo una spiegazione biomeccanica a un problema che, in gran parte, dipendeva dal comportamento di Laura. Lei conosceva le mie indicazioni e mi aveva sempre assicurato di seguirle. Fu allora che iniziai a pormi una domanda semplice, ma scomoda:

Laura mi aveva mentito?

A prima vista sembrava di sì. Eppure definirla una bugia non mi aiutava a capire che cosa fosse successo. Perché una paziente consapevole delle indicazioni mi aveva dato, controllo dopo controllo, una risposta tanto diversa dalle sue abitudini reali?

Avrebbe potuto scegliere di non dirmi la verità. Ma poteva anche esserci qualcosa, nel modo in cui ricordava e raccontava le proprie abitudini, che io non avevo considerato. Da allora cominciai a chiedermi: **perché ciò che un paziente riferisce può essere diverso da ciò che fa?**

Se pensiamo subito a una bugia, cercheremo di smentire il paziente. Se invece proviamo a capire come è arrivato a darci quella risposta, abbiamo più possibilità di scoprire che cosa accade davvero e di aiutarlo a cambiare. Nelle pagine che

seguono esploreremo alcuni dei meccanismi che possono creare questa distanza tra comportamento e racconto. Spesso agiscono contemporaneamente: ciascuno può contribuire a spiegare una parte di ciò che osserviamo.

La memoria ricostruttiva

Siamo portati a immaginare la memoria come un grande archivio nel quale gli eventi vengono conservati ordinatamente, pronti per essere recuperati quando necessario. La ricerca scientifica ci dice però che non funziona così. Ricordare non significa riaprire un cassetto e recuperare una copia perfetta del passato, ma ricostruirlo integrando frammenti di esperienza, conoscenze pregresse, aspettative e significati personali.

Se qualcuno ci chiedesse quante ore abbiamo dormito ogni notte nell'ultimo mese, difficilmente sapremmo rispondere con precisione. Probabilmente ricorderemmo alcune notti particolari e, partendo da quelle, proveremmo a stimare una media.

Lo stesso può accadere quando chiediamo a un paziente per quante ore abbia usato gli allineatori nelle settimane precedenti. Inserirli e rimuoverli sono gesti ripetuti ogni giorno: è difficile ricordare la durata esatta di ciascun intervallo. Il paziente può quindi darci una stima imprecisa senza avere alcuna intenzione di ingannarci.

Frederic Bartlett descrisse il ricordo come un processo ricostruttivo. In seguito, gli studi di Elizabeth Loftus mostrarono che le informazioni ricevute dopo un evento possono influenzarne il ricordo. Daniel Schacter descrisse diverse distorsioni della memoria come aspetti del suo normale funzionamento.

Quando chiediamo a un paziente di raccontarci come si è comportato nelle settimane precedenti, raccogliamo dunque una ricostruzione, non un resoconto esatto di ogni giornata. Questo non rende automaticamente falsa la sua risposta. La rende umana.

La dissonanza cognitiva

La memoria ricostruttiva ci aiuta a comprendere perché un paziente possa ricordare il proprio comportamento in modo impreciso. Esistono però situazioni nelle quali questa spiegazione, da sola, sembra insufficiente. Il paziente è seduto davanti a noi. Alcuni movimenti non si sono espressi come previsto. Gli chiediamo come stia andando con gli allineatori e la risposta arriva senza esitazione:

«Li ho usati sempre.»

In questi momenti viene spontaneo chiedersi se il paziente stia cercando di convincere noi oppure, almeno in parte, se stesso. Questa domanda ci porta alla **dissonanza cognitiva**, descritta da Leon Festinger nel 1957. Tendiamo a cercare coerenza tra ciò che pensiamo di noi e ciò che facciamo. Quando le due cose entrano in contrasto, possiamo avvertire una tensione e cercare un modo per ridurla.

Immaginiamo un paziente che si consideri preciso, affidabile e collaborante. Durante il trattamento, però, dimentica più volte di usare gli allineatori, prolunga i pasti, li lascia fuori durante una cena con amici oppure decide di non usarli per un'intera serata. A quel punto deve conciliare due pensieri: *sono una persona responsabile* e *in alcune occasioni non ho seguito le indicazioni*. Può riconoscere quelle occasioni e decidere di cambiare comportamento. Oppure può ridurne l'importanza ai propri occhi:

«In fondo li ho usati quasi sempre.» oppure «È stata solo una sera.»

Le eccezioni trovano così posto in un racconto che gli permette di continuare a considerarsi collaborante. Non è detto che lo faccia consapevolmente: quando ci parla, potrebbe essere sinceramente convinto di aver seguito le indicazioni molto più di quanto abbia fatto in realtà.

La desiderabilità sociale

C'è poi un altro elemento da considerare. Il paziente non sta soltanto cercando di ricordare che cosa ha fatto: sta parlando con noi e sa quale risposta ci aspettiamo. La **desiderabilità sociale** è la tendenza a presentarsi in modo favorevole agli occhi degli altri, soprattutto quando una domanda riguarda un comportamento su cui ci si può sentire giudicati.

Il paziente conosce le indicazioni ricevute. Sa quante ore dovrebbe usare gli allineatori e che gli elastici fanno parte del trattamento. Ammettere di non aver seguito quelle indicazioni può metterlo a disagio. Così, quando gli chiediamo come sta andando, il desiderio di apparire un buon paziente può influenzare la risposta. Non serve inventare una storia. Può bastare una piccola correzione: «*abbastanza spesso*» diventa «*quasi sempre*», e «*quasi sempre*» diventa «*sempre*».

È un fenomeno noto negli studi che si basano sulle risposte delle persone riguardo ai propri comportamenti. Per noi ha una conseguenza pratica: una domanda come «*Stai usando gli allineatori, vero?*» suggerisce già la risposta attesa e può rendere più difficile per il paziente raccontarci che cosa succede davvero.

Il self-serving bias

Un altro meccanismo riguarda il modo in cui spieghiamo a noi stessi i risultati. Il **self-serving bias** è la tendenza ad attribuire più facilmente i successi alle proprie azioni e gli insuccessi a cause esterne.

Quando il trattamento procede bene, il paziente può pensare: «*Sono stato bravo a seguire le indicazioni.*» Quando un movimento non si esprime, può invece pensare: «*Questi allineatori non stanno funzionando.*»

In questo caso non cambia necessariamente il ricordo di ciò che abbiamo fatto, ma il modo in cui interpretiamo ciò che è successo. Attribuire una difficoltà a una causa esterna può proteggerci dall'idea di aver contribuito al problema. Naturalmente, a volte la causa è davvero nel trattamento: un movimento può essere stato programmato male, un attachment può non essere adeguato o la risposta biologica può essere diversa da quella prevista. Questo meccanismo non ci autorizza quindi ad attribuire automaticamente la responsabilità al paziente.

Mi aiuta, però, a rileggere ciò che accadeva nei casi come quello di Laura. Io tendevo a cercare l'errore nella mia progettazione; lei poteva cercarlo negli allineatori. Così io modificavo il trattamento, mentre lei poteva continuare a essere convinta di aver collaborato come richiesto.

Il confirmation bias

Nel 1960 Peter Wason descrisse un altro fenomeno destinato a diventare centrale nello studio del ragionamento umano: il **confirmation bias**, ovvero la tendenza a cercare e interpretare più facilmente le informazioni coerenti con ciò che crediamo già.

Anche il paziente può osservare il proprio trattamento attraverso questo filtro. Chi è convinto di essere stato estremamente collaborante tenderà a dare maggiore peso alle giornate nelle quali ha utilizzato gli allineatori perfettamente, al sacrificio fatto durante una cena o alle volte in cui li ha rimessi immediatamente dopo pranzo. Molto meno spazio avranno il weekend nel quale li ha lasciati sul comodino, il lungo pranzo della domenica o la vacanza durante la quale gli orari sono diventati meno rigorosi.

Può verificarsi anche il fenomeno opposto. Un paziente convinto che il trattamento non stia funzionando tenderà a osservare soprattutto il dente ancora ruotato o la piccola imperfezione residua, mentre tutti i movimenti già completati finiranno progressivamente sullo sfondo.

La convinzione iniziale diventa così il filtro attraverso il quale interpretiamo ciò che accade. E questo vale naturalmente anche per noi professionisti. Se siamo convinti che il problema sia biomeccanico, cercheremo soprattutto gli elementi che confermano quella spiegazione. Se siamo convinti che il paziente non collabori, correremo il rischio opposto.

Conoscere il confirmation bias non serve quindi a dimostrare che il paziente ha torto. Serve anche a ricordarci quanto facilmente potremmo avere torto noi.

L'ottimismo irrealistico e il temporal discounting

C'è poi una domanda che ogni ortodontista si è posto almeno una volta: perché un paziente continua a comportarsi in modo contrario ai propri interessi pur conoscendo perfettamente le regole del trattamento? L'**ottimismo irrealistico** può aiutarci a comprenderne una parte.

Negli anni Ottanta Neil Weinstein osservò che tendiamo a considerare alcuni eventi negativi meno probabili per noi rispetto agli altri e, al contrario, a percepire come relativamente più probabili gli eventi positivi. In altre parole, conosciamo il rischio, ma tendiamo a sentirlo più lontano quando riguarda noi stessi.

Il paziente sa che utilizzare gli allineatori meno del necessario può rallentare il trattamento, ma pensa che qualche ora in meno non farà realmente differenza nel suo caso. Sa che non utilizzare gli elastici può impedire alcuni movimenti, ma immagina che riuscirà comunque a recuperare. Sa che la contenzione è importante, ma ritiene improbabile che proprio i suoi denti possano spostarsi significativamente. Non è quindi necessario che il paziente non abbia compreso l'informazione: può averla compresa perfettamente. Ciò che cambia è il peso che attribuisce alla possibile conseguenza.

A questo meccanismo può aggiungersene un altro, ben descritto negli studi sul **temporal discounting**, o svalutazione temporale: tendiamo ad attribuire un peso maggiore a costi e benefici immediati rispetto a conseguenze collocate più lontano nel tempo. Per il paziente significa confrontare continuamente un piccolo disagio presente con un vantaggio futuro. Togliere gli allineatori durante una serata, non rimetterli subito dopo cena o rinunciare agli elastici produce un beneficio piccolo ma immediato; il possibile rallentamento del trattamento, invece, appare lontano, incerto e difficilmente percepibile nel momento in cui quella decisione viene presa.

È proprio l'interazione tra questi due meccanismi a rendere particolarmente debole una conseguenza futura: non soltanto è lontana, ma il paziente può anche essere convinto che, probabilmente, non riguarderà proprio lui.

Questo punto sarà particolarmente importante quando inizieremo a costruire i protocolli, perché ci costringerà a distinguere tra informare il paziente di una conseguenza e fare in modo che quella conseguenza abbia realmente valore nel momento in cui dovrà prendere una decisione.

Quindi il paziente mente?

Arrivati a questo punto possiamo tornare alla domanda con cui abbiamo iniziato: **il paziente mente?** A volte sì. Sarebbe ingenuo costruire un intero capitolo sui meccanismi cognitivi per evitare questa possibilità. Esistono persone che sanno perfettamente di non aver seguito le indicazioni e scelgono deliberatamente di raccontarci il contrario, magari per evitare un rimprovero, proteggere la propria immagine o sottrarsi alla responsabilità. Ma fermarsi qui sarebbe altrettanto ingenuo.

Tra la realtà oggettiva e il racconto che ne facciamo esiste uno spazio molto più complesso, nel quale la memoria ricostruisce ciò che è accaduto, la dissonanza ci aiuta a preservare un'immagine coerente di noi stessi, la desiderabilità sociale modifica ciò che siamo disposti ad ammettere davanti agli altri, il self-serving bias orienta il modo in cui attribuiamo le responsabilità, il confirmation bias seleziona le informazioni più coerenti con ciò che già crediamo, mentre l'ottimismo irrealistico e il temporal discounting possono rendere meno rilevanti le conseguenze future delle nostre decisioni. Questi meccanismi non trasformano automaticamente una risposta falsa in una risposta vera, ma ci aiutano a comprendere perché la distanza tra comportamento reale e comportamento riferito possa essere molto più complessa di una semplice scelta tra sincerità e menzogna.

Ed è proprio questa distinzione a cambiare il nostro modo di stare davanti al paziente. Se il nostro obiettivo è stabilire chi abbia ragione, ogni incongruenza diventa l'inizio di un confronto: noi mostriamo ciò che osserviamo, il paziente difende ciò che ricorda, noi insistiamo e lui rafforza la propria posizione. Più cerchiamo di dimostrare che non sta dicendo la verità, più rischiamo di spingerlo a difendere la versione che ha appena raccontato. Il nostro obiettivo, però, non è ottenere una confessione, ma ottenere un comportamento diverso da quel momento in avanti.

Questa è probabilmente la conseguenza più importante di tutto ciò che abbiamo visto in questo capitolo. Davanti a un paziente che afferma di aver utilizzato gli allineatori come indicato quando il quadro clinico ci suggerisce il contrario, non abbiamo necessariamente bisogno di decidere se stia mentendo, ricordando male o proteggendo inconsapevolmente l'immagine che ha di sé. Dobbiamo piuttosto capire come riportare la conversazione su ciò che accadrà **da oggi in poi**.

Laura, alla fine, mi aveva detto la verità? Per mesi mi aveva mentito deliberatamente oppure era davvero convinta che il suo utilizzo degli elastici fosse sufficientemente vicino a ciò che le avevo chiesto? Non lo so e, a distanza di anni, mi sono reso conto che forse non è nemmeno la domanda più importante. Quello che so è che, nel momento in cui il matrimonio trasformò una conseguenza lontana e astratta in un obiettivo concreto, vicino e personalmente importante, il suo comportamento cambiò. Gli elastici erano gli stessi, la biomeccanica era la stessa e io ero lo stesso ortodontista: **era cambiato il significato che quella collaborazione aveva per lei.**

Ed è proprio lì che la comprensione della mente del paziente smette di essere soltanto interessante e comincia a diventare clinicamente utile. Perché quando la collaborazione viene meno, le conseguenze non riguardano soltanto il risultato clinico: significano più tempo, più appuntamenti, più rifiniture e più risorse impiegate per arrivare allo stesso risultato. Nel capitolo successivo proveremo quindi a guardare la mancata collaborazione da un'altra prospettiva, molto più concreta: **quanto costa davvero un paziente che non collabora?**

BIBLIOGRAFIA

Bartlett FC. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology.* Cambridge: Cambridge University Press; 1932.

Loftus EF. Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory. *Learning & Memory.* 2005;12(4):361–366.

Schacter DL. *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers.* Boston: Houghton Mifflin; 2001.

Schacter DL, Guerin SA, St Jacques PL. Memory distortion: an adaptive perspective. *Trends Cogn Sci.* 2011;15(10):467–474.

Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow.* New York: Farrar, Straus and Giroux; 2011.

Tversky A, Kahneman D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science.* 1974;185(4157):1124–1131.

Stanovich KE. *Rationality and the Reflective Mind.* Oxford: Oxford University Press; 2011.

Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. *Acad Med.* 2003;78(8):775–780.

Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance.* Stanford: Stanford University Press; 1957.

Harmon-Jones E, Mills J, editors. *Cognitive Dissonance: Reexamining a Pivotal Theory in Psychology.* 2nd ed. Washington, DC: American Psychological Association; 2019.

Vaidis DC, Bran A. Respectable challenges to respectable theory: Cognitive dissonance theory requires conceptualization clarification and operational tools. *Front Psychol.* 2019;10:1189.

Freijy T, Kothe EJ. Dissonance-based interventions for health behaviour change: A systematic review. *Br J Health Psychol.* 2013;18(2):310–337.

Crowne DP, Marlowe D. A new scale of social desirability independent of psychopathology. *J Consult Psychol.* 1960;24:349–354.

van de Mortel TF. Faking it: Social desirability response bias in self-report research. *Aust J Adv Nurs.* 2008;25(4):40–48.

Latkin CA, Edwards C, Davey-Rothwell MA, Tobin KE. The relationship between social desirability bias and self-reports of health, substance use, and social network factors among urban substance users in Baltimore, Maryland. *Addict Behav.* 2017;73:133–136.

Althubaiti A. Information bias in health research: definition, pitfalls, and adjustment methods. *J Multidiscip Healthc.* 2016;9:211–217.

Krumpal I. Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. *Qual Quant.* 2013;47:2025–2047.

Miller DT, Ross M. Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction? *Psychol Bull.* 1975;82(2):213–225.

Mezulis AH, Abramson LY, Hyde JS, Hankin BL. Is there a universal positivity bias in attributions? A meta-analytic review of individual, developmental, and cultural differences in the self-serving attributional bias. *Psychol Bull.* 2004;130(5):711–747.

Campbell WK, Sedikides C. Self-threat magnifies the self-serving bias: A meta-analytic integration. *Rev Gen Psychol.* 1999;3(1):23–43.

Wason PC. On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. *Q J Exp Psychol.* 1960;12(3):129–140.

Nickerson RS. Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Rev Gen Psychol.* 1998;2(2):175–220.

Klayman J. Varieties of confirmation bias. *Psychol Learn Motiv.* 1995;32:385–418.

Oswald ME, Grosjean S. Confirmation bias. In: Pohl RF, editor. *Cognitive Illusions: A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory.* Hove: Psychology Press; 2004.

Weinstein ND. Unrealistic optimism about future life events. *J Pers Soc Psychol.* 1980;39(5):806–820.

Weinstein ND. Unrealistic optimism about susceptibility to health problems. *J Behav Med.* 1982;5(4):441–460.

Shepperd JA, Klein WMP, Waters EA, Weinstein ND. Taking stock of unrealistic optimism. *Perspect Psychol Sci.* 2013;8(4):395–411.

Frederick S, Loewenstein G, O'Donoghue T. Time discounting and time preference: A critical review. *J Econ Lit.* 2002;40(2):351–401.

CAPITOLO

4

Il costo invisibile della scarsa collaborazione

«Guardati dalle piccole spese: una piccola falla può affondare una grande nave.»

— BENJAMIN FRANKLIN

Ci sono pazienti che ricordo per la complessità della malocclusione, altri per un risultato particolarmente difficile da ottenere e altri ancora perché, quando ripenso al loro trattamento, la prima cosa che mi viene in mente non sono i denti, ma il tempo. Non necessariamente perché il trattamento fosse stato lungo in assoluto: alcuni casi complessi richiedono tempo e questo fa parte dell'ortodonzia. Mi riferisco piuttosto a quella sensazione molto diversa che si prova quando, arrivati alla fine, si guarda indietro e ci si rende conto che una parte considerevole di quel tempo non sarebbe stata necessaria.

Una nuova scansione perché gli allineatori avevano smesso di adattarsi correttamente, una nuova progettazione, un'altra serie di allineatori, una consegna che non era prevista e qualche controllo in più. Poi magari un'altra scansione, perché anche la nuova sequenza non aveva prodotto ciò che ci aspettavamo. Nel frattempo erano trascorsi altri mesi e il trattamento, che sulla carta avrebbe dovuto trovarsi ormai vicino alla conclusione, continuava invece a occupare spazio nell'agenda dello studio.

Presi singolarmente, questi passaggi sembrano quasi innocui. Una scansione richiede solo qualche minuto, un controllo in più può essere inserito tra due appuntamenti, una nuova progettazione fa parte del nostro lavoro e, quando utilizziamo pacchetti che comprendono la possibilità di richiedere ulteriori serie di allineatori per un determinato periodo, persino la produzione di nuove mascherine può dare l'impressione di non avere un costo reale. È soltanto quando si comincia a sommare tutto che la prospettiva cambia: quante ore di poltrona abbiamo dedicato a quel paziente oltre quelle previste? Quante volte abbiamo riaperto il caso, modificato la prescrizione, controllato un nuovo setup o aggiunto un appuntamento che non avrebbe dovuto esserci? E soprattutto, quanta parte di quel lavoro aggiuntivo era davvero inevitabile e quanta, invece, era diventata necessaria perché il paziente non aveva collaborato?

Fino a quel momento avevo osservato il problema soprattutto attraverso singoli episodi clinici. Avevo davanti pazienti che perdevano tracking, trattamenti che si allungavano e rifiniture che si accumulavano, ma non avevo ancora provato a guardare il fenomeno nel suo insieme. Nel capitolo precedente abbiamo visto perché ciò che una persona ricorda e racconta del proprio comportamento possa non coincidere perfettamente con ciò che è realmente accaduto; a questo punto, però, la domanda diventa diversa. Se smettiamo di affidarci soltanto al racconto del paziente e iniziamo a misurare ciò che fa realmente, **quanto è grande quella differenza?**

Quanto collaborano davvero i nostri pazienti?

In ortodonzia siamo abituati a utilizzare la parola *compliance*, anche se negli ultimi anni la letteratura tende a preferire *adherence*, un termine che descrive in maniera meno paternalistica il grado con cui il comportamento del paziente coincide con le indicazioni ricevute.

Il problema è che non esiste ancora una definizione universalmente condivisa di aderenza ortodontica. Una delle revisioni più complete sull'argomento, pubblicata nel 2024 da Van der Bie e collaboratori, ha identificato 3284 lavori e ne ha inclusi

60 nell'analisi finale. Gli autori hanno mostrato quanto la letteratura sia frammentata e quanto sia difficile confrontare studi che misurano comportamenti differenti con strumenti differenti. Nella pratica, però, emergono tre grandi aree attraverso le quali possiamo osservare la collaborazione: utilizzare gli apparecchi secondo le indicazioni, rispettare gli appuntamenti e mantenere un livello adeguato di igiene orale durante il trattamento.

Questo significa che probabilmente non ha neppure molto senso dividere i pazienti semplicemente in "collaboranti" e "non collaboranti". Un paziente può utilizzare gli allineatori con grande regolarità ma dimenticare gli elastici, può essere impeccabile nell'igiene e saltare gli appuntamenti, oppure può iniziare il trattamento con entusiasmo e perdere progressivamente costanza dopo molti mesi. La collaborazione non è quindi una qualità immutabile della persona, ma un insieme di comportamenti che possono cambiare nel corso della terapia.

Per moltissimo tempo il metodo più semplice per sapere quanto un paziente utilizzasse un apparecchio rimovibile era chiederglielo: «*Quante ore lo utilizzi?*», «*Lo metti tutte le notti?*», «*Gli elastici li stai usando?*». Oggi possiamo confrontare queste risposte con sistemi capaci di registrare oggettivamente il tempo di utilizzo e, quando lo facciamo, emerge una distanza che merita attenzione.

Nel 2017 Al-Moghrabi e collaboratori hanno pubblicato una revisione sistematica con meta-analisi dedicata alla compliance con apparecchi ortodontici rimovibili, confrontando il tempo prescritto dall'ortodontista, quello riferito dal paziente e quello registrato oggettivamente. I risultati mostravano una direzione piuttosto chiara: la collaborazione reale risultava inferiore a quella prescritta e i pazienti tendevano a sovrastimare il proprio tempo di utilizzo. Nei sei studi che confrontavano il tempo prescritto con quello registrato oggettivamente, i pazienti utilizzavano il dispositivo ortodontico in media **5,81 ore al giorno in meno** rispetto a quanto richiesto. Ancora più interessante per il nostro discorso era la differenza tra ciò che veniva dichiarato e ciò che i dispositivi registravano: il tempo riferito risultava superiore di **5,02 ore al giorno**.

Cinque ore.

Una differenza che, ripetuta ogni giorno per settimane o mesi, modifica completamente le condizioni nelle quali dovrebbe realizzarsi il movimento ortodontico. La revisione di Van der Bie del 2024 conferma quanto sia difficile valutare la collaborazione basandosi esclusivamente su ciò che il paziente riferisce e sottolinea la maggiore affidabilità delle misure oggettive quando queste sono disponibili.

La situazione diventa ancora più delicata durante l'adolescenza. Una revisione pubblicata nel 2025, dedicata alla collaborazione degli adolescenti con gli apparec-

chi ortodontici rimovibili, ha mostrato una notevole variabilità nell'aderenza e ha identificato numerosi fattori capaci di modificarla, tra cui motivazione, dimenticanza, disagio, supporto familiare e pressioni sociali. In uno degli studi inclusi, circa il 40% degli adolescenti utilizzava la contenzione termoformata per meno di 18 ore al giorno durante una fase nella quale ne era richiesto un utilizzo di 22 ore. Il punto non è considerare gli adolescenti pazienti meno affidabili, ma riconoscere quanto sia difficile chiedere a una persona di mantenere lo stesso comportamento ogni giorno, per mesi o addirittura anni. Sulla carta «*utilizzalo tutte le notti*» sembra una prescrizione semplicissima; nella vita reale è una richiesta molto più complessa di quanto quelle quattro parole lascino immaginare.

Anche con gli allineatori, la possibilità di misurare oggettivamente il tempo di utilizzo ci permette di confrontare ciò che prescriviamo con ciò che il paziente fa realmente. Nel 2026 Sabbagh e collaboratori hanno pubblicato uno studio randomizzato controllato nel quale il tempo di utilizzo veniva registrato attraverso microsensori integrati negli allineatori. Quarantatré pazienti adulti, ai quali erano state prescritte venti ore di utilizzo giornaliero, furono divisi in due gruppi: nel primo i pazienti non sapevano che i dati raccolti sarebbero stati utilizzati per valutare la loro compliance, mentre nel secondo ne erano esplicitamente informati.

Il **67,5% dei partecipanti utilizzava gli allineatori tra dieci e venti ore al giorno**, quindi al di sotto delle venti ore prescritte. Ma il dato forse ancora più interessante riguardava l'effetto del monitoraggio: sapere che il proprio tempo di utilizzo veniva controllato aumentava l'utilizzo medio degli allineatori di **4,41 ore al giorno**. Tra i due gruppi non cambiavano l'apparecchio, la prescrizione o il trattamento; cambiava soltanto la consapevolezza che il proprio comportamento sarebbe stato misurato.

Questo risultato introduce un principio che ritroveremo più avanti nei protocolli: comprendere perfettamente un'indicazione non significa necessariamente seguirla. Il contesto nel quale chiediamo un comportamento, il modo in cui lo verifichiamo e quello in cui rendiamo visibili le sue conseguenze possono modificare ciò che il paziente farà realmente.

Quando la collaborazione modifica il trattamento

A questo punto sarebbe facile concludere che, se il paziente collabora meno, il trattamento inevitabilmente dura di più. La relazione, però, non è così semplice, perché la durata di una terapia ortodontica dipende dalla complessità della malocclusione, dalla risposta biologica individuale, dai movimenti programmati, dalle scelte terapeutiche, dalla progettazione e da molte altre variabili indipendenti dal comportamento del paziente. La stessa revisione di Van der Bie sottolinea come

la relazione tra grado di aderenza e risultato terapeutico non sia ancora completamente chiarita.

Esistono però dati che mostrano come alcuni comportamenti del paziente siano associati alla durata del trattamento. Beckwith e collaboratori analizzarono 140 trattamenti completati in cinque studi ortodontici prendendo in considerazione trentuno variabili. Sei fattori spiegavano complessivamente più della metà della variabilità osservata nella durata del trattamento e, tra questi, tre erano legati al comportamento del paziente: appuntamenti mancati, bracket o bande che avevano richiesto una sostituzione e problemi di igiene orale. Qualche anno più tardi Skidmore e collaboratori, analizzando 366 pazienti trattati con apparecchiatura fissa, trovarono nuovamente un'associazione tra maggiore durata della terapia e comportamenti quali scarso utilizzo degli elastici, igiene insufficiente e rottura dei bracket.

Si tratta prevalentemente di studi su apparecchiature fisse e sarebbe scorretto trasferirne automaticamente i risultati alla terapia con allineatori. Il principio che emerge rimane però importante: la durata del trattamento non dipende soltanto da ciò che programmiamo e facciamo noi, ma anche da ciò che il paziente fa nelle settimane che trascorrono tra un appuntamento e quello successivo. **Nella terapia con allineatori questo aspetto assume un peso particolare, perché il tempo di utilizzo quotidiano rappresenta una delle condizioni sulle quali costruiamo l'intero trattamento.** Ed è qui che incontriamo un fenomeno estremamente familiare a chi lavora quotidianamente con gli allineatori: **le rifiniture.**

Non tutte le rifiniture sono uguali

Prima di collegare rifiniture e collaborazione è indispensabile fare una distinzione: non tutte le rifiniture sono conseguenza di una scarsa collaborazione e la necessità di una nuova sequenza di allineatori non rappresenta necessariamente un fallimento del trattamento. Esistono movimenti meno prevedibili, differenti risposte biologiche, limiti biomeccanici, problemi di progettazione e molte altre condizioni cliniche che possono rendere una rifinitura perfettamente necessaria anche in un paziente impeccabile. A noi interessa un gruppo molto più specifico: **le rifiniture evitabili**, e in particolare quelle diventate necessarie perché il comportamento reale del paziente è stato diverso da quello sul quale avevamo costruito il trattamento.

La distinzione è fondamentale, soprattutto considerando quanto le rifiniture siano frequenti indipendentemente dalla loro causa. Kravitz e collaboratori hanno analizzato 500 pazienti trattati con Invisalign in due studi ortodontici e hanno trovato una media di **2,5 scansioni di rifinitura per paziente**. Soltanto il 6% aveva

concluso il trattamento senza alcuna scansione aggiuntiva, mentre la durata media reale era stata di 22,8 mesi, 5,1 mesi in più rispetto a quella inizialmente prevista. Il 17,2% dei pazienti aveva inoltre dovuto passare all'apparecchiatura fissa per completare il trattamento.

Questi numeri **non ci dicono quante di quelle rifiniture fossero dovute alla mancata collaborazione**, perché lo studio non era stato progettato per stabilirlo. Ci mostrano però quanto possa essere grande la distanza tra il trattamento che immaginiamo all'inizio e quello che diventa realmente necessario per portarlo a termine. Nel 2025 un consenso internazionale sulle indicazioni e sui limiti della terapia con allineatori ha richiamato proprio questo problema: oltre il 10% dei pazienti dello studio di Kravitz aveva richiesto cinque o più rifiniture, con un conseguente aumento del tempo e delle risorse necessarie per completare il trattamento.

Un altro lavoro ci aiuta a comprendere perché il numero delle rifiniture meriti attenzione. Abu Arqub e collaboratori hanno analizzato 355 pazienti trattati con allineatori mettendo in relazione complessità iniziale, numero di rifiniture, durata e risultato. Il miglioramento più consistente si concentrava nella **prima rifinitura**. Tra i pazienti che non avevano ancora raggiunto la soglia di miglioramento considerata dagli autori, la probabilità di raggiungerla diminuiva progressivamente con l'aumentare del numero di rifiniture; nel campione analizzato, dopo più di tre rifiniture non venivano osservati nuovi pazienti che raggiungessero per la prima volta quella soglia di miglioramento.

È importante non trasformare questo risultato in qualcosa che lo studio non dice. **Non significa che dopo tre rifiniture un trattamento sia inutile e non significa che la quarta rifinitura debba essere evitata.** Un caso complesso può richiedere ulteriori fasi perfettamente giustificate. Il dato suggerisce però qualcosa di estremamente interessante: l'aumento del numero delle rifiniture non garantisce un beneficio clinico proporzionale, ed è proprio qui che il problema clinico comincia a incontrare quello economico.

Il costo invisibile delle rifiniture

Per me questo cambia il modo di guardare a una frase che nella pratica quotidiana possiamo pronunciare con grande facilità: *«Facciamo un'altra scansione.»* Clinicamente può sembrare una decisione relativamente piccola; dal punto di vista organizzativo ed economico, però, non lo è affatto.

Molti sistemi di allineatori prevedono formule commerciali nelle quali, dopo l'acquisto iniziale del trattamento, è possibile richiedere ulteriori serie per un determinato periodo senza sostenere ogni volta un nuovo costo di produzione. È un

modello estremamente comodo, soprattutto nei trattamenti complessi, ma proprio questa caratteristica può modificare inconsapevolmente il modo in cui percepiamo economicamente una rifinitura. Se dopo una nuova scansione non arriva una nuova fattura dall'azienda, è facile avere la sensazione che quella sequenza sia sostanzialmente gratuita. Anche il paziente può percepirla nello stesso modo: se sono necessari altri allineatori, semplicemente ne arriveranno altri.

L'equivoco nasce qui.

Il prezzo della nuova serie rappresenta soltanto una parte di ciò che accade quando decidiamo di effettuare una rifinitura. Bisogna comprendere perché il trattamento abbia perso tracking, effettuare una nuova scansione, aggiornare quando necessario la documentazione, ripensare la prescrizione, controllare e approvare il nuovo setup, organizzare la consegna e programmare ulteriori controlli. Gran parte di questo costo non compare in nessuna fattura, perché è rappresentato dalla risorsa più preziosa e limitata che abbiamo all'interno dello studio: **il tempo**.

Quando parliamo di costo economico dobbiamo però tornare alla distinzione precedente. Una rifinitura clinicamente necessaria fa parte del lavoro richiesto per completare il trattamento; una rifinitura evitabile aggiunge invece risorse che avremmo potuto risparmiare. Il tempo impiegato può non comparire come una voce separata nei conti dello studio e non riceveremo una fattura che ce lo ricordi alla fine del mese, ma questo non significa che non abbia un costo.

Un'ora dedicata a recuperare un trattamento può essere un'ora nella quale avremmo potuto effettuare una prima visita, iniziare un nuovo caso o eseguire una procedura programmata. Quando lo stesso fenomeno si ripete su decine di pazienti, quelle ore cominciano a sommarsi. Se ipotizzassimo, per esempio, che una rifinitura evitabile richieda complessivamente anche soltanto un'ora di risorse cliniche e organizzative aggiuntive, **cinquanta rifiniture significherebbero cinquanta ore di lavoro**; se il tempo necessario fosse di due ore, diventerebbero cento.

Attribuire a quelle ore un valore economico universale sarebbe però scorretto. Uno studio che produce 300 euro per ora non avrà lo stesso costo opportunità di uno che ne produce 1.000, così come una scansione interamente delegata al personale avrà un impatto diverso rispetto a una procedura che coinvolge direttamente il medico. Il principio, però, non cambia: **ogni rifinitura evitabile consuma una parte della capacità produttiva dello studio che non potrà essere utilizzata per altro.**

Quando ho cercato nella letteratura una cifra che permettesse di stabilire quanto costasse mediamente una rifinitura evitabile, non l'ho trovata e probabilmente non potrebbe esistere un valore universale, perché dipende dall'organizzazione dello

studio, dal costo del personale, dal sistema di allineatori utilizzato, dal tempo dedicato alla progettazione e dal valore del tempo clinico. La letteratura ci permette però di ricostruire la catena che conduce al problema: l'aderenza reale può essere inferiore a quella prescritta e dichiarata, alcuni comportamenti del paziente sono associati a trattamenti più lunghi e le rifiniture sono estremamente frequenti nella terapia con allineatori, mentre il loro beneficio non cresce necessariamente in maniera proporzionale al loro numero. Quello che nessun articolo può dirci è **quanto tutto questo costi nel nostro studio: quello dobbiamo calcolarlo noi.**

Il punto non è quindi stabilire quale formula commerciale sia migliore, ma comprendere una distinzione molto più importante: **il prezzo di una nuova serie di allineatori e il costo necessario per gestire quella nuova fase di trattamento non sono la stessa cosa.** Il primo può anche essere già compreso nel pacchetto acquistato; il secondo continua a esistere ogni volta che lo studio deve intervenire nuovamente.

Il vero prezzo della mancata collaborazione

Arrivati a questo punto, la scarsa collaborazione assume un significato diverso. Non è più soltanto il paziente che non segue una nostra indicazione, ma una variabile capace di modificare concretamente le condizioni sulle quali abbiamo costruito il trattamento. Se gli allineatori vengono utilizzati meno del necessario, se gli elastici non vengono utilizzati secondo le indicazioni o se gli appuntamenti vengono ripetutamente disattesi, il piano che abbiamo progettato continua a essere lo stesso, ma le condizioni nelle quali dovrebbe funzionare non lo sono più.

Quando questo determina perdita di tracking, movimenti incompleti o necessità di riprogettazione, una parte della terapia deve essere recuperata. Aumentano gli appuntamenti, il tempo dedicato al paziente, la durata complessiva del trattamento e le risorse necessarie per raggiungere un risultato che avevamo programmato di ottenere in altri tempi e in altre condizioni. Ma forse il dato più importante emerso in questo capitolo non riguarda il costo: riguarda la **prevedibilità**.

Se sappiamo che l'aderenza reale può essere inferiore a quella prescritta, che ciò che il paziente riferisce può sovrastimare ciò che fa realmente e che persino la consapevolezza di essere monitorati può modificare di diverse ore al giorno il tempo di utilizzo di un allineatore, allora diventa difficile continuare a considerare la collaborazione come qualcosa che possiamo semplicemente prescrivere e poi dare per acquisito. Questo non significa togliere responsabilità al paziente, ma riconoscere

che la collaborazione è una **variabile clinica** e, come tutte le variabili che possono influenzare il risultato, deve essere considerata, osservata e gestita.

È stato questo cambio di prospettiva a modificare la domanda che mi facevo davanti a un paziente che non collaborava. Non più soltanto «*Perché non fa quello che gli ho detto?*», ma «*Se so che questo comportamento può verificarsi, cosa posso fare per riconoscerlo prima, ridurne la probabilità e intervenire quando compare?*»

Non posso sapere con certezza quante ore il paziente utilizzerà gli allineatori una volta uscito dal mio studio, né posso essere presente quando dovrà decidere se mettere gli elastici, cambiare la mascherina o rispettare una determinata indicazione. Posso però decidere come prepararlo a quelle scelte, come verificare ciò che sta accadendo durante il trattamento e soprattutto come intervenire quando riconosco uno dei comportamenti che, negli anni, ho visto ripetersi continuamente.

Ed è qui che il problema della collaborazione incontra finalmente il tema centrale di questo libro: riconoscere i comportamenti ricorrenti ci permette di prepararci e di sostituire l'improvvisazione con un metodo. **È da questa idea che sono nati i protocolli che vedremo nei prossimi capitoli.**

BIBLIOGRAFIA

van der Bie RM, Bos A, Bruers JJM, Jonkman REG. Patient adherence in orthodontics: a scoping review. *BDJ Open.* 2024;10:58.

Al-Moghrabi D, Colonio Salazar F, Pandis N, Fleming PS. Compliance with removable orthodontic appliances and adjuncts: a systematic review and meta-analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2017;152(1):17–32.

Tiwari A, Fagundes NCF, Perez-Garcia A, et al. Adolescents' adherence to intraoral removable appliances: a scoping review. *Prog Orthod.* 2025;26:41.

Sabbagh H, Baumert U, Liedtke J, Thiem S, Venkova V, Wichelhaus A. Objective assessment of wear time during orthodontic aligner therapy using microsensors: a randomized controlled trial. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2026;169(3):272–284.

Beckwith FR, Ackerman RJ Jr, Cobb CM, Tira DE. An evaluation of factors affecting duration of orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1999;115(4):439–447.

Skidmore KJ, Brook KJ, Thomson WM, Harding WJ. Factors influencing treatment time in orthodontic patients. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006;129(2):230–238.

Kravitz ND, et al. What percentage of patients switch from Invisalign to braces? A retrospective study evaluating the conversion rate, number of refinement scans, and length of treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2023;163(4):526–530.

D'Antò V, et al. Indications and limits of clear aligner therapy: an international modified Delphi consensus study. *Prog Orthod.* 2025;26:28.

Abu Arqub S, Banankhah S, Sharma R, Da Cunha Godoy L, Kuo CL, Ahmed M, Alfardan M, Uribe F. Association between initial complexity, frequency of refinements, treatment duration, and outcome in Invisalign orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2022;162(3):e141–e155.

CAPITOLO

5

Introduzione ai protocolli

«Per ogni problema umano esiste sempre una soluzione ben nota: ordinata, plausibile e sbagliata.»

— H. L. MENCKEN

Prima o poi incontreremo di nuovo il paziente che dimentica gli elastici, utilizza gli allineatori meno del necessario o assicura di avere seguito ogni indicazione mentre il trattamento racconta una storia diversa.

Il problema non è più capire se accadrà, ma decidere se, quando accadrà, improvviseremo ancora. Ogni comportamento ricorrente ci offre la possibilità di preparare una risposta riconoscibile, verificabile e condivisa dallo studio: un protocollo.

Per molti anni, invece, ho continuato a improvvisare. Quando qualcosa non funzionava cercavo la frase giusta, provavo a spiegare meglio, aggiungevo informazioni, mostravo fotografie, insistevo sulle conseguenze oppure cambiavo completamente approccio in funzione della persona che avevo davanti. Alcune volte funzio-

nava molto bene, altre decisamente meno; con alcuni pazienti riuscivo a ottenere un cambiamento immediato, con altri finivo in conversazioni interminabili e con altri ancora uscivo dalla visita con la sensazione di avere spiegato perfettamente il problema senza essere riuscito a modificare nulla. Alla visita successiva, se il comportamento si ripresentava, ricominciavo sostanzialmente da capo.

Con il tempo mi sono reso conto che c'era qualcosa di paradossale in questo modo di lavorare. In ortodonzia utilizziamo protocolli praticamente per tutto: standardizziamo la raccolta dei record, la diagnosi, la pianificazione, le procedure cliniche, i controlli e molte delle nostre decisioni biomeccaniche perché sappiamo che, quando una determinata situazione tende a ripetersi, definire in anticipo il modo in cui affrontarla riduce la variabilità e aumenta la prevedibilità. Quando la variabile che si discosta dal progetto è il comportamento del paziente, invece, tendiamo ancora molto spesso a reagire caso per caso, nonostante anche qui le situazioni si ripetano con una regolarità sorprendente.

Cambiano i nomi, le età, le malocclusioni e le giustificazioni, ma le strutture che sostengono molti problemi di collaborazione sono molto meno numerose di quanto potrebbe sembrare. È stata probabilmente questa la scoperta più importante: **i comportamenti problematici sono numerosi, ma non sono infiniti e soprattutto non sono completamente imprevedibili**. Se impariamo a riconoscere i pattern che tendono a ripetersi, anche la nostra risposta può smettere di essere improvvisata e cominciare a essere progettata.

È da questa esigenza che sono nati i protocolli.

Prima dei protocolli: progettare la collaborazione

Nel capitolo 2 abbiamo visto che comunicare efficacemente non significa soltanto sapere che cosa dire, ma anche adattare il linguaggio, il ritmo e la quantità di informazioni alla persona che abbiamo davanti. Questo può aiutarci a rendere una spiegazione più chiara, credibile e significativa. Anche una comunicazione perfettamente calibrata, però, conserva un limite: può favorire la comprensione, ma non può garantire il comportamento.

Un paziente può avere compreso perfettamente quanto sia importante utilizzare gli allineatori, utilizzare gli elastici o seguire la contenzione e, poche ore dopo, comportarsi comunque in maniera differente. Può persino uscire dallo studio sinceramente convinto che da quel momento farà esattamente ciò che gli abbiamo chiesto, per poi tornare gradualmente alle proprie abitudini quando la vita quotidiana

riprende il sopravvento. **Informare una persona e modificarne il comportamento non sono la stessa cosa.**

La psicologia ha studiato a lungo questa distanza tra intenzione e comportamento. Tra i modelli più interessanti per il nostro ragionamento ci sono le *implementation intentions* studiate da Peter Gollwitzer, nelle quali un'intenzione generale viene trasformata in un piano molto più concreto che collega una determinata situazione a un'azione specifica: non semplicemente *"devo ricordarmi di fare questa cosa"*, ma *"quando si verificherà questa situazione, farò questa azione"*. È una distinzione particolarmente utile in ortodonzia, perché molti problemi di collaborazione non derivano dall'assenza dell'intenzione di collaborare, ma dalla difficoltà di trasformare quell'intenzione in una routine quotidiana sufficientemente stabile.

Questo, però, rappresenta soltanto una parte del problema. Rendere un comportamento più semplice da eseguire può aiutarci quando il paziente vuole collaborare ma fatica a trasformare quell'intenzione in un'abitudine; in altre situazioni dobbiamo prima riuscire a dare al comportamento richiesto un valore sufficiente perché il paziente decida realmente di modificarlo. Ed è qui che entra un altro elemento importante nella costruzione dei miei protocolli: la **persuasione**.

Curiosamente, non era affatto un argomento nuovo per me. Molto prima di diventare ortodontista ero affascinato dalla magia, dalla prestidigitazione, dal mentalismo e dall'ipnosi. Mi interessava capire perché due persone potessero osservare la stessa scena e percepire cose differenti, come l'attenzione potesse essere orientata verso alcuni elementi e quanto il contesto nel quale un'informazione viene presentata potesse modificarne l'interpretazione. Negli anni questa curiosità mi ha portato ad approfondire anche la comunicazione e la persuasione, inizialmente per interesse personale e, solo molto più tardi, a chiedermi se alcuni di quei principi potessero avere un'applicazione concreta anche nel rapporto con i pazienti.

La parola *persuasione* può creare un certo disagio quando viene accostata alla medicina, quasi implicasse necessariamente la volontà di convincere qualcuno a fare qualcosa contro il proprio interesse. Credo però che il problema non sia la persuasione in sé, quanto l'obiettivo per il quale viene utilizzata. Ogni comunicazione modifica in qualche misura la percezione di chi ascolta: scegliere una parola invece di un'altra, presentare una conseguenza attraverso ciò che può essere guadagnato oppure perduto, mostrare una fotografia, utilizzare un numero o formulare una domanda significa già costruire una cornice attraverso la quale l'interlocutore interpreterà ciò che stiamo dicendo.

La persuasione diventa eticamente problematica quando serve a nascondere informazioni, alterare i fatti, sfruttare una vulnerabilità o portare una persona

verso una scelta vantaggiosa per noi ma non per lei. Può assumere un significato completamente diverso quando viene utilizzata per aiutare un paziente a mantenere un comportamento che lui stesso ha accettato come necessario per raggiungere l'obiettivo terapeutico che ha scelto. Se una persona decide liberamente di iniziare un trattamento con allineatori e sa che il risultato dipenderà anche dal proprio comportamento, aiutarla a mantenere gli allineatori per il tempo necessario, utilizzare gli elastici o seguire correttamente la contenzione non significa sottrarle libertà, ma riconoscere che tra sapere che cosa dovremmo fare e riuscire realmente a farlo ogni giorno esiste uno spazio enorme, popolato da abitudini, dimenticanze, gratificazioni immediate, resistenze e razionalizzazioni.

È proprio in quello spazio che devono lavorare i protocolli.

Le tre leve della collaborazione

Quando ho iniziato a ragionare in questo modo, mi sono reso conto che non avevo bisogno di trovare ogni volta una formula diversa per convincere il paziente a collaborare. Dovevo prima capire **che cosa avesse realmente valore per la persona che avevo davanti**, perché non tutti desiderano le stesse cose con la stessa intensità e, soprattutto, non tutti attribuiscono lo stesso peso alle conseguenze di un comportamento.

Con il tempo ho iniziato a riconoscere tre grandi leve che oggi ritrovo continuamente nei miei protocolli: **il tempo, il risultato e l'investimento**. Non sono tre tecniche persuasive, ma tre modi diversi attraverso i quali una conseguenza può diventare realmente significativa per il paziente.

La prima leva è il **tempo**, una risorsa limitata, facilmente comprensibile e immediatamente collegabile alle conseguenze delle nostre azioni. In ortodonzia possiede inoltre una caratteristica particolare, perché il paziente tende spesso a percepire la durata della terapia come qualcosa che dipende prevalentemente dal medico, mentre molti trattamenti contengono una componente comportamentale capace di modificarla profondamente. Per alcune persone terminare sei mesi prima o sei mesi dopo rappresenta una differenza enorme: può esserci un matrimonio, una partenza, un trasferimento, l'università oppure semplicemente il desiderio di liberarsi finalmente degli allineatori. In questi casi rendere evidente il rapporto tra ciò che il paziente farà oggi e ciò che potrebbe accadere nei mesi successivi può avere molto più significato di una nuova spiegazione biomeccanica.

La seconda leva è il **risultato**. Alcuni pazienti attribuiscono al risultato finale un valore talmente elevato da accettare senza particolare difficoltà anche un per-

corso più lungo, purché questo consenta loro di raggiungere esattamente l'obiettivo desiderato. In questi casi parlare continuamente di mesi aggiuntivi può avere pochissimo effetto, mentre diventa molto più importante collegare il comportamento richiesto alla qualità del risultato che si vuole ottenere, facendo comprendere che un determinato movimento potrebbe non esprimersi completamente oppure che una collaborazione insufficiente potrebbe costringerci ad accettare un compromesso che inizialmente non era previsto.

La terza leva è l'**investimento**, termine con il quale non intendo soltanto il denaro. Un trattamento ortodontico contiene certamente un investimento economico, ma anche mesi o anni di tempo, appuntamenti, organizzazione familiare, attenzione quotidiana, rinunce e fiducia. Tutto ciò che il paziente ha già dedicato alla terapia possiede un valore e può diventare particolarmente significativo quando un comportamento rischia di compromettere ciò che è già stato costruito o di costringerci a ripetere una parte del percorso.

Tempo, risultato e investimento accompagneranno praticamente tutti i protocolli che incontreremo più avanti, ma non dovranno necessariamente essere utilizzati contemporaneamente e non esiste una leva universalmente migliore delle altre. Saranno **il contesto clinico e la persona che abbiamo davanti** a suggerirci quale conseguenza possa avere maggiore significato in quel momento. Ci interessa quindi fissare un principio generale: **una comunicazione può influenzare un comportamento soltanto quando riesce a collegare ciò che chiediamo a una conseguenza che il paziente considera realmente importante**.

La struttura fondamentale del protocollo

Quando ho iniziato a mettere insieme questi principi mi sono accorto che, al di là delle singole tecniche, le conversazioni che funzionavano meglio tendevano a seguire una struttura abbastanza costante. Non si trattava di trovare ogni volta parole particolarmente brillanti, ma di attraversare alcuni passaggi in un ordine che rendesse meno probabile lo scontro e più probabile un cambiamento concreto.

Il primo passaggio consiste nel **ridurre la difensività**, presentando il problema attraverso osservazioni cliniche, domande specifiche ed elementi verificabili invece che attraverso giudizi sulla persona. Il secondo consiste nel permettere al paziente, quando possibile, di **preservare la propria immagine senza preservare il comportamento problematico**: non abbiamo necessariamente bisogno che ammetta di avere sbagliato o mentito, ma abbiamo bisogno che riconosca che qualcosa deve cambiare. Il terzo consiste nel rendere **concrete le conseguenze**, collegando il

comportamento agli effetti che può realmente produrre e scegliendo, in funzione della persona, quale delle tre leve — tempo, risultato o investimento — abbia maggiore significato. Il quarto passaggio consiste nel **ridurre l'ambiguità del comportamento futuro**, trasformando un generico *"devi collaborare di più"* in qualcosa di sufficientemente preciso da poter essere osservato e verificato. Infine dobbiamo **facilitare il comportamento e verificarne l'effetto**, riducendo gli ostacoli che possono impedire al paziente di trasformare l'intenzione in azione e prevedendo un feedback abbastanza vicino nel tempo da permetterci di capire se ciò che abbiamo modificato stia realmente funzionando.

Questa struttura non deve diventare una gabbia rigida. La funzione del protocollo non è ottenere sempre la stessa risposta dal paziente, cosa impossibile, ma rendere più prevedibile **la nostra risposta** davanti a problemi che abbiamo già incontrato. Nelle prossime pagine vedremo quindi una serie di principi psicologici e comunicativi che potremo utilizzare nella costruzione degli script in funzione della situazione clinica e della persona che abbiamo davanti. **Li ritroveremo poi applicati concretamente nei protocolli dei capitoli successivi.**

1. Ridurre la difensività

Nelle conversazioni difficili partivo dal punto che mi sembrava più logico: il problema. Se il paziente non utilizzava gli elastici, parlavo degli elastici; se utilizzava poco gli allineatori, parlavo delle ore; se non metteva la contenzione, spiegavo il rischio di recidiva. Era un modo di procedere perfettamente razionale dal mio punto di vista, ma con il tempo mi sono accorto che le prime parole della conversazione potevano influenzare profondamente il modo in cui il paziente avrebbe interpretato tutto ciò che avrei detto dopo.

Se apriamo un controllo dicendo «*Non stai facendo quello che ti avevo chiesto*», abbiamo già definito implicitamente i ruoli della conversazione: noi siamo la persona che accusa e il paziente diventa quella che deve difendersi. Possiamo avere perfettamente ragione dal punto di vista clinico, ma da quel momento una parte dell'energia della conversazione verrà utilizzata per stabilire responsabilità, giustificare ciò che è successo o proteggere l'immagine personale.

Se invece iniziamo dicendo «*Vediamo insieme come stanno rispondendo i denti rispetto a ciò che avevamo programmato*» oppure «*C'è un movimento che non sta procedendo come ci aspettavamo e vorrei capire che cosa possiamo fare per rimetterlo nella direzione giusta*», non abbiamo modificato il problema clinico e non abbiamo nascosto ciò che pensiamo, ma abbiamo costruito un contesto differente per affrontarlo.

La richiesta non comincia nel momento in cui la pronunciamo, ma nel modo in cui prepariamo la conversazione che la contiene. Il principio del **framing**, studiato da Tversky e Kahneman, descrive proprio come il modo in cui un'informazione o un problema vengono presentati possa influenzarne la percezione e le decisioni che ne conseguono, anche quando gli elementi fondamentali rimangono invariati. Per questo, quando devo affrontare una collaborazione insufficiente, cerco oggi di non iniziare dalla colpa ma dal trattamento. Non significa evitare il confronto, bensì creare le condizioni perché il confronto abbia qualche possibilità in più di produrre un cambiamento invece di una difesa.

Lo stesso principio vale quando il paziente solleva un'obiezione. Uno degli errori più naturali nella comunicazione clinica è cercare immediatamente di correggere ciò che ci viene detto. Se afferma che qualcosa è fastidioso, siamo tentati di spiegargli che non dovrebbe esserlo poi così tanto; se sostiene di non riuscire a fare qualcosa, iniziamo a dimostrargli che in realtà potrebbe farlo; se ci dice di avere sempre utilizzato gli allineatori, cerchiamo di spiegargli che ciò che osserviamo dimostra il contrario.

Il problema è che, nel momento in cui cerchiamo di dimostrare che la percezione dell'altra persona è sbagliata, la costringiamo quasi automaticamente a difenderla. Se il paziente dice «*Non riesco a utilizzare gli elastici perché mi danno troppo fastidio*» e noi rispondiamo immediatamente «*Non è possibile, tutti gli altri pazienti li portano*», la conversazione smette rapidamente di riguardare gli elastici e comincia a riguardare la legittimità della sua esperienza. Il paziente dovrà convincerci che il fastidio esiste, mentre noi cercheremo di convincerlo che dovrebbe essere tollerabile, e alla fine potremo avere discusso per dieci minuti senza essere arrivati minimamente più vicini al comportamento che ci interessa ottenere.

Se il framing riguarda la cornice attraverso la quale presentiamo un problema, il **reframing** consiste nel provare a cambiarla, attribuendo allo stesso fatto un significato diverso senza bisogno di negarlo. Se una parte della terapia è scomoda posso riconoscere che lo sia e, successivamente, collegare quella scomodità al ruolo che svolge nel raggiungimento dell'obiettivo; se un comportamento richiede uno sforzo, posso riconoscerlo e aiutare il paziente a collocare quello sforzo all'interno di una cornice differente.

Un'obiezione che è stata riconosciuta ha meno bisogno di essere difesa, e soltanto a quel punto diventa possibile lavorare sul significato che le attribuiamo. Questo non significa dare ragione al paziente su qualsiasi cosa. Significa scegliere con attenzione il terreno sul quale vale la pena discutere, perché il nostro obiettivo

non è vincere una disputa verbale, ma creare le condizioni perché il comportamento necessario diventi più probabile.

2. Preservare l'immagine senza preservare il comportamento

Nel capitolo dedicato alla mente del paziente abbiamo visto quanto possa essere difficile riconoscere di avere avuto un comportamento che entra in conflitto con l'immagine che abbiamo di noi stessi. Questo principio diventa particolarmente importante quando dobbiamo intervenire sulla collaborazione.

Dire a qualcuno «*sei un paziente poco collaborante*» significa trasformare un comportamento in una caratteristica della persona. Il paziente non deve più soltanto discutere di quante ore abbia utilizzato gli allineatori, ma difendere la propria identità di persona responsabile. Da quel momento ogni nostra osservazione rischia di essere percepita come un giudizio personale.

Per questo ho imparato progressivamente a separare la persona dal comportamento. Un paziente può essere estremamente preciso negli appuntamenti e dimenticare gli elastici, può mantenere un'igiene impeccabile e utilizzare male gli allineatori oppure può avere collaborato perfettamente per un anno e attraversare un periodo nel quale la propria routine è diventata più difficile. Definirlo globalmente *"non collaborante"* non ci aiuta a comprendere quale comportamento dobbiamo modificare e, soprattutto, può aumentare la necessità di difendersi.

Quando possibile, preferisco fare il contrario e partire da qualcosa che il paziente sta già facendo bene. Se utilizza correttamente gli allineatori ma dimentica gli elastici, posso riconoscere la prima parte della collaborazione e utilizzare quella capacità come punto di partenza per la seconda. Non si tratta di adulazione e non dobbiamo attribuire qualità inesistenti; si tratta di riconoscere un comportamento reale e utilizzarlo per costruire quello che manca. Il messaggio implicito non è *"sei una persona incapace di collaborare"*, ma *"hai già dimostrato di riuscire a gestire una parte impegnativa del trattamento; dobbiamo trasferire quella stessa precisione anche qui"*. **Proteggere la persona non significa proteggere il comportamento che dobbiamo modificare.**

La stessa logica diventa ancora più importante quando il racconto del paziente e ciò che osserviamo clinicamente non coincidono. Gli chiediamo «*Li hai utilizzati?*» e lui risponde «*Sì*». Proviamo allora a essere più precisi: «*Quante ore?*». «*Sempre, praticamente tutto il giorno.*» A quel punto, davanti a qualcosa che clinicamente non ci sembra possibile, potremmo essere tentati di rispondere: «*Non può essere, perché altrimenti questo dente si sarebbe mosso*». Il problema è che, da quel momento,

la conversazione cambia obiettivo: invece di cercare una soluzione al problema clinico, noi cerchiamo di dimostrare che il paziente non ha collaborato e lui cerca di dimostrare il contrario.

Ma per modificare il comportamento non abbiamo necessariamente bisogno di una confessione. Se ciò che osserviamo è sufficiente per capire che qualcosa deve cambiare, possiamo utilizzare quell'informazione per decidere cosa fare senza obbligare il paziente ad ammettere di avere sbagliato o di averci fornito un'informazione non corretta. **Il protocollo deve permetterci di uscire dalla contrapposizione tra dimostrare che il paziente ha torto e accettare la sua versione dei fatti:** possiamo riconoscere che il comportamento deve cambiare senza dover prima stabilire chi abbia ragione sul passato.

Non si tratta di ignorare ciò che è successo o di accettare qualsiasi spiegazione. Significa semplicemente distinguere le informazioni che ci servono per prendere una decisione clinica da quelle che cerchiamo soltanto per ricostruire una responsabilità. Una volta raccolte le prime, preferisco spostare la conversazione dal passato al futuro. Non sempre abbiamo bisogno di stabilire con precisione assoluta quante ore il paziente abbia utilizzato gli allineatori tre settimane fa, mentre abbiamo certamente bisogno di stabilire come dovrà utilizzarli da domani e come verificheremo se il cambiamento sta funzionando.

Il passato ci serve per prendere una decisione, non per vincere una discussione.

3. Rendere concrete le conseguenze

Una volta ridotta la necessità di difendersi, dobbiamo rendere comprensibile perché quel comportamento debba cambiare. È qui che entrano realmente in gioco le tre leve: **tempo, risultato e investimento**.

Una delle cose che più ha modificato il mio modo di parlare con i pazienti è stata comprendere che una motivazione espressa dal paziente può avere molto più significato di una motivazione fornita da me. Per anni ho cercato di spiegare perché fosse importante collaborare, quando spesso sarebbe stato più utile fermarmi prima e capire che cosa fosse davvero importante per la persona che avevo davanti. La differenza può sembrare minima, ma cambia l'equilibrio della conversazione: nel primo caso sono io a dire al paziente perché dovrebbe desiderare qualcosa, nel secondo cerco di comprendere ciò che desidera già e collego il comportamento necessario a quell'obiettivo.

Questo principio si avvicina a ciò che la letteratura sull'influenza sociale descrive in termini di **impegno e coerenza**: le persone tendono a preferire comportamenti compatibili con posizioni, obiettivi o impegni che riconoscono come propri. Non significa intrappolare il paziente nelle sue parole, ma utilizzare ciò che lui stesso considera importante come punto di riferimento per il comportamento successivo. Se un paziente mi dice che la sua priorità è finire prima del matrimonio, non ho bisogno di convincerlo che il tempo sia importante, perché me lo ha appena detto lui. Se mi spiega che non gli interessa quanto durerà il trattamento purché il risultato sia perfetto, insistere sulla durata significa utilizzare la leva sbagliata. Se invece percepisce con particolare forza **l'investimento che ha già fatto nella terapia**, sarà probabilmente più significativo collegare la collaborazione alla possibilità di proteggere ciò che ha costruito. **Prima di cercare di modificare un comportamento, quindi, dobbiamo capire quale conseguenza abbia realmente valore per la persona che abbiamo davanti.**

A questo punto dobbiamo riuscire a renderla concreta. Noi ortodontisti tendiamo inevitabilmente a descrivere i problemi attraverso le categorie che abbiamo imparato a utilizzare nella nostra formazione: vediamo tracking, torque, ancoraggio, recidiva, stabilità e movimenti non espressi, perché è attraverso questi concetti che interpretiamo il trattamento. Il paziente, però, non vive la terapia attraverso le stesse categorie. Dire «*questo canino non sta esprimendo correttamente il movimento programmato*» può essere clinicamente impeccabile, ma non necessariamente produce una rappresentazione significativa nella mente di chi ci ascolta. Spiegare che, se quel movimento continua a rimanere indietro, potremmo dover fermare la sequenza, eseguire una nuova scansione e aggiungere alcuni mesi al percorso rende lo stesso problema molto più concreto. **Tempo, risultato e investimento non cambiano la realtà clinica, ma ci permettono di tradurla in qualcosa che il paziente possa valutare attraverso categorie che hanno significato per lui.**

Questo passaggio diventa particolarmente importante perché molte conseguenze ortodontiche sono lontane nel tempo. Il paziente che questa sera decide di non rimettere gli allineatori dopo cena non vede immediatamente una perdita di tracking; quello che dimentica gli elastici non percepisce quella notte il movimento che non avverrà. Il beneficio della collaborazione è spesso differito, mentre il vantaggio della trasgressione è immediato: può mangiare più comodamente, non deve cercare gli elastici, può andare a dormire senza pensare alla terapia. Rendere concreta una conseguenza significa quindi ridurre questa distanza, collegando mentalmente il comportamento di oggi a qualcosa che il paziente desidera ottenere o evitare domani.

Anche il modo in cui presentiamo quella conseguenza può modificarne il significato. Uno dei principi centrali della *prospect theory* è che le persone non valutano guadagni e perdite in maniera perfettamente simmetrica e che, in molti contesti decisionali, una perdita può avere un peso psicologico particolarmente elevato. Possiamo spiegare al paziente che utilizzare correttamente gli elastici gli permetterà di continuare verso il risultato programmato oppure fargli comprendere che una collaborazione discontinua rischia di compromettere una correzione che ha già ottenuto; possiamo mostrargli il beneficio di terminare secondo i tempi previsti oppure rendergli visibile la possibilità di perdere parte del tempo già investito.

Questo principio deve essere utilizzato con responsabilità. Rendere una conseguenza più evidente non significa necessariamente descrivere al paziente ogni possibile scenario con lo stesso peso: possiamo scegliere di enfatizzare quello che riteniamo più utile a fargli comprendere l'importanza del comportamento richiesto e, in alcuni casi, presentare in modo più netto una conseguenza possibile proprio per ridurre il rischio che venga sottovalutata. Se una perdita di tracking può richiedere una nuova scansione o una collaborazione discontinua può allungare il trattamento, possiamo utilizzare queste possibilità per rendere più concreto il messaggio, anche se non possiamo sapere con certezza che si verificheranno. **La conseguenza non deve essere certa per essere comunicata, ma deve rimanere sufficientemente plausibile da poter essere sostenuta clinicamente.**

Rendere una conseguenza concreta significa anche scegliere con attenzione il modo in cui la rappresentiamo. Per molto tempo sono stato convinto che una spiegazione più dettagliata fosse necessariamente una spiegazione migliore, mentre con gli anni ho imparato che il paziente raramente ricorda tutto ciò che diciamo durante una visita, soprattutto quando le informazioni sono numerose, tecniche o lontane dalla sua esperienza quotidiana. Molto più facilmente ricorderà un'immagine, un confronto, una frase o un numero che gli abbia permesso di trasformare un concetto astratto in qualcosa di immediatamente comprensibile. Per questo fotografie, scansioni, metafore, confronti e anche semplici riferimenti numerici possono diventare strumenti estremamente utili.

Non tutti i numeri che utilizziamo durante una conversazione devono necessariamente rappresentare una misurazione scientifica. A volte un numero può avere semplicemente una funzione comunicativa: rende più intuitiva una proporzione, dà una dimensione a una conseguenza o permette al paziente di ricordare più facilmente il messaggio. **Ciò che conta è distinguere una semplificazione utilizzata per comunicare da un dato clinico presentato come scientificamente misurato.** Se mostro una scansione o cito un dato reale, quel dato deve naturalmente essere cor-

retto; se invece utilizzo un numero, una metafora o una semplificazione per rendere comprensibile un concetto, quello strumento appartiene alla comunicazione.

Il nostro obiettivo non è trasferire al paziente tutta la complessità del nostro ragionamento clinico, ma fare in modo che il concetto importante sopravviva alla visita e possa tornargli in mente qualche ora dopo, quando dovrà decidere come comportarsi.

4. Ridurre l'ambiguità del comportamento futuro

Una volta compreso perché qualcosa debba cambiare, dobbiamo stabilire **che cosa cambierà concretamente**. Espressioni come *"quasi sempre"*, *"più che posso"*, *"solo qualche volta"*, *"praticamente tutto il giorno"* oppure *"non riesco"* appartengono perfettamente al linguaggio quotidiano, ma descrivono molto male un comportamento clinicamente rilevante.

Per noi *"utilizzare gli allineatori"* può significare utilizzarli ventidue ore al giorno; per il paziente può significare averli utilizzati per la maggior parte della giornata, averli rimessi con attenzione prima dell'appuntamento oppure averli utilizzati tutte le volte che gli è stato possibile. Medico e paziente possono quindi utilizzare le stesse parole attribuendo loro significati molto diversi.

Per molto tempo la mia reazione è stata discutere queste affermazioni. Se ciò che osservavo clinicamente mi suggeriva qualcosa di differente, cercavo di convincere il paziente che il suo *"sempre"* non fosse realmente sempre. Oggi preferisco fare qualcosa di molto più semplice: cerco di **rendere specifico il racconto**. Non discuto sul significato di *"sempre"*, ma ricostruisco una giornata; non cerco di stabilire se *"non riesco"* sia vero o falso, ma cerco di capire in quale momento preciso compaia la difficoltà.

Se il paziente mi dice che utilizza sempre gli allineatori, posso chiedergli a che ora fa colazione, quanto rimangono fuori, che cosa succede durante il pranzo, se beve caffè durante il pomeriggio, come gestisce la cena e a che ora li rimette prima di andare a dormire. Se invece mi dice di non riuscire a utilizzare gli elastici, posso cercare di capire quando accade: durante il lavoro, mentre parla, la sera oppure quando esce; posso chiedergli se li dimentica, se non li ha con sé oppure se il fastidio diventa eccessivo dopo qualche ora. Non sto costruendo un interrogatorio per coglierlo in contraddizione, ma trasformando una valutazione globale e soggettiva in una sequenza di comportamenti che possiamo osservare e, se necessario, modificare. **Quando il problema diventa specifico, molto spesso diventa anche più gestibile.**

Lo stesso principio deve valere quando definiamo ciò che dovrà accadere da quel momento in avanti. Più una prescrizione è importante per il risultato, meno dovrebbe dipendere dall'interpretazione personale. «*Cerca di utilizzare gli elastici il più possibile*» lascia uno spazio enorme all'ambiguità; definire quando devono essere messi, quando possono essere tolti e che cosa fare se vengono dimenticati trasforma invece una raccomandazione generica in un comportamento osservabile. È qui che tornano utili le *implementation intentions* di cui abbiamo parlato all'inizio del capitolo. Dire al paziente *"devi ricordarti gli elastici"* gli lascia il compito di ricordarsene ogni volta; costruire con lui una regola del tipo *"quando finisco di lavarmi i denti la sera, metto gli elastici"* collega invece il comportamento a una situazione riconoscibile. Non abbiamo modificato la prescrizione, ma abbiamo reso più semplice trasformarla in una routine.

Ridurre l'ambiguità significa però anche prestare attenzione al modo in cui noi stessi formuliamo le prescrizioni. In una relazione terapeutica esiste inevitabilmente una differenza di competenze: il paziente viene da noi proprio perché si aspetta che sappiamo distinguere ciò che è necessario da ciò che è facoltativo. Eppure, nel tentativo comprensibile di non sembrare autoritari, capita talvolta che siamo noi stessi a rendere negoziabile qualcosa che clinicamente non lo è.

Formule come *"magari prova"*, *"sarebbe meglio"*, *"cerca di farlo"* oppure *"vediamo se riesci"* sono perfettamente appropriate quando stiamo realmente proponendo qualcosa di facoltativo, ma diventano problematiche quando riguardano un comportamento che consideriamo necessario per far funzionare la terapia. Essere autorevoli non significa essere duri né utilizzare il ruolo del medico per ottenere obbedienza cieca, ma assumersi la responsabilità di dire con chiarezza quando una determinata condizione è necessaria per raggiungere l'obiettivo che abbiamo concordato.

Questo diventa particolarmente importante quando il paziente cerca comprensibilmente una soluzione più semplice. Se ci chiede se possa utilizzare gli allineatori meno ore, eliminare gli elastici o ridurre una prescrizione che consideriamo necessaria, il desiderio di mantenere una relazione piacevole può portarci a rendere negoziabile qualcosa che clinicamente non lo è. La soluzione che ho trovato più utile consiste nel distinguere il **cosa** dal **come**. Il *cosa* appartiene alla prescrizione clinica: se un determinato comportamento è necessario per la terapia, non ha senso fingere che non lo sia. Il *come*, invece, può spesso essere costruito insieme al paziente, lasciandogli spazio nell'organizzazione, nella routine e nella strategia attraverso cui integrare quel comportamento nella propria vita quotidiana.

Il paziente non decide quindi se un elemento clinicamente necessario della terapia lo sia oppure no, ma può partecipare a decidere come renderlo compatibile

con la propria giornata. È un equilibrio che considero fondamentale: **autorevolezza sul bisogno clinico e autonomia sulla strategia comportamentale**.

5. Facilitare il comportamento e verificarne l'effetto

Aver definito con precisione che cosa deve fare il paziente non significa ancora che riuscirà a farlo. Non sempre il problema dipende dalla mancanza di motivazione: un comportamento può essere difficile da inserire nella routine, richiedere troppe decisioni, dipendere dalla memoria nel momento sbagliato oppure essere associato a un contesto nel quale il paziente non dispone di ciò che gli serve.

In questi casi aumentare la pressione comunicativa serve relativamente poco, mentre può essere molto più utile modificare l'ambiente nel quale quel comportamento dovrebbe avvenire. È uno dei concetti alla base dell'**architettura delle scelte**, cioè l'idea che ogni decisione avvenga all'interno di un contesto e che il modo in cui quel contesto viene organizzato possa facilitare o rendere più difficile determinate azioni.

All'interno di questa logica si colloca il principio del *nudging*: piccoli interventi che rendono più semplice compiere un comportamento utile senza impedire le alternative. Un promemoria, una verifica più ravvicinata, una confezione di elastici conservata nel posto giusto o una routine collegata a un'abitudine già esistente possono ridurre la distanza tra l'intenzione dichiarata e il comportamento quotidiano.

Il paziente che dimentica gli elastici prima di dormire potrebbe, per esempio, collegarli a un gesto che compie già ogni sera, come lavarsi i denti o appoggiare il telefono sul comodino. Chi tende a lasciare gli allineatori a casa potrebbe organizzare la propria routine in modo da avere sempre con sé ciò che gli serve. In questi casi non abbiamo necessariamente aumentato la motivazione, ma abbiamo ridotto l'attrito che impediva all'intenzione di trasformarsi in azione. **Il nostro obiettivo non è quindi soltanto convincere il paziente a fare qualcosa, ma rendere quel comportamento sufficientemente semplice da poter entrare nella sua vita quotidiana.**

A questo punto manca però ancora un elemento: **il feedback**. Uno dei problemi dei trattamenti ortodontici è che molte conseguenze arrivano lentamente. Il paziente può utilizzare gli allineatori meno del necessario per diversi giorni senza vedere alcuna differenza evidente e può dimenticare gli elastici per settimane senza percepire immediatamente ciò che sta accadendo. Quando finalmente il problema diventa clinicamente visibile, il comportamento che lo ha prodotto può essere

ormai lontano nel tempo e il collegamento tra causa ed effetto diventa molto meno intuitivo.

Per questo mostrare una fotografia precedente, confrontare due scansioni, indicare un punto nel quale l'allineatore non si adatta più correttamente oppure far vedere che un movimento è rimasto indietro può essere molto più efficace che ripetere per l'ennesima volta la stessa raccomandazione. Il feedback rende visibile qualcosa che altrimenti rimarrebbe astratto e permette al paziente di collegare più facilmente ciò che fa ogni giorno a ciò che sta accadendo durante il trattamento.

Il feedback, però, non deve trasformarsi nella prova all'interno di un processo. Non mostriamo la scansione per dire *«Vede che avevo ragione io?»*, perché in quel momento avremmo semplicemente trasformato uno strumento clinico in un'arma all'interno della discussione. Lo utilizziamo per rendere visibile il rapporto tra ciò che sta accadendo e ciò che dovrà cambiare.

Ma il feedback non serve soltanto al paziente. **Serve anche a noi per verificare se l'ipotesi sulla quale abbiamo costruito il nostro intervento fosse corretta.** Se abbiamo identificato un comportamento problematico, abbiamo cercato di modificarlo e dopo un intervallo adeguato il trattamento continua a non rispondere come ci aspettavamo, non possiamo limitarci a concludere che il paziente stia ancora collaborando male. Dobbiamo essere disponibili a riconsiderare ciò che avevamo ipotizzato e chiederci se esista un problema clinico, biologico o biomeccanico che non avevamo riconosciuto.

Il feedback chiude quindi il protocollo e, allo stesso tempo, può farlo ripartire. Sposta la conversazione dalla fiducia personale agli elementi osservabili: non dobbiamo stabilire se credere o non credere al paziente, ma possiamo guardare insieme ciò che sta succedendo, decidere che cosa modificare e verificare abbastanza presto se la nuova strategia stia funzionando. **Un protocollo non termina quando abbiamo detto al paziente che cosa fare, ma quando abbiamo verificato che ciò che abbiamo deciso insieme stia producendo l'effetto che cercavamo.**

Responsabilità condivisa, ruoli distinti

Un trattamento ortodontico è inevitabilmente una collaborazione nella quale medico e paziente partecipano allo stesso percorso con responsabilità differenti. Noi abbiamo la responsabilità della diagnosi, della progettazione, delle decisioni cliniche, dei controlli e delle modifiche necessarie durante la terapia; il paziente ha responsabilità diverse, che comprendono seguire le prescrizioni, utilizzare corret-

tamente allineatori ed elastici, rispettare gli appuntamenti e comunicarci quando qualcosa non sta funzionando.

Responsabilità condivisa non significa quindi responsabilità indistinta. Dire semplicemente *"il risultato dipende da entrambi"* è corretto soltanto se siamo poi in grado di chiarire quale parte dipenda da noi e quale dal paziente. Questo ci permette di evitare due estremi opposti: attribuire automaticamente al paziente qualsiasi problema oppure assumere noi la responsabilità anche di comportamenti sui quali non abbiamo alcun controllo diretto.

È anche uno dei motivi per cui i protocolli dovrebbero cominciare **prima che sorga il problema**. Definire i ruoli quando tutto sta andando bene è molto più semplice che cercare di stabilirli nel momento in cui il trattamento ha già perso tracking e medico e paziente stanno cercando di capire di chi sia la responsabilità.

Lo stesso vale per le conseguenze. Se un determinato comportamento può richiedere una nuova scansione, modificare i tempi o cambiare il modo in cui dovremo procedere, è preferibile che il paziente lo sappia prima che quella situazione si verifichi. **Una conseguenza spiegata dopo il problema può essere percepita come una punizione; la stessa conseguenza definita in anticipo diventa una condizione del percorso terapeutico.**

Un protocollo deve appartenere allo studio

C'è infine un aspetto che considero indispensabile: un protocollo non può esistere soltanto nella testa dell'ortodontista, perché durante un trattamento il paziente parla con la segreteria, con le assistenti, con gli igienisti, con altri medici e con tutte le persone che partecipano al suo percorso. Se ognuna di loro comunica una regola diversa, quella regola smette rapidamente di essere una regola.

Non è necessario che tutti utilizzino esattamente le stesse parole. Una ripetizione troppo rigida potrebbe apparire artificiale e impedire a ciascun membro del team di comunicare in modo naturale. È però indispensabile che **il significato della risposta non cambi**.

La segreteria deve sapere quali appuntamenti possano essere modificati, quali conseguenze organizzative debbano essere comunicate e quali decisioni spettino esclusivamente al clinico. Le assistenti devono conoscere il significato delle prescrizioni e non trasformare involontariamente una condizione necessaria in un semplice consiglio. Il medico, da parte sua, non può smentire davanti al paziente una posizione che il team ha correttamente applicato sulla base del protocollo condiviso.

Il paziente può quindi confrontarsi con persone differenti, ma dovrebbe continuare a percepire **una sola direzione clinica**. Se una prescrizione viene presentata come indispensabile dal medico e come facoltativa dall'assistente, non possiamo stupirci se il paziente sceglierà l'interpretazione che gli richiede meno sforzo. Allo stesso modo, se una regola o una conseguenza cambia a seconda della persona con cui parla, quella regola diventa inevitabilmente negoziabile.

La coerenza del team non significa quindi ripetere tutti le stesse frasi, ma condividere le stesse condizioni, gli stessi limiti e la stessa direzione. **Un protocollo diventa realmente tale soltanto quando smette di essere la risposta personale del medico e diventa il modo coerente con cui tutto lo studio affronta una situazione già conosciuta.**

Dai principi alle strategie

Nessuno dei principi descritti in questo capitolo rappresenta una formula magica e nessuno, preso isolatamente, è sufficiente a costruire un protocollo. Non dovremo utilizzare ogni volta framing, avversione alla perdita, nudging, feedback e tutti gli altri strumenti contemporaneamente, perché una conversazione costruita in questo modo risulterebbe artificiale e probabilmente anche inefficace.

Ogni strategia dovrà selezionare soltanto gli elementi utili al problema che abbiamo davanti. In alcuni casi dovremo soprattutto ridurre la difensività, in altri rendere più concreta una conseguenza, ridurre l'ambiguità, facilitare un comportamento oppure stabilire con maggiore chiarezza una condizione clinica. La psicologia cognitiva e l'economia comportamentale non ci forniscono quindi un copione da recitare, ma strumenti che possono aiutarci a comprendere perché alcune risposte facilitino il cambiamento mentre altre ci conducano più facilmente allo scontro.

Anche la forma dovrà adattarsi alla persona che abbiamo davanti. Un paziente diretto potrà aver bisogno di una spiegazione breve e orientata alla decisione, mentre uno più analitico richiederà informazioni e passaggi più dettagliati e una persona più insicura potrebbe aver bisogno di maggiore gradualità e rassicurazione. Ciò che non dovrebbe cambiare è la logica del protocollo: **ridurre la difensività, proteggere la persona senza proteggere il comportamento, rendere concrete le conseguenze, definire con precisione il comportamento futuro, facilitarne l'esecuzione e verificarne l'effetto**.

I protocolli presentati nelle prossime pagine derivano dall'osservazione di situazioni cliniche incontrate ripetutamente, dalle risposte che inizialmente non hanno funzionato e dalle modifiche introdotte nel tempo. Non devono essere interpretati

come formule universali capaci di produrre sempre la stessa reazione, perché il comportamento umano conserva inevitabilmente una quota di variabilità e nessuna sequenza comunicativa può garantire la collaborazione. Il loro valore non consiste nell'eliminare questa variabilità, ma nel permetterci di affrontare situazioni simili attraverso un metodo riconoscibile, che possa essere osservato, discusso e migliorato. **Una risposta improvvisata scompare insieme alla singola conversazione; un metodo ripetibile può invece produrre apprendimento per tutto lo studio.**

Per questo, nei capitoli successivi, ogni protocollo seguirà una struttura riconoscibile. Partiremo dalla situazione clinica e dai segnali che ci consentono di identificarla, individueremo il comportamento che deve essere modificato e gli errori più comuni che possono aumentare la resistenza del paziente, quindi definiremo la sequenza operativa, le domande da porre, gli elementi da verificare e le conseguenze da anticipare. Il dialogo clinico mostrerà come tradurre quella struttura in parole concrete, mentre il riquadro **"Perché questo protocollo funziona"** ci permetterà di ritornare, quando sarà utile, ai principi psicologici che abbiamo appena descritto.

Questa distinzione tra procedura e spiegazione è importante, perché il collega deve sapere che cosa dire e che cosa fare, ma dovrebbe anche comprendere perché una determinata sequenza possa essere più efficace dell'accusa, del richiamo generico o della semplice ripetizione delle istruzioni. Soltanto comprendendo il meccanismo sarà possibile modificare le parole senza alterare la funzione del protocollo.

L'obiettivo non è quindi costruire una raccolta di *"frasi furbe"* e neppure trasformare l'ortodontista in un esperto di persuasione. Vorrei arrivare a qualcosa di molto più semplice e utile: fare in modo che, davanti a un paziente che non collabora, il nostro primo pensiero smetta progressivamente di essere «*come glielo spiego ancora una volta?*» e diventi invece «*che cosa sta impedendo a questa persona di fare ciò che sa già di dover fare, quale conseguenza ha realmente valore per lei e quale protocollo posso utilizzare per aumentare la probabilità che quel comportamento cambi?*»

Per molti anni abbiamo progettato con estrema precisione il movimento dei denti, lasciando invece all'improvvisazione le conversazioni necessarie a proteggere quel progetto. Abbiamo ripetuto le istruzioni, motivato il paziente e cercato ogni volta una frase nuova; quando il problema si ripresentava, ricominciavamo da capo.

I protocolli cambiano questa prospettiva. Non cercano di rendere prevedibile il comportamento del paziente e certamente non possono controllarlo, ma ci permettono di rendere più prevedibile **la nostra risposta**. Se alcuni comportamenti seguono pattern riconoscibili, possiamo imparare a riconoscerli; se possiamo riconoscerli, possiamo prepararci a gestirli e, se possiamo prepararci a gestirli, la

nostra risposta può finalmente smettere di essere un'improvvisazione e diventare un metodo.

È da qui che comincia la parte più pratica di questo libro.

BIBLIOGRAFIA

Gollwitzer PM. Implementation intentions: strong effects of simple plans. *Am Psychol.* 1999;54(7):493–503.

Tversky A, Kahneman D. The framing of decisions and the psychology of choice. *Science.* 1981;211(4481):453–458.

Cialdini RB. *Influence: The Psychology of Persuasion.* Rev ed. New York: Harper Business; 2006.

Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica.* 1979;47(2):263–291.

Thaler RH, Sunstein CR. *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.* New Haven: Yale University Press; 2008.

Thaler RH, Sunstein CR, Balz JP. Choice architecture. In: Shafir E, ed. *The Behavioral Foundations of Public Policy.* Princeton: Princeton University Press; 2013:428–439.

CAPITOLO

6

Il paziente che non usa gli allineatori

«Fare bene vale più che dire bene.»

— BENJAMIN FRANKLIN

Ci sono situazioni nelle quali basta osservare gli allineatori in bocca per rendersi conto che qualcosa non sta procedendo come avevamo programmato, ma non tutte le perdite di fitting hanno lo stesso significato e, soprattutto, non tutte richiedono la stessa risposta clinica.

Se un singolo dente non segue perfettamente l'allineatore, non penso automaticamente a un problema di collaborazione e non interrompo necessariamente la sequenza per eseguire una nuova scansione. Sappiamo bene che alcuni movimenti sono meno predicibili di altri: un incisivo laterale superiore che deve eseguire una rotazione complessa, un'estrusione difficile o un altro movimento particolarmente

impegnativo può rimanere indietro anche in un paziente che utilizza gli allineatori in maniera impeccabile. Se quel movimento non è strategico per la prosecuzione della terapia e la sua mancata espressione non compromette i movimenti successivi, molto spesso preferisco continuare con la sequenza programmata e recuperarlo successivamente durante la fase di rifinitura.

La situazione cambia quando la perdita di fitting non riguarda più un singolo dente, ma comincia a diventare generalizzata. **Per questo motivo il primo controllo durante la sequenza lo programmo normalmente dopo circa due mesi.** È un intervallo che considero sufficientemente lungo per capire come il paziente stia realmente utilizzando gli allineatori e per iniziare a osservare un'eventuale perdita di fitting, ma allo stesso tempo abbastanza breve da permettermi, nella maggior parte dei casi, di intervenire prima che la discrepanza diventi troppo importante. Se a quel controllo mi accorgo che diversi denti stanno iniziando a rimanere indietro rispetto alla posizione programmata, spesso siamo ancora nelle condizioni di recuperare il fitting modificando il comportamento del paziente o rallentando temporaneamente la sequenza, senza essere costretti a interrompere tutto ed eseguire una nuova scansione.

Quando a questo primo controllo osservo una perdita di fitting che non riguarda più un singolo movimento, ma coinvolge progressivamente più denti, il sospetto che il paziente non stia utilizzando gli allineatori per il numero di ore necessario diventa inevitabilmente molto forte. È proprio in quel momento che inizia uno dei problemi di comunicazione più frequenti nel trattamento con allineatori e, per capire cosa stia succedendo, comincio con una domanda molto semplice:

> *«Come sta andando con gli allineatori? Qual è il momento della giornata in cui fai più fatica a rimetterli?»*

Questa domanda mi aiuta più di un generico *«Riesci a utilizzarli sempre?»*, al quale il paziente tende quasi inevitabilmente a rispondere di sì. Cerco allora di ricostruire meglio quello che succede durante una normale giornata, chiedendo quando li toglie, quanto durano i pasti, cosa succede durante il lavoro, quando esce la sera o nel fine settimana. Presto particolare attenzione al tempo che trascorre tra la fine del pasto e il momento in cui gli allineatori vengono effettivamente reinseriti, perché spesso è proprio lì, più che durante il pasto stesso, che si accumulano le ore senza allineatori.

Non lo faccio come un interrogatorio, ma cercando di capire insieme al paziente se esistano momenti nei quali, senza rendersene conto, il tempo trascorso senza

allineatori sia maggiore di quanto percepisca. Alla fine, però, può capitare che continui a essere assolutamente sicuro della propria risposta:

«No, dottore. Li utilizzo davvero sempre.»

A quel punto mi trovo davanti a due informazioni che sembrano difficili da conciliare: da una parte quello che vedo clinicamente mi suggerisce che i denti non stanno seguendo gli allineatori come dovrebbero, mentre dall'altra ho davanti una persona che mi assicura con grande convinzione di avere seguito scrupolosamente tutte le indicazioni ricevute.

Il comportamento che dobbiamo modificare

Il comportamento sul quale vogliamo intervenire non è genericamente *"collaborare di più"*. Dobbiamo fare in modo che il paziente utilizzi gli allineatori per il numero di ore necessario, riducendo soprattutto quei periodi della giornata nei quali rimangono fuori dalla bocca più a lungo di quanto lui stesso percepisca.

Questo è importante perché molto spesso il problema non nasce da una decisione consapevole di utilizzare poco gli allineatori, ma dalla somma di molti intervalli apparentemente insignificanti: una colazione che dura più del previsto, il caffè dopo pranzo, una telefonata prima di rimetterli, un aperitivo, una cena che si prolunga o semplicemente il fatto di lasciarli sul tavolo e ricordarsene un'ora dopo. Presi singolarmente sembrano episodi trascurabili; sommati nell'arco della giornata possono ridurre in maniera importante il tempo reale di utilizzo.

Per questo il primo obiettivo non è stabilire se il paziente stia dicendo la verità, ma trasformare un generico *«li utilizzo sempre»* in una descrizione sufficientemente concreta della sua giornata da permetterci di capire dove possa trovarsi il problema.

L'errore che facevo: cercare di convincere il paziente

Di fronte a queste situazioni sceglievo il modo che mi sembrava più semplice e logico. Se vedevo una perdita generalizzata di fitting, spiegavo al paziente che probabilmente non stava utilizzando gli allineatori abbastanza e insistevo sulla necessità di aumentare le ore di utilizzo. Gli mostravo quello che vedevo clinicamente e gli dicevo qualcosa come:

«Guarda che qui si vede chiaramente che i denti non stanno seguendo gli allineatori. Devi cercare di utilizzarli di più.»

Il problema era che dall'altra parte ricevevo quasi sempre la stessa risposta:

«Ma io li utilizzo.»

Io vedevo l'unfitting e insistevo, mentre il paziente ribadiva di avere seguito le indicazioni. Più cercavo di convincerlo che il problema fosse la sua collaborazione, più lui sentiva il bisogno di difendere il proprio comportamento e, dopo qualche minuto, ci trovavamo a discutere non più di come recuperare il trattamento, ma di chi dei due avesse ragione.

Questa dinamica può diventare ancora più evidente quando davanti abbiamo un paziente adulto molto sicuro di sé, magari una persona con un ruolo professionale importante, abituata a prendere decisioni, a dirigere altre persone e a sostenere con fermezza le proprie posizioni. Dire apertamente a quel paziente «*Non è vero, gli allineatori non li stai utilizzando*» significa mettere in discussione non soltanto la sua collaborazione, ma anche la sua credibilità.

A quel punto il problema clinico rischia di trasformarsi in uno scontro personale nel quale entrambi cerchiamo, più o meno consapevolmente, di dimostrare di avere ragione. Il paradosso è che, anche se riuscissi a vincere quella discussione, non avrei necessariamente ottenuto ciò che mi interessa davvero, perché il mio obiettivo non dovrebbe essere convincere il paziente che ha sbagliato nelle settimane precedenti, ma fare in modo che utilizzi correttamente gli allineatori da quel momento in avanti.

Ci ho messo del tempo a capirlo e, probabilmente, ho avuto bisogno di una paziente particolare per cambiare completamente prospettiva.

La paziente alla quale non credevo

Avevo trattato con gli allineatori prima il marito e successivamente i due figli di Chantal. Tutti e tre erano stati molto collaboranti e i loro trattamenti si erano conclusi senza particolari difficoltà, così quando anche lei decise di sistemare i denti non avevo nessun motivo per aspettarmi qualcosa di diverso. Il suo era, almeno apparentemente, un caso molto semplice, con un po' di affollamento soprattutto a livello degli incisivi inferiori e niente che, dal punto di vista biomeccanico, mi facesse immaginare particolari difficoltà.

Iniziammo il trattamento e già durante i primi controlli mi resi conto che qualcosa non stava andando come previsto, perché gli incisivi si muovevano molto meno di quanto mi sarei aspettato e gli allineatori progressivamente perdevano fitting. Lei lavorava nel mondo della moda, viaggiava moltissimo e aveva una vita professionale particolarmente intensa e ricca di eventi, aperitivi e altri momenti conviviali durante i quali è facile dimenticarsi degli allineatori. Per questa ragione, nella mia testa, la spiegazione sembrava quasi ovvia: semplicemente non li utilizzava abbastanza.

Cominciai quindi a insistere sulla collaborazione, ricordandole che gli allineatori dovevano essere utilizzati per il numero di ore prescritto e spiegandole che, se continuava in quel modo, i denti non avrebbero seguito correttamente la programmazione. Lei, però, continuava a ripetermi la stessa cosa:

«Enzo, io li utilizzo.»

Io continuavo a guardare quegli incisivi e continuavo a non crederle. La situazione andò avanti per più di sei mesi, fino a quando Chantal mi disse che dopo qualche mese si sarebbe trasferita a Londra per lavoro e mi chiese di concludere il trattamento prima della sua partenza. A quel punto pensai di eliminare definitivamente quella che, nella mia testa, continuava a essere la causa principale del problema e le proposi di mettere dei bracket sugli incisivi inferiori, promettendole che in un paio di mesi si sarebbero perfettamente allineati. Ero abbastanza tranquillo, perché ero convinto che, una volta eliminata la variabile della collaborazione, quei pochi denti si sarebbero allineati rapidamente.

Dopo due mesi gli incisivi erano ancora storti.

Fu probabilmente la prima volta in cui presi davvero in considerazione una possibilità che fino a quel momento avevo quasi escluso: forse quella paziente non mi aveva mai mentito e il problema che avevo attribuito per mesi alla sua collaborazione poteva dipendere, almeno in parte, dalla sua risposta biologica al movimento ortodontico.

Non in tutti i pazienti i denti si muovono alla stessa velocità

Quell'esperienza mi spinse a interessarmi maggiormente alla variabilità individuale del movimento ortodontico e scoprii che ciò che avevo osservato clinicamente aveva una base biologica molto più solida di quanto avessi immaginato.

Quando applichiamo una forza ortodontica, infatti, non stiamo spostando meccanicamente un dente come potremmo spostare un oggetto. La forza rappresenta lo stimolo iniziale di una complessa risposta biologica che coinvolge il legamento parodontale, l'osso alveolare, osteoclasti, osteoblasti, mediatori dell'infiammazione e numerosi meccanismi cellulari e molecolari. La velocità con cui questa risposta avviene presenta una considerevole variabilità individuale e, anche quando cerchiamo di standardizzare la forza applicata, persone differenti possono mostrare velocità di movimento molto diverse.

Uno degli studi che meglio dimostra questo fenomeno è stato pubblicato da Giannopoulou e collaboratori sull'*European Journal of Orthodontics*. Gli autori applicarono un protocollo sperimentale standardizzato nel quale due premolari di cia-

scun partecipante venivano spostati vestibolarmente per otto settimane utilizzando una forza di 1 N. Nonostante la forza fosse standardizzata e fossero stati esclusi ostacoli locali o funzionali al movimento, la quantità di spostamento ottenuta variò enormemente tra gli individui, passando da appena 0,6 mm fino a 5,8 mm, con una media di 2,7 mm. Ancora più interessante fu osservare che i denti appartenenti allo stesso individuo tendevano a comportarsi in maniera simile, mostrando un'elevata correlazione intraindividuale. Gli stessi autori conclusero che questa ampia variabilità permetteva di identificare, all'interno del campione, soggetti *slow movers* e *fast movers*.

Il concetto è stato ripreso anche in studi clinici successivi. In un trial randomizzato sulla chiusura degli spazi estrattivi, per esempio, gli autori utilizzarono esplicitamente le espressioni *fast movers* e *slow movers* per distinguere pazienti che, nello stesso intervallo temporale, mostravano quantità differenti di movimento dentale. In quello specifico studio furono definiti *fast movers* i casi con un movimento di almeno 1 mm al mese. Naturalmente questa soglia non rappresenta una definizione universale da trasferire alla pratica clinica e non ci consente di dividere semplicemente tutti i nostri pazienti in due categorie, ma dimostra quanto il concetto di una diversa velocità individuale di movimento sia reale e utilizzato nella stessa letteratura ortodontica.

Le ragioni di questa variabilità sono probabilmente molteplici e non ancora completamente comprese. Il movimento ortodontico dipende dalla risposta biologica dei tessuti alla forza e sono state studiate differenze individuali nei sistemi molecolari coinvolti nel rimodellamento osseo e del legamento parodontale. Alcune ricerche hanno indagato anche il possibile contributo genetico e, in particolare, polimorfismi di geni coinvolti nei sistemi RANK, RANKL e OPG e in altri mediatori della risposta ortodontica. È interessante che anche in questo ambito gli autori facciano esplicitamente riferimento al fenomeno clinico degli *slow movers* e dei *fast movers*, ipotizzando che almeno una parte della diversa velocità di movimento possa dipendere dalle caratteristiche biologiche del singolo individuo.

Questa variabilità biologica, naturalmente, esisteva anche quando i nostri trattamenti venivano eseguiti con apparecchiature fisse. In quel contesto, però, uno *slow mover* rappresentava soprattutto un problema di tempo. Se un dente non aveva ancora raggiunto la posizione desiderata, nella maggior parte dei casi potevamo semplicemente lasciare lavorare più a lungo lo stesso arco e aspettare che la risposta biologica facesse il proprio corso. Come mi ha sempre detto il mio grande maestro Davide Mirabella: «*Let them cook.*» Lasciali cucinare. A volte la cosa migliore da fare era semplicemente dare ai denti il tempo necessario per esprimere il movimento.

Il fatto che quel paziente avesse bisogno di più tempo non ci obbligava necessariamente a modificare la sequenza terapeutica: potevamo adattare il ritmo del trattamento alla velocità con cui i suoi denti si stavano realmente muovendo.

Con gli allineatori il problema assume una dimensione diversa, perché non è più soltanto una questione di quanto tempo impiega il dente a muoversi, ma di quanto la sua velocità biologica riesca a rimanere sincronizzata con la sequenza programmata. Ogni allineatore viene progettato presupponendo che il movimento previsto dall'allineatore precedente sia stato sufficientemente espresso. Se il paziente è uno *slow mover* e noi continuiamo a sostituire gli allineatori secondo un intervallo troppo rapido rispetto alla sua risposta biologica, il dente può progressivamente rimanere indietro rispetto alla posizione prevista. L'allineatore successivo cerca allora di adattarsi a una posizione che il dente non ha ancora raggiunto e questa discrepanza, cambio dopo cambio, può accumularsi fino a diventare clinicamente evidente sotto forma di perdita di fitting.

È probabilmente questa una delle ragioni per cui il concetto di *slow mover*, pur non essendo affatto nuovo, diventa particolarmente rilevante nella terapia con allineatori. Con l'apparecchiatura fissa potevamo spesso permetterci semplicemente di aspettare più a lungo; con gli allineatori dobbiamo invece cercare di sincronizzare la velocità con cui facciamo avanzare la sequenza con la velocità con cui la biologia di quel paziente è realmente in grado di esprimere il movimento.

Tutto questo non significa naturalmente che una perdita generalizzata di fitting debba essere automaticamente attribuita alla biologia, né che lo *slow mover* rappresenti la spiegazione più probabile ogni volta che un trattamento con allineatori non procede come previsto. La collaborazione rimane una delle prime variabili da prendere in considerazione quando diversi denti iniziano contemporaneamente a perdere fitting. La letteratura sugli *slow movers* ci ricorda però qualcosa di altrettanto importante: dalla sola osservazione clinica non possiamo sempre sapere con certezza quanto ciò che stiamo vedendo dipenda dal comportamento del paziente e quanto possa invece essere influenzato dalla sua risposta biologica individuale.

Chantal, alla fine, mi aveva insegnato proprio questo. Nel suo caso avevo eliminato la variabile della collaborazione passando all'apparecchiatura fissa e i denti avevano continuato a muoversi lentamente: **era davvero una *slow mover*.** Ma proprio quell'esperienza mi fece capire anche qualcos'altro. Se una risposta biologica più lenta poteva spiegare realmente una perdita di fitting, allora potevo utilizzare quella stessa possibilità clinica anche quando mi trovavo davanti a un paziente nel quale sospettavo fortemente che il problema fosse invece la collaborazione, senza

doverlo accusare e senza dover dimostrare che mi stesse raccontando qualcosa di diverso da ciò che faceva realmente.

È da lì che, negli anni, è nata una delle strategie che utilizzo più frequentemente.

Non devo dimostrare che il paziente sta mentendo

Quando oggi incontro un paziente con una perdita generalizzata di fitting, non parto più dall'accusa e non cerco immediatamente di convincerlo che non sta utilizzando gli allineatori. Per prima cosa cerco di ricostruire insieme a lui quello che sta succedendo, ripercorrendo le sue abitudini quotidiane e cercando eventuali momenti nei quali gli allineatori rimangono fuori dalla bocca più a lungo di quanto il paziente stesso percepisca. Questo passaggio è importante anche per tutto ciò che abbiamo visto nella prima parte del libro sulla memoria ricostruttiva e sulla differenza che può esistere tra il comportamento reale e il modo in cui ciascuno di noi ricorda e racconta il proprio comportamento.

Se, dopo questa conversazione, il paziente continua ad assicurarmi di utilizzare gli allineatori esattamente come prescritto, non cerco più di dimostrargli il contrario, ma scelgo deliberatamente di accettare la sua versione e introduco un'altra possibile spiegazione:

> *«Guarda, abbiamo due informazioni che dobbiamo mettere insieme. Io vedo che i tuoi denti non stanno seguendo gli allineatori alla velocità che avevamo previsto e tu mi stai dicendo che li stai utilizzando correttamente. Se le cose stanno così, dobbiamo prendere in considerazione un'altra possibilità.»*

Normalmente a questo punto il paziente diventa molto attento, perché non si sente accusato e vuole capire quale possa essere l'altra spiegazione. Continuo:

> *«Non in tutte le persone i denti si spostano alla stessa velocità. La maggior parte dei pazienti risponde nei tempi che utilizziamo normalmente, mentre esiste una piccola percentuale di persone nelle quali la risposta biologica è nettamente più lenta. In letteratura vengono utilizzati anche i termini fast movers e slow movers. Se tu stai davvero utilizzando gli allineatori come mi dici e i denti continuano a rimanere indietro, dobbiamo considerare la possibilità che tu sia uno slow mover.»*

A questo punto non ho contraddetto il paziente e non gli ho chiesto di ammettere nulla. Al contrario, ho preso per buona la sua versione dei fatti, ma proprio perché l'ho accettata devo trarne una conseguenza clinica coerente:

«Se i tuoi denti si muovono più lentamente, una settimana potrebbe non essere sufficiente perché riescano a seguire completamente il movimento programmato in ogni allineatore. Se continuassimo comunque a cambiarli ogni sette giorni, rischieremmo di accumulare progressivamente un ritardo tra la posizione prevista e quella reale dei denti, peggiorando sempre di più il fitting.»

La conseguenza che propongo è semplice:

«Per questo, almeno per il momento, invece di cambiare l'allineatore ogni settimana dovremmo cambiarlo ogni tre settimane. Poi controlleremo come stanno rispondendo i denti e, se vedremo che il fitting migliora, potremo provare progressivamente ad accelerare passando, per esempio, a un cambio ogni due settimane.»

Il cambio ogni tre settimane rappresenta una mia scelta clinica prudenziale e non un intervallo che la letteratura abbia identificato come necessario per tutti i pazienti con una risposta biologica più lenta. Per il paziente, tuttavia, il passaggio da sette a ventuno giorni rende immediatamente concreta una conseguenza che fino a quel momento poteva essere rimasta astratta: se per ogni allineatore dovessimo avere bisogno di tre volte il tempo previsto, mantenendo quel ritmo anche la durata complessiva del trattamento potrebbe diventare addirittura tre volte maggiore.

Ed è proprio a questo punto che, molto spesso, accade la cosa più interessante.

Il paziente rimane qualche secondo a pensarci e comincia spontaneamente a ricostruire il proprio comportamento in maniera un po' diversa:

«Beh, Doc, in effetti ventidue ore proprio sempre forse no. Nel weekend capita che li tenga meno e quando esco magari rimangono fuori più a lungo. Se provo davvero a impegnarmi di più e a utilizzarli sempre, possiamo continuare a cambiarli ogni settimana?»

È importante capire che non gli ho chiesto di confessare nulla. Non gli ho detto che non gli credo e non ho cercato di dimostrare che mi stesse mentendo. Ho semplicemente preso sul serio quello che mi stava raccontando e gli ho mostrato quale sarebbe stata la conseguenza clinica coerente se davvero, nonostante un utilizzo corretto, i suoi denti non fossero riusciti a seguire il ritmo programmato.

Nel momento in cui comprende che questo potrebbe significare passare da sette a ventuno giorni e quindi allungare enormemente il trattamento, cambia anche il modo in cui valuta quelle ore senza allineatori. Quello che fino a pochi minuti prima veniva riassunto con «*li utilizzo sempre*» può diventare «*in effetti, durante il weekend un po' meno*», oppure «*quando esco capita che rimangano fuori parecchio*».

E, quando succede, nella maggior parte dei casi **non passo affatto alle tre settimane**. Se il paziente riconosce spontaneamente che le ore di utilizzo sono state inferiori a quelle prescritte e mi dice di voler provare a essere più preciso, mantengo il cambio settimanale e gli do la possibilità di dimostrarlo attraverso ciò che succederà nelle settimane successive. Le tre settimane rimangono invece la conseguenza clinica coerente quando il paziente continua a confermarmi di avere utilizzato correttamente gli allineatori.

In altre parole, non utilizzo il rallentamento come una punizione. Utilizzo il Tempo per rendere concreta la conseguenza di ciò che sto osservando e permettere al paziente di scegliere se modificare il proprio comportamento.

In questa fase la leva più potente è il Tempo

Come ho già descritto, Tempo, Risultato e Investimento rappresentano tre delle leve che utilizzo più frequentemente nella comunicazione durante un trattamento con allineatori, ma non hanno tutte lo stesso peso in ogni momento della terapia.

Quando il paziente ha iniziato da pochi mesi, utilizzare la leva dell'Investimento ha generalmente poco senso, perché il trattamento è appena iniziato e il paziente ha appena affrontato il costo economico della terapia. Anche il Risultato rimane certamente importante, ma in questa fase può essere ancora relativamente lontano e il paziente può avere difficoltà a percepire quanto una collaborazione insufficiente oggi possa compromettere qualcosa che vedrà soltanto molti mesi dopo. Il Tempo, invece, è immediatamente comprensibile.

Se una persona ha iniziato una terapia sapendo che avrebbe cambiato gli allineatori ogni settimana e che il trattamento sarebbe durato indicativamente quindici o diciotto mesi, sentirsi dire che da quel momento potrebbe essere necessario utilizzare ogni allineatore per tre settimane rende la conseguenza estremamente concreta. Non stiamo più parlando genericamente della possibilità che *«il trattamento si allunghi»*: il paziente vede immediatamente che il ritmo con cui sta procedendo potrebbe diventare tre volte più lento rispetto a quello che aveva immaginato all'inizio.

Per questo spiego:

> *«Inevitabilmente dobbiamo mettere in conto che il trattamento possa allungarsi molto. Se i tuoi denti hanno davvero bisogno di due o tre volte più tempo per seguire ogni allineatore, non possiamo aspettarci di mantenere la durata che avevamo inizialmente previsto. Prima dobbiamo capire qual è il ritmo al quale*

i tuoi denti riescono realmente a seguire gli allineatori e poi potremo fare una previsione più attendibile.»

Non ho bisogno di dire al paziente che una terapia di diciotto mesi durerà sicuramente quattro anni e mezzo, perché non posso saperlo e non sarebbe corretto trasformare una possibile conseguenza in una previsione certa. Posso però fargli capire che, **se il ritmo rimanesse realmente quello di un allineatore ogni tre settimane anziché ogni sette giorni, il tempo necessario potrebbe diventare anche tre volte maggiore**.

Ed è proprio questa differenza tra una conseguenza generica e una conseguenza concreta a rendere la leva del Tempo così efficace. Dire *«se non li porti il trattamento durerà di più»* è qualcosa che il paziente probabilmente ha già sentito e che può rimanere completamente astratto. Passare da sette a ventuno giorni significa invece tradurre quella stessa conseguenza in qualcosa che può vedere, misurare e mettere in relazione con il proprio obiettivo.

Una strategia che funziona in entrambi gli scenari

La caratteristica che più mi interessa di questo approccio è che non ho bisogno di sapere con assoluta certezza quale delle due spiegazioni sia quella corretta.

Se il paziente utilizza realmente gli allineatori ventidue ore al giorno e presenta una risposta biologica particolarmente lenta, rallentare il cambio e rivalutare il fitting rappresenta una scelta prudente e coerente con quello che sto osservando clinicamente.

Se invece, come probabilmente accade nella maggior parte delle situazioni nelle quali utilizzo questa strategia, il paziente utilizza gli allineatori molte meno ore di quelle che dichiara, non l'ho accusato di mentire e non l'ho costretto a difendersi. Gli ho semplicemente mostrato una conseguenza del comportamento attuale che per lui è immediatamente rilevante.

Molto spesso è proprio questo che porta alla revisione spontanea del suo racconto. Il paziente non ha bisogno di passare bruscamente da *«li utilizzo sempre»* a *«ti stavo mentendo»*. Può semplicemente fermarsi, ripensare alla propria settimana e riconoscere che forse quel *sempre* non significava davvero ventidue ore ogni giorno. Se a quel punto decide di impegnarsi maggiormente, posso mantenere il cambio settimanale e verificare se alle parole seguirà effettivamente un comportamento diverso.

Se invece continua a sostenere che le ore di utilizzo sono già corrette, non ho motivo di discutere: accetto quella spiegazione, rallento il cambio e verifico la risposta.

In entrambi i casi ho ottenuto ciò che mi interessava davvero: **una decisione concreta su quello che succederà da quel momento in avanti.**

La confessione non muove i denti

Credo che questo sia stato uno dei cambiamenti più importanti nel mio modo di comunicare con i pazienti poco collaboranti. Per molto tempo ho pensato che il mio compito fosse riuscire a far capire al paziente che non stava facendo ciò che gli avevo chiesto, quasi come se l'ammissione dell'errore rappresentasse una condizione necessaria per poter ripartire correttamente. Con il tempo, però, ho capito che ottenere quell'ammissione non era affatto ciò di cui avevo bisogno.

Paradossalmente, oggi quella sorta di confessione arriva più frequentemente proprio perché ho smesso di cercarla. Quando il paziente non si sente messo sotto accusa e comprende invece la conseguenza concreta di ciò che stiamo osservando, può permettersi di riconsiderare il proprio comportamento senza vivere quel cambiamento di versione come una sconfitta.

Se mi dice «*In effetti nel weekend li ho utilizzati meno, però da oggi mi impegno davvero*», quella informazione mi è certamente utile, perché mi consente di mantenere il cambio settimanale e verificare se una migliore collaborazione sia sufficiente a recuperare il fitting. Ma non è la confessione ad avere valore terapeutico: è ciò che il paziente farà dopo.

Se dopo dieci minuti di discussione riuscissi invece a costringerlo ad ammettere «*Hai ragione, in realtà li portavo dodici ore al giorno*», avrei forse la soddisfazione di sapere che avevo interpretato correttamente il fitting, ma dal punto di vista clinico non avrei ancora ottenuto ciò che mi interessa davvero. **La confessione non muove i denti, mentre un cambiamento di comportamento sì.**

La strategia dello *slow mover* permette al paziente di modificare il proprio comportamento senza costringerlo ad ammettere che ciò che mi aveva raccontato fino a pochi minuti prima non fosse completamente vero. Gli offre la possibilità di salvare la faccia, ma contemporaneamente gli rende molto più difficile ignorare la conseguenza di continuare nello stesso modo.

Se mettiamo una persona nella condizione di dover scegliere tra ammettere di non avere seguito le nostre indicazioni e continuare a difendere la propria versione, può scegliere la seconda possibilità anche quando questo non la aiuta affatto

a raggiungere il risultato che desidera. Se invece eliminiamo quella discussione e spostiamo l'attenzione sulle conseguenze cliniche e sulle possibili soluzioni, le permettiamo di cambiare comportamento senza dover prima riconoscere apertamente di avere sbagliato.

Per questo, quando l'evidenza clinica e il racconto del paziente non coincidono, oggi cerco molto meno di stabilire chi abbia ragione e molto di più di trovare una strategia che possa funzionare indipendentemente dalla spiegazione. **Non abbiamo bisogno di dimostrare al paziente che abbiamo ragione; abbiamo bisogno di creare le condizioni perché possa iniziare a fare la cosa giusta.**

SCRIPT OPERATIVO

Quando osservo una perdita generalizzata di fitting, dopo avere ricostruito insieme al paziente le sue abitudini e avere ricevuto la conferma che gli allineatori vengono utilizzati correttamente, la conversazione può essere impostata in questo modo:

> *«Vedo che diversi denti non stanno seguendo gli allineatori alla velocità che avevamo previsto. Abbiamo cercato di capire insieme come li stai utilizzando e tu mi confermi che li porti correttamente, quindi dobbiamo prendere in considerazione un'altra possibilità. Non in tutte le persone i denti si muovono alla stessa velocità e ci sono pazienti nei quali la risposta biologica al movimento ortodontico è più lenta. In letteratura vengono utilizzati anche i termini fast movers e slow movers e, se tu stai realmente utilizzando gli allineatori come mi dici, è possibile che tu appartenga a questo secondo gruppo.*
>
> *Se i tuoi denti si muovono più lentamente, una settimana potrebbe non essere sufficiente perché riescano a seguire completamente la posizione prevista da ogni allineatore. Se continuassimo a cambiarli ogni sette giorni, questo piccolo ritardo potrebbe aumentare progressivamente e il fitting peggiorerebbe sempre di più. Per questo, se le ore di utilizzo sono davvero quelle che mi hai indicato, dobbiamo dare ai denti più tempo e passare, almeno inizialmente, da una settimana a tre settimane per ogni allineatore.*
>
> *Questo significa che il ritmo del trattamento diventerebbe tre volte più lento. Non posso dirti oggi che l'intera terapia durerà tre volte tanto, perché dobbiamo prima vedere come rispondono i denti e potremo eventualmente accelerare di nuovo, ma se dovessimo mantenere questo ritmo per tutto il trattamento anche la durata complessiva potrebbe aumentare in maniera molto importante. Adesso dobbiamo*

> *quindi capire qual è il ritmo con cui i tuoi denti riescono realmente a seguire gli allineatori.»*

A questo punto lascio spazio al paziente. Se mi dice:

> *«Doc, in effetti forse non sono sempre ventidue ore. Se mi impegno davvero, possiamo provare a mantenere il cambio settimanale?»*

la mia risposta può essere altrettanto semplice:

> *«Certo. Se pensi che ci siano state delle ore che possiamo recuperare, preferisco darti questa possibilità. Continuiamo con il cambio settimanale, ma da oggi dobbiamo essere molto precisi. Al prossimo controllo sarà il fitting a dirci se questa modifica è stata sufficiente.»*

Se invece continua a confermarmi che le ore di utilizzo sono già corrette, non insisto e non cerco di fargli cambiare versione: applico il rallentamento che gli ho spiegato e verifico successivamente la risposta.

Perché questo protocollo funziona

- **Riduzione della reattanza**

Contraddire direttamente il paziente e dirgli che non sta utilizzando gli allineatori come sostiene può spingerlo a difendere ancora di più la propria posizione. Accettare inizialmente la sua versione e proporre una spiegazione alternativa evita lo scontro e mantiene la conversazione concentrata sulla soluzione del problema.

- **Salvare la faccia**

La strategia dello *slow mover* permette al paziente che ha utilizzato poco gli allineatori di modificare il proprio comportamento senza essere costretto ad ammettere di avere mentito. Può semplicemente riconsiderare il significato del suo *«sempre»* e riconoscere che alcune ore sono state perse. In questo modo il cambiamento di comportamento non richiede prima una sconfitta personale.

- **Salienza della conseguenza**

Dire *«devi utilizzarli di più»* indica ciò che dovrebbe fare, ma non rende necessariamente evidente perché dovrebbe farlo. Passare da sette a ventuno giorni traduce invece la conseguenza in qualcosa di immediatamente comprensibile.

Leva del Tempo

Nelle prime fasi del trattamento l'Investimento è stato appena sostenuto e il Risultato finale può essere ancora lontano, mentre il Tempo rappresenta una conseguenza vicina e facilmente comprensibile. La prospettiva di procedere a un ritmo tre volte più lento può cambiare rapidamente il valore attribuito a quelle ore nelle quali gli allineatori vengono lasciati fuori.

Feedback

Il protocollo non termina con la conversazione. Se il paziente decide di mantenere il cambio settimanale impegnandosi maggiormente, il fitting al controllo successivo diventa il feedback che ci permette di verificare se il cambiamento di comportamento sia stato sufficiente. Se invece rallentiamo il cambio e il fitting continua a non migliorare, dobbiamo essere disponibili a riconsiderare anche la nostra ipotesi clinica.

BIBLIOGRAFIA

Giannopoulou C, Dudic A, Pandis N, Kiliaridis S. Slow and fast orthodontic tooth movement: an experimental study on humans. *European Journal of Orthodontics.* 2016;38(4):404–408.

Bertl K, Neuner H, Meran A, et al. Does the time-point of orthodontic space closure initiation after tooth extraction affect the incidence of gingival cleft development? A randomized controlled clinical trial. *Journal of Periodontology.* 2020;91(5):572–581.

Küchler EC, Schröder A, Corso P, et al. Genetic polymorphisms influence gene expression of human periodontal ligament fibroblasts in the early phases of orthodontic tooth movement. *Odontology.* 2020;108:493–502.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Leva principale: tempo e controllo.

Con un paziente dominante eviterei il confronto diretto, perché mettere in discussione apertamente ciò che ci sta raccontando rischia di trasformare rapidamente il colloquio in una sfida. È più efficace presentare le due possibilità in maniera chiara, lasciando che sia il comportamento successivo a determinare quale strada potremo seguire.

> *«Se le ore sono già quelle corrette, dobbiamo rallentare perché i tuoi denti hanno bisogno di più tempo. Se invece pensi che ci sia margine per essere più preciso, possiamo mantenere il cambio settimanale e verificare subito se recuperiamo il fitting. Al prossimo controllo avremo la risposta.»*

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

I

Influente

Leva principale: risultato e motivazione.

Con un paziente influente eviterei una spiegazione troppo lunga o tecnica, concentrandomi maggiormente sulla possibilità di recuperare rapidamente la situazione e mantenere il ritmo iniziale se riesce a modificare concretamente il comportamento.

> *«Possiamo ancora provare a mantenere il cambio settimanale. Se sai che in alcune giornate li hai utilizzati meno, da oggi recuperiamo quelle ore e vediamo come reagiscono i denti. Se al prossimo controllo il fitting è tornato quello che vogliamo, continuiamo così.»*

S

Stabile

Leva principale: rassicurazione e percorso.

Con un paziente stabile è importante evitare che la situazione venga interpretata come il segnale che il trattamento stia fallendo. Spiegherei quindi che abbiamo due possibili strade e che entrambe possono essere controllate nel tempo.

> *«Non significa che il trattamento non stia funzionando. Dobbiamo soltanto capire se i denti hanno bisogno di più tempo oppure se possiamo recuperare qualche ora di utilizzo. Se pensi di poter essere più preciso, continuiamo per ora con il cambio settimanale e al prossimo controllo vediamo insieme come stanno rispondendo.»*

C

Coscienzioso

Leva principale: dati e spiegazione.

Con un paziente coscienzioso utilizzerei maggiormente ciò che possiamo osservare clinicamente, mostrando il fitting e spiegando con precisione le due ipotesi e il modo in cui il controllo successivo ci permetterà di distinguerle.

> *«Clinicamente vediamo che i denti sono rimasti indietro rispetto alla posizione prevista. Se le ore di utilizzo sono già corrette, dobbiamo considerare una risposta biologica più lenta e aumentare il tempo di ogni allineatore. Se invece pensi che ci siano state delle ore di utilizzo mancanti, possiamo mantenere per ora il cambio settimanale, correggere quel dato e verificare al prossimo controllo se la discrepanza si riduce.»*

CAPITOLO 6

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Al primo controllo della sequenza, normalmente dopo circa due mesi, quando compare una perdita progressiva e generalizzata di fitting. Valutare anche programmazione e risposta biologica prima di attribuirla alla collaborazione.
OBIETTIVO	Recuperare il fitting modificando il comportamento o l'intervallo di cambio e verificando la risposta.
COSA FARE	1. Ricostruire la giornata: pasti, lavoro, serate, weekend e tempo trascorso prima di reinserire gli allineatori. 2. Se il paziente conferma un utilizzo corretto, considerare anche una risposta biologica più lenta. 3. Prospettare il passaggio da sette a ventuno giorni, spiegando che rallenterebbe significativamente il trattamento. Ventuno giorni è una scelta del protocollo descritto, non una prescrizione universale. 4. Se riconosce un utilizzo insufficiente, concordare le ore prescritte e mantenere il cambio settimanale quando le condizioni cliniche lo consentono. 5. Se conferma un utilizzo corretto, rallentare il cambio e rivalutare il fitting, decidendo successivamente se mantenere il ritmo o accelerare. 6. Se il fitting non migliora, riconsiderare anche l'ipotesi clinica iniziale.
COSA VERIFICARE	Distribuzione della perdita di fitting, ore e routine di utilizzo, intervallo di cambio e risposta al controllo successivo. Una promessa di maggiore impegno deve essere seguita da un cambiamento verificabile.

CAPITOLO

7

Il paziente che usa gli allineatori, ma non gli elastici

«Una catena è forte quanto il suo anello più debole.»

— PROVERBIO INGLESE

Quando iniziai a utilizzare gli elastici intermascellari insieme agli allineatori, ormai molti anni fa, erano ancora relativamente pochi i clinici che li integravano sistematicamente nelle proprie meccaniche, soprattutto per la correzione delle seconde classi attraverso distalizzazione o altre **meccaniche sagittali**. Per me rappresentavano una componente fondamentale del trattamento e, come spesso mi è accaduto ogni volta che introducevo qualcosa di nuovo nel mio modo di lavorare, osservavo con estrema attenzione ogni caso cercando di capire quali meccaniche funzionassero meglio e quali movimenti fossero più predicibili.

Alcuni trattamenti procedevano esattamente come avevo previsto, mentre altri sembravano comportarsi in maniera completamente diversa. Iniziavo una distalizzazione, aspettavo qualche mese e al controllo mi trovavo davanti una situazione apparentemente contraddittoria: gli allineatori seguivano perfettamente i denti, il fitting era ottimo, l'affollamento si stava risolvendo, le rotazioni miglioravano e tutto ciò che dipendeva direttamente dall'azione degli allineatori sembrava procedere nella direzione corretta. **La seconda classe, invece, non migliorava.**

Con il passare del tempo iniziai a riconoscere uno schema che si ripeteva con una certa regolarità: **un paziente poteva utilizzare correttamente gli allineatori e, contemporaneamente, essere molto meno costante con gli elastici.** Mi resi conto così che avevo commesso un errore concettuale molto semplice: tendevo a considerare la collaborazione come una caratteristica generale del paziente, mentre utilizzare correttamente gli allineatori e utilizzare correttamente gli elastici sono due comportamenti completamente differenti. Oggi questa distinzione mi sembra quasi ovvia, ma per molti anni non lo è stata affatto.

Quando gli allineatori funzionano e gli elastici no

Nella mia pratica utilizzo gli elastici intermascellari principalmente per la correzione sagittale e per quella trasversale. Nei crossbite possono essere molto utili, anche se generalmente li introduco in una fase più avanzata del trattamento e, per questo motivo, il problema della collaborazione assume caratteristiche un po' diverse. La situazione nella quale il loro utilizzo diventa particolarmente importante, e nella quale ho imparato maggiormente a osservare il comportamento del paziente, è invece la correzione sagittale.

Quando eseguo una distalizzazione, gli elastici vengono prescritti fin dall'inizio e mi aspetto che la correzione sagittale proceda parallelamente ai movimenti programmati dagli allineatori. Se dopo alcuni mesi vedo che gli spazi tra i denti posteriori si stanno creando e che gli allineatori continuano ad avere un buon fitting, ma la seconda classe molare non migliora e cominciano contemporaneamente a comparire effetti anteriori che non desideravo, il sospetto che gli elastici non vengano utilizzati con sufficiente continuità diventa molto forte. È sostanzialmente ciò che avevamo visto accadere nel caso di Laura raccontato nella prima parte del libro.

Quando utilizzo invece una meccanica interarcata, introduco gli elastici dopo avere allineato, livellato e coordinato trasversalmente le arcate. Anche in questo caso il segnale è abbastanza evidente, perché gli allineatori continuano a fittare

bene e tutto procede come previsto, ma la correzione sagittale non si evidenzia come mi sarei aspettato.

È quindi una situazione molto diversa rispetto al paziente che non utilizza correttamente gli allineatori. Nel capitolo precedente la perdita generalizzata di fitting rappresentava uno dei principali campanelli d'allarme; qui, invece, il fitting può essere perfetto e il paziente può guardarsi allo specchio ogni giorno vedendo i propri denti diventare progressivamente più dritti, convincendosi che il trattamento stia funzionando esattamente come dovrebbe. Ed è proprio questo, paradossalmente, uno dei motivi per cui può essere così difficile fargli comprendere l'importanza degli elastici.

Gli allineatori infatti, una volta inseriti, possono rimanere in bocca per molte ore senza richiedere ulteriori decisioni. Il paziente li toglie per mangiare, generalmente li ha davanti a sé e, terminato il pasto, deve semplicemente ricordarsi di rimetterli.

Gli elastici richiedono invece una serie di piccoli comportamenti aggiuntivi che devono ripetersi più volte durante la giornata. Devono essere tolti e sostituiti con regolarità, bisogna ricordarsi di avere sempre una confezione disponibile e, soprattutto all'inizio, inserirli può risultare meno semplice e più fastidioso. Ogni pasto, ogni uscita, il lavoro, la scuola, lo sport o un viaggio possono quindi diventare momenti nei quali quella routine si interrompe.

La letteratura specifica sugli elastici conferma quanto questi piccoli ostacoli possano essere importanti. Veeroo e collaboratori hanno intervistato pazienti ai quali era stato prescritto un utilizzo full-time degli elastici intraorali e hanno identificato, tra le principali barriere alla collaborazione, la dimenticanza, i pasti, il dolore o il discomfort, le situazioni sociali, lo sport, la perdita o la rottura degli elastici e la scarsa percezione del beneficio ottenuto.

Non basta sapere se un paziente è collaborante. Dobbiamo capire con quale parte della terapia sta collaborando e, soprattutto, dove si interrompe il comportamento che gli abbiamo prescritto.

Il primo modo per scoprirlo è evitare la domanda apparentemente più naturale, che probabilmente è anche quella che ci fornisce meno informazioni. Se chiedo «*Gli elastici li stai utilizzando?*», la risposta è quasi sempre prevedibile: «*Sì, dottore. Sempre.*»

Se però provo a ricostruire una giornata normale, quel *sempre* spesso diventa meno assoluto. Comincio allora a chiedere: «*Quando fai colazione li togli? E appena hai finito cosa fai? Dopo pranzo li rimetti immediatamente? Li utilizzi anche al lavoro o a scuola? Quando esci la sera? Nel weekend? Hai sempre una bustina con te?*»

A quel punto può emergere che «*sempre*» significa in realtà durante la notte e buona parte della giornata, ma non quando il paziente è al lavoro, oppure durante la settimana ma molto meno nel weekend, oppure ancora che dopo pranzo trascorrono alcune ore prima che si ricordi di rimetterli. Questo non significa necessariamente che prima mi stesse mentendo deliberatamente. Come abbiamo già visto nella prima parte del libro, la rappresentazione che abbiamo del nostro comportamento può essere diversa da ciò che realmente facciamo durante la giornata e sappiamo che il tempo di utilizzo riferito dai pazienti tende a essere superiore a quello misurato oggettivamente. Per questo non mi interessa chiedere dieci volte «*Sei sicuro di utilizzarli?*». Non devo capire soltanto se li utilizza, ma **quando li utilizza, quando li toglie e soprattutto quando non li rimette**.

Ci sono poi alcuni piccoli segnali che negli anni ho imparato a osservare e che possono aiutarmi a ricostruire meglio il comportamento reale del paziente. Una frase che ho sentito talmente tante volte da essere diventata quasi un piccolo classico è quella del paziente che arriva al controllo senza elastici e, quando gli chiedo come mai quel giorno non li abbia messi, mi risponde: «*Non li ho messi perché tanto dovevo venire qui.*» A quel punto rispondo semplicemente: «*E cosa c'entra? Se devi utilizzarli sempre, devi averli anche quando vieni da me.*»

Non è quell'ora trascorsa senza elastici prima del controllo a preoccuparmi particolarmente, quanto il ragionamento che sta dietro a quella decisione. Se il paziente considera del tutto naturale sospenderli proprio il giorno in cui viene dall'ortodontista, probabilmente non ha ancora interiorizzato il concetto fondamentale della prescrizione. Gli elastici non sono qualcosa che si utilizza quando ci si ricorda o quando non crea troppo disturbo: se vengono prescritti con utilizzo continuativo, devono diventare parte della terapia esattamente come gli allineatori.

Un altro piccolo indicatore che nella pratica trovo estremamente utile è osservare **come** il paziente mette gli elastici. Quando ho qualche dubbio glieli porgo e gli dico semplicemente «*Fammi vedere come li metti*». Un paziente che utilizza realmente gli elastici da settimane o da mesi tende ad avere automatizzato quel gesto, conosce gli agganci, sa come posizionare le dita e generalmente riesce a inserirli rapidamente, spesso senza neppure utilizzare uno specchio. Quando invece una persona che dovrebbe utilizzarli da mesi mi chiede lo specchio, cerca a lungo gli agganci, ha bisogno dello strumento oppure impiega diversi minuti per riuscire a inserirli, per me si accende un'altra piccola spia.

Lo stesso principio vale per un altro indicatore comportamentale che utilizzo da molti anni: **quanti elastici vengono effettivamente consumati**. Quando li prescrivo consegno normalmente due confezioni, quindi circa duecento elastici, e chiedo al

paziente di sostituirli almeno tre volte al giorno. Non gli dico che quella quantità non sarà sufficiente per arrivare al controllo successivo, che generalmente programmo dopo tre o quattro mesi, perché voglio osservare spontaneamente che cosa succederà.

Se il paziente segue realmente la prescrizione, quella quantità dovrebbe terminare molto prima dell'appuntamento e dovrà quindi contattare lo studio dicendo qualcosa come «*Dottore, sto finendo gli elastici. Posso passare a prenderne altri?*». Quella telefonata non mi permette naturalmente di sapere quante ore al giorno li abbia utilizzati, ma rappresenta un comportamento coerente con ciò che gli avevo prescritto e, soprattutto, avviene spontaneamente, senza che io gli abbia anticipato che mi sarei aspettato quella richiesta.

La situazione opposta è ancora più interessante. Dopo tre o quattro mesi il paziente torna al controllo, gli chiedo come sia messo con gli elastici e magari mi risponde: «*Benissimo, dottore. Ne ho ancora una bustina quasi piena.*» A quel punto non ho bisogno di iniziare una discussione su quante ore li abbia realmente utilizzati. Se gli avevo consegnato circa duecento elastici e gli avevo chiesto di sostituirli almeno tre volte al giorno, quella quantità semplicemente non è compatibile con diversi mesi di utilizzo secondo la prescrizione.

È interessante che anche Veeroo e collaboratori abbiano utilizzato il numero degli elastici consumati come indicatore di compliance, chiedendo ai partecipanti di conservare e restituire quelli utilizzati. La mia non nasce come una misurazione scientifica della collaborazione, ma il principio è simile: **qualche volta ciò che il paziente consuma racconta il suo comportamento meglio di ciò che il paziente ricorda di aver fatto.**

Naturalmente nessuno di questi elementi, preso singolarmente, dimostra che il paziente non stia collaborando. La difficoltà nell'inserire gli elastici può dipendere dalle capacità manuali, dalla vista, dall'età o dalla complessità dello schema; il numero di elastici rimasti può essere influenzato dal fatto che il paziente ne abbia persi, ricevuti altri o utilizzato una confezione diversa. Quello che mi interessa è la **convergenza degli indizi**: una correzione sagittale che non procede come previsto, un racconto poco coerente della giornata, una scarsa familiarità nell'inserimento degli elastici e un consumo incompatibile con la prescrizione. **Quando più elementi iniziano a raccontare la stessa storia, il quadro diventa molto più significativo.**

Gli elastici funzionano se vengono utilizzati come prescritti

Una volta capito **dove** la collaborazione tende a interrompersi, c'è un secondo passaggio che considero altrettanto importante: assicurarmi che il paziente abbia realmente compreso che cosa significhi la prescrizione che gli ho dato. Se prescrivo gli elastici per tutta la giornata, il paziente non può trasformare autonomamente quella prescrizione in un utilizzo esclusivamente notturno o limitato ai momenti nei quali è più comodo utilizzarli. Metterli soltanto di notte non significa eseguire la stessa terapia un po' meno bene, ma significa **eseguire una prescrizione differente da quella che ho programmato**.

Per rendere intuitivo questo concetto utilizzo da anni un esempio molto semplice: «*Immagina di essere con una macchina in salita senza freni. Quando metti gli elastici è come se stessi accelerando: la macchina sale, sale, sale e noi progressivamente otteniamo la correzione che vogliamo. Nel momento in cui togli gli elastici, però, non è che la macchina rimane ferma nel punto in cui sei arrivato: comincia a tornare indietro e perdi una parte di quello che avevi guadagnato. Per questo basta anche un solo giorno senza elastici per perdere quello che abbiamo ottenuto nei tre o quattro giorni precedenti. Ma non dobbiamo ragionare soltanto in termini di giorni interi, perché lo stesso problema può verificarsi ogni giorno per diverse ore. Pensa, per esempio, a quello che succede se li utilizzi bene dal pomeriggio, durante la sera e per tutta la notte, ma poi al mattino vai a scuola e non li metti più fino alle cinque del pomeriggio. Oppure li metti al mattino, li togli durante l'intervallo per mangiare qualcosa e poi, perché non hai con te una bustina nuova, rimani senza elastici per tutto il resto della giornata. In quelle ore non stiamo semplicemente mettendo in pausa il trattamento: rischiamo di perdere una parte dell'effetto che avevamo ottenuto nelle ore precedenti. Lo stesso vale per il weekend. Se dal lunedì al venerdì li utilizzi bene, ma sabato e domenica esci, fai sport, vedi gli amici e decidi di non metterli, rischiamo di perdere in quei due giorni gran parte di quello che avevamo guadagnato durante la settimana. Il problema, quindi, non è soltanto quante ore di elastici riesci a sommare alla fine della giornata, ma quanto riusciamo a mantenere continua la loro azione. È questo il motivo per cui insisto così tanto: non voglio che gli elastici vengano utilizzati soltanto quando è comodo, perché devono accompagnare con continuità la correzione che stiamo cercando di ottenere.*»

Il rapporto numerico che utilizzo con il paziente — un giorno senza elastici può far perdere quanto ottenuto nei tre o quattro giorni precedenti — **non deriva da una quantificazione sperimentale e non deve essere interpretato come tale**. Non esistono dati che permettano di stabilire con questa precisione quanta correzione venga persa dopo un giorno o dopo un determinato numero di ore senza elastici.

Eppure utilizzo deliberatamente questa frase da anni perché rende intuitivo il concetto di continuità della forza e, soprattutto, perché **voglio che la possibilità di interrompere gli elastici preoccupi il paziente**.

È, in un certo senso, un'altra delle **bugie bianche** di cui abbiamo parlato nella prima parte del libro: non invento un rischio che non esiste, perché un utilizzo intermittente degli elastici può realmente compromettere la continuità della meccanica che ho programmato, ma trasformo volutamente quel rischio in un messaggio più semplice, netto e memorabile di quanto la letteratura mi permetterebbe di quantificare. **Lo faccio con un obiettivo preciso: aumentare la probabilità che il paziente rispetti la prescrizione.** Dire che una giornata senza elastici può costargli diversi giorni di correzione rende molto più concreta la conseguenza del suo comportamento rispetto a una generica raccomandazione a utilizzarli con maggiore continuità.

Esiste inoltre un altro aspetto da considerare: la forza sviluppata dagli elastici non rimane costante nel tempo. In uno studio *in vivo* su pazienti che utilizzavano elastici di II Classe, Qodcieh e collaboratori hanno osservato una progressiva degradazione della forza, particolarmente evidente già nelle prime ore di utilizzo. **Anche per questo, nella mia pratica chiedo al paziente di sostituire gli elastici almeno tre volte al giorno.**

Prima di motivare, cerco di capire perché non li utilizza

Quando mi rendo conto che il paziente non sta utilizzando gli elastici come prescritto, non penso automaticamente che il problema sia una mancanza di motivazione, ma cerco prima di capire che cosa succede realmente. Esiste infatti una grande differenza tra chi non ne ha compreso l'importanza, chi li utilizza soltanto di notte perché ha deciso autonomamente che otto ore siano sufficienti, chi li trova troppo fastidiosi durante il lavoro e chi, invece, vorrebbe sinceramente utilizzarli ma ogni giorno finisce di pranzare, torna alla propria scrivania e se ne dimentica fino alla sera.

In quest'ultimo caso continuare a spiegare quanto gli elastici siano importanti serve a poco, perché il problema non è convincere maggiormente il paziente, ma **rendere più semplice il comportamento**. Posso quindi suggerirgli di tenere una confezione di elastici sulla scrivania, una in borsa e magari una in macchina o in un altro luogo nel quale passa abitualmente la giornata, oppure posso sfruttare il principio delle **implementation intentions**, già descritto nel Capitolo 5, associando il reinserimento degli elastici a un gesto che avviene sempre e trasformando una

raccomandazione vaga come «*Ricordati di rimetterli*» in una regola molto più concreta: «*Quando finisci di mangiare, lava i denti e rimetti allineatori ed elastici.*»

Anche i reminder digitali possono essere utili quando il problema è semplicemente ricordarsi di ripetere un comportamento. Leone e collaboratori, in uno studio su 42 pazienti di II Classe, hanno inviato al gruppo sperimentale messaggi motivazionali e di promemoria due volte alla settimana per tre mesi, osservando una correzione della II Classe 3,7 volte maggiore rispetto al gruppo di controllo. Più recentemente, Şenocak e Camcı hanno studiato 124 adolescenti, 68 dei quali valutati specificamente per l'utilizzo degli elastici di II Classe, confrontando reminder testuali, video e nessun reminder. **Quando il problema è ricordarsi un comportamento ripetitivo, aumentare la motivazione non è sempre sufficiente; qualche volta dobbiamo costruire meglio la routine.**

Completamente diversa è la situazione del paziente che non dimentica gli elastici, ma **sceglie consapevolmente di non utilizzarli in alcuni momenti della giornata**. Li mette a casa e durante la notte, ma li toglie al lavoro, a scuola o quando esce perché sono visibili, interferiscono con il modo di parlare o lo fanno sentire a disagio. In questo caso reminder e confezioni di ricambio servono a poco, perché il problema non è ricordarsi di rimetterli: il paziente ha deciso che, in determinate situazioni, il costo sociale o il fastidio degli elastici è più importante della prescrizione che gli abbiamo dato.

Ed è proprio qui che cambia anche il nostro intervento. Non basta rendere il comportamento più facile: dobbiamo rendere **più significativa la conseguenza del non seguirlo**. Il problema, infatti, non è soltanto che il trattamento potrebbe durare più a lungo. Se gli elastici vengono utilizzati esclusivamente nelle ore trascorse a casa, la correzione può procedere più lentamente, rimanere incompleta e condizionare anche il risultato finale. A quel punto devo chiarire al paziente che esiste una scelta: rispettare la prescrizione che abbiamo programmato, valutare se esista un'alternativa clinicamente adatta oppure accettare che il percorso possa diventare più lungo, meno prevedibile e con un risultato potenzialmente diverso da quello inizialmente programmato.

Il paziente vede i denti dritti, non vede la II Classe

Quando invece mi accorgo che il problema è soprattutto motivazionale, la leva che utilizzo maggiormente è ancora una volta il **Tempo**. Potremmo pensare che con gli elastici sia più efficace utilizzare il Risultato, perché ciò che rischiamo di perdere è

proprio la correzione sagittale, ma nella pratica c'è un problema molto semplice: **il paziente spesso non vede quello che vediamo noi**.

Noi osserviamo una II Classe, valutiamo il rapporto molare e canino e sappiamo esattamente quanta correzione manca. Il paziente, invece, si guarda allo specchio e vede soprattutto gli incisivi che diventano più dritti, l'affollamento che diminuisce e il sorriso che progressivamente migliora. Dal suo punto di vista il trattamento sta funzionando e diventa quindi difficile comprendere perché continuiamo a insistere tanto su due piccoli elastici.

Per questo gli spiego: «*I denti stanno diventando più dritti e questo lo vedi anche tu, perché quella parte del trattamento dipende soprattutto dagli allineatori. Gli elastici, però, stanno facendo un altro lavoro: servono a correggere il rapporto tra l'arcata superiore e quella inferiore. Se questa parte rimane indietro, rischiamo di arrivare più avanti con i denti perfettamente allineati ma con l'occlusione ancora da correggere. A quel punto dovremo continuare a lavorare proprio su quello che è rimasto indietro e* ***il trattamento durerà più di quanto avevamo previsto***.»

Il **Tempo** rende così concreta una conseguenza che il paziente fatica a percepire guardandosi allo specchio: può non riconoscere una II Classe residua, ma comprende perfettamente cosa significhi **dover continuare il trattamento più a lungo**.

A questo punto arriva spesso una domanda assolutamente comprensibile: «*Ma per quanto tempo dovrò utilizzarli?*» Se sto insistendo sul fatto che gli elastici devono essere utilizzati con continuità e che una collaborazione insufficiente può prolungare il trattamento, è naturale che il paziente voglia sapere fino a quando dovrà continuare.

È qui che, nella mia pratica, il **Dental Monitoring**, di cui parleremo in un capitolo successivo, rappresenta un vantaggio enorme. Spiego al paziente che non deve essere lui a decidere quando ridurre o sospendere gli elastici e che non è necessario aspettare il successivo appuntamento in studio, perché attraverso le scansioni periodiche posso seguire a distanza l'evoluzione della correzione. Gli dico: «*Tu non preoccuparti di capire quando sarà il momento di ridurli o sospenderli. Continua a utilizzarli esattamente come ti ho prescritto perché, anche se ci rivedremo in studio tra tre, quattro o magari sei mesi, io seguirò l'evoluzione attraverso le tue scansioni e, quando vedrò che abbiamo ottenuto la correzione che vogliamo, sarò io a dirti come modificare l'utilizzo. Non devi decidere tu quando gli elastici hanno finito il loro lavoro.*»

Questo passaggio non serve soltanto a rassicurare il paziente, ma anche a **togliere ogni ambiguità alla prescrizione**: fino a quando non riceve una mia indicazione diversa, deve continuare a utilizzare gli elastici esattamente come gli ho prescritto.

In questo modo riduco anche il rischio che inizi autonomamente a diminuire le ore semplicemente perché ritiene di averli utilizzati abbastanza.

Tutti questi elementi mi servono quindi per capire dove si interrompe la collaborazione e scegliere la strategia più adatta per recuperarla. **Come nel protocollo precedente, il mio obiettivo non è ottenere una confessione né dimostrare al paziente che non sta utilizzando gli elastici come sostiene, ma creare le condizioni perché da quel momento il suo comportamento cambi.**

SCRIPT OPERATIVO

Quando gli allineatori stanno lavorando correttamente ma la correzione sagittale non procede come previsto, posso impostare la conversazione in questo modo:

> *«Gli allineatori stanno lavorando bene e infatti i denti stanno diventando progressivamente più dritti. Gli elastici, però, hanno un compito diverso e in questo momento quella parte del trattamento non sta procedendo come mi aspetto. Prima di modificare qualcosa voglio quindi capire insieme a te come li stai utilizzando durante una giornata normale. Non mi interessa soltanto sapere se li metti, ma soprattutto quando rimangono fuori: cosa succede dopo pranzo? Li rimetti immediatamente? Li utilizzi al lavoro o a scuola? Quando esci la sera? Nel weekend?»*
>
> *«Se il problema è che in alcuni momenti semplicemente te ne dimentichi, dobbiamo rendere più facile ricordarteli: tieni una bustina al lavoro o a scuola, una sempre con te e crea una regola fissa. Quando finisci di mangiare, lava i denti e rimetti allineatori ed elastici. Se invece scegli di non utilizzarli in alcune situazioni perché sono visibili, ti danno fastidio o interferiscono con il modo in cui parli, dobbiamo ragionare diversamente, perché utilizzarli soltanto quando è comodo significa seguire una prescrizione diversa da quella che abbiamo programmato.»*
>
> *«I denti stanno diventando più dritti e quindi, guardandoti allo specchio, puoi avere l'impressione che tutto stia procedendo perfettamente. Gli elastici, però, servono a correggere il rapporto tra l'arcata superiore e quella inferiore. Se quella parte rimane indietro, rischiamo di arrivare più avanti con i denti perfettamente allineati ma con l'occlusione ancora da correggere e il trattamento potrebbe durare più di quanto avevamo previsto. Per questo da oggi voglio che gli elastici diventino parte della terapia esattamente quanto gli allineatori.»*

Perché questo protocollo funziona

■ **Ricostruzione del comportamento**
Chiedere semplicemente «*Porti gli elastici?*» favorisce una risposta globale e prevedibile, mentre ricostruire i diversi momenti della giornata permette di identificare le situazioni nelle quali la prescrizione viene realmente interrotta. In questo modo la conversazione smette di riguardare la sincerità del paziente e si concentra sul comportamento che dobbiamo modificare.

■ **Indicatori comportamentali**
L'evoluzione della correzione sagittale, la presenza degli elastici al momento del controllo, la naturalezza con cui il paziente riesce a inserirli e il consumo delle confezioni, considerati insieme, possono fornire informazioni molto più utili di una semplice dichiarazione verbale. Non servono a dimostrare che il paziente stia mentendo, ma ad aiutarci a ricostruire ciò che sta realmente accadendo.

■ **Riduzione dell'attrito**
Se il problema è pratico, aumentare semplicemente la motivazione serve a poco. Tenere gli elastici in più luoghi strategici e avere sempre una confezione disponibile riduce il rischio che il comportamento venga interrotto perché il paziente ha dimenticato la bustina o non ne ha una a disposizione.

■ **Implementation intentions**
Una regola come «*Quando finisci di mangiare, lava i denti e rimetti allineatori ed elastici*» sfrutta il principio delle **implementation intentions**, già descritto nel Capitolo 5, associando il comportamento a un evento concreto che si ripete ogni giorno e rendendo più facile trasformarlo in una routine.

■ **Salienza della conseguenza**
Quando il problema non è dimenticare gli elastici, ma scegliere consapevolmente di non utilizzarli in alcuni momenti, rendere il comportamento più semplice non è sufficiente. Diventa necessario rendere più significativa la conseguenza di quella scelta, trasformando qualcosa che il paziente difficilmente riesce a vedere in qualcosa che per lui abbia un significato concreto.

■ **Leva del Tempo**
Il paziente vede facilmente che gli incisivi stanno diventando più dritti, mentre può non percepire affatto che la correzione sagittale sia rimasta indietro. Per questo il **Tempo** diventa spesso più efficace del Risultato: spiegare che potrebbe arrivare con i denti allineati ma con una parte della terapia ancora da completare rende immediatamente comprensibile perché la collaborazione debba migliorare adesso e non alla fine del trattamento.

BIBLIOGRAFIA

Al-Moghrabi D, Colonio Salazar F, Pandis N, Fleming PS. Compliance with removable orthodontic appliances and adjuncts: a systematic review and meta-analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2017;152(1):17–32.

Leone SMM, de Souza-Constantino AM, Conti ACCF, Capelozza Filho L, Almeida-Pedrin RR. The influence of text messages on the cooperation of Class II patients regarding the use of intermaxillary elastics. *Angle Orthod.* 2019;89(1):111–116.

Qodcieh SMA, Al-Khateeb SN, Jaradat ZW, Abu Alhaija ESJ. Force degradation of orthodontic latex elastics: an in-vivo study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2017;151(3):507–512.

Şenocak I, Camcı H. Effect of various active reminders via mobile phone on cooperation of orthodontic teenage patients regarding oral hygiene and Class II elastics use: a three-month follow-up prospective cohort study. *J Orofac Orthop.* 2025;86(Suppl 1):39–47.

Veeroo HJ, Cunningham SJ, Newton JT, Travess HC. Motivation and compliance with intraoral elastics. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2014;146(1):33–39.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Leva principale: tempo e controllo.

Con un paziente dominante eviterei lunghe discussioni su quante ore abbia realmente utilizzato gli elastici e mostrerei direttamente ciò che non sta accadendo clinicamente, collegandolo alla possibilità di prolungare inutilmente il trattamento.

> *«Gli allineatori stanno facendo il loro lavoro, ma la Classe non si sta correggendo come dovrebbe. Se questa parte rimane indietro, arriveremo con i denti dritti ma con una parte della terapia ancora da completare e perderemo tempo. Da oggi dobbiamo quindi utilizzare gli elastici con la continuità che abbiamo stabilito.»*

I

Influente

Leva principale: semplicità e risultato.

Con un paziente influente cercherei soprattutto di rendere la routine semplice e compatibile con una vita sociale dinamica, utilizzando poche regole concrete piuttosto che lunghe spiegazioni tecniche.

> *«Facciamola semplice: una bustina sempre con te e una al lavoro o a scuola, e una regola fissa. Quando finisci di mangiare, lava i denti e rimetti allineatori ed elastici. Così non devi pensarci ogni volta e facciamo lavorare insieme tutte e due le parti della terapia.»*

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

S

Stabile

Leva principale: routine e rassicurazione.

Con un paziente stabile eviterei che la mancata correzione venga vissuta come un fallimento del trattamento e mi concentrerei sulla costruzione di una routine prevedibile e facilmente ripetibile.

> *«Gli allineatori stanno andando bene e non dobbiamo stravolgere nulla. Dobbiamo semplicemente rendere più regolare l'utilizzo degli elastici. Vediamo insieme in quali momenti tendi a dimenticarli, costruiamo una routine che diventi automatica e poi controlliamo come cambia la correzione.»*

C

Coscienzioso

Leva principale: evidenza clinica e precisione.

Con un paziente coscienzioso mostrerei direttamente la relazione sagittale e distinguerei chiaramente ciò che gli allineatori stanno ottenendo da ciò che dipende maggiormente dagli elastici.

> *«Guarda qui: l'allineamento sta procedendo bene e il fitting è corretto, ma il rapporto sagittale non è cambiato quanto ci aspettavamo. Sono due componenti differenti del trattamento e per questo abbiamo bisogno che la prescrizione degli elastici venga seguita con maggiore continuità. Nelle prossime scansioni controlleremo se la correzione riprende come previsto.»*

CAPITOLO 7

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Quando gli allineatori mantengono un buon fitting e i movimenti procedono, ma la correzione sagittale affidata agli elastici rimane indietro.
OBIETTIVO	Individuare dove si interrompe la prescrizione e ottenere un utilizzo degli elastici più continuo.
COSA FARE	1. Ricostruire l'utilizzo durante pasti, lavoro, scuola, serate e weekend. Chiedere quando vengono tolti e quanto tempo passa prima di reinserirli. 2. Osservare presenza degli elastici, naturalezza nell'inserimento e consumo delle confezioni, interpretandoli insieme al quadro clinico. 3. Distinguere dimenticanze e ostacoli pratici dalla scelta consapevole di non utilizzarli. 4. Se il problema è pratico, collocare le confezioni nei luoghi abituali, associare il reinserimento a una routine e utilizzare reminder quando necessario. 5. Se il problema è motivazionale, spiegare che i denti possono allinearsi mentre la correzione sagittale rimane incompleta, rendendo necessario prolungare il trattamento. 6. Ribadire utilizzo e sostituzione secondo la prescrizione; verificare la risposta ai controlli o alle scansioni successive.
COSA VERIFICARE	Evoluzione della correzione sagittale, continuità di utilizzo, routine e risposta all'intervento concordato. Nessun indicatore indiretto dimostra da solo la mancata collaborazione.

CAPITOLO

8

La rifinitura fisiologica

«Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili.»

— GEORGE BOX

Ogni volta che progetto il primo set di allineatori, alla fine della sequenza aggiungo sempre **quattro allineatori passivi**. Li chiamiamo passivi perché, almeno sulla carta, non contengono nuovi movimenti programmati, ma in realtà ho sempre considerato questa definizione un po' semplicistica. Se i movimenti programmati negli allineatori precedenti non si sono espressi completamente, infatti, anche una mascherina che nel setup è definita passiva può non esserlo del tutto dal punto di vista clinico. Può continuare a mantenere ciò che abbiamo ottenuto e, in alcuni casi, lasciare ancora tempo ai movimenti precedenti per completarsi.

Ma non è questa la ragione principale per cui li inserisco.

La ragione più importante riguarda qualcosa di cui abbiamo parlato molte volte in questo libro: il **comportamento**. Non voglio arrivare alla fine della fase attiva del primo set, fare una nuova scansione e dire al paziente che adesso dovrà utilizzare la stessa mascherina per due o tre settimane mentre aspettiamo la progettazione e la produzione della rifinitura. Per mesi gli ho chiesto di costruire una routine precisa: ogni settimana prende un nuovo allineatore, lo sostituisce al precedente e continua il trattamento. Se improvvisamente interrompo quella routine e gli dico di mantenere la stessa mascherina per settimane, sto modificando proprio l'abitudine che fino a quel momento mi ha aiutato a ottenere la sua collaborazione.

Non è soltanto una mia impressione clinica. La letteratura sulle abitudini mostra come i comportamenti ripetuti tendano progressivamente ad associarsi ai segnali e al contesto nei quali vengono eseguiti. Wood e collaboratori hanno osservato che, quando questi elementi rimangono stabili, un'abitudine ha maggiori probabilità di continuare a guidare il comportamento, mentre una variazione del contesto può interromperne l'espressione automatica. Verplanken e Wood hanno successivamente sviluppato questo concetto mostrando come la discontinuità dei segnali che sostengono un'abitudine possa rappresentare proprio uno dei momenti nei quali il comportamento torna a dipendere maggiormente da processi intenzionali.

Non significa naturalmente che, se per qualche settimana il paziente non cambia l'allineatore, improvvisamente dimentichi tutto ciò che ha fatto nei mesi precedenti. Significa qualcosa di molto più semplice e, per me, clinicamente rilevante: **se una routine funziona, preferisco non interromperla senza motivo.**

Per questo programmo fin dall'inizio quattro allineatori passivi e organizzo il controllo quando il paziente arriva al primo allineatore passivo. In quel momento controllo l'occlusione, verifico quali movimenti si sono espressi correttamente e quali hanno bisogno di essere perfezionati e, se siamo di fronte a quella che considero una normale rifinitura fisiologica, eseguo una nuova scansione. Mentre io progetto la fase successiva e aspettiamo che arrivino i nuovi allineatori, il paziente continua semplicemente la sua routine: passa al secondo passivo, poi al terzo e infine al quarto, continuando a cambiare la mascherina con la stessa frequenza con cui lo ha fatto fino a quel momento.

Può sembrare un dettaglio organizzativo, ma per me non lo è affatto. **Non sto utilizzando i passivi soltanto per mantenere la posizione dei denti: li utilizzo anche per mantenere il comportamento del paziente.**

Ed è proprio durante questo appuntamento, quando il paziente è arrivato al primo passivo e la parte attiva del primo set è terminata, che negli anni mi sono sentito fare moltissime volte la stessa domanda. Il paziente si siede sulla poltrona sapendo

che quello è un controllo importante. Ha cambiato trenta, trentacinque, magari quaranta allineatori, uno dopo l'altro. Guarda i suoi denti e, nella maggior parte dei casi, vede un sorriso migliore, molto diverso da quello con cui aveva iniziato. Io controllo l'occlusione, verifico quali movimenti si sono espressi correttamente e quali invece hanno bisogno di essere perfezionati, poi gli spiego che faremo una nuova scansione. Ed è a quel punto che arriva la domanda:

«Come, non abbiamo finito?»

All'inizio mi sorprendeva. Durante la prima visita avevo spiegato che il trattamento sarebbe durato, per esempio, quindici-diciotto mesi. Era soltanto una previsione, naturalmente: alcuni trattamenti possono durare dodici mesi, altri ventiquattro o più. Ma la durata complessiva era stata discussa e il paziente l'aveva accettata.

Poi erano arrivati gli allineatori. Una lunga sequenza di mascherine, ciascuna con il proprio numero stampato sopra. E da quel momento iniziava quasi inconsapevolmente un nuovo conto alla rovescia: 12 di 40, 18 di 40, 25 di 40, 32 di 40... Ogni settimana il paziente ne completava una e si avvicinava un po' di più a quel numero che aveva davanti agli occhi.

Nel frattempo, i quindici-diciotto mesi di cui avevamo parlato alla prima visita diventavano qualcosa di sempre più lontano. Non perché il paziente avesse necessariamente dimenticato ciò che gli avevo detto, ma perché quella previsione espressa in mesi era stata progressivamente sostituita da qualcosa di molto più concreto, che poteva vedere, toccare e contare ogni settimana. La terapia aveva smesso di essere un periodo di tempo ed era diventata una sequenza con un inizio e, soprattutto, una fine perfettamente visibile.

Quando arrivava verso le ultime mascherine, nella sua testa non stava semplicemente terminando il primo set di allineatori: stava terminando il trattamento. Per questo, quando gli spiegavo che avremmo fatto una nuova scansione per ordinare una rifinitura, la sua sorpresa era del tutto comprensibile. A quel punto avrei potuto limitarmi a ricordargli quello che gli avevo detto mesi prima:

«Ti ricordi? Avevamo parlato di quindici-diciotto mesi.»

Ed effettivamente per un certo periodo l'ho fatto. Poi mi sono reso conto che stavo cercando di correggere alla fine un'aspettativa che avevo lasciato costruire per mesi. Se quella reazione continuava a presentarsi, il problema non era trovare una risposta migliore quando il paziente arrivava alla fine del set, ma evitare che arrivasse a quel momento convinto che l'ultima mascherina coincidesse con la fine del trattamento.

Dovevo quindi intervenire già alla consegna del primo set, quando il paziente iniziava a costruirsi un'idea di quanto sarebbe durato il suo percorso. Avevo bisogno di un modo semplice per fargli capire che quelle mascherine rappresentavano soltanto la prima grande fase. È così che ho iniziato a parlare dell'80%.

L'80%

Ho cominciato quindi a modificare quello che dicevo al momento della consegna. Non volevo più che il paziente identificasse il numero degli allineatori ricevuti con la durata complessiva della terapia e avevo bisogno di un concetto abbastanza facile da ricordare anche molti mesi dopo. Ho deciso quindi di utilizzare un numero, perché negli anni mi sono accorto che i numeri rendono più concreta un'informazione che altrimenti rischia di rimanere vaga e le conferiscono anche una maggiore sensazione di precisione.

Dire «*probabilmente dopo questo primo set dovremo fare ancora qualcosa*» è molto diverso dal dire «*con questo primo set faremo circa l'80% del lavoro*». La seconda frase è più immediata e, soprattutto, più facile da ricordare.

Ho scelto volutamente un numero semplice: l'80%. Non è un dato scientifico né pretende di prevedere matematicamente quanto otterremo con il primo set; è un riferimento comunicativo che utilizzo per trasmettere un concetto molto semplice: **la prima scatola non è tutto il trattamento**. Alla consegna dico sempre:

> *«Queste sono le prime mascherine del trattamento. Con questo primo set faremo la parte più importante del lavoro e il nostro obiettivo è arrivare indicativamente all'80% del risultato. Quando saremo alla fine faremo una nuova scansione, vedremo quali movimenti si sono espressi esattamente come volevamo e utilizzeremo una seconda serie per lavorare sui dettagli e sui movimenti che avranno bisogno di maggiore precisione.»*

Da quando ho iniziato ad anticipare questo concetto, la conversazione alla fine del primo set è diventata molto più semplice. Quando il paziente arriva all'ultima parte della sequenza, la rifinitura non è più una sorpresa: sa fin dall'inizio che il primo set rappresenta la parte più importante del trattamento, ma non necessariamente l'ultima.

Anticipare la rifinitura fin dall'inizio permette anche di chiarire un altro concetto importante: **una rifinitura, di per sé, non significa che il trattamento abbia fallito**. Nessun sistema biologico esegue necessariamente ogni movimento con la stessa precisione con cui lo abbiamo programmato sullo schermo. Alcuni denti seguono perfettamente la sequenza, altri possono avere bisogno di una correzione ulteriore;

alcuni movimenti si esprimono completamente, altri meno. La rifinitura serve proprio a questo: partire da ciò che abbiamo realmente ottenuto e utilizzare una nuova progettazione per completare ciò che manca e perfezionare il risultato.

Il problema è che proprio quando arriviamo a questa fase succede qualcosa che, dal punto di vista della collaborazione, può diventare pericoloso.

Il paradosso della rifinitura

Il paziente guarda i propri denti e, molto spesso, è già contento. Quello che vede è enormemente diverso rispetto alla situazione iniziale: gli incisivi sono allineati, il sorriso è cambiato e magari amici e familiari gli hanno già detto che i denti sono bellissimi. Noi, invece, continuiamo a vedere ciò che manca: una rotazione che non si è espressa completamente, un torque da perfezionare, un movimento verticale da completare, alcuni contatti da rifinire.

È qui che nasce una differenza importante tra ciò che vediamo noi e ciò che vede il paziente. Noi sappiamo che stiamo entrando nella fase in cui dobbiamo essere ancora più precisi; lui può avere la sensazione che ormai sia praticamente tutto fatto.

Ed è proprio qui che spesso cambia anche il comportamento del paziente. Se percepisco che la parte importante del lavoro è già stata completata e che mancano soltanto pochi dettagli, sarò naturalmente portato ad attribuire meno valore a ogni singola ora di utilizzo. Quelle ventidue ore che durante il trattamento sembravano indispensabili iniziano a diventare venti, poi diciotto, magari qualche sera l'allineatore rimane fuori un po' più a lungo perché, in fondo, i denti sono già dritti.

Il problema è che il ragionamento clinico dovrebbe essere quasi opposto. Se alcuni movimenti sono rimasti incompleti dopo il primo set, sono proprio quelli sui quali dobbiamo concentrare la nostra attenzione durante la rifinitura. Non posso chiedere a un movimento che ha già dimostrato di essere meno prevedibile di esprimersi meglio mentre il paziente riduce contemporaneamente le ore durante le quali gli sto applicando la forza necessaria.

È questo il concetto che voglio ribaltare nella sua testa: **la rifinitura non è il momento in cui possiamo collaborare meno perché manca poco; è il momento in cui dobbiamo collaborare di più proprio perché ciò che manca richiede maggiore precisione.** Ed è proprio da questo paradosso che nascono due delle obiezioni che mi sono sentito ripetere più spesso negli anni. La prima arriva quasi sempre quando il paziente vede il nuovo set:

«*Ma allora perché sono ancora così tante?*»

Il paziente ha ricevuto, per esempio, quaranta allineatori nel primo set e ora gli consegniamo una rifinitura da quindici, diciotto o venti. Li guarda e fa un calcolo assolutamente comprensibile:

> *«Ma se con quaranta mascherine abbiamo fatto quasi tutto, perché adesso me ne servono così tante per fare così poco?»*

Anche questa domanda mi ha costretto nel tempo a rendere più precisa la mia spiegazione.

La prima ragione è che nella rifinitura sto lavorando proprio sui movimenti che hanno avuto maggiore difficoltà a esprimersi. Se un movimento non ha seguito il primo setup come mi aspettavo, non avrebbe molto senso riproporlo semplicemente alla stessa velocità. Posso decidere di rallentarlo, distribuirlo su più step e rendere più graduale l'espressione della forza. Di conseguenza, un movimento apparentemente piccolo può occupare un numero di allineatori maggiore di quanto il paziente immagini guardando semplicemente la posizione dei denti.

La seconda ragione è che non sto pensando soltanto ai denti che devono ancora muoversi. Mentre lavoro sui dettagli che mancano, voglio anche mantenere e consolidare tutto quello che ho già ottenuto. Il tempo della rifinitura, quindi, non serve esclusivamente a produrre nuovi movimenti, ma anche a preservare quelli che si sono già espressi correttamente.

C'è poi una terza ragione, molto più semplice e quasi aritmetica, che può alterare parecchio la percezione del numero complessivo di allineatori e che si collega direttamente ai quattro passivi di cui abbiamo parlato all'inizio del capitolo. Se il primo set contiene quaranta allineatori e quattro sono passivi, significa che trentasei sono destinati alla fase attiva: i quattro passivi rappresentano il 10% dell'intera sequenza e il loro peso sul numero totale è quindi relativamente piccolo. In una rifinitura breve, invece, quella proporzione cambia completamente. Se avessi, per esempio, dodici allineatori attivi e aggiungessi quattro passivi, la sequenza diventerebbe di sedici e un quarto delle mascherine consegnate sarebbe costituito dai passivi. Il paziente vede sedici allineatori e pensa che serviranno tutti per spostare quei pochi denti che mancano, mentre una parte della sequenza ha una funzione completamente diversa. Per questo gli spiego anche il numero:

> *«Non farti spaventare dal numero che vedi sulla scatola. Non significa che dovrai utilizzare necessariamente tutte queste mascherine. I movimenti che dobbiamo ancora fare sono pochi, ma li abbiamo rallentati perché sono quelli che richiedono maggiore precisione. In più, alla fine ho aggiunto quattro mascherine passive che non contengono nuovi movimenti programmati e che ci servono soprattutto*

per non interrompere la tua routine mentre prepariamo eventualmente la fase successiva. Quindi il numero che vedi non corrisponde al numero di mascherine attive che ci separano dalla fine del trattamento.»

Questa spiegazione ha anche un secondo vantaggio: toglie al paziente un'altra possibile giustificazione per ridurre la collaborazione. Quindici o venti nuovi allineatori non significano che il trattamento sia improvvisamente tornato indietro; significano che siamo entrati in una fase diversa, nella quale stiamo lavorando più lentamente e con obiettivi più selettivi.

C'è però un'altra interpretazione che può portare esattamente allo stesso risultato. Questa volta non nasce dal numero degli allineatori, ma da ciò che il paziente sente quando li utilizza:

«Dottore, queste mascherine non tirano.»

Oppure:

«Dottore, queste mascherine mi sembrano molto più morbide.»

All'inizio la mia risposta era semplicemente tecnica. Spiegavo al paziente che era normale, perché il nuovo set era stato costruito sulla scansione appena eseguita. La prima mascherina, quindi, partiva da una situazione estremamente vicina a quella reale dei suoi denti e non poteva necessariamente produrre la stessa sensazione che ricordava da altre fasi della terapia.

La spiegazione era corretta, ma a un certo punto mi sono accorto che non risolveva completamente il problema.

Per il paziente la sensazione di pressione era diventata, nel corso dei mesi, una specie di prova fisica del fatto che l'allineatore stesse funzionando. Quando sentiva tirare pensava che la mascherina stesse lavorando; quando non sentiva quasi nulla poteva facilmente arrivare alla conclusione opposta. E se una cosa non sembra lavorare, diventa molto più facile concedersi di utilizzarla meno.

Ho cominciato quindi a essere molto più esplicito anche su questo punto:

«All'inizio queste mascherine potrebbero sembrarti più morbide, ed è normale. Sono state costruite sulla scansione che abbiamo appena fatto, quindi la prima parte della sequenza parte esattamente dalla posizione in cui sei oggi. Ma i movimenti che dobbiamo ottenere sono proprio quelli che nel primo set hanno avuto bisogno di maggiore aiuto. Per questo, in questa fase, le ventidue ore sono ancora più importanti di quanto lo fossero prima.»

Questa spiegazione mi permette di anticipare l'interpretazione sbagliata prima che il paziente possa trasformarla in una ragione per diminuire le ore. Negli anni ho cercato anche una soluzione che non fosse soltanto comunicativa.

Da quando utilizzo una sistematica che mi permette di scegliere tra materiali con caratteristiche differenti, ho iniziato a utilizzare nelle rifiniture quello più rigido. La scelta ha per me anche un razionale biomeccanico, soprattutto quando devo lavorare sul controllo radicolare, ma nel tempo mi sono accorto che produceva un altro effetto interessante: il paziente percepiva maggiormente la presenza dell'allineatore e continuava ad avere la sensazione che quella mascherina avesse ancora un lavoro da fare.

Naturalmente questo non significa che un allineatore che *"tira di più"* sia necessariamente più efficace, né che la sensazione riferita dal paziente possa essere utilizzata come misura della forza ortodontica. Il vantaggio che mi interessa in questo caso è soprattutto comportamentale: la percezione dell'allineatore rafforza nel paziente la sensazione che il trattamento sia ancora attivo e, di conseguenza, la necessità di continuare a utilizzarlo con la stessa attenzione.

È una di quelle osservazioni nate più dalla poltrona che dai libri e che, con il tempo, ho finito per riassumere in una frase molto semplice: se il paziente non sente lavorare gli allineatori, rischia di smettere di considerarli importanti e riduce la collaborazione.

Ed è proprio durante una rifinitura, quando il paziente vede già il risultato e potrebbe essere naturalmente portato a diminuire la propria collaborazione, che non voglio che questo accada.

SCRIPT OPERATIVO

Tutte queste osservazioni, accumulate negli anni, hanno progressivamente modificato il modo in cui consegno una rifinitura. Oggi non aspetto che il paziente mi dica che pensava di aver finito, che le mascherine sono troppe o che non le sente tirare. Se so che sono obiezioni ricorrenti, preferisco affrontarle prima.

La conversazione può suonare più o meno così:

> *«Siamo arrivati esattamente alla fase di cui avevamo parlato all'inizio. Con il primo set abbiamo fatto la parte più grande del lavoro e siamo arrivati più o meno a quell'80% del risultato che volevamo. Adesso dobbiamo lavorare sui dettagli e soprattutto sui movimenti che non si sono espressi con la stessa precisione degli altri.*
>
> *Proprio per questo questa fase non è meno importante della prima. Anzi, alcuni dei movimenti che dobbiamo fare adesso sono quelli che hanno già dimostrato di avere bisogno di maggiore attenzione e li abbiamo rallentati apposta per renderli*

> *più graduali. Per farli esprimere abbiamo ancora bisogno della stessa cosa che ci è servita fino a oggi: una forza costante, e quindi le ventidue ore.*
>
> *Vedrai anche che il numero delle mascherine può sembrarti alto rispetto alle poche cose che dobbiamo ancora sistemare, ma non significa che ci sia ancora da rifare metà del trattamento. Alcuni movimenti sono stati distribuiti su più allineatori proprio perché vogliamo farli più lentamente e, inoltre, alla fine ho aggiunto quattro mascherine passive che ci permettono di non interrompere la tua routine mentre prepariamo eventualmente la fase successiva.*
>
> *All'inizio potresti anche avere la sensazione che queste mascherine tirino meno. È normale, perché sono state costruite sulla scansione dei tuoi denti così come sono oggi. Non interpretarlo però come se avessero meno bisogno di essere utilizzate: i movimenti che stiamo cercando adesso sono proprio quelli sui quali voglio la massima continuità.*
>
> *Abbiamo già fatto la parte più grande del percorso e il risultato si vede. Adesso sarebbe un peccato diminuire l'impegno proprio sui movimenti che ci permettono di trasformare un buon risultato nel risultato che avevamo programmato.»*

Questa conversazione non nasce da una singola teoria della comunicazione. È il risultato di tante piccole obiezioni ascoltate negli anni e della necessità di smettere di rispondere ogni volta quando ormai erano già comparse.

Con il tempo ho imparato che, quando un'obiezione si ripete con sufficiente frequenza, continuare a diventare più bravo nel rispondere non è necessariamente la soluzione migliore. Preferisco fare in modo che quella stessa obiezione abbia meno possibilità di nascere.

Se so che il paziente potrebbe pensare di avere finito, preparo quell'aspettativa già alla consegna del primo set. Se so che potrebbe considerare quindici o venti allineatori troppi, gli spiego da dove deriva quel numero. Se so che potrebbe interpretare una minore sensazione di pressione come una minore necessità di utilizzarli, tolgo quell'ambiguità prima che diventi una giustificazione per cambiare comportamento.

È questo, alla fine, il vero obiettivo del protocollo: **lasciare meno spazio possibile alle interpretazioni che possono giustificare una riduzione della collaborazione e rendere invece evidente quale parte del risultato dipenda ancora dal comportamento del paziente.**

La rifinitura non è un fallimento e non è nemmeno una fase nella quale possiamo finalmente rilassarci. È il momento in cui passiamo dai grandi cambiamenti ai

dettagli e, proprio perché quei dettagli riguardano spesso i movimenti che hanno avuto più difficoltà a esprimersi, la qualità della collaborazione continua a essere determinante.

Il paziente vede che manca poco. Il nostro compito è fargli capire quanto conta quel poco.

Perché questo protocollo funziona

Framing e gestione dell'aspettativa

La rifinitura non viene presentata come *"un altro set perché non abbiamo finito"*, ma come una fase prevista del trattamento nella quale passiamo dai grandi movimenti alla precisione. Il fatto clinico non cambia, ma cambia la cornice attraverso la quale il paziente lo interpreta: non stiamo ricominciando, stiamo completando ciò che avevamo programmato.

Il riferimento indicativo dell'80% rafforza questa costruzione dell'aspettativa. Dire «*probabilmente dopo questo primo set dovremo fare ancora qualcosa*» lascia un'informazione vaga, facile da dimenticare o reinterpretare con il passare dei mesi. Dire invece «*con questo primo set faremo circa l'80% del lavoro*» crea un riferimento concreto e più facile da ricordare. L'80% non viene utilizzato come dato scientifico, ma come ancora comunicativa: quando mesi dopo il paziente si avvicina alla fine del primo set e il numero stampato sulle mascherine gli suggerisce che il trattamento sia terminato, possiamo riportarlo all'aspettativa che avevamo costruito fin dall'inizio.

Prevenzione dell'ambiguità

Le principali obiezioni vengono affrontate prima che compaiano. Il paziente sa già che il primo set potrebbe non coincidere con la fine del trattamento, perché una rifinitura può contenere un numero apparentemente elevato di allineatori e perché le nuove mascherine potrebbero essere percepite diversamente.

Anticipare queste spiegazioni significa lasciare meno spazio alle interpretazioni che potrebbero diventare una giustificazione per ridurre la collaborazione. Se so che un'obiezione compare con sufficiente frequenza, preferisco prevenirla piuttosto che diventare ogni volta più bravo a risponderle.

Goal gradient

La letteratura sul *goal gradient* mostra come la vicinanza a un obiettivo possa aumentare l'impegno necessario per raggiungerlo. Nella mia esperienza clinica, tuttavia, durante una rifinitura può comparire anche un problema diverso: se il paziente

considera il risultato già sufficientemente buono, proprio quando si avvicina alla fine può iniziare a diminuire il proprio impegno.

Il protocollo cerca quindi di evitare che la vicinanza al risultato venga interpretata come una ragione per rilassarsi. Se manca poco, non significa che quel poco conti meno. Al contrario, proprio perché stiamo lavorando sui movimenti che hanno avuto maggiore difficoltà a esprimersi, gli ultimi dettagli richiedono la stessa continuità, se non maggiore attenzione, rispetto alla fase precedente.

■ Commitment e consistency

Durante la rifinitura non chiediamo al paziente di acquisire un nuovo comportamento, ma di continuare quello che ha già mantenuto per mesi. Le ventidue ore rimangono le stesse e vengono presentate come la naturale prosecuzione dell'impegno che gli ha permesso di raggiungere il risultato che vede allo specchio.

Lo stesso principio spiega anche perché inserisco quattro allineatori passivi anziché lasciare il paziente per settimane con lo stesso allineatore. Se una routine funziona, preferisco proteggerla anziché interromperla senza necessità. Al primo passivo eseguo il controllo e la scansione; durante l'attesa il paziente passa al secondo, al terzo e infine al quarto. Il cambio settimanale continua e, dal suo punto di vista, il comportamento rimane sostanzialmente lo stesso.

■ Salienza del Risultato

A questo punto il paziente possiede già gran parte del risultato e proprio ciò che ha ottenuto può diventare la leva principale del protocollo. Il messaggio non si concentra semplicemente sul fatto che manchino ancora alcuni dettagli, ma sul valore di quei dettagli e sulla necessità di portare fino in fondo ciò che è già stato costruito.

Dire semplicemente «*devi continuare a utilizzare gli allineatori ventidue ore*» descrive una regola. Spiegare invece che i movimenti rimasti sono proprio quelli che hanno avuto maggiore difficoltà a esprimersi rende evidente perché quella regola continua ad avere valore. La prospettiva cambia: non stiamo chiedendo al paziente di ricominciare, ma di completare il risultato per il quale ha già investito mesi di trattamento.

La rifinitura, quindi, non deve diventare il momento nel quale il paziente sente che la terapia sta lentamente spegnendosi. Dal punto di vista comunicativo dobbiamo ottenere l'esatto contrario: fargli percepire che siamo entrati nella fase in cui il risultato è vicino, ma proprio per questo ogni dettaglio conta.

Quando invece una rifinitura non sarà fisiologica, ma sarà diventata necessaria perché il paziente non ha collaborato, il problema sarà completamente diverso. In quel caso non dovremo soltanto spiegare una nuova serie di allineatori: dovremo

gestirla senza insegnare al paziente che la mancata collaborazione non ha conseguenze.

Ma quello merita un protocollo a parte.

BIBLIOGRAFIA

Wood W, Tam L, Guerrero Witt M. Changing circumstances, disrupting habits. *Journal of Personality and Social Psychology.* 2005;88(6):918–933. doi:10.1037/0022-3514.88.6.918.

Verplanken B, Wood W. Interventions to Break and Create Consumer Habits. *Journal of Public Policy & Marketing.* 2006;25(1):90–103. doi:10.1509/jppm.25.1.90.

Kivetz R, Urminsky O, Zheng Y. The Goal-Gradient Hypothesis Resurrected: Purchase Acceleration, Illusionary Goal Progress, and Customer Retention. *Journal of Marketing Research.* 2006;43(1):39–58. doi:10.1509/jmkr.43.1.39.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Leva principale: tempo e risultato.

Con un paziente dominante eviterei di dilungarmi sulla fisiologia della rifinitura e punterei soprattutto sul fatto che la parte principale è già stata completata e che mantenere la stessa precisione ci permette di chiudere gli ultimi movimenti senza perdere inutilmente tempo.

> *«La parte principale è fatta. Adesso dobbiamo chiudere correttamente gli ultimi movimenti senza perdere tempo: ventidue ore e arriviamo al risultato programmato.»*

I

Influente

Leva principale: risultato e motivazione.

Con un paziente influente utilizzerei maggiormente ciò che può già vedere allo specchio, trasformando la vicinanza al risultato in una ragione per mantenere alta la collaborazione anziché in una giustificazione per rilassarsi.

> *«Guarda quanto è cambiato il sorriso. Siamo davvero vicini, ma proprio questi ultimi dettagli sono quelli che faranno la differenza. Non molliamo adesso.»*

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

S

Stabile

Leva principale: continuità e rassicurazione.

Con un paziente stabile sottolineerei soprattutto che non gli sto chiedendo di modificare nuovamente le proprie abitudini. La routine che ha funzionato fino a quel momento deve semplicemente continuare mentre cambiano gli obiettivi clinici della fase.

> *«Non devi cambiare nulla della routine che hai seguito fino a oggi. Continuiamo con le stesse ventidue ore e con lo stesso ritmo; cambia soltanto il fatto che adesso stiamo lavorando sui dettagli finali.»*

C

Coscienzioso

Leva principale: precisione e spiegazione clinica.

Con un paziente coscienzioso mostrerei ciò che è stato ottenuto e ciò che deve ancora essere perfezionato, spiegando perché i movimenti residui sono stati riprogrammati in maniera più graduale.

> *«La nuova scansione ci ha permesso di misurare quali movimenti si sono espressi completamente e quali no. Quelli residui sono stati riprogrammati in maniera più graduale, quindi la continuità delle ventidue ore rimane fondamentale.»*

CAPITOLO 8

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Dalla progettazione del primo set, preparando il paziente alla possibile rifinitura; il passaggio operativo avviene al primo allineatore passivo.
OBIETTIVO	Completare i movimenti residui mantenendo le ore di utilizzo e la routine costruite durante la prima sequenza.
COSA FARE	1. Programmare quattro allineatori passivi alla fine della sequenza. 2. Alla consegna, spiegare che il primo set rappresenta la parte principale, ma non necessariamente l'intero trattamento. Il riferimento all'80% è comunicativo, non una misura scientifica. 3. Al primo passivo, controllare occlusione e movimenti ottenuti, eseguire la scansione e programmare la rifinitura quando necessaria. 4. Durante l'attesa, mantenere i cambi passando al secondo, al terzo e al quarto passivo. 5. Spiegare quali movimenti rimangono e perché vengono rallentati nella nuova sequenza. 6. Chiarire che il numero degli allineatori non misura da solo il lavoro residuo e che una minore pressione percepita non giustifica una riduzione delle ore.
COSA VERIFICARE	Occlusione, movimenti ottenuti e residui, aspettative, continuità di utilizzo e fitting della nuova sequenza. Il risultato vicino deve sostenere l'impegno, non diventare il motivo per ridurlo.

CAPITOLO

9

Le conseguenze diseducative della rifinitura

«Le conseguenze di un'azione influenzano la probabilità che essa si ripeta.»

— B. F. SKINNER

Una rifinitura non corregge soltanto i denti; purtroppo può anche insegnare al paziente che collaborare non è indispensabile.

Quando una perdita generalizzata di fitting compare per la prima volta, accetto che possano esistere spiegazioni differenti e cerco di recuperare il comportamento senza pretendere una confessione, come spiegato nel capitolo 6. Ma se il paziente ha già interrotto più sequenze, ricevuto nuove serie e continua a tornare con lo stesso problema, non sto più gestendo soltanto una collaborazione insufficiente.

Sto gestendo anche ciò che ha imparato dalle rifiniture precedenti: che una nuova scansione cancellerà le conseguenze e il trattamento potrà ricominciare alle stesse condizioni. È qui che una possibilità clinicamente utile rischia di diventare diseducativa.

Il caso di Alessandro

Circa dieci anni fa iniziai il trattamento di Alessandro, un ragazzo di tredici anni che presentava l'agenesia dei due incisivi laterali superiori e una malocclusione di seconda classe piena. L'obiettivo del trattamento era correggere la seconda classe e creare gli spazi necessari per sostituire, al momento opportuno, gli elementi mancanti. Si trattava di un piano che richiedeva una collaborazione costante, perché il risultato dipendeva non soltanto dall'utilizzo degli allineatori, ma anche da quello degli elastici.

Alessandro, però, non utilizzava praticamente mai le mascherine. Lo rivedevo ogni quattro mesi e ci trovavamo sempre nella stessa situazione: il fitting era ormai compromesso, i movimenti non si erano espressi e non era possibile proseguire con la serie che gli avevamo consegnato. Ci fermavamo, eseguivamo un'altra scansione e preparavamo un nuovo piano di trattamento, accompagnando ogni ripartenza con la stessa spiegazione e con la sua promessa che, questa volta, avrebbe collaborato seriamente.

Nel corso dei primi due anni di trattamento avevamo già preparato cinque rifiniture, o almeno quelle che allora continuavo a considerare tali. Ogni nuova scansione sembrava offrirci la possibilità di ricominciare, ma in realtà non modificava il comportamento di Alessandro, che aveva progressivamente imparato che, se non avesse utilizzato gli allineatori, sarebbe stato comunque possibile interrompere la serie e produrne un'altra.

Dopo quasi due anni, finalmente, qualcosa cambiò. Alessandro iniziò a utilizzare le mascherine con maggiore regolarità e, nel giro di circa sei mesi, i denti si allinearono in modo evidente. Per la prima volta avevamo ottenuto un risultato clinico importante, anche se rimaneva da completare la correzione della seconda classe perché gli elastici non erano stati utilizzati con la stessa costanza. Decisi quindi di eseguire una rifinitura, spiegandogli che quella nuova serie avrebbe dovuto consolidare ciò che avevamo raggiunto e completare i movimenti ancora necessari.

Quando lo rividi dopo quattro mesi, rimasi sorpreso dalla situazione clinica. I denti non solo non erano rimasti nella posizione raggiunta con la precedente rifinitura, ma erano diventati addirittura più storti. Dopo essere riusciti finalmente ad

allinearli, eravamo tornati indietro praticamente all'inizio perché Alessandro non aveva utilizzato nessuno dei nuovi allineatori.

Mentre osservavamo insieme le fotografie e confrontavamo la scansione con quella precedente, fu suo padre a fare una considerazione che avrebbe modificato per sempre il mio modo di gestire queste situazioni:

> *«Caspita, questa volta i denti sono addirittura più storti di prima. Immagino che adesso ci saranno dei costi, perché l'azienda vedrà che Alessandro non ha collaborato. Non penso che possa continuare a produrre gratuitamente mascherine se il paziente non le utilizza.»*

In quel momento mi si accese una lampadina. Fino ad allora avevo continuato a presentare ogni nuova scansione come una possibilità compresa nel trattamento, senza rendermi conto che proprio questa apparente assenza di limiti aveva contribuito a cancellare le conseguenze della mancata collaborazione. Il padre di Alessandro aveva invece individuato spontaneamente ciò che io non ero ancora riuscito a trasformare in una strategia comunicativa: se una nuova serie non produce un miglioramento significativo, oppure se la situazione risulta addirittura peggiorata, non può continuare a essere considerata una normale rifinitura compresa nel piano di trattamento. Gli risposi:

> *«Infatti è proprio così. L'azienda confronterà questa scansione con la precedente e vedrà che durante l'ultima serie non è stato ottenuto alcun miglioramento significativo. Se dovremo produrre ancora altri allineatori, la nuova fase avrà un costo.»*

Quella risposta nacque spontaneamente durante quella conversazione, ma mi permise di comprendere qualcosa di molto più importante. Fino a quel momento Alessandro aveva ricevuto cinque nuove possibilità, tutte accompagnate da raccomandazioni e promesse, ma nessuna era stata associata a una conseguenza concreta. Per la prima volta, invece, la possibilità di un costo rendeva visibile il fatto che una nuova scansione non avrebbe potuto cancellare ancora una volta ciò che era accaduto nei mesi precedenti.

Non fu quindi una teoria economica a suggerirmi questa strategia, ma l'osservazione spontanea di un padre che, vedendo i denti del figlio peggiorati, considerò del tutto naturale che la mancata collaborazione avesse finalmente una conseguenza.

Quando una seconda possibilità diventa una regola

Alcuni pazienti ammettono di avere collaborato poco e accompagnano ogni nuova richiesta con una spiegazione credibile e una promessa apparentemente sincera. Altri continuano invece a sostenere di avere utilizzato correttamente gli allineatori anche quando il confronto tra le scansioni racconta una storia completamente diversa. Dopo ripetute ripartenze, tuttavia, stabilire quale delle due versioni sia più sincera diventa meno importante che interrompere il meccanismo attraverso il quale entrambe conducono automaticamente allo stesso risultato: un'altra serie di allineatori.

Il paziente sincero può imparare che è sufficiente riconoscere la propria difficoltà e promettere di cambiare, mentre quello meno sincero può comprendere che continuare a negare non produce conseguenze differenti. Il problema, quindi, non consiste soltanto nelle parole utilizzate dal paziente, ma nella risposta che riceve dallo studio. **Se ogni spiegazione, vera o falsa che sia, viene seguita da una nuova scansione e da un'altra ripartenza alle stesse condizioni, siamo noi a rendere progressivamente meno importante la sua collaborazione.**

La prima volta possiamo avere offerto una seconda possibilità; dalla seconda o dalla terza, però, possiamo avere iniziato involontariamente a insegnare una regola: **collaborare è certamente preferibile, ma non è davvero indispensabile, perché sarà sempre possibile ricominciare.**

È qui che il problema diventa interessante anche dal punto di vista comportamentale. Ogni nostra decisione clinica produce una conseguenza e quella conseguenza può influenzare ciò che accadrà successivamente. Quando diciamo «*Non preoccuparti, ripartiamo*», vogliamo rassicurare il paziente e preservare la relazione terapeutica, ma il messaggio che lui può ricevere è diverso: ciò che è accaduto nei mesi precedenti non produce una conseguenza concreta, perché una nuova serie permetterà comunque di ricominciare.

È uno dei principi alla base del **condizionamento operante**: le conseguenze di un comportamento contribuiscono a modificarne la probabilità di ripetizione. Naturalmente non stiamo premiando intenzionalmente la mancata collaborazione, ma possiamo costruire senza rendercene conto un sistema nel quale le sue conseguenze vengono eliminate ogni volta attraverso una nuova scansione. Lo stesso principio generale è alla base degli interventi di *contingency management*, utilizzati in altri contesti sanitari nei quali conseguenze definite in anticipo e collegate a comportamenti verificabili vengono utilizzate per favorire l'aderenza. Questo non dimostra che introdurre un costo migliori automaticamente l'utilizzo degli allinea-

tori, ma sostiene un principio molto più prudente e utile per il nostro protocollo: **le conseguenze funzionano meglio quando sono chiare, anticipate e collegate a qualcosa di verificabile.**

Con i trattamenti che comprendono ulteriori serie senza un nuovo costo di produzione compare anche un secondo problema. Dal punto di vista clinico questa disponibilità rappresenta un enorme vantaggio, ma dal punto di vista del paziente può rendere progressivamente meno evidente la differenza tra completare una serie e doverla ripetere perché non è stata realmente utilizzata. La letteratura sullo *zero-price effect* mostra che ciò che ha prezzo zero non viene semplicemente percepito come qualcosa che costa molto poco, ma viene valutato in modo particolare. Non significa che ciò che è gratuito venga automaticamente considerato privo di valore e, soprattutto, non significa che un paziente utilizzi meno gli allineatori perché sa che le rifiniture sono comprese. Il problema è più sottile: **se ogni ripartenza appare gratuita, automatica e potenzialmente illimitata, diventa meno evidente la conseguenza concreta del non avere completato quella precedente.**

Un concetto utilizzato in economia sanitaria che può aiutarci a comprendere questo meccanismo è quello di *moral hazard*, o azzardo morale. L'esempio classico è quello delle assicurazioni: quando una persona sa di essere protetta dalle conseguenze economiche di un possibile danno, può avere meno incentivo a prevenirlo rispetto a quando sa che quelle conseguenze ricadranno direttamente su di lei. Questo non significa che provochi intenzionalmente il danno o che agisca in malafede: significa semplicemente che la presenza di una protezione può modificare il comportamento. Nel nostro caso il meccanismo può essere simile. Il paziente non decide necessariamente di utilizzare meno gli allineatori perché sa che potrà riceverne altri, ma può imparare progressivamente che la mancata collaborazione non modifica realmente ciò che accade: se una serie non viene utilizzata, ne verrà semplicemente prodotta un'altra. **Il problema, quindi, non è che il paziente approfitti consapevolmente del sistema, ma che il sistema finisca per rendere la mancata collaborazione quasi priva di conseguenze.**

E sarebbe troppo facile attribuire tutta la responsabilità al paziente, perché spesso siamo proprio noi medici a favorire involontariamente questo meccanismo. Programmiamo un appuntamento di dieci minuti per controllare il fitting e ci accorgiamo che il paziente non ha collaborato, che i denti non sono migliorati e che la serie non può essere proseguita. A quel punto dovremmo fermarci, documentare la situazione, mostrare il confronto con la scansione precedente e affrontare una conversazione potenzialmente scomoda, ma per evitarla la soluzione più semplice è fare un'altra scansione. Richiede pochi minuti, chiude apparentemente il problema

e ci permette di rimandare tutto alla nuova serie. **Scansionare è facile; modificare un comportamento lo è molto meno.** E così quella che durante il controllo ci sembra la soluzione più rapida può diventare, nei mesi successivi, quella meno efficiente: il paziente evita di confrontarsi con le conseguenze della propria mancata collaborazione, noi rimandiamo il problema e qualche mese dopo rischiamo di ritrovarci esattamente nella stessa situazione.

Questo non significa che sia sbagliato offrire una seconda possibilità. Un trattamento ortodontico può durare molti mesi e durante questo periodo possono verificarsi problemi personali, familiari o lavorativi che rendono temporaneamente più difficile collaborare. Essere comprensivi significa anche riconoscere queste situazioni e accettare che un singolo periodo difficile non debba necessariamente compromettere l'intero trattamento.

Il problema non è offrire una seconda possibilità. Il problema è offrirla senza far capire che è una seconda possibilità.

Se ci limitiamo a eseguire un'altra scansione e a chiedere una nuova promessa, non esiste nulla che distingua quella ripartenza dalle eventuali ripartenze successive. Possiamo invece accogliere la spiegazione del paziente e, nello stesso momento, introdurre la regola che guiderà da quel momento la prosecuzione del trattamento:

> *«Capisco che tu abbia attraversato un periodo difficile e questa volta possiamo ripartire. Devo però spiegarti che questa nuova scansione è diventata necessaria soprattutto perché gli allineatori non sono stati utilizzati come previsto. Quando terminerai la prossima serie, confronteremo la nuova posizione dei denti con quella di oggi e dovremo osservare un miglioramento significativo, compatibile con una collaborazione adeguata. Se questo miglioramento non ci sarà, non potremo continuare a considerare automaticamente un'altra serie come una normale rifinitura compresa.»*

Questa formulazione non colpevolizza il paziente e non trasforma la rifinitura in una punizione. **Gli concede una nuova possibilità, ma contemporaneamente stabilisce che quella possibilità ha un limite e, soprattutto, definisce in anticipo come verificheremo se è stata utilizzata.**

Dal racconto del paziente a un risultato verificabile

Il caso di Alessandro, e soprattutto le parole di suo padre, mi hanno aiutato a trasformare un'intuizione in una regola molto semplice che da allora ho iniziato a utilizzare in queste situazioni: quando concedo una nuova possibilità, non voglio più valutare soltanto la promessa del paziente, ma il risultato che quella promessa

sarà stata in grado di produrre. Per questo spiego fin dall'inizio che la scansione successiva verrà confrontata con quella di partenza e che quello che cercheremo non sarà la perfezione di ogni singolo movimento, ma un progresso clinicamente significativo e complessivamente compatibile con un utilizzo corretto degli allineatori.

Sappiamo bene, infatti, che anche un paziente perfettamente collaborante può arrivare alla fine di una serie con una rotazione incompleta, un movimento residuo oppure un elemento che ha perso fitting. Allo stesso modo, può accadere che un paziente che prima non utilizzava quasi mai gli allineatori abbia realmente aumentato le ore di utilizzo e percepisca questo cambiamento come una collaborazione ormai adeguata. Quel miglioramento va riconosciuto, ma il riferimento non può essere soltanto quanto il paziente sia migliorato rispetto a prima: deve essere anche quanto il suo comportamento sia diventato adeguato rispetto a ciò che il trattamento richiede. È possibile avere compiuto un grande passo avanti rispetto al proprio punto di partenza e non essere ancora arrivati a una collaborazione sufficiente sul piano clinico.

Da qui nasce una distinzione che per me è diventata fondamentale. Se alla scansione successiva osservo un avanzamento complessivo evidente e rimangono soltanto alcuni movimenti incompleti, sto guardando una normale rifinitura: il paziente ha fatto la sua parte e adesso tocca a me completare il trattamento. Se invece vedo soltanto movimenti marginali, nessun avanzamento sostanziale o addirittura un peggioramento, la situazione è completamente diversa, perché non sto più rifinendo un trattamento eseguito, ma sto cercando di ripetere una fase che il paziente non ha realmente portato avanti. **Il criterio non consiste quindi nel distinguere il movimento perfetto da quello imperfetto, ma una serie realmente utilizzata da una serie che non ha prodotto un risultato compatibile con una collaborazione adeguata.**

Il confronto tra le scansioni, naturalmente, non mi dice quante ore il paziente abbia realmente utilizzato gli allineatori e non pretende di farlo. Mi permette però di spostare la conversazione su un terreno diverso: non devo più discutere se siano state diciotto, venti o ventidue ore, né cercare di stabilire quanto sia sincero il suo racconto, perché posso confrontare la situazione di partenza con quella ottenuta. In altre parole, **smetto di discutere la promessa e comincio a osservare il risultato.**

Una volta stabilito che la nuova scansione dovrà mostrare un miglioramento significativo, dobbiamo chiarire anche cosa accadrà se questo miglioramento non ci sarà. **La possibilità di continuare a considerare ogni nuova serie come una normale rifinitura compresa nel trattamento non può essere illimitata**, e questa

regola può essere collegata alla casa produttrice oppure presentata come una precisa scelta organizzativa dello studio. Nel primo caso riduciamo la possibilità che il paziente interpreti la decisione come una punizione arbitraria del medico: la nuova scansione non viene presentata come una semplice fotografia dalla quale ripartire, ma come una documentazione oggettiva che può essere confrontata con quella precedente per valutare il risultato raggiunto.

La regola può essere spiegata così:

> *«Quando invieremo la prossima scansione, l'azienda potrà confrontarla con quella di oggi e valutare il risultato complessivo raggiunto. Non sarà necessario che ogni singolo dente abbia espresso perfettamente tutti i movimenti programmati, ma dovrà essere presente un miglioramento significativo e compatibile con un utilizzo corretto degli allineatori. Se questo miglioramento sarà evidente, gli eventuali movimenti incompleti potranno essere gestiti attraverso una normale rifinitura; se invece i progressi saranno soltanto marginali, non ci sarà alcun avanzamento sostanziale o i denti saranno addirittura peggiorati, l'azienda potrà non considerare la nuova serie come una normale rifinitura compresa nel trattamento e gli ulteriori allineatori potrebbero quindi comportare un costo aggiuntivo.»*

In alternativa, il professionista può presentare questa regola come una scelta dello studio:

> *«Questa volta possiamo eseguire una nuova scansione e ripartire, ma alla fine della prossima serie dovremo osservare un miglioramento significativo e compatibile con un utilizzo corretto degli allineatori. Se il trattamento sarà progredito e rimarranno soltanto alcuni movimenti incompleti, potremo completarli attraverso una normale rifinitura. Se invece non ci sarà un avanzamento sostanziale, non potremo continuare a ripetere la stessa fase e dovremo valutare se interrompere il trattamento oppure proseguirlo con un nuovo piano e un costo aggiuntivo.»*

La richiesta di un costo aggiuntivo non rappresenta una punizione, ma serve a rendere concretamente diverse due situazioni che clinicamente lo sono già: completare un trattamento che il paziente ha realmente seguito oppure ripetere una fase che non ha prodotto risultati perché gli allineatori non sono stati utilizzati come prescritto.

Come abbiamo visto nel capitolo 6, quando ci troviamo per la prima volta davanti a una perdita generalizzata di fitting cerchiamo soprattutto di rendere concreta la conseguenza sul **Tempo**: se il cambio settimanale non è sufficiente, il tempo neces-

sario per ogni allineatore potrebbe aumentare e con esso la durata complessiva del trattamento. Quando invece il paziente ha già sperimentato due, tre o quattro ripartenze, questa leva può perdere progressivamente la propria efficacia, perché aspettare più a lungo e ricominciare sono ormai diventati parte della normalità. È a questo punto che entra in gioco la leva dell'**Investimento**, non per minacciare il paziente o fargli pagare la mancata collaborazione, ma per rendere evidente che un'altra ripartenza non è automatica e che ripetere una fase non eseguita non equivale a completare alcuni movimenti residui.

Perché questa conseguenza sia corretta ed efficace, però, deve essere comunicata **prima** della nuova serie e non introdotta al controllo successivo. Se il paziente la conosce prima di ripartire, rappresenta una condizione chiara della nuova possibilità che gli stiamo offrendo; se invece la scopre soltanto dopo avere nuovamente collaborato poco, può percepirla come una regola inventata retroattivamente. Il passaggio decisivo consiste quindi nel sostituire la promessa con una condizione verificabile: non chiediamo più «*Mi prometti che questa volta collaborerai?*», perché quella promessa l'abbiamo probabilmente già sentita, ma spieghiamo che la prosecuzione alle stesse condizioni dipenderà dal risultato osservabile alla scansione successiva.

Una nuova scansione acquisisce la posizione attuale dei denti e ci consente di preparare altri allineatori, ma non restituisce il tempo perduto e, soprattutto, non modifica da sola il comportamento che ha prodotto il problema. Se continuiamo a ripartire senza cambiare le condizioni, ripetiamo lo stesso trattamento affidandoci ancora una volta alla stessa promessa. La rifinitura conserva invece tutto il proprio valore quando serve a completare un percorso che il paziente ha realmente seguito; quando viene utilizzata per ripetere continuamente fasi mai eseguite, smette di essere soltanto uno strumento di precisione clinica e rischia di diventare una compensazione della mancata collaborazione.

Le rifiniture comprese servono a completare un trattamento eseguito, non a sostituire indefinitamente un trattamento che non è mai stato realmente seguito.

Essere comprensivi non significa eliminare ogni conseguenza. Una seconda possibilità può essere offerta, e in molti casi è giusto offrirla, ma proprio perché continui ad avere il significato di una seconda possibilità non può trasformarsi in una possibilità infinita.

SCRIPT OPERATIVO

A questo punto la conversazione con il paziente deve trasformare ciò che abbiamo appena spiegato in una regola semplice, comprensibile e soprattutto definita prima di iniziare la nuova serie. Non dobbiamo chiedere un'altra promessa né cercare di ottenere un'ammissione di scarsa collaborazione: dobbiamo chiarire quale risultato ci aspettiamo e cosa accadrà se quel risultato non verrà raggiunto.

> *«Questa volta possiamo eseguire una nuova scansione e ripartire, ma devo spiegarti una regola importante. Quando terminerai questa serie, la nuova scansione verrà confrontata con quella di oggi e dovrà mostrare un miglioramento significativo, compatibile con un utilizzo corretto degli allineatori. Questo non significa che ogni singolo dente dovrà raggiungere perfettamente la posizione programmata, perché alcuni movimenti possono essere meno prevedibili, ma il trattamento nel suo complesso dovrà essere realmente progredito.*
>
> *Se avrai collaborato e saranno rimasti soltanto alcuni movimenti incompleti, potremo procedere con una normale rifinitura. Se invece non ci sarà un miglioramento sostanziale, oppure i denti saranno addirittura peggiorati, l'azienda potrà non considerare la nuova serie come una normale rifinitura compresa nel trattamento e gli ulteriori allineatori potrebbero quindi comportare un costo aggiuntivo. Non si tratta di una punizione: significa semplicemente che non staremmo completando un trattamento eseguito, ma ripetendo ancora una volta una fase che non è stata portata avanti.»*

Perché questo protocollo funziona

- **Interrompe il rinforzo involontario**

Se ogni episodio di mancata collaborazione viene seguito automaticamente da una nuova serie, **la possibilità di ripartire senza alcuna conseguenza concreta può favorire la ripetizione dello stesso schema**. Anticipare un limite interrompe questo meccanismo senza trasformare il controllo in una punizione.

- **Rende visibile la conseguenza**

Una generica raccomandazione a collaborare meglio rimane astratta, mentre **la possibilità che un'ulteriore serie non possa più essere considerata una normale rifinitura compresa nel trattamento** rende immediatamente percepibile la differenza tra completare un trattamento e doverne ripetere una fase.

- **Sposta l'attenzione dalle promesse ai risultati**

Il confronto tra le scansioni evita di basare la decisione esclusivamente su ciò che il paziente dichiara e introduce un criterio clinico osservabile, pur senza pretendere di misurare direttamente le ore di utilizzo.

- **Utilizza la leva dell'Investimento**

Quando il Tempo non è più sufficiente a modificare un comportamento già ripetuto, l'eventualità di un costo aggiuntivo restituisce valore alla nuova possibilità e rende meno facile considerarla automatica.

- **Preserva la relazione terapeutica**

La conseguenza viene comunicata in anticipo, collegata **a criteri definiti prima della nuova serie** e presentata come una condizione della prosecuzione, evitando che il paziente la interpreti come una decisione personale o come una reazione emotiva del medico.

BIBLIOGRAFIA

Staddon JER, Cerutti DT. Operant conditioning. Annual Review of Psychology. 2003;54:115–144.

Shampanier K, Mazar N, Ariely D. Zero as a special price: the true value of free products. Marketing Science. 2007;26(6):742–757.

Baicker K, Mullainathan S, Schwartzstein J. Behavioral hazard in health insurance. Quarterly Journal of Economics. 2015;130(4):1623–1667.

Koohi Rostamkalaee Z, Jafari M, Gorji HA. A systematic review of strategies used for controlling consumer moral hazard in health systems. BMC Health Services Research. 2022;22:1260.

Al-Moghrabi D, Colonio Salazar F, Pandis N, Fleming PS. Compliance with removable orthodontic appliances and adjuncts: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2017;152(1):17–32.

Van der Bie RM, Bos A, Bruers JJM, Jonkman REG. Patient adherence in orthodontics: a scoping review. BDJ Open. 2024;10:58.

Bolívar HA, Klemperer EM, Coleman SRM, et al. Contingency management for patients receiving medication for opioid use disorder: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021;78(10):1092–1102.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Leva principale: controllo e conseguenza concreta.

Con un paziente dominante è preferibile utilizzare una comunicazione diretta, breve e orientata alla decisione, evitando spiegazioni troppo lunghe che potrebbero essere percepite come una perdita di tempo.

> *«Possiamo ripartire, ma da questo momento utilizziamo un criterio preciso: alla prossima scansione dovrà esserci un miglioramento significativo. Se il trattamento sarà realmente progredito, completeremo normalmente i movimenti rimasti; se invece non ci sarà un progresso sostanziale, un'altra serie non potrà essere considerata una normale rifinitura compresa e comporterà un costo aggiuntivo.»*

I

Influente

Leva principale: motivazione e risultato.

Con un paziente influente è utile mantenere un tono positivo e coinvolgente, senza permettere che l'entusiasmo della nuova promessa sostituisca un impegno verificabile.

> *«Questa può davvero essere la serie con cui rimettiamo il trattamento nella direzione giusta. Alla prossima scansione, però, dovremo vedere un miglioramento significativo, perché sarà il risultato a dirci se questa volta la collaborazione è stata sufficiente. Se il trattamento sarà realmente progredito, potremo completarlo normalmente; se invece non vedremo un progresso sostanziale, un'altra serie non potrà essere considerata una normale rifinitura compresa e comporterà un costo aggiuntivo.»*

S

Stabile

Leva principale: rassicurazione e chiarezza.

Con un paziente stabile dobbiamo evitare che la regola venga vissuta come una minaccia, spiegandola con calma e sottolineando che il suo scopo è consentire una conclusione ordinata del trattamento.

> *«Capisco che questi mesi siano stati difficili e possiamo ripartire senza trasformare questo controllo in un rimprovero. Voglio però spiegarti con chiarezza cosa accadrà: confronteremo la prossima scansione con quella di oggi e dovremo osservare un miglioramento significativo. Se il trattamento starà realmente progredendo, potremo completarlo normalmente; se invece il miglioramento non sarà sufficiente, prima di ripartire nuovamente dovremo valutare insieme come proseguire e l'eventuale costo della nuova fase.»*

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

C

Coscienzioso

Leva principale: criterio oggettivo e distinzione clinica.

Con un paziente coscienzioso è utile spiegare con precisione che il confronto riguarda il risultato complessivo e non pretende una corrispondenza perfetta di ogni movimento con il setup.

> *«Il confronto non verrà effettuato valutando un singolo dente, ma considerando il progresso complessivo rispetto ai movimenti programmati. Non pretendiamo una corrispondenza perfetta con il setup, perché alcuni movimenti possono non esprimersi completamente anche quando gli allineatori vengono utilizzati correttamente. Dovrà però essere presente un miglioramento clinicamente significativo e coerente con una collaborazione adeguata. In assenza di questo progresso, la fase successiva non potrà essere considerata una normale rifinitura compresa.»*

CAPITOLO 9

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Quando occorre ripetere una fase principalmente per collaborazione insufficiente e il paziente ha già ricevuto una possibilità di ripartenza.
OBIETTIVO	Condizionare la nuova possibilità a un progresso verificabile, interrompendo l'automatismo delle ripartenze senza conseguenze.
COSA FARE	1. Rivalutare le cause della mancata progressione, distinguendo collaborazione insufficiente e altre difficoltà cliniche. 2. Riconoscere la difficoltà e offrire una nuova possibilità quando appropriato. 3. Prima della nuova serie, spiegare che la scansione successiva verrà confrontata con quella di partenza. 4. Chiarire che ci aspettiamo un miglioramento clinicamente significativo, non soltanto un nuovo impegno dichiarato. 5. Se il trattamento progredisce e rimangono movimenti residui, gestirli come una normale rifinitura. 6. Se manca un avanzamento sostanziale o la situazione peggiora, rivalutare la prosecuzione. Un'ulteriore serie potrà comportare un costo aggiuntivo secondo le condizioni comunicate in anticipo.
COSA VERIFICARE	Fitting, confronto tra scansioni, progresso complessivo, movimenti residui, eventuale peggioramento e storia delle ripartenze. Verificare che il paziente abbia compreso la distinzione tra completare il trattamento e ripetere una fase non eseguita.

CAPITOLO

10

Il paziente che sparisce

«Il tempo perduto non si ritrova mai.»

— BENJAMIN FRANKLIN

Ci sono pazienti che decidono di interrompere o sospendere un trattamento e ce lo dicono apertamente: vengono in studio, ci spiegano che per qualche motivo non vogliono o non possono continuare in quel momento e decidiamo insieme come gestire la situazione. **Nel mio studio, quando un paziente decide di sospendere il trattamento, gli facciamo firmare un consenso di sospensione nel quale rendiamo esplicito che il percorso terapeutico viene interrotto e definiamo le condizioni nelle quali potrà eventualmente essere ripreso.** In questo modo non rimane nessuna ambiguità: noi sappiamo che il trattamento è sospeso e il paziente sa che non sta semplicemente saltando qualche controllo. Poi esiste un'altra categoria di pazienti, probabilmente molto più frequente di quanto vorremmo, che non

interrompe mai veramente il trattamento, almeno non a parole, ma semplicemente a un certo punto smette di venire e sparisce.

All'inizio non sembra nemmeno un problema particolarmente serio. Il paziente salta un appuntamento, la segreteria lo richiama e spesso riceve una risposta assolutamente tranquillizzante: «*Sì, lo so, scusatemi, in questo periodo sono incasinatissimo. Appena riesco vi richiamo io.*» Naturalmente non richiama e, dopo qualche settimana, lo studio prova nuovamente a contattarlo. Questa volta magari risponde: «*Guardi, adesso proprio non riesco. Magari il mese prossimo.*» Passa un altro mese, poi due; all'inizio continuiamo a cercarlo, successivamente i tentativi inevitabilmente si diradano, perché nel frattempo abbiamo altri pazienti da seguire, altre telefonate da fare e altri problemi da risolvere. Senza che nessuno abbia mai deciso formalmente di interrompere il trattamento, quel nome semplicemente scompare dall'agenda e, con il passare del tempo, finisce per scomparire anche dalla nostra quotidianità.

Può trascorrere un anno, possono passarne due, tre o persino quattro, fino a quando una mattina la segretaria entra in studio e ci dice: «*Ti ricordi Mario Rossi? Ha chiamato perché vorrebbe prendere un appuntamento per continuare il trattamento.*» Ed è proprio quella parola, *continuare*, che secondo me contiene quasi tutto il problema di questo capitolo.

Dal suo punto di vista, infatti, il trattamento potrebbe non essere mai realmente terminato. È rimasto semplicemente sospeso, quasi come un film che aveva messo in pausa e che oggi pensa di poter riprendere esattamente dallo stesso fotogramma. Lui sa di non essere venuto per tre anni, naturalmente, ma questo non significa necessariamente che abbia percepito quella lunga assenza come la conclusione del trattamento; può essere convinto che ciò che aveva acquistato e pagato sia ancora lì ad aspettarlo.

Il problema è che durante quei tre anni la bocca non è rimasta in pausa. I denti possono essersi mossi, l'occlusione può essere cambiata, gli ultimi allineatori o la contenzione possono essere stati utilizzati in maniera imprevedibile, possono essere comparsi restauri, carie o problemi parodontali e persino le richieste del paziente possono essere diverse da quelle concordate all'inizio. Anche le condizioni cliniche, organizzative ed economiche nelle quali avevamo programmato quel trattamento possono essere cambiate.

Il tempo, infatti, non congela un trattamento ortodontico.

Beckwith e successivamente Skidmore hanno mostrato come la durata del trattamento ortodontico sia influenzata anche da variabili legate alla collaborazione e alla continuità del paziente; Melo e colleghi hanno evidenziato il peso degli appuntamenti mancati nei pazienti adulti, mentre Bichara e colleghi hanno osservato

tempi di trattamento quasi un anno più lunghi nei soggetti che avevano mancato più di due appuntamenti. La letteratura conferma quindi qualcosa che clinicamente conosciamo bene: perdere la continuità non è semplicemente un problema di agenda.

Rimane però una domanda alla quale la letteratura non può rispondere al posto nostro e che rappresenta il vero problema di questo capitolo: **per quanto tempo un trattamento può rimanere aperto quando il paziente è semplicemente scomparso?** Quando quel paziente ricompare dopo tre anni dicendo di voler "continuare", prima ancora di decidere quali allineatori ordinare dobbiamo capire qualcosa di più importante: **stiamo davvero continuando il vecchio trattamento oppure, nel frattempo, quello che abbiamo davanti è diventato un nuovo trattamento?**

L'equivoco dei cinque anni

Nel mondo degli allineatori esiste una ragione molto concreta che può avere contribuito a creare questa aspettativa e, se vogliamo essere corretti, almeno una parte della responsabilità è probabilmente anche nostra. Molti pacchetti commerciali consentono allo studio, secondo modalità che cambiano da un'azienda all'altra, di richiedere serie aggiuntive di allineatori senza costi aggiuntivi all'interno di una determinata finestra temporale, che in alcuni casi può arrivare, per esempio, a cinque anni.

Il problema nasce quando decidiamo di spiegarlo al paziente e, come inevitabilmente accade nella comunicazione quotidiana, cerchiamo di semplificare. Probabilmente molti di noi hanno pronunciato almeno una volta una frase come: *«Con questo trattamento hai gli allineatori compresi per cinque anni»*, oppure ancora più semplicemente: *«Hai cinque anni di trattamento».* Noi sappiamo cosa intendiamo, ma una frase che per noi descrive una condizione commerciale può facilmente trasformarsi, nella testa del paziente, in qualcosa di molto diverso: *«Io ho pagato un trattamento che dura cinque anni e quindi, fino a quella data, qualunque cosa succeda è compresa.»*

Diventa allora comprensibile che possa pensare di fermarsi per qualche mese, poi per un anno, magari sparire completamente e infine ricomparire prima della scadenza chiedendo semplicemente di riprendere. È proprio qui che nasce l'equivoco, perché **la finestra commerciale concessa dall'azienda allo studio e la durata clinica del trattamento non sono la stessa cosa**. La prima indica per quanto tempo lo studio può richiedere ulteriori serie di allineatori senza costi aggiuntivi; la seconda indica il tempo necessario per completare il trattamento.

Immaginiamo un paziente che ricompare dopo quattro anni all'interno di un pacchetto che prevede una finestra di cinque. Potremmo essere ancora nelle condizioni di ordinare una nuova serie, ma dobbiamo rivalutarlo, eseguire una nuova scansione, ripianificare il caso e soprattutto capire quanto trattamento abbiamo ancora davanti. Se fossero necessari altri diciotto mesi, quella finestra potrebbe terminare mentre il paziente è ancora in terapia.

Per questo credo che il vero errore sia parlare al paziente di "cinque anni di trattamento", perché **non gli stiamo vendendo cinque anni di tempo**. I cinque anni rappresentano una finestra commerciale, non la durata del trattamento.

Quando torna, non sappiamo ancora se sta continuando

Quando un paziente ricompare dopo tre o quattro anni, la tentazione più naturale è quella di riaprire immediatamente il vecchio piano di trattamento e cercare di capire da quale allineatore possiamo ripartire. In fondo conosciamo già quel paziente, abbiamo ancora fotografie, scansioni e setup. Il problema è che tutto ciò che vediamo sul monitor appartiene al paziente di tre o quattro anni prima, mentre sulla poltrona abbiamo il paziente di oggi.

Durante quel periodo i denti possono essersi spostati, l'occlusione può essere cambiata, possono essere comparsi problemi dentali o parodontali e spesso non sappiamo esattamente che cosa il paziente abbia fatto con gli ultimi allineatori. Potrebbe averli abbandonati dopo poche settimane, aver continuato a utilizzare per anni sempre lo stesso, averli utilizzati soltanto di notte come una sorta di contenzione oppure aver continuato autonomamente a cambiare quelli che aveva ancora a casa. Anche le sue richieste possono essere cambiate: tre anni prima magari eravamo vicini alla conclusione e lui era soddisfatto; oggi può tornare chiedendoci di modificare qualcosa che non faceva nemmeno parte degli obiettivi concordati all'inizio.

Per questo la prima domanda non dovrebbe essere «*Da quale allineatore possiamo ripartire?*», ma piuttosto: **«Dove siamo oggi e che cosa dobbiamo fare da qui in avanti?»** Prima di decidere se stiamo continuando il vecchio trattamento dobbiamo nuovamente visitare il paziente, ricostruire ciò che è successo durante l'assenza, valutare la situazione clinica attuale e confrontarla con quella che avevamo lasciato.

La vecchia scansione, il vecchio setup e tutti i file rimangono estremamente utili, perché ci permettono di ricostruire da dove eravamo partiti e dove eravamo arrivati. **Non è il file a essere "scaduto": è la situazione clinica che può essere cambiata.** Per questo considero la visita dopo una lunga assenza una vera rivalutazione e non

semplicemente il primo controllo dopo una pausa: **prima rivalutiamo il paziente e soltanto dopo decidiamo se quello che stiamo per fare può ancora essere chiamato "continuare".**

A questo punto potremmo essere tentati di stabilire una regola uguale per tutti: dopo dodici mesi il trattamento viene considerato interrotto, dopo due anni la ripresa comporta un nuovo costo, dopo tre si ricomincia da zero. Sarebbe semplice, ma non credo che il tempo trascorso possa essere l'unico criterio, perché tre anni di assenza possono raccontare storie completamente diverse. Un paziente può avere collaborato poco fin dall'inizio, saltato ripetutamente i controlli e progressivamente abbandonato un trattamento che procedeva già con difficoltà; un altro può avere collaborato perfettamente fino al momento in cui una malattia, un problema familiare importante o un trasferimento gli hanno reso realmente impossibile continuare. Sul calendario possono essere trascorsi gli stessi tre anni, ma non necessariamente dobbiamo prendere la stessa decisione.

Non si tratta di stabilire chi meriti di essere premiato o punito, ma di capire **quanto del lavoro che devo fare oggi possa ancora ragionevolmente rientrare nell'impegno assunto all'inizio e quanto, invece, richieda un nuovo impegno da parte dello studio**. Ed è proprio in questo senso che deve essere affrontata anche la questione economica: **un eventuale nuovo costo non serve a far pagare al paziente ciò che è successo nel passato, ma il lavoro necessario da oggi in avanti**.

Nella mia pratica riconduco il ritorno di questi pazienti a tre grandi scenari, non come regole rigide, ma come criteri che mi aiutano a mantenere una certa coerenza nelle decisioni.

Nel **primo scenario** considero ancora ragionevole riprendere il trattamento mantenendo le condizioni economiche originarie. Potrebbe essere il caso di un paziente che prima dell'interruzione aveva collaborato bene, che ha dovuto fermarsi per una ragione seria e imprevedibile e che ritorna con una situazione clinica ancora facilmente recuperabile. Posso decidere di farmi carico del lavoro necessario perché considero ciò che devo fare ancora sufficientemente vicino all'impegno assunto all'inizio.

Nel **secondo scenario** il vecchio trattamento è ancora recuperabile, ma la situazione è diventata più complessa. Sono trascorsi diversi anni, devo ripianificare una parte importante del caso oppure mi trovo vicino alla fine della finestra commerciale originaria. Posso decidere di ripartire stabilendo limiti molto chiari oppure chiedere un contributo proporzionato al nuovo lavoro necessario. Non credo abbia senso stabilire una cifra universale: quello che considero fondamentale è che il paziente conosca le condizioni **prima** di ricominciare.

Nel **terzo scenario**, infine, il legame con il vecchio trattamento è diventato troppo debole per poter parlare ancora semplicemente di prosecuzione. Possono essere trascorsi molti anni, la situazione clinica può essere significativamente diversa, gran parte di ciò che avevamo ottenuto può essere andata perduta oppure posso trovarmi nella necessità di rifare sostanzialmente diagnosi, pianificazione e trattamento. In questo caso considero più corretto proporre un nuovo percorso terapeutico e definire un nuovo accordo economico. Anche in questo terzo scenario il messaggio rimane lo stesso: non sto chiedendo al paziente di pagare perché è sparito, ma perché **quello che devo fare oggi non è più semplicemente continuare ciò che avevamo lasciato allora**.

Il paziente va avvertito mentre sta sparendo

Finora abbiamo ragionato soprattutto su cosa fare quando il paziente ricompare, ma una parte importante del problema nasce molto prima, nel periodo in cui sta progressivamente scomparendo dai nostri controlli. È proprio in quel momento che possiamo evitare molti degli equivoci futuri.

Naturalmente il primo obiettivo deve essere recuperarlo e riportarlo all'interno di una normale continuità terapeutica. La revisione sistematica con meta-analisi di Mohammed e colleghi ha mostrato come i sistemi di reminder possano migliorare l'aderenza agli appuntamenti ortodontici e ridurre il rischio di appuntamenti mancati. Quando però le assenze cominciano a ripetersi, il contenuto della telefonata deve cambiare: non basta più chiedere quando vuole fissare il prossimo controllo, dobbiamo spiegare che una lunga interruzione non è neutra. La segreteria potrebbe dirgli:

> *«Capisco che in questo momento tu abbia difficoltà a venire, però non possiamo lasciare il trattamento sospeso senza controlli per troppo tempo. Se l'interruzione dovesse prolungarsi, quando vorrai riprendere il Dottore dovrà rivalutare la situazione e potrebbero cambiare anche le condizioni economiche del trattamento. Per questo è meglio capire insieme adesso come gestire questo periodo.»*

Preferisco che il paziente riceva questo messaggio mentre il problema sta nascendo piuttosto che spiegarglielo tre anni dopo. Non è una minaccia, ma l'anticipazione di una conseguenza reale che gli permette di scegliere se organizzarsi per continuare oppure concordare con noi una vera sospensione. **Se decide di sospendere, nel mio studio formalizziamo questa scelta facendogli firmare un consenso di sospensione del trattamento**, in modo che sia chiaro per entrambi che la terapia non sta

semplicemente rimanendo aperta in attesa che il paziente decida autonomamente quando tornare. In realtà questo concetto dovrebbe essere spiegato fin dall'inizio:

> *«Se durante il trattamento dovesse succedere qualcosa e avessi bisogno di fermarti per un periodo, non c'è nessun problema, ma non sparire. Chiamaci e decidiamo insieme come gestirlo, perché lasciare il trattamento sospeso per molto tempo senza controlli può cambiare sia la situazione clinica sia le condizioni economiche alle quali potremo riprendere.»*

Il problema, quindi, non è che un paziente possa avere bisogno di fermarsi, ma che lo faccia senza comunicarcelo. Se ci avverte possiamo valutare la situazione, mettere in sicurezza ciò che abbiamo ottenuto e concordare una sospensione; se invece continua a non presentarsi e progressivamente smette anche di rispondere, il silenzio non può diventare una modalità implicita per mantenere il trattamento aperto indefinitamente.

Dopo ragionevoli tentativi di recuperarlo ritengo quindi utile inviargli una comunicazione scritta nella quale rendiamo chiaro che, in assenza dei controlli necessari, non siamo più nelle condizioni di supervisionare attivamente il trattamento e che un eventuale ritorno dopo una lunga interruzione richiederà una nuova valutazione clinica e delle condizioni alle quali sarà possibile riprendere. Nella stessa comunicazione possiamo indicargli come comportarsi con gli allineatori e gli eventuali dispositivi ancora presenti e ricordargli di non proseguire autonomamente il trattamento. Tutti i tentativi di contatto e le comunicazioni importanti dovrebbero essere registrati nella cartella clinica. Se dopo tre anni il paziente ritornerà, dovremo poter ricostruire quando abbiamo perso la continuità, quali tentativi siano stati fatti per recuperarla e quali informazioni gli siano state date mentre il trattamento si stava interrompendo.

L'interruzione deve diventare chiara mentre sta avvenendo, non essere ricostruita tre anni dopo.

Quando il paziente ricompare

Quando, magari dopo tre anni, il paziente telefona dicendo di voler *"continuare il trattamento"*, la segreteria non deve decidere se quel trattamento sia ancora aperto, se sia ancora compreso oppure quanto costerà riprenderlo, perché in quel momento non abbiamo ancora gli elementi per saperlo. Allo stesso modo eviterei di entrare al telefono in una discussione su ciò che era stato detto anni prima o sulle ragioni per cui il paziente sia scomparso. La risposta può essere molto semplice:

> *«Certo, fissiamo un appuntamento con il Dottore. È passato parecchio tempo dall'ultimo controllo, quindi prima dobbiamo rivalutare la situazione e poi il Dottore ti spiegherà come possiamo riprendere e a quali condizioni.»*

Quando il paziente arriva, ricostruisco ciò che è successo dall'ultima volta che l'ho visto, valuto la situazione clinica attuale, la confronto con quella che avevamo lasciato e stabilisco quanto del vecchio trattamento sia ancora recuperabile**. Soltanto a quel punto decido quale soluzione proporre e a quali condizioni possiamo ripartire.** In questo modo l'eventuale nuovo costo non viene presentato come la conseguenza del fatto che il paziente sia sparito, ma **del lavoro che oggi è necessario per completare il trattamento.**

SCRIPT OPERATIVO

Una volta deciso in quale dei tre scenari ci troviamo, cerco di mantenere sempre lo stesso ordine: parto dalla situazione di oggi, spiego che cosa è necessario fare per arrivare alla conclusione e soltanto dopo chiarisco a quali condizioni possiamo ripartire.

Se possiamo riprendere mantenendo le condizioni originarie:

> *«Ho rivalutato tutto e possiamo ancora riprendere il trattamento mantenendo le condizioni che avevamo stabilito all'inizio. Da questo momento, però, dobbiamo essere continui: se dovesse succedere qualcosa che ti impedisce di proseguire, chiamaci e decidiamo insieme come gestirlo, ma non possiamo lasciare nuovamente il trattamento sospeso per anni.»*

Se il vecchio trattamento è recuperabile ma siamo vicini ai limiti delle condizioni originarie:

> *«Possiamo ancora riprendere, ma siamo ormai vicini alla scadenza della finestra prevista dal pacchetto originario. Se riusciamo a completare il trattamento entro quella finestra, non cambia nulla; se invece dopo quella data dovessero essere necessari altri allineatori, potrebbero esserci dei costi aggiuntivi. Preferisco dirtelo adesso, prima di ricominciare.»*

Se quello che dobbiamo fare è ormai un nuovo trattamento:

> *«Sono passati diversi anni e oggi la situazione è diversa da quella che avevamo lasciato. Per arrivare al risultato non è sufficiente ordinare altri allineatori e ripartire da dove ci eravamo fermati: devo ripianificare il caso e iniziare un nuovo percorso. Per questo quello che ti propongo oggi è un nuovo trattamento, con un nuovo accordo economico.»*

In nessuno dei tre casi sento il bisogno di iniziare ricordando al paziente quante volte non si sia presentato, quante telefonate abbia fatto la segreteria o quante volte ci abbia promesso che sarebbe tornato. Queste informazioni devono essere documentate nella cartella clinica, ma utilizzarle per aprire la conversazione rischia soltanto di spostarla su chi abbia ragione e chi abbia torto. **A me interessa riportarlo sul presente: questa è la situazione che abbiamo oggi, questo è ciò che dobbiamo fare e queste sono le condizioni alle quali possiamo farlo.**

Del resto, anche qui vale uno dei principi già incontrati: **la confessione non muove i denti**. Non ho bisogno che il paziente ammetta di avere sbagliato; ho bisogno che capisca dove siamo oggi e, se decidiamo di ripartire, sappia esattamente a quali condizioni lo stiamo facendo.

Perché questo protocollo funziona

- **Sposta la discussione dal passato al presente**

Non cerchiamo di stabilire chi abbia ragione su ciò che è accaduto durante gli anni di assenza. Partiamo dalla situazione clinica attuale e da ciò che è necessario fare da oggi in avanti, evitando che la conversazione si trasformi in una discussione sulle responsabilità del passato.

- **Elimina l'ambiguità della ripartenza**

Il fatto che il trattamento non sia stato formalmente concluso non significa che possa essere riattivato in qualsiasi momento alle condizioni originarie. La rivalutazione stabilisce che cosa del vecchio trattamento sia ancora recuperabile e a quali condizioni possiamo ripartire.

- **Collega il costo al lavoro futuro**

L'eventuale nuovo costo non viene presentato come una sanzione per essere spariti, ma come la conseguenza del lavoro clinico, organizzativo ed economico necessario da quel momento in avanti. Questo permette di utilizzare la leva dell'Investimento senza trasformarla in una punizione.

■ **Anticipa le conseguenze**

Avvertire il paziente mentre sta perdendo continuità gli permette di sapere che un'assenza prolungata può modificare sia la situazione clinica sia le condizioni alle quali potrà riprendere. Una conseguenza comunicata prima è molto diversa da una condizione imposta quando il paziente ritorna anni dopo.

Quando dopo anni vedo nuovamente quel nome in agenda, quindi, non considero automaticamente riaperto il trattamento che avevamo lasciato. Considero invece riaperta una possibilità: quella di rivedere il paziente, capire dove siamo oggi e decidere insieme se e come possiamo ripartire.

Il paziente può sparire. Il trattamento non può rimanere aperto per sempre.

BIBLIOGRAFIA

Beckwith FR, Ackerman RJ Jr, Cobb CM, Tira DE. An evaluation of factors affecting duration of orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1999;115(4):439–447.

Skidmore KJ, Brook KJ, Thomson WM, Harding WJ. Factors influencing treatment time in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129(2):230–238.

Melo ACEO, Carneiro LOT, Pontes LF, Cecim RL, Mattos JNR, Normando D. Factors related to orthodontic treatment time in adult patients. Dental Press J Orthod. 2013;18(5):59–63.

Bichara LM, Aragón MLC, Brandão GAM, Normando D. Factors influencing orthodontic treatment time for non-surgical Class III malocclusion. J Appl Oral Sci. 2016;24(5):431–436.

Mohammed H, Rizk MZ, Wafaie K, Ulhaq A, Almuzian M. Reminders improve oral hygiene and adherence to appointments in orthodontic patients: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod. 2019;41(2):204–213.

Rischen RJ, Breuning KH, Bronkhorst EM, Kuijpers-Jagtman AM. Records needed for orthodontic diagnosis and treatment planning: a systematic review. PLoS One. 2013;8(11):e74186.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Leva principale: decisione e condizioni.

Con un paziente dominante eviterei una lunga ricostruzione del passato e andrei rapidamente al punto:

> *«Ho rivalutato la situazione e oggi queste sono le possibilità. Possiamo recuperare una parte del vecchio trattamento a queste condizioni oppure, se necessario, ripianificare completamente il caso. Ti spiego le differenze e decidiamo come procedere.»*

Se è previsto un nuovo costo: «*Non è un costo legato al fatto che sei mancato, ma al lavoro che dobbiamo fare da oggi per arrivare al risultato.*»

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

I

Influente

Leva principale: futuro e risultato.

Con un paziente influente eviterei che la conversazione diventi una lunga ricostruzione di tutto ciò che non ha fatto. Posso utilizzare la sua disponibilità a ricominciare per riportarlo immediatamente sul futuro:

> *«Perfetto, allora guardiamo avanti. Vediamo che cosa possiamo recuperare, che cosa dobbiamo rifare e organizziamo bene questa nuova fase.»*

Il contenuto della decisione non cambia, comprese le eventuali condizioni economiche, ma la comunicazione è orientata soprattutto al risultato.

S

Stabile

Leva principale: rassicurazione e chiarezza.

Un paziente stabile può arrivare già preoccupato di essere rimproverato o di dover ricominciare tutto:

> *«Prima vediamo con calma dove siamo oggi e quanto di quello che avevamo fatto possiamo recuperare. Poi ti spiego quali possibilità abbiamo e a quali condizioni possiamo ripartire.»*

L'obiettivo è rassicurarlo sul processo senza anticipare promesse che non possiamo ancora mantenere.

C

Coscienzioso

Leva principale: dati e criteri.

Con un paziente coscienzioso utilizzerei maggiormente la documentazione disponibile:

> *«Questa era la situazione quando ci siamo fermati, questa è quella di oggi e questo è il lavoro che dobbiamo ancora fare. È per queste ragioni che posso recuperare questa parte del vecchio trattamento, mentre quest'altra deve essere ripianificata.»*

CAPITOLO 10

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Quando il paziente interrompe i controlli oppure ritorna dopo una lunga assenza chiedendo di continuare il trattamento.
OBIETTIVO	Recuperare la continuità quando possibile e subordinare l'eventuale ripartenza alla situazione clinica attuale.
COSA FARE	1. Contattare il paziente quando gli appuntamenti iniziano a essere saltati e cercare di comprendere la difficoltà. 2. Anticipare che un'assenza prolungata può modificare la situazione clinica e le condizioni della ripresa. 3. Se decide di fermarsi, formalizzare la sospensione con il relativo consenso. 4. Se sparisce, documentare i tentativi di contatto e comunicare l'interruzione. 5. Al ritorno, rivalutare il paziente: la vecchia documentazione aiuta a ricostruire il percorso, ma non sostituisce la valutazione attuale. 6. Distinguere prosecuzione del trattamento originario, prosecuzione con nuove condizioni e nuovo trattamento. 7. Chiarire percorso ed eventuali costi prima di ripartire. Il costo riguarda il lavoro necessario, non rappresenta una sanzione per l'assenza.
COSA VERIFICARE	Tempo trascorso, motivo dell'interruzione, situazione clinica, collaborazione precedente, recuperabilità del trattamento, condizioni commerciali residue e lavoro ancora necessario.

CAPITOLO

11

Il paziente mai soddisfatto

«Nulla è abbastanza per colui per il quale ciò che è abbastanza è troppo poco.»

— EPICURO

Esiste una categoria di pazienti che, negli anni, ho imparato a riconoscere con particolare attenzione. Non sono necessariamente pazienti difficili, non sono quelli che non utilizzano gli allineatori e non sono nemmeno quelli che saltano gli appuntamenti o dimenticano sistematicamente gli elastici. Anzi, spesso sono estremamente attenti al trattamento: osservano continuamente i propri denti, confrontano fotografie scattate a distanza di settimane e arrivano agli appuntamenti sapendo esattamente quale dettaglio desiderano mostrarmi. Il problema è che non sono mai completamente soddisfatti.

Una volta corretto ciò che li aveva portati da noi, la loro attenzione tende a spostarsi su particolari sempre più piccoli, che inizialmente probabilmente non

avevano neppure notato. Quasi senza accorgercene, il trattamento rischia così di trasformarsi nella ricerca di una perfezione sempre più difficile da raggiungere e, qualche volta, impossibile.

Con gli allineatori questo rischio è diventato, nella mia esperienza, ancora più evidente. Le simulazioni digitali permettono di osservare il risultato nel dettaglio, le fotografie vengono confrontate continuamente e la possibilità di programmare nuovi movimenti può facilmente trasmettere l'idea che ci sia sempre qualcosa che possa essere ancora migliorato. A questo si aggiunge una differenza molto semplice rispetto all'ortodonzia fissa: dopo molti mesi di trattamento, il paziente con l'apparecchio fisso generalmente non vede l'ora di toglierlo, mentre continuare per qualche mese con gli allineatori viene spesso percepito come un sacrificio molto più piccolo. Il desiderio di terminare, quindi, può diventare meno forte proprio mentre aumenta l'attenzione verso dettagli sempre più piccoli.

Per molto tempo anch'io ho ragionato in questo modo. Se il paziente mi mostrava un dettaglio che poteva essere migliorato e ritenevo possibile farlo, cercavo di accontentarlo. Mi sembrava la scelta più logica: migliorare ancora il risultato e, nello stesso tempo, aumentare la sua soddisfazione. Con il tempo ho capito che le due cose non procedono necessariamente insieme e che, con alcuni pazienti, ogni ulteriore correzione può semplicemente spostare l'attenzione sul dettaglio successivo.

La domanda, quindi, non è soltanto **quanto possiamo ancora migliorare un risultato**, ma **quando continuare a cercare di migliorarlo smette di essere realmente utile**.

Quando migliorare non basta

Stefano aveva circa quarant'anni quando arrivò nel mio studio, dopo avere già consultato diversi colleghi. Presentava una malocclusione tutt'altro che semplice: una seconda classe subdivisione, con una prima classe a destra e una seconda classe piena a sinistra, un morso profondo praticamente del 100% e un importante affollamento dell'arcata inferiore.

Programmai un trattamento con allineatori ed elastici e gli spiegai che avremmo avuto bisogno indicativamente di dodici-quindici mesi. Stefano collaborò e, alla fine del primo set, il risultato era davvero molto buono: avevamo raggiunto una perfetta prima classe anche a sinistra, aperto il morso e ottenuto un ottimo allineamento. In quel periodo ero ancora agli inizi della mia esperienza con i trattamenti complessi mediante allineatori e quel risultato aveva per me un significato particolare. Ero

orgoglioso di essere riuscito a correggere una malocclusione che molti colleghi non avrebbero neppure preso in considerazione per un trattamento con allineatori.

Stefano, però, mi fece notare un piccolo dettaglio relativo all'incisivo laterale inferiore sinistro. Aveva ragione: quel dente poteva essere migliorato e decidemmo quindi di effettuare una rifinitura. Volevo completare il trattamento nel modo migliore possibile, ma desideravo anche che Stefano fosse pienamente soddisfatto. Pensavo che le due cose coincidessero: **più avessi migliorato il risultato, più sarebbe aumentata la sua soddisfazione.**

Alla fine della prima rifinitura quel dettaglio era migliorato, ma Stefano aveva cominciato a osservarne un altro. Effettuammo quindi un'altra scansione, poi un'altra rifinitura e successivamente un'altra ancora. Ogni volta riuscivamo a migliorare un dettaglio, ma l'attenzione si spostava su qualcosa di nuovo. Alla fine arrivammo a otto rifiniture e il trattamento, che avrebbe dovuto durare indicativamente dodici-quindici mesi, raggiunse i ventotto.

Il paradosso era evidente: **il risultato clinico continuava a migliorare, ma la soddisfazione di Stefano non aumentava con esso**. Ogni volta che correggevamo un'imperfezione, la sua attenzione si spostava su un dettaglio ancora più piccolo. Neppure dopo l'ottava rifinitura era completamente soddisfatto e mi disse, più o meno:

> *«Adesso ci siamo quasi. Ci sarebbe ancora qualcosina da migliorare, però il trattamento sta durando troppo e non ho voglia di continuare così.»*

Il trattamento non terminò quindi perché Stefano era finalmente soddisfatto. Terminò perché, dopo ventotto mesi, **non era più disposto a investire altro tempo per farlo**. Se continuare non avesse avuto per lui quel costo, probabilmente avremmo trovato ancora qualcos'altro da modificare.

A quel punto ero stanco e frustrato anch'io. Il risultato clinico che cercavamo era stato raggiunto da tempo, ma ogni nuovo dettaglio era diventato una ragione sufficiente per continuare. Mi resi conto che avevo commesso un errore: **avevo continuato a chiedermi che cosa potessimo ancora migliorare, senza chiedermi se avesse davvero senso farlo.** Stefano mi insegnò una lezione che non ho più dimenticato:

Ascoltare il paziente non significa consegnargli il volante del trattamento.

Quando cambia il punto di riferimento

All'inizio del trattamento il paziente può essere preoccupato per un affollamento importante, un morso profondo o un incisivo evidentemente fuori posizione. Quan-

do questi problemi vengono corretti, però, il suo punto di riferimento cambia. Con il passare dei mesi tende anche a dimenticare quanto fosse diversa la situazione iniziale e finisce per confrontare il risultato non più con il sorriso con cui era arrivato da noi, ma con ciò che ancora potrebbe essere migliorato. Un dettaglio che all'inizio probabilmente non avrebbe neppure notato può così diventare il nuovo problema da correggere.

La letteratura sulla percezione del sorriso ci mostra inoltre che ortodontisti e pazienti non attribuiscono necessariamente la stessa importanza agli stessi dettagli e che esistono soglie differenti nella capacità di riconoscere piccole asimmetrie dentali e gengivali. Studi condotti attraverso fotografie del sorriso, e più recentemente anche attraverso sistemi di eye-tracking, hanno dimostrato quanto possa diventare selettiva l'attenzione quando ci concentriamo su particolari sempre più piccoli.

Nella pratica clinica, questo mi ha portato negli anni a distinguere due modi molto diversi di guardare lo stesso risultato, che definisco **estetica sociale** ed **estetica ispettiva**. Non sono termini che derivano dalla letteratura, ma due espressioni che utilizzo per descrivere qualcosa che vedo continuamente nei miei pazienti.

L'**estetica sociale** è quella del sorriso nella vita reale: mentre una persona parla, ride, si muove e interagisce con gli altri. Nessuno osserva un singolo incisivo da pochi centimetri; percepiamo il sorriso nel suo insieme.

L'**estetica ispettiva** compare invece quando smettiamo di guardare il sorriso e cominciamo a ispezionarlo. Il paziente si avvicina allo specchio, inclina la testa, cambia la luce, ingrandisce una fotografia o confronta due selfie cercando una differenza. Più a lungo osserva il particolare, più quel particolare rischia di diventare importante.

Il problema è che, una volta corretto quel dettaglio, questo tipo di osservazione non necessariamente si interrompe. L'attenzione può semplicemente spostarsi sul particolare successivo, esattamente come era accaduto con Stefano. Il risultato continua a migliorare, ma contemporaneamente diventa sempre più difficile arrivare a un punto in cui il paziente non trovi più nulla da modificare.

È per questo che **migliorare ulteriormente il risultato non significa necessariamente aumentare anche la soddisfazione**.

Una delle situazioni in cui questa distanza tra risultato clinico e percezione del paziente diventa più evidente è quella che incontro con una certa frequenza alla fine del trattamento. Mostro al paziente le fotografie finali o la scansione digitale e, osservandole insieme, anche lui riconosce che i denti sono correttamente allineati; poi si guarda allo specchio e mi dice:

«Sul monitor li vedo dritti, ma quando mi guardo continuano a non piacermi.»

Rispondergli semplicemente che i denti sono dritti non serve. La sua insoddisfazione è reale, ma questo non significa necessariamente che dipenda ancora dalla loro posizione. Ciò che continua a non convincerlo può essere legato alla forma dei denti, all'usura dei margini, alle differenze anatomiche tra i due lati, al rapporto con le labbra o, più semplicemente, alla percezione complessiva del proprio sorriso.

È qui che diventa fondamentale distinguere due affermazioni apparentemente simili: *«I denti non sono dritti»* e *«Il mio sorriso non mi piace»*. Nel primo caso dovremmo essere in grado di identificare un dente, una posizione e il movimento necessario per modificarla. Nel secondo stiamo descrivendo una percezione estetica più generale, che non necessariamente può essere corretta spostando ancora i denti. Per questo, prima di programmare un'altra rifinitura, chiedo al paziente:

«Riesci a mostrarmi esattamente quale dente non ti convince e che cosa vorresti cambiare? Che cosa dovremmo vedere di diverso alla fine della nuova rifinitura per poter dire che ha funzionato?»

La risposta a queste domande cambia completamente la situazione. Se riusciamo a identificare un dente, un movimento e un risultato verificabile, possiamo valutare se abbia senso tentare di ottenerlo. Se invece la richiesta rimane *«vorrei vederli più belli»*, *«vorrei che fossero ancora più dritti»* oppure *«vorrei piacermi di più»*, **non abbiamo ancora identificato un obiettivo ortodontico sul quale costruire una nuova fase di trattamento**.

Possiamo programmare un movimento dentale, ma non possiamo programmare il modo in cui il paziente si vedrà allo specchio. Continuare a muovere i denti nella speranza che cambi una sensazione che non siamo riusciti a tradurre in un obiettivo preciso rischia semplicemente di portarci a un'altra rifinitura e, qualche mese dopo, alla stessa conversazione. In questi casi cerco quindi di non negare ciò che il paziente prova, ma di chiarire il limite di ciò che un'altra serie di allineatori può realmente fare:

«Non sto mettendo in dubbio quello che vedi quando ti guardi allo specchio. Dobbiamo però capire che cosa esattamente non ti convince e se dipende dalla posizione dei denti. Se riusciamo a identificare un movimento preciso che possa migliorarlo, possiamo valutarlo. Se invece non riusciamo a definire che cosa dovremmo cambiare, un'altra serie di allineatori potrebbe spostare ancora i denti senza cambiare ciò che oggi non ti piace.»

Ascoltare la richiesta del paziente e cercare di comprenderla è fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo giustamente cercato di renderlo sempre più partecipe

delle decisioni terapeutiche: deve comprendere gli obiettivi del trattamento, poter esprimere le proprie aspettative e discutere con noi le possibilità per raggiungerli. Coinvolgerlo, però, non significa che ogni richiesta debba automaticamente trasformarsi in una nuova fase di trattamento. Rimane nostra la responsabilità di valutare se ciò che desidera correggere rappresenti un obiettivo clinicamente appropriato e se il beneficio atteso giustifichi la prosecuzione.

Per molto tempo, alla fine di una rifinitura, anch'io chiedevo quasi automaticamente: *«C'è qualcos'altro che vorresti cambiare?»*. È una domanda che sembra innocua, ma che contiene già un suggerimento: **che ci sia ancora qualcosa da cercare**. In un paziente particolarmente attento ai dettagli può diventare quasi un invito a osservare ancora più da vicino il proprio sorriso fino a trovare una nuova imperfezione.

Con il tempo ho quindi cambiato il modo in cui gestisco gli ultimi controlli. Prima effettuo la mia valutazione clinica e verifico se abbiamo raggiunto gli obiettivi concordati, controllando l'occlusione, l'allineamento, l'overjet, l'overbite, i contatti e tutti gli altri elementi necessari per poter considerare conclusa la fase attiva del trattamento. **Solo a quel punto coinvolgo il paziente nella valutazione finale**, gli mostro ciò che abbiamo ottenuto e ascolto gli eventuali aspetti che desidera ancora discutere.

La differenza può sembrare minima, ma cambia completamente il significato della conversazione. Il paziente rimane partecipe e continua ad avere tutto lo spazio necessario per esprimere ciò che vede e ciò che prova, **ma non gli stiamo chiedendo di cercare qualcosa che non va**. La nostra responsabilità rimane quella di valutare se ciò che ci sta mostrando rappresenti ancora un obiettivo clinico che giustifichi la prosecuzione del trattamento.

Una delle cose che oggi faccio più frequentemente con questi pazienti è **riportarli al punto di partenza**. Con Stefano avrei dovuto farlo molto prima: invece di continuare a osservare insieme a lui ogni nuovo particolare, avrei dovuto allargare nuovamente l'inquadratura e mostrargli quanto fosse cambiato il risultato rispetto alla situazione iniziale.

Riprendo quindi le fotografie iniziali e le confronto con quelle attuali. Non lo faccio per dimostrare al paziente che dovrebbe essere soddisfatto, perché la soddisfazione non può essere imposta, ma **per rimettere accanto ciò che oggi sta osservando a pochi centimetri e il problema complessivo che avevamo deciso di trattare all'inizio.**

«Guardiamo insieme il risultato nel suo complesso. Questo era il punto dal quale siamo partiti e questi erano gli obiettivi che avevamo stabilito. Li abbiamo raggiunti. Il dettaglio che mi stai mostrando lo vedo anch'io, ma dobbiamo chiederci se modificarlo produrrebbe un beneficio reale oppure se stiamo cercando di migliorare qualcosa che è già clinicamente corretto.»

In questo modo non nego ciò che il paziente vede e non gli dico che il dettaglio non esiste. **Gli restituisco la prospettiva complessiva del trattamento**, dopo mesi nei quali la sua attenzione si è progressivamente concentrata su particolari sempre più piccoli.

A questo punto, però, dobbiamo capire che cosa rappresenti realmente la richiesta del paziente di continuare, perché non tutte le richieste hanno lo stesso significato.

Se uno degli obiettivi che avevamo concordato non è stato raggiunto, per me non esiste alcuna discussione: il trattamento deve essere completato e, se è necessaria un'altra rifinitura, sono io il primo a proporla.

Esiste poi la situazione opposta, nella quale la richiesta del paziente **non corrisponde a un obiettivo ortodontico preciso oppure richiederebbe un movimento che considero inutile, imprevedibile o clinicamente inopportuno**. In questo caso non procedo, indipendentemente dalla sua disponibilità a continuare.

Ma esiste anche una terza possibilità, ed è quella che più frequentemente crea difficoltà con il paziente mai soddisfatto. **Gli obiettivi del trattamento sono stati raggiunti e io non considero necessaria un'altra rifinitura, ma il paziente individua un dettaglio ulteriore, reale, modificabile e clinicamente accettabile sul quale desidera ancora intervenire.**

È questa la situazione più difficile da gestire, perché non posso dire al paziente che ciò che mi sta mostrando non esiste e nemmeno che non possa essere modificato. Posso però spiegargli che **una cosa è completare gli obiettivi del trattamento, un'altra è decidere di continuare oltre quegli obiettivi per cercare un ulteriore perfezionamento del risultato**.

Quando le spiegazioni non bastano

Per molto tempo ho cercato di gestire queste situazioni affidandomi soprattutto alla comunicazione. Mostravo le fotografie iniziali, ricordavo gli obiettivi che avevamo concordato, confrontavo il punto di partenza con il risultato raggiunto e spiegavo perché un'altra rifinitura non avrebbe necessariamente prodotto un miglioramento significativo. Tutto questo continua a essere indispensabile e rappresenta ancora

oggi la prima parte del mio approccio, ma con alcuni pazienti mi sono accorto che non era sufficiente. Potevo dedicare molto tempo a spiegare che gli obiettivi erano stati raggiunti e che il dettaglio che stavamo osservando non rendeva necessaria un'altra fase di trattamento, ma alla fine la domanda era quasi sempre la stessa:

«Ho capito, dottore, ma se possiamo ancora provare, perché non dovremmo farlo?»

Dal punto di vista del paziente, in realtà, era una domanda perfettamente logica. Se continuare non comportava un ulteriore pagamento, se utilizzare gli allineatori per qualche altro mese non rappresentava ormai un sacrificio particolarmente importante e se avevamo comunque la possibilità di produrre un'altra serie, **perché fermarsi?** Anche se il beneficio atteso era minimo e incerto, il costo percepito del tentativo era praticamente nullo.

È stato questo il passaggio che per molto tempo non avevo compreso. Continuavo a cercare argomenti migliori per spiegare perché fosse ragionevole fermarsi, mentre il paziente continuava a vedere una possibilità di miglioramento che, dal suo punto di vista, non aveva quasi nessuna conseguenza. Finché le due alternative erano *fermarsi* oppure *provare ancora gratuitamente*, anche un dettaglio molto piccolo poteva sembrare sufficiente per scegliere la seconda. Ho quindi capito che, in questa specifica situazione, le spiegazioni da sole non bastavano. **Dovevo rendere concreta la decisione di continuare.**

Nel mio studio ho scelto di rendere concreta questa decisione introducendo un costo per l'ulteriore fase di trattamento, che generalmente è di **1.000 euro.** La cifra in sé non rappresenta il punto centrale e non vuole naturalmente essere una regola applicabile a tutti: ogni collega può stabilire un importo coerente con la propria realtà professionale. Ciò che conta è che sia sufficientemente significativo da trasformare quella che fino a quel momento veniva percepita come la semplice possibilità di *«provare ancora»* in una vera decisione. Voglio essere molto chiaro su questo punto, perché **non introduco il costo con l'obiettivo di vendere un'altra rifinitura; al contrario, quando lo introduco, la mia speranza è che il paziente decida di non farla. La sua funzione è deliberatamente dissuasiva**.

Fino a quel momento il paziente si stava chiedendo *«Se possiamo ancora provare, perché dovremmo fermarci?»*. Nel momento in cui continuare comporta un nuovo investimento, la domanda diventa invece *«Questo dettaglio è davvero così importante da giustificare altri 1.000 euro e qualche altro mese di trattamento?»*. È esattamente questo cambiamento che sto cercando: il dettaglio è lo stesso, il movimento che potremmo tentare di ottenere è lo stesso, ma **cambia il valore che il paziente attribuisce a**

quel dettaglio quando continuare smette di essere privo di conseguenze. Molto spesso, infatti, dopo aver spiegato il costo, il paziente guarda nuovamente il proprio sorriso e mi chiede: «*Ma secondo lei ne vale davvero la pena?*». Per me è questo il momento in cui la strategia ha raggiunto il suo obiettivo, perché finalmente non si sta più chiedendo soltanto se sia possibile continuare, ma quanto sia realmente importante per lui farlo.

Naturalmente, la disponibilità a sostenere questo costo non rende accettabile qualsiasi richiesta. Questa possibilità riguarda esclusivamente la situazione che abbiamo appena descritto: gli obiettivi del trattamento sono stati raggiunti e la modifica richiesta non è necessaria, ma è precisa, clinicamente accettabile e ragionevolmente realizzabile. Se considero il movimento inutile, imprevedibile o potenzialmente dannoso, non procedo indipendentemente dalla disponibilità del paziente a pagare; allo stesso modo, se il paziente continua genericamente a dire «*non mi piacciono*» senza riuscire a identificare che cosa vorrebbe modificare, non abbiamo ancora un obiettivo sul quale costruire una nuova fase. Il costo non rende indicato un movimento che non lo è: entra in gioco soltanto dopo che abbiamo stabilito che quella modifica può essere effettuata, ma non è necessaria per completare il trattamento.

SCRIPT OPERATIVO

Quando considero raggiunti gli obiettivi del trattamento ma il paziente mi indica un ulteriore dettaglio che vorrebbe modificare, la conversazione può essere più o meno questa:

> *«Guardiamo insieme da dove siamo partiti e quali erano gli obiettivi che avevamo stabilito. Il dettaglio che mi stai mostrando lo vedo anch'io e possiamo provare a modificarlo, ma dal mio punto di vista non è necessaria un'altra rifinitura per completare il trattamento, perché gli obiettivi che avevamo concordato sono stati raggiunti.*
>
> *Se pensassi che ci fosse ancora qualcosa che dobbiamo correggere, sarei io il primo a proporti un'altra serie di allineatori e naturalmente non avrebbe alcun costo aggiuntivo. In questo caso, invece, stiamo parlando di un ulteriore perfezionamento che tu desideri ottenere oltre il risultato già raggiunto.*
>
> *Se per te questo dettaglio è abbastanza importante da voler continuare, possiamo valutarlo, purché riusciamo a definire esattamente che cosa vogliamo modificare*

> *e il movimento sia clinicamente accettabile e ragionevolmente prevedibile. Nel mio studio questa ulteriore fase ha un costo di 1.000 euro.*
>
> *Non ti sto consigliando di farla; al contrario, la mia raccomandazione è di fermarci. Ti sto semplicemente dando la possibilità di decidere se questo particolare sia per te abbastanza importante da giustificare un nuovo investimento e qualche altro mese di trattamento.»*

Se il paziente, a questo punto, mi domanda «*Ma secondo lei ne vale davvero la pena?*», la risposta deve essere coerente con ciò che gli ho appena spiegato. Se considero raggiunti gli obiettivi e il beneficio atteso marginale, gli dico esattamente questo. **Il costo non serve a vendere la rifinitura, ma a rendere reale la scelta di effettuarla.**

Perché questo protocollo funziona

- **Riporta il confronto al punto di partenza**

Con il passare del tempo il paziente tende ad abituarsi al risultato ottenuto e a spostare progressivamente l'attenzione su ciò che ancora potrebbe essere migliorato. Riprendere le fotografie iniziali non serve a convincerlo che debba essere soddisfatto, ma a evitare che l'ultimo piccolo dettaglio diventi l'unico parametro con cui giudicare l'intero trattamento.

- **Evita di suggerire che esista necessariamente qualcosa da correggere**

La domanda «C'è ancora qualcosa che vuoi cambiare?» contiene implicitamente un invito a cercare. Per questo preferisco effettuare prima la mia valutazione clinica e soltanto dopo ascoltare le eventuali osservazioni del paziente. Non riduco il suo coinvolgimento, ma evito di trasformare il controllo finale in una ricerca sistematica dell'imperfezione successiva.

- **Trasforma una possibilità in una decisione**

Quando un'altra rifinitura viene percepita come disponibile senza conseguenze, anche un beneficio molto piccolo può sembrare sufficiente per tentare. L'introduzione di un costo modifica questa valutazione perché rende nuovamente visibili alcuni aspetti che la possibilità di continuare aveva progressivamente fatto passare in secondo piano: il tempo, l'impegno e soprattutto il valore che il paziente attribuisce realmente al dettaglio che desidera modificare.

Il punto non è convincerlo attraverso il denaro, ma interrompere l'automatismo del «possiamo provare ancora». Per questo l'importo deve essere sufficientemente significativo da richiedere una scelta consapevole, pur rimanendo naturalmente

una decisione organizzativa che ogni professionista deve adattare alla propria realtà.

Mantiene separati desiderio e indicazione clinica

Il fatto che il paziente sia disposto a sostenere il costo non modifica il nostro giudizio clinico. Prima dobbiamo stabilire che la richiesta sia precisa, clinicamente accettabile e ragionevolmente realizzabile; soltanto dopo possiamo discutere l'eventuale fase aggiuntiva. **La disponibilità di altri allineatori non costituisce, da sola, un'indicazione a utilizzarli.**

BIBLIOGRAFIA

Zhao G, Zhu F. Age matters in orthodontics: divergent motivations, perfectionism, and patient-clinician discord in treatment need assessment. *Front Med (Lausanne).* 2026;12:1714237.

Chaptini A, Ghoubril J, Moussallem M, Khoury E. Perception thresholds of dental and gingival asymmetries by orthodontists, dentists, and laypeople when observing close-up smile images using eye tracking technology. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2025;167(2):177–187.

Correa BD, Bittencourt MAV, Machado AW. Influence of maxillary canine gingival margin asymmetries on the perception of smile esthetics among orthodontists and laypersons. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2014;145(1):55–63.

Pachêco-Pereira C, Pereira JR, Dick BD, Perez A, Flores-Mir C. Factors associated with patient and parent satisfaction after orthodontic treatment: a systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(4):652–659.

Al-Omiri MK, Abu Alhaija ES. Factors affecting patient satisfaction after orthodontic treatment. *Angle Orthod.* 2006;76(3):422–431.

Lee R, Hwang S, Lim H, Cha JY, Kim KH, Chung CJ. Treatment satisfaction and its influencing factors among adult orthodontic patients. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2018;153(6):808–817.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Con un paziente **D** tendo a essere diretto e orientato alla decisione: «Gli obiettivi che avevamo stabilito sono stati raggiunti. Possiamo tentare di modificare ancora questo dettaglio, ma non considero necessaria un'altra rifinitura. Se vuoi comunque proseguire, possiamo valutarla come una fase aggiuntiva.»

I

Influente

Con un paziente **I** riporto maggiormente l'attenzione sul cambiamento complessivo e sull'estetica sociale: «Guarda quanto è cambiato il tuo sorriso rispetto all'inizio. Il dettaglio che mi stai mostrando esiste, ma prima di continuare vorrei che valutassimo quanto sia realmente importante rispetto al risultato complessivo che abbiamo ottenuto.»

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

S

Stabile

Con un paziente **S** cerco soprattutto di evitare che la conclusione del trattamento venga vissuta come l'abbandono di qualcosa di incompleto: «Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati e considero corretto concludere qui il trattamento. Se questo particolare per te rimane molto importante possiamo comunque valutarlo, ma non è qualcosa che ritengo necessario correggere.»

C

Coscienzioso

Con un paziente **C** utilizzo criteri più analitici e verificabili: «Abbiamo controllato gli obiettivi iniziali e i parametri clinici che avevamo stabilito. Il dettaglio che osservi è reale e possiamo definirlo con precisione, ma il beneficio prevedibile di un'ulteriore rifinitura è limitato. Possiamo quindi valutare insieme se abbia realmente senso proseguire.»

CAPITOLO 11

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Quando il paziente continua a chiedere di proseguire dopo il raggiungimento degli obiettivi oppure esprime un'insoddisfazione senza identificare una modifica precisa.
OBIETTIVO	Distinguere un trattamento incompleto da una richiesta aggiuntiva e procedere soltanto con un obiettivo clinicamente appropriato e verificabile.
COSA FARE	1. Valutare se gli obiettivi concordati siano stati raggiunti. 2. Confrontare fotografie iniziali e situazione attuale, mostrando il cambiamento ottenuto. 3. Identificare la richiesta: quale dente, quale movimento, quale risultato dovrebbe essere diverso? 4. Se un obiettivo concordato non è stato raggiunto, completare il trattamento. 5. Se la richiesta è generica o clinicamente inappropriata, non avviare una nuova fase. 6. Se esiste un dettaglio reale, modificabile e clinicamente accettabile, ma non necessario per completare il trattamento, valutare una fase aggiuntiva. 7. Definire obiettivo, beneficio atteso, limiti ed eventuale costo prima di procedere. La disponibilità a pagare non rende appropriata una richiesta che non lo è.
COSA VERIFICARE	Obiettivi iniziali, risultato attuale, precisione della richiesta, beneficio prevedibile e comprensione dei criteri con cui considereremo conclusa l'eventuale fase aggiuntiva.

CAPITOLO

12

Il paziente al 95%

«Il meglio è nemico del bene.»

— VOLTAIRE

Ci sono pazienti che, quando si siedono sulla poltrona, ci fanno capire immediatamente che avremo davanti un trattamento complesso. Poi ce ne sono altri che producono esattamente la sensazione opposta. Sorridono e quasi ci chiediamo perché siano venuti: i denti sono già dritti, l'occlusione è buona, il sorriso è piacevole e magari hanno già fatto ortodonzia in passato. A una prima occhiata sembra esserci pochissimo da correggere. Poi il paziente indica un incisivo leggermente ruotato, un piccolo spazio, un dente appena fuori posizione e dice:

«Dottore, vorrei sistemare solo questa piccola cosa.»

Con il tempo ho imparato che proprio quel **solo** dovrebbe aumentare immediatamente la nostra attenzione.

Noi vediamo un piccolo movimento e siamo naturalmente portati a pensare a un piccolo trattamento: pochi allineatori, poco tempo, poca difficoltà. Ma non è necessariamente così. Anzi, alcuni dei trattamenti che sembrano più semplici dal punto di vista biomeccanico possono diventare tra i più delicati da gestire, perché quando la situazione di partenza è già molto buona anche un dettaglio minimo assume un peso completamente diverso.

Barry Glaser ha descritto molto bene questa situazione utilizzando l'espressione **"Tiny Touch-Up Patient"**. Partendo da questa stessa osservazione, nel tempo ho iniziato a chiamare questi pazienti i **pazienti al 95%**: pazienti che arrivano già molto vicini al risultato che desiderano e ci chiedono di intervenire soltanto su quel piccolo margine che ancora li separa dal loro obiettivo.

Immaginiamo due pazienti. Il primo arriva da noi con un problema evidente: denti visibilmente storti, un affollamento importante o comunque una situazione che desidera chiaramente cambiare. Alla fine del trattamento il risultato non sarà mai perfetto, perché la perfezione non è naturale e, in realtà, non esiste, ma il miglioramento sarà così evidente che il paziente non dovrà cercarlo: gli basterà confrontare il prima e il dopo per rendersi conto di quanto sia cambiato il suo sorriso. Il secondo paziente entra invece nel nostro studio con un sorriso già molto bello e i denti praticamente dritti. Non cerca una grande trasformazione: è venuto proprio per quel piccolo dettaglio che continua a vedere e che vorrebbe correggere.

Ed è questa la differenza che cambia completamente la prospettiva. Nel primo paziente il miglioramento è ampio, evidente e distribuito su molti aspetti del sorriso; nel paziente al 95%, invece, tutto il valore del trattamento viene concentrato su un dettaglio molto piccolo. Quello che per noi può rappresentare una minima correzione, per lui rappresenta l'intero motivo per cui ha deciso di iniziare una terapia: **quel 5%, per lui, rappresenta il 100% del problema**. Per questo considero il paziente al 95% potenzialmente più delicato di molti casi apparentemente complessi: **abbiamo poco margine per migliorare e moltissimo da preservare**.

Ed è proprio quella parola, *solo*, che rischia di condizionare anche noi. Se il paziente considera piccolo il problema, iniziamo facilmente a considerare piccolo anche il trattamento. «*Facilissimo*», «*ci vogliono pochi allineatori*», «*è una cosa da niente*» sono frasi apparentemente rassicuranti che ho smesso di utilizzare. Nel momento in cui diciamo che qualcosa sarà facilissimo, infatti, non stiamo più descrivendo soltanto la biomeccanica: stiamo costruendo un'aspettativa. Il paziente può interpretare quella frase come la garanzia che il risultato desiderato sarà semplice da ottenere e perfettamente prevedibile, mentre sappiamo bene che un movimento biologico non diventa perfettamente prevedibile soltanto perché è minimo.

C'è poi un altro aspetto che conviene chiarire fin dall'inizio: il fatto che il paziente veda un solo dente fuori posizione non significa necessariamente che il trattamento consista semplicemente nello spostare quel dente nel punto giusto. Per ruotare un incisivo potremmo aver bisogno di creare spazio, per chiudere un piccolo diastema potremmo dover controllare l'inclinazione dei denti vicini e, per mantenere una buona occlusione, potremmo dover coinvolgere altri elementi o persino entrambe le arcate. Un dente può inoltre non rispondere esattamente come previsto, può rendersi necessaria una rifinitura e possono entrare in gioco il torque, i contatti con i denti vicini, i tessuti parodontali o limiti anatomici che il paziente non può conoscere quando ci chiede di «*spostare appena questo dente*». Spiegarlo prima è importante, perché il nostro obiettivo rimane correggere quel dettaglio, ma per farlo correttamente potremmo dover intervenire anche su denti che il paziente considera già perfettamente a posto. Se questo non è stato chiarito dall'inizio, ogni movimento che va oltre il singolo dente può essere vissuto come qualcosa che non aveva richiesto. **La dimensione apparente del problema, da sola, non ci dice quanto sarà semplice ottenere esattamente il risultato che abbiamo in mente.**

Lo stesso equivoco può verificarsi sul piano economico. Il paziente vede un solo dente da muovere e può pensare che, essendo una cosa piccola, anche il trattamento debba necessariamente costare poco. Naturalmente ogni collega stabilirà liberamente il proprio modello economico, ma pochi allineatori non significano automaticamente poco valore o poca responsabilità: anche un piccolo trattamento richiede diagnosi, pianificazione e responsabilità clinica. **Il paziente non sta acquistando quattro, sei o dieci allineatori: sta affrontando un trattamento ortodontico.**

Definire l'obiettivo prima di iniziare

Con questi pazienti considero fondamentale rallentare proprio quando tutto sembra suggerirci di andare veloci. Prima di iniziare devo capire con precisione che cosa il paziente vuole cambiare, non in modo generico ma in maniera molto specifica. Guardo con lui le fotografie, la scansione e la situazione clinica, gli chiedo di indicarmi esattamente ciò che non gli piace e cerco di capire quale risultato immagina. Poi gli faccio una domanda che considero fondamentale: **«Se riuscissimo a correggere esattamente questa cosa e tutto il resto rimanesse identico a com'è oggi, saresti soddisfatto?»**

È una domanda molto semplice, ma spesso permette di capire immediatamente se la richiesta sia davvero circoscritta. Se la risposta è un sì netto, abbiamo identificato un obiettivo preciso e condiviso. Se invece arriva un «*Sì… però magari, già che*

ci siamo, potremmo anche...», significa che probabilmente quella piccola correzione non è l'unica cosa che il paziente vorrebbe cambiare, ed è molto meglio scoprirlo prima di iniziare. Nei casi più delicati ritengo utile che ciò che abbiamo concordato venga addirittura **condiviso e firmato dal paziente**, non per trasformare il rapporto medico-paziente in qualcosa di legale o difensivo, ma semplicemente perché rimanga chiaro nel tempo il motivo per cui abbiamo iniziato il trattamento e quale risultato ci siamo proposti di raggiungere.

Se il paziente vuole ruotare leggermente un incisivo, il riferimento sarà quella rotazione; se vuole chiudere un piccolo spazio, sarà la chiusura di quello spazio. Può sembrare una distinzione banale, ma stabilire con precisione il punto di arrivo significa anche stabilire quando il trattamento potrà essere considerato concluso. **Se non sappiamo che cosa deve accadere per poter dire "abbiamo finito", ogni miglioramento rischia semplicemente di diventare il punto di partenza per una nuova richiesta.**

Una volta raggiunto l'obiettivo iniziale, infatti, può accadere che l'attenzione del paziente si sposti su qualcosa che prima passava inosservato. Questo non significa necessariamente che abbiamo davanti una persona cronicamente insoddisfatta: può essere semplicemente la conseguenza del cambiamento ottenuto. Il punto è distinguere ciò che manca per raggiungere l'obiettivo concordato da una nuova richiesta. Se il paziente era venuto per chiudere uno spazio e quello spazio non è completamente chiuso, stiamo ancora completando il trattamento; se invece lo abbiamo chiuso come concordato e adesso compare un altro dettaglio da modificare, stiamo parlando di qualcosa di diverso. Il paziente raramente lo presenta in questi termini. Più spesso dice: *«Già che ci siamo...»*. Ed è proprio quel *già che ci siamo* che può trasformare un piccolo ritocco in un percorso senza una vera conclusione.

C'è un caso che probabilmente mi ha insegnato più di tutti gli altri quanto possa essere pericoloso confondere il desiderio di accontentare un paziente con la scelta clinicamente più corretta, e che ancora oggi considero uno degli episodi più stressanti della mia esperienza professionale. Nadia era la mamma di un mio piccolo paziente che avevo trattato per una terza classe con un espansore mascellare. Era molto soddisfatta del risultato ottenuto dal figlio e, durante uno dei suoi controlli, mi disse quasi scherzando: *«Doc, prima o poi dobbiamo mettere mano anche ai miei denti»*. Le chiesi che cosa non le piacesse e lei mi spiegò che, nel complesso, il sorriso le andava bene, ma percepiva l'arcata superiore un po' stretta e soprattutto non le piaceva la posizione dell'incisivo laterale superiore destro, il 12, leggermente lingualizzato rispetto agli altri denti. Nelle fotografie quel dente rimaneva più in ombra e sembrava più scuro, ed era proprio quel dettaglio che la disturbava.

Visto che era già in studio, le proposi di fare una scansione per capire meglio la situazione. Fu proprio quella scansione a mostrarci che il caso era meno semplice di quanto potesse sembrare guardando soltanto il laterale: Nadia presentava una tendenza alla terza classe, una tendenza al crossbite sul lato destro nella zona dei premolari e del primo molare e un certo affollamento nell'arcata inferiore. Le spiegai che, se avessimo voluto impostare un trattamento ortodontico completo, avremmo dovuto considerare entrambe le arcate e correggere l'intero equilibrio occlusale. Lei, però, fu molto chiara: dell'affollamento inferiore non le interessava nulla, perché «*tanto sotto non si vedeva*», mentre ciò che voleva davvero era portare più vestibolarmente quel laterale superiore che nelle fotografie rimaneva in ombra. Accettai quindi di eseguire un trattamento limitato all'arcata superiore con una formula commerciale limitata a 20 allineatori. L'obiettivo era preciso e relativamente semplice: correggere la posizione del 12 senza trasformare quella richiesta in un trattamento ortodontico completo che la paziente, in quel momento, non desiderava affrontare.

Dopo circa dieci-dodici allineatori, in poco più di tre mesi, raggiungemmo esattamente quello che Nadia mi aveva chiesto. Il laterale era nella posizione corretta, il sorriso era migliorato e lei era molto soddisfatta. Le chiesi esplicitamente se il risultato le piacesse e mi confermò di sì, per cui, rispetto all'obiettivo per cui era venuta inizialmente, il trattamento avrebbe potuto essere considerato concluso. Fu proprio a quel punto, però, che Nadia iniziò a guardare il suo sorriso in modo diverso: cominciò a notare maggiormente la zona posteriore destra e mi disse che avrebbe voluto vedere l'arcata un po' più ampia nella zona dei premolari, riducendo quello che percepiva come un corridoio buccale troppo evidente. Le spiegai perché non ritenevo fosse una buona idea limitarsi a espandere l'arcata superiore: da una parte avremmo dovuto mantenere una corretta relazione con l'arcata inferiore, altrimenti avremmo rischiato di creare precontatti; dall'altra, espandendo i premolari, avremmo inevitabilmente creato spazi difficili da gestire. Nadia però insisteva. Non voleva una grande espansione, mi diceva «*solo un pochino, quello che si può fare*».

Ed è qui che commisi l'errore. Mi sembrava di conoscerla, avevo trattato suo figlio, fino a quel momento il rapporto era stato eccellente e Nadia mi era sempre sembrata una persona ragionevole. Per questo decisi di venirle incontro e le proposi una nuova scansione, spiegandole che avrei preparato una simulazione estremamente prudente, con la minima espansione che ritenevo compatibile con l'occlusione. Quando tornò per vedere il setup accadde qualcosa che oggi riconosco immediatamente come uno dei segnali più importanti del paziente al 95%: guardò la simulazione e mi disse che avrebbe voluto un po' più di espansione. Modificai

leggermente il setup e le mostrai che, aumentando il movimento, avremmo potuto creare degli spazi e modificare i rapporti con l'arcata inferiore, ma lei mi chiese ancora un piccolo incremento. Le feci vedere nuovamente quali potevano essere le conseguenze, insistendo sul rischio di creare precontatti e sulla necessità di trovare un compromesso, fino a quando mi disse che quella quantità di espansione le sembrava sufficiente e approvai la rifinitura.

Tre mesi dopo Nadia tornò estremamente insoddisfatta. L'espansione dei premolari aveva creato piccoli spazi nei quali tendeva a inserirsi il cibo e, nel tentativo di gestire la forma d'arcata, il canino superiore destro era rientrato leggermente e aveva sviluppato un contatto prematuro con il canino inferiore. A quel punto cercai di correggere il problema con una seconda rifinitura, riportando il canino più vestibolare e modificando nuovamente la posizione dei premolari, ma ogni volta che correggevo un aspetto ne emergeva un altro: migliorava il canino, ma cambiavano i contatti posteriori; sistemavamo i contatti e compariva qualche altro dettaglio che Nadia percepiva come fastidioso. Quello che era nato come un piccolo ritocco stava progressivamente diventando un trattamento senza una vera fine. Pur di cercare ancora di soddisfarla, arrivai addirittura ad aprire, a mie spese, un nuovo caso per avere a disposizione ulteriori serie di allineatori e continuare a cercare una soluzione che potesse renderla finalmente contenta. Quello che inizialmente era stato un trattamento di circa tre mesi, concluso con una paziente soddisfatta del risultato ottenuto sull'incisivo laterale, diventò così un percorso di quindici-diciotto mesi.

Ogni appuntamento diventava progressivamente più difficile e una visita che normalmente sarebbe durata dieci minuti poteva trasformarsi in un'ora o persino un'ora e mezza di discussioni. Nadia era sempre più arrabbiata, io sempre più stressato e il rapporto che all'inizio era stato eccellente si deteriorava visita dopo visita. Ricordo ancora perfettamente la sensazione che provavo quando vedevo il suo nome comparire in agenda: sapevo che mi aspettava un appuntamento lungo e difficile e, ancora prima che arrivasse in studio, sentivo già crescere una tensione che finiva per accompagnarmi per tutta la giornata. Continuavo a ricordarle che, prima di iniziare quella seconda fase, le avevo spiegato più volte perché non ritenevo opportuno espandere soltanto l'arcata superiore. La sua risposta, però, fu probabilmente una delle lezioni più importanti che abbia mai ricevuto da un paziente:

«Sì, dottore, ma sei tu il medico. Avresti dovuto dirmi di no.»

Con il tempo ho dovuto ammettere che, in quella frase, Nadia aveva ragione. Non perché io non avessi compreso la biomeccanica del caso, perché l'avevo compresa perfettamente e gliel'avevo anche spiegata, ma perché, una volta stabilito che quella

richiesta non era clinicamente opportuna, la responsabilità di mantenere quel limite rimaneva mia. Il paziente può insistere, può dirci che accetta il rischio, può chiederci «*soltanto un pochino*», ma siamo comunque noi a decidere se quel movimento debba essere eseguito. La storia arrivò molto vicina a trasformarsi in un vero contenzioso medico-legale: Nadia chiese un'altra valutazione e le venne spiegato che, per correggere correttamente la situazione, sarebbe stato opportuno trattare entrambe le arcate e impostare il caso in maniera complessiva, in pratica proprio il tipo di trattamento che le avevo proposto all'inizio e che lei aveva rifiutato.

Alla fine, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, decisi di rimborsarle completamente quanto aveva pagato. Il bilancio fu pesante sotto ogni punto di vista: avevo sostenuto personalmente il costo di due casi, avevo restituito l'intero compenso, avevo utilizzato una quantità enorme di tempo clinico e di energie dello staff e un trattamento che avrebbe potuto concludersi brillantemente dopo tre mesi era durato più di un anno. Nadia era insoddisfatta, io lo ero altrettanto e una paziente che inizialmente aveva una fiducia enorme nello studio difficilmente avrebbe continuato a parlare di noi con lo stesso entusiasmo con cui lo aveva fatto dopo il trattamento del figlio. Ma il costo maggiore, almeno per me, non fu economico: fu lo stress generato da una situazione che avevo contribuito io stesso a creare nel tentativo di accontentare una paziente, nonostante sapessi fin dall'inizio che quel tipo di espansione limitata all'arcata superiore non rappresentava la soluzione che avrei scelto clinicamente.

Con il senno di poi, il momento in cui avrei dovuto fermarmi è molto facile da individuare: era l'appuntamento dopo il primo set, quando Nadia era soddisfatta e il laterale per cui era venuta era nella posizione corretta. L'obiettivo concordato era stato raggiunto e tutto ciò che venne dopo non fu il completamento di quel trattamento, ma l'inizio di un nuovo trattamento che io stesso non ritenevo clinicamente corretto e che accettai comunque nel tentativo di accontentarla. È esattamente questo il pericolo del paziente al 95%: non tanto il piccolo movimento per cui viene inizialmente da noi, quanto la possibilità che, una volta raggiunto quell'obiettivo, il bersaglio si sposti e noi continuiamo a inseguirlo, fino a perdere di vista il confine tra ascoltare ciò che il paziente desidera e assecondare una richiesta che non riteniamo più clinicamente corretta.

Oggi, davanti alla stessa situazione, la mia risposta sarebbe molto diversa: «*Capisco perfettamente quello che vorresti migliorare e capisco anche perché adesso, guardando il sorriso in modo diverso, questa cosa ti dia più fastidio. Il problema è che, per cercare di ottenere quella modifica, dovrei intervenire su un equilibrio che oggi funziona bene e non sono sicuro che sarebbe la scelta migliore per te. Se vuoi, possiamo ragionare insieme su un*

trattamento più completo che prenda in considerazione anche questo aspetto; altrimenti, rispetto all'obiettivo per cui avevamo iniziato, credo che possiamo considerare il trattamento concluso». Questa esperienza mi ha insegnato una regola che oggi considero fondamentale nella gestione dei pazienti al 95%: **ascoltare il paziente significa prendere sul serio ciò che desidera, ma non significa fare necessariamente ciò che ci chiede.**

Preservare il 95%

Il caso di Nadia ha cambiato profondamente il modo in cui affronto questi pazienti. Prima di chiedermi come ottenere il movimento che mi stanno chiedendo, oggi cerco di capire che cosa rischio di modificare nel tentativo di ottenerlo. Una situazione di partenza molto buona contiene infatti un paradosso: abbiamo poco da guadagnare, perché il difetto che vogliamo correggere è piccolo, ma possiamo avere molto da perdere, perché intorno a quel difetto esistono denti, contatti e rapporti occlusali che funzionano già correttamente. Ogni movimento deve quindi offrire un beneficio che giustifichi ciò che siamo costretti a modificare per realizzarlo.

La prima verifica riguarda l'indicazione, perché non sempre ciò che viene percepito come un problema di posizione dipende realmente dalla posizione del dente. Una differenza tra due incisivi può dipendere dalla forma delle corone, dai margini incisali, dalla gengiva, dall'usura, dal colore o semplicemente dal modo in cui la luce colpisce due superfici differenti. In questi casi continuare a muovere un dente può non risolvere affatto ciò che disturba il paziente, mentre una piccola correzione restaurativa, un rimodellamento del margine incisale o, in casi selezionati, un intervento sui tessuti gengivali possono produrre un risultato molto più proporzionato. La domanda da farci diventa quindi: **sto cercando di correggere con l'ortodonzia qualcosa che appartiene davvero all'ortodonzia?**

Anche quando la risposta è sì, però, un piccolo movimento rimane un movimento biologico. Con gli allineatori possiamo programmare sullo schermo rotazioni di pochi gradi, estrusioni di qualche decimo di millimetro, variazioni di torque o chiusure di spazi estremamente precise, ma ciò che vediamo nel software rimane un progetto e la risposta clinica non diventa matematicamente prevedibile soltanto perché il movimento è piccolo. Questo assume un'importanza ancora maggiore quando proprio quel movimento rappresenta l'intera ragione per cui il paziente ha deciso di iniziare il trattamento.

Dobbiamo poi pensare fin dall'inizio anche alla stabilità. Nel paziente che ha corretto un problema importante, una minima variazione della posizione di un dente

può persino passare inosservata; nel paziente venuto esclusivamente per chiudere mezzo millimetro di spazio o correggere una piccola rotazione, la stessa recidiva può rappresentare la ricomparsa esatta del motivo per cui aveva deciso di trattarsi. **La contenzione, quindi, non può essere un dettaglio da discutere alla fine, ma deve fare parte della conversazione iniziale.**

Il paziente ci sta chiedendo di correggere il 5%. Noi abbiamo la responsabilità di non danneggiare il 95% che possiede già.

SCRIPT OPERATIVO

Con un paziente di questo tipo preferisco affrontare la questione prima ancora di iniziare, perché la chiarezza iniziale evita quasi sempre conversazioni molto più difficili alla fine:

> *«La tua situazione di partenza è già molto buona e questa è una cosa positiva. Proprio per questo dobbiamo essere molto precisi nel definire che cosa vuoi cambiare, perché mi stai chiedendo di intervenire su un piccolo dettaglio all'interno di una situazione che funziona già bene. Prima dobbiamo capire se ciò che ti disturba dipende davvero dalla posizione del dente e, se è così, quello diventerà il nostro obiettivo. Tieni però presente che, anche se vuoi correggere un solo dente, potremmo aver bisogno di muoverne altri, creare spazio o lavorare su entrambe le arcate per farlo correttamente senza compromettere ciò che oggi funziona già.*
>
> *Se decidiamo di iniziare, definiamo insieme il risultato che vogliamo ottenere e anche quando potremo considerare il trattamento concluso. Se raggiungiamo quell'obiettivo, avremo ottenuto ciò per cui abbiamo iniziato. Se strada facendo dovessi notare un altro dettaglio, naturalmente lo valuteremo insieme, ma sarà una nuova richiesta e dovremo capire se abbia davvero senso intervenire. E proprio perché stiamo correggendo qualcosa di molto piccolo, dobbiamo pensare fin dall'inizio anche a come mantenere il risultato nel tempo.»*

Il tono deve rimanere positivo. Non stiamo cercando di spaventare il paziente né di costruire una serie di clausole difensive; stiamo semplicemente chiarendo che accettiamo di correggere **un obiettivo definito**, non di iniziare un percorso di perfezionamento senza una conclusione.

Perché questo protocollo funziona

■ **Definisce il bersaglio prima di iniziare**

Nel paziente al 95% il dettaglio che desidera correggere rappresenta una parte minima del sorriso, ma quasi tutto il motivo per cui ha deciso di iniziare il trattamento. Definirlo con precisione consente a medico e paziente di sapere fin dall'inizio che cosa stanno cercando di ottenere e, soprattutto, di riconoscere quando quell'obiettivo è stato raggiunto.

■ **Ridimensiona il significato della parola "solo"**

Un piccolo problema non implica necessariamente un trattamento banale. Spiegare fin dall'inizio che potremmo dover coinvolgere altri denti, creare spazio o intervenire su entrambe le arcate evita che ogni movimento necessario venga interpretato come qualcosa di inatteso. **La dimensione del problema percepito non determina necessariamente la complessità del trattamento necessario per correggerlo.**

■ **Protegge ciò che funziona già**

Partire da una situazione molto buona modifica il rapporto tra beneficio atteso e ciò che dobbiamo preservare. Prima di accettare la richiesta dobbiamo quindi verificare non soltanto se il movimento sia possibile, ma se sia ortodonticamente indicato e se il beneficio atteso giustifichi le modifiche necessarie per ottenerlo.

■ **Definisce contemporaneamente risultato e stabilità**

Nel paziente al 95% una piccola recidiva può equivalere alla ricomparsa dell'intero problema percepito. Discutere la contenzione prima del trattamento rende quindi chiaro che correggere il dettaglio rappresenta soltanto una parte del percorso: l'altra consiste nel riuscire a conservarlo.

BIBLIOGRAFIA

Haouili N, Kravitz ND, Vaid NR, Ferguson DJ, Makki L. Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2020;158(3):420–425.

Kokich VO Jr, Kiyak HA, Shapiro PA. Comparing the perception of dentists and lay people to altered dental esthetics. *J Esthet Dent.* 1999;11(6):311–324.

Al-Moghrabi D, Littlewood SJ, Fleming PS. Orthodontic retention protocols: an evidence-based overview. *Br Dent J.* 2021;230(11):770–776.

Pachêco-Pereira C, Pereira JR, Dick BD, Perez A, Flores-Mir C. Factors associated with patient and parent satisfaction after orthodontic treatment: a systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(4):652–659.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Con il paziente **D** vado rapidamente al risultato e ai confini del trattamento: «*La situazione è già molto buona. Definiamo esattamente il dettaglio che vuoi correggere e il risultato che vogliamo raggiungere. Potremmo dover coinvolgere anche altri denti per farlo correttamente, ma il nostro obiettivo rimarrà quello che abbiamo concordato. Una volta raggiunto, il trattamento sarà concluso.*»

I

Influente

Con il paziente **I** coinvolgo maggiormente l'immagine del sorriso e la condivisione del risultato: «*Partiamo già da una situazione molto bella e proprio per questo voglio proteggere tutto ciò che funziona. Fammi vedere esattamente qual è il dettaglio che vorresti migliorare: lo definiamo insieme e lo documentiamo, così alla fine potremo confrontare il risultato con ciò che volevi ottenere. Quando avremo raggiunto quell'obiettivo, il trattamento sarà concluso e poi sarà fondamentale mantenerlo.*»

S

Stabile

Con il paziente **S** sottolineo soprattutto che non vogliamo stravolgere una situazione che funziona già bene: «*Partiamo da una situazione molto favorevole e l'obiettivo non è cambiare tutto, ma intervenire con prudenza proprio su questo dettaglio mantenendo stabile ciò che funziona. Prima di iniziare definiamo insieme che cosa vuoi ottenere e ti spiego quali denti potrebbe essere necessario coinvolgere, così durante il percorso non avrai sorprese.*»

C

Coscienzioso

Con il paziente **C** utilizzo una struttura più analitica: «*Il dettaglio che mi stai indicando va prima analizzato per capire da cosa dipenda realmente. Se è un problema di posizione dentale, valuteremo il movimento necessario e il suo effetto su spazio, contatti e occlusione; se dipende invece dalla forma del dente o dai tessuti circostanti, potremmo considerare una soluzione diversa. Definiamo quindi l'obiettivo, i criteri con cui considereremo il trattamento completato e come manterremo il risultato.*»

CAPITOLO 12

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Quando il paziente parte da una situazione già favorevole e chiede di correggere un dettaglio, presentandolo come un intervento minimo.
OBIETTIVO	Correggere il dettaglio quando indicato, proteggendo ciò che funziona già e definendo prima il punto di arrivo.
COSA FARE	1. Identificare esattamente il dente, il dettaglio e il risultato desiderato. 2. Verificare che il problema dipenda dalla posizione dentale e che il movimento sia ortodonticamente indicato. 3. Valutare quali denti, contatti ed equilibri dovranno essere coinvolti e quali debbano essere preservati. 4. Spiegare che una richiesta limitata può richiedere movimenti più estesi di quanto il paziente immagini. 5. Definire e documentare l'obiettivo e i criteri di conclusione, distinguendoli da eventuali nuove richieste. 6. Chiarire che un piccolo movimento rimane biologico e non consente promesse di precisione matematica. 7. Programmare la contenzione fin dall'inizio: una minima recidiva può riproporre l'intero problema percepito.
COSA VERIFICARE	Origine del difetto, indicazione clinica, effetti sull'occlusione, aspettative, raggiungimento dell'obiettivo e mantenimento del risultato. Non sottovalutare il "solo": quel dettaglio può rappresentare il 100% del motivo per cui il paziente vuole trattarsi.

CAPITOLO

13

Quando finire non significa aver finito

«Finis coronat opus.»

— PROVERBIO LATINO MEDIEVALE

Per anni ho osservato nei miei pazienti qualcosa che non riuscivo a spiegarmi completamente. Avevo la sensazione che alcuni risultati ottenuti con gli allineatori tendessero a recidivare più facilmente rispetto a quelli che avevo trattato con apparecchiatura fissa. Non succedeva in tutti i casi e non riguardava tutti i movimenti nello stesso modo, ma nella mia esperienza erano soprattutto le rotazioni e alcuni movimenti verticali, come intrusioni ed estrusioni, a richiamare la mia attenzione.

All'inizio si trattava soltanto di un'impressione clinica e, proprio per questo, non potevo trasformarla automaticamente in una conclusione. La prima spiegazione che ho preso in considerazione è stata quella più immediata: forse non stavo

osservando un problema di stabilità, ma semplicemente movimenti che con gli allineatori erano più difficili da ottenere completamente. La letteratura ci ricorda infatti che l'efficacia del trattamento non è identica per ogni tipo di movimento e che il controllo di alcune rotazioni, del torque e dei movimenti verticali può rappresentare una sfida maggiore rispetto ad altri spostamenti.

Questa spiegazione, tuttavia, non riusciva a giustificare completamente ciò che vedevo, perché non stavo guardando soltanto denti che non avevano raggiunto la posizione programmata. In molti casi quella posizione era stata raggiunta correttamente; la difficoltà compariva dopo, quando si trattava di mantenerla.

Ho iniziato quindi a chiedermi se non stessi osservando il problema dal punto di vista sbagliato. Forse la domanda non era soltanto **come avevo mosso quel dente**, ma **quanto tempo gli avevo concesso per stabilizzarsi dopo averlo mosso**.

Quando spostiamo ortodonticamente un dente, infatti, non stiamo semplicemente cambiando le coordinate della sua corona all'interno dell'arcata, ma stiamo modificando un sistema biologico costituito da osso, legamento parodontale e tessuti gengivali, che devono progressivamente adattarsi alla nuova posizione. La conclusione del movimento ortodontico e la fine della riorganizzazione biologica, quindi, non coincidono necessariamente.

I lavori classici sulla stabilità post-trattamento hanno mostrato che i diversi tessuti non si riorganizzano tutti con la stessa velocità. Il legamento parodontale tende a riorganizzarsi nell'arco di circa tre-quattro mesi, mentre le fibre collagene gengivali possono richiedere quattro-sei mesi. Ancora più lentamente possono comportarsi alcune componenti delle fibre sopracrestali, descritte nei lavori istologici classici come non completamente riorganizzate **a 232 giorni dalla conclusione del movimento ortodontico**, soprattutto dopo la correzione delle rotazioni.

Proprio quest'ultimo dato ha attirato la mia attenzione: **232 giorni significano quasi otto mesi**. Non significa che tutti i denti abbiano bisogno di quasi otto mesi per diventare stabili, né che la letteratura suggerisca il protocollo che ho successivamente sviluppato. Mi ha permesso però di mettere meglio a fuoco un concetto fondamentale: **un dente può aver terminato il proprio movimento molto prima che i tessuti che lo circondano abbiano completato il loro adattamento alla nuova posizione.**

A quel punto ho iniziato a pensare anche a una differenza molto semplice tra apparecchiatura fissa e allineatori. Con il fisso una rotazione può essere completamente corretta nelle prime fasi della terapia, così come una curva di Spee può essere appiattita o un movimento verticale completato molto prima della rimozione dell'apparecchiatura. Il trattamento, però, continua: procediamo con archi più

rigidi, meccaniche sagittali, controllo degli spazi e rifinitura dell'occlusione, mentre quel dente rimane per mesi all'interno di un sistema che ne limita lo spostamento.

Quando finalmente rimuoviamo l'apparecchio, può quindi essere trascorso molto tempo dalla conclusione di quello specifico movimento. È qui che ho iniziato a formulare una possibile spiegazione di ciò che osservavo: **con l'apparecchiatura fissa una parte della stabilizzazione potrebbe avvenire mentre il trattamento è ancora in corso.**

Con gli allineatori, invece, questo intervallo può essere molto più breve. Una rotazione, un'intrusione o un'estrusione possono essere programmate fino agli ultimi allineatori e, se necessario, essere nuovamente corrette durante una rifinitura. Possiamo quindi arrivare alla fine del trattamento attivo praticamente nello stesso momento in cui stiamo completando proprio uno dei movimenti che consideriamo più delicati.

Questo mi ha portato a guardare la durata del trattamento da un punto di vista diverso. **Diciotto mesi di terapia non significano necessariamente diciotto mesi di stabilizzazione per ogni movimento che abbiamo eseguito.** Due pazienti possono aver effettuato entrambi diciotto mesi di trattamento, ma un incisivo potrebbe trovarsi nella sua posizione definitiva da nove mesi nel primo paziente e soltanto da poche settimane nel secondo.

Questa rimane una mia ipotesi clinica, non un meccanismo dimostrato dalla letteratura. Insieme a ciò che sappiamo sui tempi di riorganizzazione dei tessuti, mi ha però portato a modificare il modo in cui concludevo i miei trattamenti.

Da questa riflessione è nato il mio protocollo di stabilizzazione.

Nove mesi che prima non esistevano

Un tempo, quando ero soddisfatto del risultato, il passaggio era molto semplice: terminavo il trattamento attivo, eseguivo la scansione per le contenzioni e chiedevo al paziente di utilizzarle durante la notte, secondo il protocollo che descriverò nel capitolo successivo. In sostanza, passavo quasi direttamente dalle circa ventidue ore di utilizzo degli allineatori alle circa dieci ore della contenzione notturna.

A un certo punto ho smesso di farlo. Se i tessuti avevano bisogno di tempo per riorganizzarsi, mi sembrava poco coerente completare gli ultimi movimenti e, immediatamente dopo, ridurre drasticamente le ore durante le quali quei denti venivano mantenuti nella posizione appena raggiunta. Ho quindi inserito tra il trattamento attivo e la contenzione definitiva una fase che prima non esisteva: **la fase di stabilizzazione**.

Nella mia pratica dura complessivamente nove mesi. Questa durata non deriva da uno studio che abbia dimostrato che nove mesi rappresentino il periodo ideale, ma è una decisione clinica maturata nel tempo, mettendo insieme ciò che osservavo nei miei pazienti e la lunga finestra biologica descritta per la riorganizzazione di alcuni tessuti sopracrestali, fino ai **232 giorni** di cui abbiamo parlato.

A quel punto dovevo però capire come organizzare quei nove mesi. Non volevo che diventassero semplicemente un lungo periodo di attesa, ma che accompagnassero progressivamente il paziente dalle circa ventidue ore della fase attiva alle circa dieci ore della futura contenzione notturna. Li ho quindi divisi in **tre fasi consecutive di tre mesi**, ciascuna con un obiettivo preciso.

Tre mesi per stabilizzare. Tre mesi per scalare. Tre mesi per assestare.

È nata così la sequenza che utilizzo ancora oggi, il **Protocollo di Stabilizzazione Pasciuti 3-3-3**, che prevede complessivamente 24 allineatori di stabilizzazione. Lo riservo però ai pazienti per i quali esistono condizioni cliniche adeguate e una collaborazione sufficiente: se la mancata collaborazione rende irrealistico aggiungere altri nove mesi di allineatori, concludo la fase attiva e passo direttamente alla contenzione.

I primi tre mesi: stabilizzare

I primi dodici allineatori vengono utilizzati esattamente come quelli attivi che li hanno preceduti: uno alla settimana, circa ventidue ore al giorno. Per il paziente cambia apparentemente molto poco, perché continua la routine alla quale si è abituato durante il trattamento; dal punto di vista terapeutico, invece, cambia completamente l'obiettivo. Non sto più cercando di modificare l'occlusione o di completare nuovi movimenti clinicamente significativi, ma di mantenere quanto ottenuto e concedere ai tessuti un primo periodo di adattamento alla posizione raggiunta.

I secondi tre mesi: scalare

Terminati i primi dodici allineatori, inizio a ridurre progressivamente le ore di utilizzo. L'allineatore numero 13 viene utilizzato ventuno ore al giorno, il numero 14 venti ore, il numero 15 diciannove e così via, diminuendo di un'ora a ogni cambio settimanale fino ad arrivare all'allineatore numero 24, utilizzato per dieci ore al giorno.

In questo modo il passaggio dalla copertura pressoché continua all'utilizzo notturno non avviene improvvisamente: ogni settimana concediamo un'ora in più senza allineatore, accompagnando progressivamente il paziente verso la fase successiva.

Gli ultimi tre mesi: assestare

Quando il paziente arriva all'allineatore numero 24, il programma cambia ancora una volta. Non deve più sostituirlo, ma continua a utilizzare **quello stesso allineatore per i successivi tre mesi**, soltanto durante la notte, per circa dieci ore.

A questo punto sono trascorsi sei mesi dalla conclusione dei movimenti attivi e non voglio più soltanto mantenere i denti nella posizione raggiunta: voglio lasciare maggiore spazio anche alla funzione, perché l'occlusione possa progressivamente trovare il proprio equilibrio.

Ho sempre pensato che il compito dell'ortodontista non sia quello di costruire un'occlusione sullo schermo e poi cercare di immobilizzarla indefinitamente in quella posizione. Il nostro obiettivo è portare i denti nelle condizioni migliori perché, una volta terminati i movimenti ortodontici, anche la masticazione, i contatti e la funzione possano contribuire al loro assestamento.

Per questo, durante gli ultimi tre mesi, nelle ore diurne non esiste più materiale interposto tra le arcate e i denti tornano a entrare in contatto durante la funzione, favorendo quel progressivo assestamento dell'occlusione che definiamo **settling**.

La scelta di mantenere lo stesso allineatore per tutti e tre i mesi è intenzionale. Un materiale termoplastico utilizzato ripetutamente non mantiene necessariamente nel tempo le stesse caratteristiche meccaniche che possedeva quando era nuovo. Fenomeni viscoelastici come il rilassamento delle tensioni (*stress relaxation*) determinano una progressiva modificazione delle forze esercitate dal materiale.

Non considero questa progressiva modificazione delle proprietà meccaniche dell'allineatore la causa del *settling*, né il mio protocollo è stato studiato sperimentalmente per dimostrare una relazione di questo tipo. **La scelta di mantenere lo stesso allineatore fa parte piuttosto di una strategia nella quale l'allineatore deve progressivamente smettere di comportarsi come qualcosa che cerca di controllare rigidamente ogni dettaglio dell'occlusione**, continuando però a proteggere durante la notte la posizione raggiunta.

Al termine di questa fase sono trascorsi **nove mesi dalla conclusione dei movimenti attivi**. Solo a quel punto considero concluso il periodo di stabilizzazione ed eseguo una nuova scansione per realizzare la contenzione definitiva.

Nella pratica: come ottengo i 24 allineatori di stabilizzazione

C'è però un problema molto pratico: decidere di utilizzare ventiquattro allineatori di stabilizzazione non significa necessariamente poterli ordinare come ventiquattro copie passive della stessa posizione finale. I sistemi commerciali possono porre

limiti alla possibilità di richiedere sequenze così lunghe senza movimenti programmati.

Nel tempo ho quindi sviluppato una strategia di progettazione che mi consente di ottenere la sequenza necessaria al protocollo. Alla fine della terapia eseguo una nuova scansione e richiedo una rifinitura; quando ricevo il nuovo setup digitale elimino tutti i movimenti dentali proposti e riporto sostanzialmente il progetto alla posizione ottenuta alla fine del trattamento precedente.

Questo determinerebbe però la produzione di un solo allineatore per arcata. Per ottenere i ventiquattro allineatori seleziono quindi due denti terminali, solitamente i secondi o terzi molari, uno per arcata, e su ciascuno programmo intenzionalmente un movimento clinicamente insignificante, come **0,2 mm di intrusione** oppure un minimo movimento radicolare di torque o tip.

Il software riconosce così la presenza di un movimento e genera una sequenza di allineatori. A quel punto intervengo sullo staging, rallentando intenzionalmente quella minima attivazione fino a distribuirla sui **ventiquattro allineatori** necessari al protocollo.

Dal punto di vista digitale questi allineatori non sono quindi completamente passivi, perché nel setup rimane una micro-attivazione programmata su un singolo dente terminale per ciascuna arcata. **Dal punto di vista clinico, però, quella micro-attivazione è irrilevante ai fini del trattamento:** viene inserita esclusivamente come espediente di progettazione per ottenere il numero di allineatori necessario al protocollo.

Questa procedura rappresenta una soluzione tecnica che utilizzo nella mia pratica con il sistema con cui lavoro; non è una procedura indicata dal produttore né un protocollo validato dalla letteratura e deve naturalmente essere adattata alle caratteristiche del sistema utilizzato e del singolo caso.

Rimane però un problema che non è biomeccanico, ma comportamentale. Il paziente è seduto davanti a noi, guarda il proprio sorriso ed è soddisfatto, e anche noi siamo soddisfatti. Dopo mesi di terapia gli diciamo finalmente la frase che aspetta da tempo: «*Abbiamo finito*». Pochi minuti dopo, però, gli spieghiamo che dovrà continuare a utilizzare gli allineatori per altri nove mesi.

La sua reazione è comprensibile: «*Come altri nove mesi? Non avevamo finito?*»

Il problema è proprio nella parola *finito*. **Abbiamo finito di spostare i denti, ma non abbiamo ancora finito il trattamento.** Il risultato è stato raggiunto, ma dobbiamo ancora proteggerlo mentre i tessuti si adattano alla nuova posizione.

Se presentiamo la stabilizzazione come qualcosa che viene dopo il trattamento, quasi un'appendice da affrontare ormai con maggiore libertà, rischiamo di essere

noi stessi a ridurre la collaborazione del paziente. Per questo preferisco presentarla fin dall'inizio come una fase ancora pienamente integrata nella terapia: **non dobbiamo più ottenere il risultato, dobbiamo evitare di perdere quello che abbiamo appena ottenuto.**

SCRIPT OPERATIVO

Quando presento la fase di stabilizzazione al paziente, cerco prima di tutto di evitare un equivoco: non gli sto dicendo che il trattamento non ha funzionato o che abbiamo bisogno di altri nove mesi per ottenere il risultato. Al contrario, parto proprio dal fatto che quel risultato è già stato raggiunto.

> *«Oggi abbiamo raggiunto il risultato che volevamo. I denti sono arrivati dove volevamo portarli e quindi da questo momento non dobbiamo più spostarli. C'è però una cosa importante da capire: il fatto che un dente sia arrivato nella posizione corretta non significa che sia già stabile in quella posizione. I tessuti che lo circondano hanno bisogno di tempo per riorganizzarsi e, soprattutto all'inizio, se smettessimo improvvisamente di proteggerlo potremmo permettergli di iniziare a spostarsi di nuovo.*
>
> *Sarebbe un peccato arrivare fino a qui, dopo tutto il tempo e l'impegno che abbiamo investito, ottenere il risultato che volevamo e poi rischiare di perderne una parte proprio adesso. Per questo considero questi nove mesi ancora parte del trattamento: non dobbiamo più muovere i denti, ma dobbiamo conservare ciò che abbiamo ottenuto mentre diventa stabile.*
>
> *Lo faremo in maniera graduale. Per i primi tre mesi continuerai a utilizzare gli allineatori ventidue ore al giorno, esattamente come hai fatto fino a oggi; nei tre mesi successivi diminuirai progressivamente di un'ora alla settimana, fino ad arrivare a dieci ore; negli ultimi tre mesi utilizzerai invece l'ultimo allineatore soltanto durante la notte.*
>
> *Ogni tre mesi faremo quindi un passo avanti: prima stabilizziamo, poi riduciamo gradualmente e infine lasciamo maggiore spazio all'assestamento. Dopo nove mesi faremo una nuova scansione e, se tutto è rimasto nella posizione che abbiamo ottenuto, passeremo alla contenzione definitiva. Il lavoro difficile lo abbiamo fatto. Adesso dobbiamo evitare di perdere quello che abbiamo conquistato.»*

In questo modo non sto semplicemente chiedendo al paziente di continuare a utilizzare gli allineatori, ma sto attribuendo un significato preciso al comportamento che gli chiedo. Dire soltanto «*dovrai continuare per altri nove mesi*» rischierebbe di

trasformare la stabilizzazione, nella sua percezione, in un prolungamento incomprensibile di una terapia che considera già terminata. Il messaggio che voglio trasmettere è diverso: **il risultato è stato raggiunto, ma deve ancora essere stabilizzato**.

Come negli altri protocolli, anche qui posso modulare il messaggio attraverso le tre leve di **risultato, tempo e investimento**, senza modificare il comportamento che sto chiedendo. In questa fase la leva più naturale è probabilmente il risultato: «*Il risultato lo abbiamo raggiunto. Adesso dobbiamo proteggerlo mentre diventa stabile.*» Con alcuni pazienti posso rendere più evidente il tempo già dedicato alla terapia: «*Abbiamo lavorato per mesi per portare i denti in questa posizione. Non avrebbe senso rischiare di perdere in poche settimane una parte di quello che abbiamo costruito.*» Con altri posso richiamare l'investimento complessivo, inteso non soltanto in termini economici, ma anche come costanza e impegno: «*Hai investito molto per arrivare fin qui. Questi nove mesi servono a proteggere quell'investimento.*» La conseguenza clinica non cambia. Cambia ciò che scelgo di rendere più rilevante per la persona che ho davanti.

Perché questo protocollo funziona

- **Trasforma il risultato in qualcosa da proteggere**

Nella stabilizzazione il risultato non è più qualcosa da raggiungere, ma qualcosa che il paziente possiede già. Entrano quindi in gioco *loss aversion* ed *endowment effect*: **non gli stiamo più chiedendo di collaborare per ottenere qualcosa, ma per evitare di perdere ciò che ha conquistato.**

- **Cambia la cornice dei nove mesi**

Il *framing* modifica il significato attribuito alla stessa richiesta. **"Altri nove mesi di trattamento"** possono sembrare un prolungamento della terapia; **"nove mesi per proteggere il risultato"** trasformano invece quel periodo in una fase con uno scopo preciso.

- **Mantiene la continuità del comportamento**

Nei primi tre mesi il paziente continua la stessa routine della fase attiva; soltanto successivamente riduce il tempo di utilizzo, un'ora alla settimana. Il cambiamento non è quindi improvviso né affidato a indicazioni generiche, ma **graduale, prevedibile e misurabile**.

■ **Divide un periodo lungo in obiettivi comprensibili**

Nove mesi possono sembrare lunghi. Tre fasi consecutive di tre mesi hanno invece un obiettivo immediatamente riconoscibile: **stabilizzare, scalare, assestare**. Il paziente sa sempre dove si trova e quale sarà il passaggio successivo.

BIBLIOGRAFIA

Melrose C, Millett DT. Toward a perspective on orthodontic retention? *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998;113(5):507–514.

Haouili N, Kravitz ND, Vaid NR, Ferguson DJ, Makki L. Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2020;158(3):420–425.

Albertini P, Mazzanti V, Mollica F, Pellitteri F, Palone M, Lombardo L. Stress Relaxation Properties of Five Orthodontic Aligner Materials: A 14-Day In-Vitro Study. *Bioengineering (Basel).* 2022;9(8):349.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Con il paziente dominante preferisco essere diretto, concentrandomi sul risultato e sul controllo:

> *«Il risultato lo abbiamo raggiunto. Adesso dobbiamo assicurarci di non perderne una parte. Per nove mesi seguiamo il 3-3-3 e poi passiamo alla contenzione definitiva.»*

I

Influente

Con il profilo influente posso valorizzare maggiormente ciò che vede e il risultato che ha appena ottenuto:

> *«Guarda dove siamo arrivati. Il sorriso che volevamo adesso c'è. Questi nove mesi servono a proteggerlo mentre diventa stabile: sarebbe davvero un peccato mollare proprio adesso.»*

S

Stabile

Con il profilo stabile sottolineo soprattutto continuità e gradualità:

> *«Non cambia improvvisamente nulla. Per i primi tre mesi continui esattamente come hai fatto fino a oggi, poi inizieremo a ridurre gradualmente. Ogni passaggio sarà progressivo e ti accompagnerà verso il solo utilizzo notturno.»*

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

C

Coscienzioso

Con il paziente coscienzioso posso utilizzare una spiegazione più razionale e biologica:

> *«I movimenti sono terminati, ma la riorganizzazione dei tessuti richiede più tempo. Per questo utilizziamo una fase di nove mesi durante la quale manteniamo inizialmente la copertura e poi riduciamo progressivamente le ore prima della contenzione definitiva.»*

CAPITOLO 13

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Dopo il raggiungimento degli obiettivi attivi, nei pazienti clinicamente idonei e sufficientemente collaboranti. È il protocollo dell'autore, non un regime universalmente validato.
OBIETTIVO	Proteggere il risultato e rendere graduale il passaggio dalle ore della fase attiva alla contenzione notturna.
COSA FARE	1. **Stabilizzare — primi tre mesi.** Allineatori 1–12, cambio settimanale, ventidue ore al giorno: mantenere la posizione raggiunta. 2. **Scalare — secondi tre mesi.** Allineatori 13–24, cambio settimanale: ridurre l'utilizzo da ventuno a dieci ore al giorno, un'ora alla settimana. 3. **Assestare — ultimi tre mesi.** Utilizzare lo stesso allineatore 24 per dieci ore ogni notte, mantenendo la protezione notturna e lasciando maggiore spazio alla funzione. 4. **Passare alla contenzione.** Dopo nove mesi, eseguire una nuova scansione e predisporre la contenzione definitiva. Il percorso comprende ventiquattro allineatori e tre fasi di tre mesi. Se altri nove mesi di utilizzo non sono realisticamente sostenibili, concludere la fase attiva e passare direttamente alla contenzione definitiva.
COSA VERIFICARE	Idoneità clinica, collaborazione, adattamento dei dispositivi, mantenimento della posizione e andamento dell'assestamento occlusale. La riduzione delle ore deve seguire il percorso concordato.

CAPITOLO

14

La consegna della contenzione

«Un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura.»

— BENJAMIN FRANKLIN

La consegna della contenzione definitiva segna l'inizio del mantenimento a lungo termine e può arrivare in due momenti diversi. Nei pazienti idonei e collaboranti segue i nove mesi del protocollo di stabilizzazione; nei pazienti per i quali quella fase non è indicata, arriva direttamente al termine del trattamento attivo. In entrambi i casi è un passaggio meno spettacolare della rimozione degli attachment o della consegna dell'ultimo allineatore, ma altrettanto decisivo. Per mesi, qualche volta per anni, abbiamo costruito insieme un risultato. Abbiamo chiesto al paziente di utilizzare gli allineatori, rispettare i cambi, utilizzare gli elastici, presentarsi ai controlli e seguire le nostre indicazioni, fino ad arrivare finalmente al giorno che aspettava dall'inizio, quello in cui pronunciamo una frase apparentemente innocua:

«Abbiamo finito.»

Per il paziente quelle due parole possono significare molto più di quello che immaginiamo, perché possono essere interpretate come la fine delle regole da rispettare e degli orari da seguire, come il momento in cui le mascherine appartengono definitivamente al passato e, soprattutto, come la conferma che il risultato ottenuto sia ormai acquisito e non possa più essere perso.

Per questo cerco di non presentare mai la consegna della contenzione come la fine della terapia e preferisco spiegare chiaramente che ciò che sta terminando è soltanto una fase del percorso:

> *«Oggi termina la fase che precede la contenzione definitiva: per te è stata la stabilizzazione di nove mesi» — oppure, quando il protocollo non era indicato, «la fase attiva del trattamento». «Da questo momento inizia il mantenimento a lungo termine. Conservare il risultato dipenderà soprattutto da te e dalla regolarità con cui utilizzerai la contenzione.»*

La differenza può sembrare piccola, ma cambia completamente il significato di ciò che sta accadendo, perché da quel giorno la responsabilità quotidiana di conservare il risultato passa progressivamente nelle mani del paziente.

Proprio perché considero questo passaggio di responsabilità un momento fondamentale della terapia, alla consegna delle contenzioni faccio leggere e firmare al paziente un consenso informato dedicato alla fase di contenzione. Non si tratta di una semplice indicazione inserita nel consenso iniziale al trattamento ortodontico, né di una raccomandazione data velocemente al termine dell'ultimo controllo, ma di un documento specifico per questa nuova fase, che consegniamo e facciamo firmare nel momento in cui viene consegnata la contenzione definitiva.

Nel consenso vengono spiegati il motivo per cui la contenzione è necessaria, le modalità con cui dovrà essere utilizzata, cosa fare in caso di perdita o rottura e quali possono essere le conseguenze di un utilizzo insufficiente, ma soprattutto viene formalizzato quel passaggio di responsabilità che ho appena spiegato verbalmente al paziente e che riassumo con una frase molto semplice:

«Se mettere i denti nella loro corretta posizione è stato compito nostro, mantenere il risultato raggiunto sarà il tuo.»

La firma, quindi, non rappresenta soltanto un adempimento formale o uno strumento di tutela medico-legale, ma per me è soprattutto la conclusione di un momento comunicativo nel quale prima spiego al paziente che cosa cambia da quel giorno, poi gli fornisco le informazioni necessarie per gestire correttamente questa nuova fase e infine gli chiedo di confermare di averle comprese. Non è un modo per

attribuirgli anticipatamente una colpa nel caso qualcosa dovesse andare storto, ma serve a rendere chiara una responsabilità quando siamo ancora nella condizione migliore per farlo: **prima che si presenti un problema.**

Prima di concludere la consegna verifico che la contenzione si inserisca completamente e scatto alcune fotografie intraorali con il dispositivo in posizione, conservandole insieme alla scansione finale, in modo da creare un punto di partenza documentato. Se in futuro la contenzione non dovesse più entrare correttamente, il confronto non dipenderà da ricordi contrapposti, perché potremo osservare come si adattava alla consegna, verificare che cosa sia cambiato e decidere quale soluzione sia clinicamente appropriata. Le fotografie non servono quindi a dimostrare che il paziente non abbia utilizzato la contenzione, ma a rendere più oggettiva la valutazione della situazione attuale.

Tutto questo diventa ancora più importante se consideriamo che la stabilità ortodontica non può essere considerata un risultato acquisito una volta per tutte. Dopo il trattamento esiste una tendenza alla recidiva e, indipendentemente da essa, la dentatura continua a modificarsi nel corso della vita; la contenzione deve quindi essere considerata parte integrante della terapia e il suo protocollo deve essere adattato alla situazione clinica, ai movimenti effettuati e alle caratteristiche del singolo paziente.

Non esiste nella letteratura un unico protocollo di contenzione universalmente valido per tutti i pazienti, ma esiste una consapevolezza sempre maggiore della necessità di un mantenimento molto prolungato. In un'indagine condotta tra ortodontisti specialisti, per esempio, il 67–78% degli intervistati consigliava ai propri pazienti una contenzione a vita.

Nel mio protocollo seguo questa stessa filosofia e considero quindi la contenzione una fase permanente della terapia, il che non significa, naturalmente, che la stessa mascherina debba durare per tutta la vita. Il dispositivo può consumarsi, deformarsi, rompersi o essere perso e, quando necessario, dovrà essere sostituito, ma ciò che non cambia è la necessità di continuare a proteggere nel tempo il risultato raggiunto.

La mascherina ha una durata. La contenzione no.

Dieci ore, tutte le notti

Quando do una prescrizione al paziente, soprattutto se gli sto chiedendo di rispettarla per tutta la vita, preferisco spiegargli perché. Nel mio protocollo le mascherine di contenzione devono essere utilizzate **tutte le notti per almeno dieci ore**, indica-

tivamente dalle 21, dopo cena, alle 7 del mattino, prima di colazione. Anche in questo caso il numero non nasce semplicemente dall'abitudine clinica, ma trova un interessante supporto nella letteratura.

İshakoğlu e Çokakoğlu hanno studiato 42 pazienti utilizzando contenzioni termoplastiche dotate di microsensori, potendo quindi misurare oggettivamente il tempo reale di utilizzo anziché affidarsi soltanto a ciò che i pazienti dichiaravano. Dopo dodici mesi, i pazienti sono stati distinti in due gruppi in base al tempo medio giornaliero di utilizzo, inferiore a nove ore oppure pari o superiore a nove ore, e nei pazienti che utilizzavano la contenzione meno di nove ore al giorno è stata osservata una maggiore perdita di allineamento. Gli autori hanno quindi concluso che un tempo medio inferiore alle nove ore non era sufficiente a mantenere l'irregolarità entro limiti clinicamente accettabili, raccomandando almeno nove ore al giorno per il mantenimento dell'allineamento anteriore.

È importante interpretare correttamente questo dato, perché non significa che esista una soglia biologica assoluta per cui a otto ore e cinquantanove minuti i denti si muovano e a nove ore rimangano immobili. Lo studio riguarda inoltre un campione specifico di pazienti trattati con estrazioni di quattro premolari e il risultato statisticamente significativo tra i gruppi riguardava l'allineamento anteriore inferiore; ci offre però un'informazione clinicamente molto utile, perché suggerisce che **un utilizzo medio inferiore alle nove ore può non essere sufficiente per mantenere adeguatamente l'allineamento anteriore inferiore**.

È partendo da questo dato che nel mio protocollo prescrivo dieci ore, non perché esista uno studio che dimostri che rappresentino una soglia biologica universale, ma perché considero ragionevole aggiungere un piccolo margine rispetto alle nove ore indicate dallo studio e, contemporaneamente, fornire al paziente una prescrizione semplice, concreta e facile da ricordare: **dieci ore, tutte le notti, per tutta la vita**.

Questo non significa che, se dieci ore sono sufficienti, utilizzarla venti o ventidue ore debba necessariamente garantire una stabilità ancora maggiore. Le evidenze disponibili non dimostrano infatti un vantaggio significativo dell'utilizzo full-time rispetto a un adeguato utilizzo part-time. Thickett e Power hanno confrontato in uno studio clinico randomizzato l'utilizzo full-time e part-time di contenzioni termoplastiche e, dopo dodici mesi, non sono emerse differenze statisticamente significative tra i due protocolli per la maggior parte delle misure considerate; anche le revisioni della letteratura vanno nella stessa direzione, indicando che l'utilizzo part-time delle contenzioni rimovibili può essere sufficiente, pur sottolineando che la qualità complessiva delle evidenze rimane limitata.

Il messaggio, quindi, non è che dieci ore rappresentino la dose perfetta per ogni paziente e per ogni situazione clinica, perché la contenzione rimane un ambito nel quale non esiste un unico protocollo universalmente accettato. Quello che voglio trasmettere al paziente è qualcosa di molto più semplice: terminato il trattamento attivo, **non gli sto chiedendo di continuare per tutta la vita a utilizzare una mascherina ventidue ore al giorno come faceva con gli allineatori**, ma di trasformare la contenzione in una routine notturna sostenibile.

Dire però al paziente «*utilizzala di notte*» lascia ancora troppo spazio all'interpretazione, perché per qualcuno una notte dura nove ore e per qualcun altro sei; qualcuno inserisce la contenzione quando va a letto, qualcun altro soltanto poco prima di addormentarsi, mentre altri possono considerare normale saltare una sera perché, in fondo, la prescrizione ricevuta era semplicemente *di notte*. Per questo preferisco trasformare un'indicazione generica in una routine precisa: **21–7**. Alle nove di sera, dopo cena, la mascherina entra e alle sette del mattino, prima di colazione, esce, completando così le dieci ore prescritte. Non attribuisco naturalmente alcun significato biologico alle nove di sera o alle sette del mattino; il vantaggio è soprattutto comportamentale, perché associare un'azione a momenti riconoscibili e ripetuti della giornata rende più semplice trasformarla in un'abitudine.

Questo diventa particolarmente importante quando consideriamo che la collaborazione con la contenzione tende a deteriorarsi con il trascorrere del tempo. Kacer e collaboratori hanno analizzato l'utilizzo delle contenzioni nei primi due anni dopo il trattamento attivo e hanno osservato che, mentre nei primi tre mesi il 69% dei pazienti riferiva di utilizzarle tutte le notti, tra 19 e 24 mesi la percentuale di pazienti classificati come collaboranti secondo i criteri dello studio era scesa al 45%, mentre il 19% dichiarava di non utilizzarle più. Si trattava di dati autoriferiti, raccolti attraverso un questionario, e quindi non di una misurazione oggettiva del comportamento, ma la tendenza che mostrano è clinicamente molto riconoscibile: **con il passare del tempo la collaborazione tende a diminuire**.

La vera sfida, quindi, non è convincere il paziente a utilizzare la contenzione la sera stessa in cui gliela consegniamo, quando il risultato è davanti ai suoi occhi, il ricordo del trattamento è ancora recente e il valore di ciò che ha ottenuto è estremamente evidente. Dobbiamo costruire un comportamento capace di sopravvivere quando quel sorriso sarà diventato normale, quando il trattamento sarà ormai un ricordo e quando noi non saremo più presenti ogni poche settimane a ricordargli cosa deve fare. **È per questo che preferisco una routine precisa a una raccomandazione generica.**

Le ore perse non si recuperano

C'è poi un altro messaggio che considero fondamentale dare già il giorno della consegna. Il paziente non deve costruire l'idea che la prescrizione delle dieci ore funzioni come una sorta di conto corrente nel quale, se una sera non utilizza la contenzione, possa semplicemente utilizzarla più a lungo il giorno successivo e recuperare le ore perse, perché il problema non sono le ore in sé, ma ciò che può accadere ai denti durante il periodo in cui non vengono mantenuti.

Se uno o più denti iniziano a cambiare posizione, la geometria della dentatura non coincide più perfettamente con quella sulla quale era stata costruita la contenzione. Quando il paziente prova a reinserirla può quindi sentirla più stretta o accorgersi che non calza più nello stesso modo, ed è proprio in quel momento che può nascere un ragionamento apparentemente logico ma potenzialmente pericoloso: «*Sta stringendo, quindi la utilizzo un po' di più e rimetterà i denti a posto.*»

Non voglio che il paziente utilizzi autonomamente la contenzione come se fosse un nuovo allineatore, perché quella mascherina è stata costruita **per mantenere una posizione**, non per eseguire un nuovo movimento ortodontico programmato. Se i denti non coincidono più con la posizione sulla quale è stata realizzata, il dispositivo può iniziare a esercitare forze che non sono state progettate come parte di un trattamento e, proprio per questo, alla consegna introduco una regola molto semplice:

> *«Se per qualche giorno non la utilizzi e quando la rimetti senti che stringe molto, non pensare di recuperare semplicemente utilizzandola più ore. Questa mascherina è stata costruita per mantenere i tuoi denti nella posizione di oggi, non per fare nuovi movimenti ortodontici. Se non entra più correttamente o devi forzarla, chiamaci.»*

Non è necessario spiegare al paziente tutta la biomeccanica che può svilupparsi quando una contenzione non corrisponde più alla posizione dentale; è molto più importante impedirgli di costruire una convinzione sbagliata e fargli comprendere fin dal giorno della consegna che **le ore perse non si recuperano: quello che dobbiamo evitare è che venga persa la posizione**.

Quando una contenzione viene persa o rotta

Esiste poi un problema apparentemente banale che negli anni mi sono trovato ad affrontare molte volte: il paziente perde la contenzione, telefona allo studio e chiede semplicemente «*Me ne fate un'altra?*». Fin qui nulla di strano; il problema può nascere quando scopre che produrre una nuova contenzione ha un costo.

Per comprendere la sua reazione dobbiamo tornare al modo in cui lo abbiamo educato durante il trattamento attivo. Un paziente trattato con allineatori può aver ricevuto decine di mascherine, può averne persa o rotta qualcuna e può aver effettuato una o più rifiniture senza percepire direttamente il costo del singolo dispositivo, soprattutto quando il pacchetto acquistato comprendeva allineatori aggiuntivi. Nella sua mente può quindi essersi costruita progressivamente un'associazione molto semplice: **mascherina = compresa nel trattamento**.

Quando gli consegniamo una contenzione trasparente, ai suoi occhi appare qualcosa di estremamente simile a ciò che ha utilizzato fino a quel momento. Per noi è cambiata completamente la funzione, mentre per lui continua a essere una mascherina e, se non modifichiamo esplicitamente questo modello mentale, non possiamo stupirci se, quando la perde o la rompe, ritiene che anche quella debba essere sostituita gratuitamente.

Ancora una volta, il momento migliore per affrontare il problema non è quando il paziente telefona dicendo di averla persa, ma **prima che la perda**. Nel consenso specifico che faccio firmare è indicato chiaramente che la perdita o la rottura della contenzione comporterà un costo per la sua sostituzione, ma non voglio che quel costo venga percepito come una punizione o come una penale per essere stato distratto: il paziente sta semplicemente pagando la produzione di **un nuovo dispositivo**.

Durante il trattamento aveva acquistato una terapia che comprendeva determinate prestazioni e determinati dispositivi, ma quella fase si è conclusa e non può trasformarsi nella promessa implicita di produrre gratuitamente contenzioni sostitutive per tutta la vita. Se la contenzione deve accompagnare il paziente nel tempo, dobbiamo spiegargli fin dall'inizio che i singoli dispositivi potranno consumarsi, rompersi o essere persi e che, quando sarà necessario sostituirli, la produzione di una nuova contenzione avrà un costo. Anche questo fa parte del passaggio di responsabilità che abbiamo iniziato a costruire nel momento stesso della consegna.

SCRIPT OPERATIVO

Tutti questi concetti devono essere scientificamente corretti, ma non devono trasformare il controllo finale in una lezione universitaria. Il paziente deve uscire dallo studio ricordando poche cose, estremamente chiare, e per questo la conversazione può essere molto più semplice del ragionamento che la sostiene.

> *«Oggi termina la fase che precede la contenzione definitiva: per te è stata la stabilizzazione di nove mesi» — oppure, quando il protocollo non era indicato, «la fase attiva del trattamento». «Da questo momento inizia il mantenimento a lungo termine e conservare il risultato dipenderà soprattutto da te e dalla regolarità con cui utilizzerai la contenzione. Questa fase dura per tutta la vita; io scherzando dico sempre che la contenzione è come i diamanti: è per sempre.»*

A quel punto passo alla prescrizione concreta, cercando di lasciare al paziente una regola che possa ricordare senza possibilità di interpretazione:

> *«La regola è molto semplice: dieci ore, tutte le notti. La cosa più facile è mettere la contenzione alle nove di sera, dopo cena, e toglierla alle sette del mattino, prima di colazione. Ventuno-sette: sono dieci ore. Non devi utilizzarla tutto il giorno, devi utilizzarla bene tutte le notti.»*

Subito dopo anticipo quello che potrebbe accadere se quella routine non venisse rispettata, perché voglio che il paziente sappia come comportarsi prima di trovarsi nella situazione:

> *«E attenzione a una cosa: le ore non si recuperano. Se salti qualche notte e quando rimetti la contenzione senti che stringe molto o non entra più come prima, non pensare "la utilizzo di più e torna tutto a posto". Questa mascherina è stata costruita per mantenere i denti dove sono oggi, non per fare un nuovo trattamento. Se non entra bene o devi forzarla, chiamaci subito.»*

Nello stesso momento chiarisco anche cosa dovrà fare in caso di perdita o rottura e, soprattutto, evito che possa nascere in futuro un equivoco sul costo della sostituzione:

> *«Se perdi la contenzione o si rompe, chiamaci subito e non aspettare qualche giorno pensando che tanto non succeda niente, perché da quel momento i denti non sono più mantenuti nella posizione che abbiamo raggiunto. Ricordati anche che, se dobbiamo produrne una nuova, quella nuova avrà un costo: il trattamento attivo si è concluso e da oggi la gestione della contenzione fa parte della tua responsabilità nel mantenimento del risultato.»*

Infine torno al motivo per cui gli sto dando tutte queste indicazioni, perché non voglio che il paziente esca ricordando soltanto una serie di regole, ma che comprenda soprattutto che cosa quelle regole stanno proteggendo:

> *«La cosa più importante è questa: oggi ti consegniamo un risultato che abbiamo raggiunto insieme; da questo momento il tuo compito è conservarlo. Se smetti di utilizzare le contenzioni e i denti si spostano, potrebbe non essere sufficiente rifare semplicemente una mascherina e, se vorrai recuperare il risultato ottenuto, potrebbe essere necessario un nuovo trattamento ortodontico, che sarà un nuovo trattamento con un nuovo costo.»*

Solo dopo questa spiegazione faccio leggere e firmare il consenso specifico alla contenzione. A quel punto la firma non rappresenta l'inizio dell'informazione, ma la sua conclusione, perché il paziente ha visto il risultato, ha compreso che la fase clinica guidata è terminata ma che il mantenimento continua, conosce la propria responsabilità, sa per quante ore e per quanto tempo deve utilizzare la contenzione, sa cosa fare se viene persa, si rompe o non entra più correttamente e conosce le possibili conseguenze di una mancata collaborazione. Abbiamo così affrontato tutte queste eventualità nel momento in cui era ancora possibile farlo nel modo migliore: **prima che diventassero un problema.**

Perché questo protocollo funziona

Cambia il significato della contenzione. Dire al paziente che non è finita la terapia, ma che inizia una nuova fase, modifica il modo in cui interpreta la contenzione. Non viene presentata come un accessorio da utilizzare finché se ne ricorda, ma come lo strumento con cui dovrà proteggere nel tempo un risultato che possiede già e per il quale ha investito tempo, energie e denaro. Qui confluiscono **cambio di framing, salienza del risultato e avversione alla perdita**.

Trasforma una raccomandazione in un comportamento preciso. «*Dieci ore, tutte le notti, 21–7*» lascia molto meno spazio all'interpretazione rispetto a «*utilizzala di notte*». Collegare inoltre l'inserimento e la rimozione della contenzione a due momenti riconoscibili della giornata aiuta a trasformare la prescrizione in una routine stabile. Qui confluiscono **riduzione dell'ambiguità e implementation intention**, concetti che abbiamo già spiegato nei capitoli precedenti e che qui non serve sviluppare nuovamente.

Trasferisce la responsabilità prima che esista un problema. Il paziente conosce fin dal giorno della consegna cosa fare se salta alcune notti, se la contenzione stringe, non entra più correttamente, viene persa o si rompe, e sa che un eventuale nuovo trattamento necessario per recuperare una recidiva rappresenterebbe una nuova terapia. Definire queste regole quando il risultato è stabile e non esiste ancora un conflitto permette di affrontare eventuali problemi futuri partendo da responsabilità già condivise.

Rende esplicito l'impegno. Il consenso specifico viene firmato soltanto dopo che prescrizione, responsabilità, possibili problemi e costi sono stati spiegati. La firma non sostituisce quindi la comunicazione, ma conclude e formalizza ciò che è stato condiviso verbalmente, compreso il fatto che la sostituzione di una contenzione persa o rotta rappresenta il costo di un nuovo dispositivo e non una sanzione.

BIBLIOGRAFIA

İshakoğlu S, Çokakoğlu S. Evaluation of relapse with thermoplastic retainers equipped with microsensors. *Angle Orthod.* 2022;92(3):340–346.

Thickett E, Power S. A randomized clinical trial of thermoplastic retainer wear. *Eur J Orthod.* 2010;32(1):1–5.

Kacer KA, Valiathan M, Narendran S, Hans MG. Retainer wear and compliance in the first 2 years after active orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2010;138(5):592–598.

Al-Moghrabi D, Littlewood SJ, Fleming PS. Orthodontic retention protocols: an evidence-based overview. *Br Dent J.* 2021;230:770–776.

Meade MJ, Millett D. Retention protocols and use of vacuum-formed retainers among specialist orthodontists. *J Orthod.* 2013;40(4):318–325.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D — **Dominante**
Con un paziente dominante il messaggio può essere diretto, breve e orientato al controllo del risultato: «*Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Da oggi sei tu ad avere il controllo sul suo mantenimento: dieci ore, tutte le notti.*»

I — **Influente**
Con un paziente influente può essere più efficace valorizzare il sorriso e il risultato estetico raggiunto: «*Guarda il sorriso che abbiamo ottenuto. Adesso dobbiamo fare in modo che rimanga così: dieci ore, tutte le notti.*»

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

S

Stabile

Con un paziente stabile può essere utile sottolineare soprattutto la semplicità della routine: *«Non devi fare nulla di complicato: dopo cena metti la contenzione e la mattina, prima di colazione, la togli. L'importante è trasformarlo in un gesto che fai tutte le sere.»*

C

Coscienzioso

Con un paziente coscienzioso funzionano particolarmente bene una prescrizione precisa e la spiegazione scientifica che la sostiene: *«La prescrizione è di dieci ore ogni notte. Non è un numero scelto arbitrariamente: deriva dai dati che abbiamo sul mantenimento dell'allineamento dopo il trattamento.»*

CAPITOLO 14

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Alla consegna della contenzione definitiva, dopo la stabilizzazione oppure direttamente dopo la conclusione della fase attiva.
OBIETTIVO	Costruire una routine di mantenimento precisa, chiarendo responsabilità, gestione dei problemi e costi di sostituzione.
COSA FARE	1. Verificare l'inserimento, fotografare la contenzione in posizione e conservare la scansione finale. 2. Spiegare che termina la fase attiva e inizia il mantenimento del risultato. 3. Prescrivere, nel protocollo descritto, dieci ore tutte le notti, per tutta la vita. Come riferimento pratico: 21–7. 4. Chiarire che le ore perse non si recuperano semplicemente aumentando autonomamente l'utilizzo successivo. 5. Chiedere di contattare lo studio se la contenzione stringe molto, non entra correttamente o deve essere forzata. 6. Richiedere una comunicazione tempestiva in caso di perdita o rottura e spiegare il costo del nuovo dispositivo. 7. Anticipare che, se i denti si spostano, una nuova contenzione potrebbe non bastare e potrebbe servire un nuovo trattamento. 8. Dopo la spiegazione, far leggere e firmare il consenso specifico.
COSA VERIFICARE	Adattamento del dispositivo e comprensione di prescrizione, durata, responsabilità, gestione dei problemi e condizioni economiche.

CAPITOLO

15

Un appuntamento virtuale a settimana

«Quando puoi misurare ciò di cui parli ed esprimerlo in numeri, ne sai qualcosa.»

— LORD KELVIN

Durante una terapia con allineatori, molte cose possono accadere nel periodo che separa due controlli in studio. Il paziente cambia autonomamente le mascherine, le utilizza secondo le proprie abitudini e spesso deve valutare da solo se continuano ad aderire correttamente ai denti. Se un allineatore comincia a perdere fitting, cioè non si adatta più perfettamente alla superficie dentale, può non accorgersene oppure può decidere di passare comunque a quello successivo, semplicemente perché è trascorso il numero di giorni previsto. Anche una riduzione delle ore di utilizzo può sembrare inizialmente priva di conseguenze, soprattutto quando il paziente

è convinto di poter recuperare utilizzando maggiormente gli allineatori nei giorni immediatamente precedenti al controllo.

Se rivediamo il paziente soltanto dopo quattro o sei mesi, però, quella piccola perdita di fitting può essersi propagata lungo l'intera sequenza. A quel punto non dobbiamo più recuperare soltanto il primo movimento che non si è espresso, ma anche le conseguenze prodotte dagli allineatori successivi, progettati presupponendo che tutti i denti avessero raggiunto la posizione programmata.

È proprio per ridurre questo intervallo privo di osservazione che, nel mio studio, utilizzo il **Dental Monitoring**, un sistema che consente di seguire a distanza l'andamento di un trattamento ortodontico. Attraverso un'applicazione installata sullo smartphone e un apposito dispositivo che aiuta a mantenere labbra e guance lontane dai denti, il paziente registra una sequenza guidata di immagini della propria bocca.

Nel linguaggio quotidiano chiamiamo questa procedura *scansione*, anche se non si tratta della stessa scansione intraorale tridimensionale che eseguiamo in studio per rilevare le arcate e progettare gli allineatori. La scansione del Dental Monitoring è, più precisamente, una documentazione fotografica guidata, acquisita dal paziente con il proprio telefono, che permette al sistema e al team clinico di osservare a distanza l'adattamento degli allineatori e l'evoluzione del trattamento.

Nel mio protocollo il paziente effettua questa scansione una volta alla settimana, prima di passare alla mascherina successiva. Le immagini ci permettono di osservare il fitting degli allineatori e di valutare se i denti stanno mantenendo il tracking, ovvero se la loro posizione reale continua a essere compatibile con quella prevista dalla sequenza programmata. **In base a ciò che osserviamo, il paziente riceve l'indicazione di passare alla mascherina successiva oppure di mantenere ancora quella attuale.**

Il cambio settimanale, quindi, non rappresenta più una semplice scadenza sul calendario. Il paziente non passa automaticamente all'allineatore successivo soltanto perché sono trascorsi sette giorni, ma attende che il controllo a distanza confermi l'esistenza delle condizioni necessarie per proseguire.

Il Dental Monitoring non sostituisce la valutazione dell'ortodontista e non permette di conoscere tutto ciò che accade nella bocca del paziente. Consente, però, di ridurre notevolmente il tempo che intercorre tra la comparsa di un problema e il momento nel quale possiamo accorgercene. Una perdita iniziale di fitting può così essere affrontata quando è ancora limitata, prima che coinvolga più denti e comprometta una parte più ampia della sequenza.

Il Dental Monitoring nasce dunque, prima di tutto, come uno strumento clinico che permette di seguire il trattamento con maggiore continuità anche quando gli appuntamenti in presenza sono distanziati. Utilizzandolo, tuttavia, mi sono accorto che svolge anche una seconda funzione, particolarmente importante nel contesto di questo libro: **rende più visibili alcuni aspetti della collaborazione del paziente.**

Quando consegno gli allineatori, spiego al paziente che il monitoraggio a distanza ci consentirà, in molti casi, di programmare gli appuntamenti in studio ogni quattro o sei mesi, adattando naturalmente la frequenza alle necessità cliniche del singolo trattamento. Questo non significa, però, che per tutto quel periodo la terapia rimanga senza controllo, perché tra un appuntamento e l'altro riceviamo le immagini settimanali e possiamo seguire con continuità l'andamento del trattamento.

Ogni scansione diventa così una sorta di piccolo appuntamento virtuale. Il paziente deve ricordarsi di effettuarla, seguire correttamente la procedura e attendere l'indicazione ricevuta attraverso il sistema prima di cambiare mascherina. Agli appuntamenti tradizionali si affiancano quindi controlli più brevi ma anche molto più frequenti, per cui la riduzione degli accessi in studio non comporta una diminuzione della responsabilità.

La scansione settimanale mi permette di osservare il fitting degli allineatori, ma anche la puntualità con cui il paziente segue il protocollo. La regolarità nell'invio delle immagini, il rispetto delle indicazioni ricevute e la risposta ai messaggi diventano comportamenti documentabili; allo stesso modo, anche la loro assenza ci fornisce un'informazione.

Mi è capitato più volte di consegnare il sistema a un paziente e osservare che, dopo un primo periodo di utilizzo regolare, le scansioni diventavano progressivamente meno frequenti, fino a interrompersi completamente. Al controllo successivo gli allineatori non aderivano più correttamente, eppure la spiegazione era quasi sempre la stessa:

«Io li ho utilizzati sempre.»

In passato, una dichiarazione del genere avrebbe potuto dare inizio a una discussione destinata a non condurre da nessuna parte. Il paziente avrebbe continuato a sostenere di avere collaborato e io avrei avuto soltanto il fitting insufficiente degli allineatori per mettere in dubbio il suo racconto. Con il monitoraggio remoto, invece, posso adottare un approccio completamente diverso, perché **non sono costretto a scegliere immediatamente tra credere al paziente e accusarlo di non essere sincero.**

Ricostruire il momento in cui si è perso il tracking

Quando il paziente sostiene di avere utilizzato correttamente gli allineatori, non apro la cronologia del Dental Monitoring dicendo: *«Adesso vediamo se è vero.»* Una frase di questo genere trasformerebbe immediatamente il confronto in un processo, spingendo il paziente a sentirsi accusato e a difendere la propria versione dei fatti. Preferisco presentare l'analisi delle scansioni come un'indagine clinica condivisa, attraverso la quale possiamo cercare insieme il periodo nel quale il trattamento ha iniziato ad allontanarsi dalla programmazione:

> *«Guardiamo insieme tutte le scansioni che hai effettuato nelle ultime settimane. In questo modo possiamo individuare la settimana nella quale il tracking ha iniziato a peggiorare e cercare di capire che cosa possa essere successo.»*

Spesso aggiungo anche una possibile spiegazione concreta, perché voglio far comprendere al paziente che non sto cercando una confessione, ma un avvenimento reale che possa aiutarci a interpretare ciò che stiamo osservando:

> *«Magari scopriamo che è successo proprio nella settimana del matrimonio del tuo migliore amico. Forse quel giorno sei rimasto senza allineatori per molte ore e, da quel momento, un dente ha iniziato a non seguire più perfettamente. Vediamo insieme se riusciamo a ricostruirlo.»*

L'esempio del matrimonio offre al paziente una via d'uscita dalla contrapposizione tra «*Li ho utilizzati sempre*» e «*Non ti credo*». Un matrimonio, una festa, una giornata di viaggio, una cena particolarmente lunga, una malattia o una settimana molto complicata possono essere ricordati più facilmente rispetto alle ore complessive durante le quali gli allineatori sono stati utilizzati. Una domanda generica come «*Hai utilizzato gli allineatori?*» produce quasi inevitabilmente una risposta altrettanto generica: *«Sì, sempre.»* Collegando invece la domanda a un momento preciso, il paziente può rendersi conto, per esempio, di avere tolto gli allineatori durante il pranzo del matrimonio e di averli rimessi soltanto in tarda serata. Non stiamo più discutendo della collaborazione in termini astratti, ma ricostruendo un comportamento reale all'interno di un momento riconoscibile.

Apro quindi la cronologia del Dental Monitoring e ripercorro con il paziente le settimane precedenti. In alcuni casi riusciamo effettivamente a individuare il periodo nel quale il fitting ha iniziato a peggiorare e possiamo collegarlo a un episodio particolare, a una riduzione delle ore di utilizzo, a un impiego insufficiente dei chewies oppure a un movimento che non si è espresso nonostante una collaborazione apparentemente adeguata. Altre volte, però, scopriamo che le scansioni necessarie per effettuare quella ricostruzione semplicemente non esistono: la cro-

nologia è vuota oppure presenta interruzioni molto evidenti e, quando il paziente risponde «*Non è possibile, io le ho fatte tutte*», non ho bisogno di accusarlo direttamente, perché è l'assenza dei dati a mostrare che il protocollo concordato non è stato rispettato.

Questo non significa necessariamente che il paziente non abbia utilizzato correttamente gli allineatori. Significa, però, che ha interrotto il canale di supervisione concordato e che, anche se l'utilizzo fosse stato adeguato, senza dati aggiornati non abbiamo potuto verificare il fitting, valutare il tracking e confermare che esistessero le condizioni per proseguire con la sequenza. A quel punto gli spiego:

> *«Il problema è proprio questo. Se avessimo una scansione per ogni settimana, potremmo individuare il periodo nel quale il fitting ha iniziato a peggiorare e cercare di capire che cosa sia successo. Poiché alcune scansioni non sono state effettuate, abbiamo perso la possibilità di accorgercene e intervenire tempestivamente. Adesso dobbiamo valutare quanto tracking sia stato perso e capire se sia ancora possibile proseguire con questi allineatori oppure se sarà necessario modificare il piano di trattamento. In ogni caso, da questo momento dovremo riprendere sia l'utilizzo corretto degli allineatori sia le scansioni settimanali, altrimenti rischieremmo di ritrovarci nuovamente nella stessa situazione.»*

Non posso sapere con certezza se il paziente stia mentendo intenzionalmente oppure se abbia ricostruito il proprio comportamento in una forma per lui più accettabile. Potrebbe ricordare le settimane nelle quali ha utilizzato correttamente il sistema e dimenticare quelle nelle quali non lo ha fatto, oppure potrebbe confondere l'intenzione di effettuare una scansione con il ricordo di averla realmente eseguita. Per la gestione clinica, tuttavia, il risultato non cambia: il protocollo concordato non è stato rispettato e noi non abbiamo potuto individuare tempestivamente il periodo nel quale il fitting ha iniziato a peggiorare.

Il monitoraggio remoto non impedisce quindi al paziente di mentire e non elimina i meccanismi attraverso i quali la memoria ricostruisce il comportamento passato, ma riduce lo spazio nel quale il racconto del paziente può diventare l'unica versione disponibile.

Esistono poi piccoli dettagli che, pur non rappresentando vere misurazioni della collaborazione, possono raccontarci qualcosa delle abitudini del paziente. Uno dei più interessanti riguarda gli elastici ortodontici. Quando li prescrivo, non chiedo al paziente di mantenerli durante la scansione domiciliare; sarebbe anzi molto più semplice rimuoverli, perché limitano l'apertura della bocca e possono rendere

la procedura più scomoda. Il comportamento più logico consisterebbe quindi nel togliere gli elastici, eseguire la scansione e inserirli nuovamente subito dopo.

Alcuni pazienti, tuttavia, effettuano la scansione con gli elastici ancora in bocca, non perché vogliano dimostrarmi di essere collaboranti e nemmeno perché abbiano ricevuto questa indicazione, ma semplicemente perché si dimenticano di toglierli. Gli elastici sono diventati una presenza talmente abituale nella loro giornata che iniziano la procedura senza nemmeno pensare alla possibilità di rimuoverli.

Per me questo comportamento rappresenta un segnale molto significativo, anche se naturalmente una scansione eseguita con gli elastici non dimostra che il paziente li abbia utilizzati per tutte le ore prescritte, perché potrebbe almeno in teoria averli inseriti poco prima. Quando, però, vedo una persona affrontare spontaneamente la maggiore difficoltà di una scansione mantenendo gli elastici in bocca, considero quel comportamento un indizio credibile della loro reale presenza nella quotidianità. Non si tratta di una prova isolata, ma di un segnale spontaneo che acquista valore proprio perché non sembra essere stato costruito per essere mostrato al medico.

Il Dental Monitoring mi permette così di osservare non soltanto il movimento dei denti, ma anche alcuni frammenti della quotidianità terapeutica del paziente. Una scansione effettuata puntualmente, una risposta immediata a un'indicazione o un elastico dimenticato in bocca possono diventare piccoli indicatori della qualità della collaborazione. **Sono però indicatori, non misurazioni**, ed è importante chiarire molto bene questo limite, perché il Dental Monitoring non contiene un cronometro all'interno dell'allineatore e non può conoscere con esattezza per quante ore al giorno il dispositivo sia stato utilizzato. Non può quindi affermare che un paziente abbia utilizzato la mascherina diciotto ore anziché ventidue.

Quello che possiamo osservare con continuità è invece l'adattamento degli allineatori, la progressione del trattamento e l'eventuale comparsa di una perdita di tracking. Se le mascherine vengono utilizzate meno del necessario, alcune conseguenze di questa discontinuità possono diventare visibili nel tempo, anche se ciò che osserviamo non ci consente di calcolare matematicamente le ore di utilizzo.

Nella comunicazione con il paziente utilizzo questa possibilità come strumento di responsabilizzazione, perché voglio che sappia fin dall'inizio che ciò che accade tra due appuntamenti non rimarrà completamente invisibile. Allo stesso tempo, evito di attribuire al sistema una precisione che non possiede e utilizzo una formulazione che distingue chiaramente tra la misurazione diretta delle ore e l'osservazione delle loro possibili conseguenze cliniche:

«Il sistema non contiene un cronometro e quindi non può dirci esattamente per quante ore hai utilizzato l'allineatore. Le scansioni settimanali ci permettono però di osservare con continuità il fitting e la progressione del trattamento. Se gli allineatori vengono utilizzati meno del necessario, spesso le conseguenze di questa discontinuità diventano visibili nel tempo.»

La distinzione è importante anche perché il mancato movimento di un dente non può essere attribuito automaticamente alla scarsa collaborazione. Possono esistere difficoltà biomeccaniche, problemi con un attachment, caratteristiche anatomiche o una risposta biologica differente da quella prevista. Il monitoraggio remoto deve quindi aiutarci ad aprire una conversazione e a formulare ipotesi cliniche, non a pronunciare una sentenza automatica contro il paziente. **Il suo vero valore non consiste nel dimostrare che il paziente abbia sbagliato, ma nel permetterci di riconoscere prima quando qualcosa non sta funzionando come previsto e di comprenderne, quando possibile, la ragione.**

Il protocollo durante la fase attiva

Nel mio studio il protocollo prevede che il paziente effettui una scansione una volta alla settimana, prima del cambio dell'allineatore, e che attenda l'indicazione ricevuta prima di passare a quello successivo. Quando il fitting non è adeguato, può essere necessario mantenere la stessa mascherina per qualche giorno in più, aumentare le ore di utilizzo o impiegare maggiormente i chewies.

Se il problema non si risolve, possiamo anticipare il controllo in studio e valutare se esistano ancora le condizioni per proseguire con la sequenza oppure se sia necessario interromperla, effettuare una nuova scansione intraorale e progettare una rifinitura. Gli appuntamenti in presenza vengono generalmente fissati ogni quattro o sei mesi, anche se la frequenza viene sempre adattata alle necessità del singolo caso.

Lo stesso principio vale quando la scansione viene inviata ma le immagini non sono sufficientemente chiare per consentire una valutazione affidabile. Se accade occasionalmente, ripetiamo insieme la procedura e verifichiamo l'eventuale presenza di difficoltà tecniche. Se il problema continua, il paziente deve essere controllato in studio. Quando il monitoraggio a distanza non è sostenibile, programmiamo controlli clinici più frequenti e possiamo consegnare un numero più limitato di allineatori per volta: **l'autonomia non può proseguire senza un canale di supervisione affidabile.**

In questo modo il cambio settimanale non rappresenta più una semplice scadenza temporale. Il pensiero spontaneo del paziente, «*È trascorsa una settimana, quindi posso cambiare la mascherina*», viene sostituito da un principio più corretto: «*È trascorsa una settimana e posso cambiare la mascherina se esistono le condizioni cliniche per proseguire.*»

Il monitoraggio durante la contenzione

Lo stesso principio può continuare anche dopo la conclusione della fase attiva. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, consegnare una contenzione significa affidare progressivamente al paziente la responsabilità di proteggere il risultato raggiunto, ma questo non implica necessariamente che da quel momento debba essere lasciato completamente solo. Nel mio studio offro la possibilità di continuare il monitoraggio anche durante la fase di contenzione attraverso un programma opzionale che associa il controllo a distanza a una forma di garanzia sul mantenimento del risultato.

Il programma ha un costo di **500 euro all'anno** e può essere mantenuto fino a tre anni. Considerando che i pacchetti di trattamento che utilizzo consentono la produzione di allineatori aggiuntivi entro cinque anni dall'inizio della terapia e che una fase attiva dura frequentemente un anno e mezzo o due anni, rimane spesso un periodo di circa tre anni nel quale possiamo continuare a seguire il paziente e, quando esistono le condizioni previste, intervenire qualora si verifichi una recidiva, senza un nuovo costo di produzione degli allineatori, quando questo è ancora compreso nel pacchetto commerciale.

La parola *garanzia*, tuttavia, deve essere utilizzata con attenzione, perché potrebbe far pensare che qualunque spostamento dentale futuro venga automaticamente corretto dallo studio indipendentemente dal comportamento del paziente. Non è questo il significato del programma. La garanzia esiste all'interno di un accordo nel quale anche il paziente mantiene alcuni impegni precisi: deve utilizzare la contenzione secondo la prescrizione ricevuta, effettuare regolarmente le scansioni richieste attraverso il Dental Monitoring, presentarsi ai controlli programmati e comunicarci tempestivamente la perdita, la rottura o qualsiasi problema di adattamento del dispositivo.

Durante questa fase richiedo una scansione con Dental Monitoring una volta al mese e associo al programma una seduta di igiene orale professionale ogni sei mesi. In quell'occasione le igieniste eseguono anche una scansione intraorale tridimensionale, che può essere confrontata con quella registrata alla conclusione del

trattamento e ci permette di verificare nel tempo la stabilità della posizione dentale. Il paziente non acquista quindi semplicemente la promessa che, se qualcosa si muoverà, verrà corretto gratuitamente, ma entra in un sistema di sorveglianza nel quale prevenzione, controlli e responsabilità personale continuano a lavorare insieme.

Se il paziente ha rispettato le condizioni concordate e, nonostante questo, si verifica una recidiva che richiede un nuovo intervento ortodontico, possiamo intervenire senza applicare un nuovo costo per il trattamento, naturalmente entro i limiti temporali e clinici previsti dal programma. Se invece le contenzioni non sono state utilizzate come prescritto, le scansioni mensili sono state interrotte, i controlli non sono stati effettuati oppure un problema è stato ignorato per mesi prima di essere comunicato, viene meno il presupposto sul quale quella garanzia era stata costruita.

Questo punto è importante perché anche un programma di garanzia può diventare controproducente se viene percepito come un trasferimento completo della responsabilità sullo studio. Il messaggio non deve essere *«Qualunque cosa succeda, ci penseremo noi»*, ma piuttosto *«Se tu continuerai a fare la tua parte, noi continueremo a fare la nostra.»* La garanzia diventa così una responsabilità reciproca: il paziente protegge il risultato attraverso la contenzione, le scansioni e i controlli concordati, mentre noi manteniamo un sistema che ci permette di individuare precocemente un eventuale cambiamento e di intervenire quando necessario.

Anche dal punto di vista economico preferisco presentare il programma in questa prospettiva. I **500 euro annuali** non rappresentano semplicemente il prezzo di un eventuale nuovo trattamento, ma comprendono un percorso di prevenzione e supervisione che continua durante la contenzione e delle sedute di igiene orale.

Il Dental Monitoring assume così un ruolo che attraversa due momenti molto diversi della terapia. Durante la fase attiva ci permette di ridurre il tempo nel quale una perdita di tracking può rimanere inosservata; durante la contenzione può aiutarci a riconoscere precocemente una modificazione del risultato. In entrambi i casi, però, il principio rimane lo stesso: **il monitoraggio funziona soltanto se esiste qualcuno che osserva e qualcuno che continua a fornire le informazioni necessarie per essere osservato.**

SCRIPT OPERATIVO

Il Dental Monitoring entra nella comunicazione con il paziente in momenti diversi del trattamento e, proprio per questo, lo script deve cambiare a seconda della situazione. Alla consegna serve soprattutto a definire le regole del sistema; quando il

tracking viene perso, deve aiutarci a ricostruire ciò che è accaduto senza trasformare il confronto in un'accusa; se le scansioni non sono state effettuate, deve rendere evidente la conseguenza della mancata supervisione; durante la contenzione, infine, deve chiarire che il programma di monitoraggio e garanzia funziona soltanto all'interno di una responsabilità reciproca.

Alla consegna

> *«Prima di cambiare ogni mascherina dovrai effettuare una scansione con lo smartphone e attendere l'indicazione ricevuta. Se tutto procede correttamente, potrai passare all'allineatore successivo; se invece un dente ha bisogno di più tempo, potremo chiederti di mantenere quello attuale e darti indicazioni specifiche.*
>
> *Il sistema non contiene un cronometro e quindi non può dirci esattamente per quante ore hai utilizzato gli allineatori. Le scansioni settimanali ci permettono però di osservare con continuità il fitting e la progressione del trattamento. Se gli allineatori vengono utilizzati meno del necessario, spesso le conseguenze di questa discontinuità diventano visibili nel tempo.*
>
> *Avrai quindi meno appuntamenti in studio, ma una responsabilità molto precisa: la scansione settimanale fa parte della terapia esattamente come l'utilizzo degli allineatori.»*

Quando il tracking è stato perso

> *«Guardiamo insieme le scansioni delle ultime settimane. In questo modo possiamo individuare il periodo nel quale il tracking ha iniziato a peggiorare e cercare di capire che cosa possa essere successo. Magari scopriremo che proprio in quella settimana c'è stato un matrimonio, un viaggio o un altro momento durante il quale gli allineatori sono rimasti fuori dalla bocca più a lungo del previsto.»*

Quando le scansioni non sono state effettuate

> *«Se avessimo una scansione per ogni settimana, potremmo individuare il periodo nel quale il fitting ha iniziato a peggiorare e cercare di capire che cosa sia successo. Poiché alcune scansioni non sono state effettuate, abbiamo perso la possibilità di accorgercene e intervenire tempestivamente.*
>
> *Adesso dobbiamo valutare quanto tracking sia stato perso e capire se possiamo ancora proseguire con questi allineatori oppure se sarà necessario modificare il piano*

> *di trattamento. In ogni caso, da questo momento dovremo riprendere sia l'utilizzo corretto degli allineatori sia le scansioni settimanali, altrimenti rischieremmo di ritrovarci nuovamente nella stessa situazione.»*

Per proporre il programma durante la contenzione

> *«Da oggi la stabilità del risultato dipenderà soprattutto dall'utilizzo della contenzione. Puoi gestire autonomamente questa fase oppure aderire al nostro programma di controllo e garanzia per i prossimi tre anni.*
>
> *Nel mio studio il programma costa 500 euro all'anno e comprende due sedute di igiene, una ogni sei mesi, il controllo attraverso una scansione domiciliare mensile e il confronto periodico tra la posizione attuale dei denti e quella ottenuta alla fine del trattamento.*
>
> *Se rispetterai il protocollo e, nonostante questo, rileveremo uno spostamento, valuteremo tempestivamente come intervenire e, quando saranno presenti le condizioni previste dal programma, non ti verrà addebitato il costo di un nuovo trattamento ortodontico.*
>
> *Per mantenere attivo il programma dovrai utilizzare correttamente la contenzione, effettuare la scansione mensile e presentarti alle due sedute di igiene previste. Non si tratta soltanto di una copertura economica, ma di un sistema che ci permette di accorgerci rapidamente se qualcosa sta cambiando.»*

Perché questo protocollo funziona

- **Rende visibile ciò che accade tra due controlli**

La scansione settimanale trasforma il lungo intervallo tra due controlli in una successione di piccoli appuntamenti digitali, nei quali il paziente sa che l'andamento del trattamento può essere osservato con regolarità. Allo stesso tempo, il feedback ravvicinato collega più chiaramente il comportamento alle sue possibili conseguenze cliniche: se il fitting inizia a peggiorare, possiamo intervenire quando il problema è ancora limitato, invece di scoprirlo molti mesi dopo.

- **Permette di ricostruire invece di accusare**

Quando il tracking viene perso o le scansioni previste non sono state effettuate, non è necessario trasformare la conversazione in un confronto tra la versione del paziente e quella del medico. La cronologia disponibile permette di ricostruire insieme ciò che è accaduto e, collegando il cambiamento a episodi concreti come un

matrimonio, un viaggio o una settimana particolare, facilita il recupero di ricordi più specifici rispetto a una domanda generica sulle ore di utilizzo. In questo modo il paziente può riconoscere una possibile riduzione della collaborazione senza sentirsi immediatamente accusato di avere mentito.

Mantiene chiari i limiti del sistema

Il Dental Monitoring non misura direttamente le ore di utilizzo e il mancato movimento di un dente non dimostra automaticamente una scarsa collaborazione. Dichiarare apertamente questi limiti rende il monitoraggio più credibile e impedisce che venga trasformato in uno strumento utilizzato per dimostrare che il paziente ha sbagliato, mantenendo invece la sua funzione più utile: individuare precocemente una deviazione e aiutarci a comprenderne le possibili cause.

Trasforma il controllo in una responsabilità condivisa

Il monitoraggio funziona soltanto se entrambe le parti rispettano il proprio ruolo: lo studio deve osservare le informazioni ricevute e intervenire quando necessario, mentre il paziente deve effettuare le scansioni, seguire le indicazioni e mantenere aperto il canale di supervisione. Questo principio diventa ancora più evidente durante la contenzione, quando la garanzia non elimina la responsabilità del paziente, ma la inserisce all'interno di un accordo reciproco e verificabile.

BIBLIOGRAFIA

Hansa I, Semaan SJ, Vaid NR. Clinical outcomes and patient perspectives of Dental Monitoring® GoLive® with Invisalign®—a retrospective cohort study. Progress in Orthodontics. 2020;21:16.

Moylan HB, Carrico CK, Lindauer SJ, Tüfekçi E. Accuracy of a smartphone-based orthodontic treatment-monitoring application: a pilot study. The Angle Orthodontist. 2019;89(5):727–733.

Hansa I, Katyal V, Ferguson DJ, Vaid NR. Outcomes of clear aligner treatment with and without Dental Monitoring: a retrospective cohort study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2021;159(4):453–459.

Sangalli L, Alessandri-Bonetti A, Dalessandri D. Effectiveness of dental monitoring system in orthodontics: a systematic review. Journal of Orthodontics. 2024;51(1):28–40.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Con il paziente dominante conviene presentare il Dental Monitoring come uno strumento che permette di individuare rapidamente un problema, prendere una decisione e ridurre il rischio di ritardi:

> *«Con le scansioni settimanali possiamo capire rapidamente se il trattamento sta procedendo correttamente e intervenire prima che un piccolo problema rallenti il risultato.»*

I

Influente

Con il paziente influente è utile valorizzare la semplicità, il contatto con il team e la possibilità di ricevere conferme frequenti senza dover tornare continuamente in studio:

> *«Ogni settimana ci invierai le immagini e resteremo in contatto attraverso l'applicazione, così potrai sapere se tutto sta procedendo bene anche senza venire ogni volta in studio.»*

S

Stabile

Con il paziente stabile è importante sottolineare la continuità del controllo e la presenza costante del team, evitando che la distanza tra gli appuntamenti venga percepita come un abbandono:

> *«Anche se gli appuntamenti saranno più distanziati, non sarai lasciato solo. Controlleremo regolarmente le scansioni e ti guideremo durante ogni passaggio.»*

C

Coscienzioso

Con il paziente coscienzioso è preferibile fornire un protocollo preciso, definendo chiaramente frequenza, procedura, criteri di cambio e limiti del sistema:

> *«La scansione dovrà essere effettuata una volta alla settimana, prima del cambio. In base al fitting riceverai l'indicazione di proseguire oppure di mantenere l'allineatore attuale. Il sistema non calcola le ore di utilizzo, ma ci permette di documentare con continuità l'andamento clinico.»*

CAPITOLO 15

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Durante la fase attiva e, per chi aderisce, nel programma opzionale di contenzione.
OBIETTIVO	Individuare precocemente le deviazioni e mantenere una supervisione continua tra i controlli in studio.
COSA FARE	***Fase attiva*** 1. Richiedere una scansione settimanale prima del cambio e attendere l'indicazione per proseguire. 2. Se il fitting non è adeguato, valutare un utilizzo più lungo dell'allineatore, ribadire le ore prescritte e l'utilizzo dei chewies quando indicato, quindi monitorare. 3. Se il problema persiste, anticipare il controllo e valutare prosecuzione, nuova scansione o rifinitura. 4. Se le scansioni mancano o sono inadeguate, ripristinarle; se necessario, aumentare i controlli e ridurre gli allineatori consegnati. 5. Programmare generalmente controlli ogni quattro–sei mesi, adattandoli al caso. ***Contenzione — programma opzionale*** 1. Concordare durata e costo: nel protocollo descritto, fino a tre anni, 500 euro all'anno. 2. Richiedere scansioni domiciliari mensili; controllo, igiene e scansione intraorale ogni sei mesi. 3. Legare la garanzia a programma attivo, corretto utilizzo, scansioni, controlli e comunicazione tempestiva dei problemi.
COSA VERIFICARE	Qualità e regolarità delle scansioni, fitting, progresso e risposta alle indicazioni. Il monitoraggio non misura le ore di utilizzo e non sostituisce tutti i controlli in presenza. Durante la contenzione, verificare il rispetto delle condizioni della garanzia.

CAPITOLO

16

Quando bisogna finire davvero

«Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.»

— QOÈLET 3,1

Per molto tempo, concludere un trattamento prima di avere raggiunto tutti gli obiettivi mi sembrava una resa. Se rimaneva qualcosa da correggere, ritenevo quasi mio dovere trovare un altro modo per riuscirci. Il trattamento portava il mio nome e l'incompletezza del risultato continuava ad apparirmi come una responsabilità personale, anche quando la collaborazione del paziente era rimasta insufficiente.

La difficoltà maggiore arrivava quando sapevo che cosa avrei voluto ottenere, ma il paziente continuava a non utilizzare gli allineatori o gli elastici con la regolarità necessaria. Avevamo chiarito le indicazioni, affrontato le difficoltà e provato a recuperare il percorso, senza ottenere un cambiamento sufficientemente stabile. Potevo programmare un'altra serie, modificare gli attachment o proporre controlli

più ravvicinati, ma nessuno di questi interventi poteva compensare da solo la collaborazione che continuava a mancare.

In quelle situazioni, ogni nuovo tentativo mi permetteva di rimandare una decisione che facevo fatica ad accettare. Finché il trattamento rimaneva aperto, il risultato incompleto sembrava ancora provvisorio. Dichiararlo concluso significava riconoscere che una parte degli obiettivi non era stata raggiunta e che non potevo raggiungerla attraverso il solo lavoro clinico.

Questo capitolo affronta proprio quel momento: quando, dopo avere rivalutato le cause dello stallo e tentato di recuperare la collaborazione, l'impegno del paziente rimane insufficiente per la terapia. Possono esserci una correzione incompleta, una rotazione o contatti da migliorare: obiettivi che hanno ancora un valore clinico, ma che richiedono una partecipazione sulla quale non riusciamo a contare.

Come decidiamo se offrire un'ultima possibilità, cambiare metodica oppure concludere la fase attiva?

La risposta richiede di considerare insieme ciò che manca e la possibilità concreta di raggiungerlo. Dobbiamo valutare l'importanza degli obiettivi residui, la situazione clinica attuale e il comportamento osservato dopo i tentativi di recupero. Sapere che un risultato potrebbe essere migliore non basta, da solo, a giustificare un'altra fase se la collaborazione necessaria continua a mancare.

Ho imparato che questa decisione fa parte della responsabilità dell'ortodontista quanto la progettazione iniziale. Richiede di essere trasparenti sul risultato, discutere le alternative e riconoscere quanto possiamo ottenere nelle condizioni presenti, senza vivere ogni obiettivo incompleto come un fallimento personale.

Quando esistono ancora margini per recuperare la collaborazione, possiamo offrire un'ultima possibilità. Deve però avere condizioni precise e un momento di verifica: altrimenti rischia di diventare soltanto un'altra ripartenza.

LO SCRIPT OPERATIVO

Lo script operativo si articola in cinque parti: definire una finestra di recupero, valutare se il trattamento abbia ripreso a progredire, considerare un cambio di metodica, decidere se concludere la fase attiva e, in questo caso, chiuderla concretamente. I passaggi successivi alla verifica dipendono dalla risposta clinica e dalle alternative appropriate per il paziente.

1. Definire la finestra di recupero

Prima di proporre la finestra di recupero, rivaluto le possibili cause dello stallo e verifico che il paziente abbia ricevuto istruzioni chiare e coerenti. Devo distinguere una collaborazione insufficiente da difficoltà legate alla programmazione, alla risposta biologica o alla comprensione delle indicazioni.

Definisco con il paziente il comportamento richiesto, il periodo nel quale mantenerlo, i dati clinici che utilizzeremo per la verifica e le alternative che valuteremo se il progresso rimarrà insufficiente. È quella che chiamo **finestra di recupero**.

La durata dipende dal caso e dal movimento che dobbiamo osservare. Il termine deve essere concordato fin dall'inizio, insieme a indicazioni concrete sull'utilizzo degli allineatori e degli elastici, sui cambi, sulle scansioni di monitoraggio e sui controlli.

La conversazione può iniziare così:

> *«Voglio verificare insieme a te se possiamo recuperare il trattamento, ma questa volta dobbiamo stabilire con chiarezza come valuteremo il risultato. Fino al prossimo controllo sarà necessario utilizzare gli allineatori e gli elastici secondo le indicazioni, rispettare i cambi ed effettuare le scansioni concordate.*
>
> *Al controllo confronteremo il fitting e il movimento ottenuto. Se vedremo un progresso sufficiente, potremo continuare. Se invece ci troveremo ancora nella stessa situazione, dovremo valutare una metodica diversa oppure, se le condizioni cliniche lo consentono, la conclusione della fase attiva.»*

L'ultima parte è fondamentale. Se non spieghiamo prima che cosa accadrà in assenza di un progresso sufficiente, alla verifica saremo nuovamente tentati di concedere un'altra possibilità. **Un'ultima possibilità che viene rinnovata automaticamente perde il proprio significato.**

2. Quando possiamo continuare con gli allineatori

Al controllo valuto il fitting, confronto le scansioni e osservo il movimento ottenuto, interpretando questi dati insieme alle altre informazioni cliniche. Le dichiarazioni del paziente aiutano a ricostruire il percorso, ma non sostituiscono la verifica della sua efficacia.

Se il comportamento è cambiato e il trattamento ha ripreso a progredire, possiamo continuare con gli allineatori. Non dobbiamo pretendere che il paziente sia diventato perfetto. Dobbiamo verificare che la collaborazione sia sufficiente per gli obiettivi residui e che il progresso giustifichi la prosecuzione.

Un breve miglioramento nei giorni precedenti il controllo può non bastare. La finestra deve permetterci di osservare una continuità adeguata a ciò che ancora dobbiamo ottenere. Se il monitoraggio o i controlli ravvicinati hanno favorito il recupero, mantengo quel supporto per il tempo necessario a consolidarlo.

3. Se dobbiamo cambiare metodica

Quando l'obiettivo rimane indicato, ma il paziente non riesce a sostenere le richieste degli allineatori, possiamo valutare un mezzo terapeutico meno dipendente dalle ore di utilizzo. Una terapia può essere indicata clinicamente e rivelarsi difficile da sostenere nella vita quotidiana della persona. Preferisco spiegarlo così:

> *«Gli allineatori possono ottenere il movimento che ci serve, ma richiedono una regolarità di utilizzo che finora non siamo riusciti a mantenere. Abbiamo provato più volte a recuperare il percorso e oggi devo riconoscere che questa metodica si sta adattando con difficoltà alla tua quotidianità. Se vuoi ancora perseguire gli obiettivi mancanti, possiamo valutare un'apparecchiatura meno dipendente dalle ore di utilizzo. Ti spiegherò quali possibilità offre e quale impegno richiede, così potrai decidere se affrontare questa nuova fase.»*

Il cambiamento richiede una nuova valutazione. Dobbiamo discutere indicazioni, limiti, rischi, tempi e investimento, chiarendo anche la collaborazione necessaria con la nuova apparecchiatura. Sostituire il mezzo terapeutico non garantisce automaticamente il risultato.

Se viene proposta una nuova fase, attraverso una metodica differente o una ripartenza con gli allineatori, dobbiamo chiarirne anche le condizioni economiche. Scansioni, rivalutazione clinica, progettazione, apparecchiature, appuntamenti e tempo del team rappresentano lavoro reale, anche quando il pacchetto dell'azienda consente ancora di ordinare altre serie di allineatori.

L'eventuale nuovo compenso deve essere coerente con quanto concordato all'inizio e con le ragioni della ripartenza. Una rifinitura fisiologica e la ripetizione di attività rese inefficaci da una collaborazione persistentemente insufficiente richiedono valutazioni differenti.

Non esiste una cifra universale. L'importo dipende dal lavoro richiesto, dai costi, dalla complessità della nuova fase e dalle condizioni comunicate e concordate. Non deve comparire improvvisamente durante il conflitto: la possibilità di un nuovo investimento va spiegata in anticipo e discussa con precisione prima di procedere.

Il pagamento, tuttavia, non dimostra che la collaborazione cambierà. Il paziente può accettare il costo e mantenere le stesse abitudini. Le condizioni economiche devono quindi accompagnare un piano concreto, con comportamenti richiesti e criteri di verifica.

Prima di ripartire dobbiamo chiarire sia il lavoro necessario sia ciò che renderà questa fase diversa dalle precedenti.

4. Se dobbiamo concludere la fase attiva

Se valutiamo la conclusione, dobbiamo distinguere le ragioni che ci portano a questa scelta.

In una prima situazione, il risultato raggiunto è clinicamente accettabile, anche se non coincide perfettamente con quello ideale programmato. Quanto rimane incompleto ha un'importanza limitata e il beneficio prevedibile di un'altra fase appare modesto rispetto al tempo e all'impegno richiesti.

In una seconda situazione rimangono obiettivi clinicamente rilevanti, ma il paziente non riesce o non desidera affrontare le condizioni necessarie per raggiungerli. Può rifiutare il cambio di metodica, non accettare il nuovo investimento oppure non essere disposto a sostenere l'impegno richiesto.

Possiamo allora valutare una conclusione con compromesso, purché la situazione residua sia clinicamente accettabile e i rischi siano stati esaminati e spiegati. La differenza riguarda il motivo per cui ci fermiamo: nel primo caso riteniamo che quanto manca non giustifichi un'ulteriore fase; nel secondo riconosciamo il valore degli obiettivi residui, ma il paziente sceglie di non affrontare il percorso necessario.

Il compromesso deve essere comprensibile. Dobbiamo descrivere quanto ottenuto, quanto incompleto, le alternative proposte e le possibili conseguenze della decisione. Se la situazione presenta rischi non accettabili, la semplice consegna di una contenzione non risolve il problema: occorre proporre una soluzione appropriata e gestire l'eventuale rifiuto, assicurando la continuità delle cure necessarie.

Per affrontare questa conversazione utilizzerei uno script come questo:

> *«Il risultato che abbiamo raggiunto non corrisponde ancora completamente a quello programmato e voglio essere trasparente su questo punto. Abbiamo provato più volte a proseguire, ma oggi non vedo condizioni sufficienti per aspettarmi che un'altra serie di allineatori, nello stesso modo, produca un risultato diverso.*
>
> *Continuare aggiungerebbe altro tempo al trattamento senza una ragionevole previsione di miglioramento. Per questo ritengo necessario scegliere un percorso diverso.*

> *Se desideri perseguire gli obiettivi mancanti, possiamo valutare un'altra metodica. Ti spiegherò indicazioni, limiti, impegno, tempi e costi. Se invece valuteremo di concludere la fase attiva, dovremo verificare che la situazione raggiunta sia clinicamente accettabile e chiarire quali obiettivi rimangano incompleti.*
>
> *Ti mostrerò che cosa abbiamo ottenuto, che cosa manca e quali conseguenze può avere la scelta di fermarci. Se concluderemo, rimuoveremo gli elementi della terapia attiva, predisporremo una contenzione adeguata e programmeremo i controlli necessari.*
>
> *Continueremo a occuparci della tua situazione. Concludere questa fase significa riconoscere il limite del percorso attuale e scegliere come proteggere il risultato raggiunto.»*

Il paziente può essere deluso, chiedere un'altra rifinitura o dichiararsi disposto a continuare per tutto il tempo necessario. Dobbiamo ascoltarlo e comprendere che cosa desideri ottenere. La sua disponibilità, però, non rende automaticamente indicata la prosecuzione.

La decisione nasce dall'incontro tra due responsabilità: il paziente stabilisce quale impegno sia disposto ad assumersi e quali proposte accettare; il medico individua le opzioni clinicamente proponibili e ne spiega le ragioni.

Il paziente può anche scegliere di non proseguire. In quel caso deve comprendere ciò che rimane incompleto, le possibili conseguenze e le alternative disponibili. Il rifiuto va documentato e accompagnato dalle indicazioni necessarie per gestire la situazione residua. Accogliere quella scelta non significa dichiarare ideale il risultato raggiunto.

5. Chiudere concretamente il trattamento

Quando la decisione è concludere, la fase attiva deve essere realmente chiusa. Non basta smettere di ordinare allineatori o lasciare il paziente con l'ultima mascherina in attesa di capire che cosa farà.

Documento la situazione finale, gli obiettivi incompleti, le alternative proposte e la scelta del paziente. Rimuovo gli attachment e gli elementi che non devono rimanere, predispongo la contenzione e consegno indicazioni comprensibili, programmando i controlli necessari.

Quando concludo per collaborazione insufficiente, non applico il protocollo di stabilizzazione descritto nei capitoli precedenti. Quel protocollo richiede altri nove mesi di utilizzo regolare degli allineatori. Se questa continuità è mancata durante

la fase attiva, non posso fondare la stabilizzazione sull'aspettativa che venga mantenuta proprio ora.

Passo quindi direttamente alla contenzione, adattandola alla situazione clinica residua. Anche questa fase richiede collaborazione: dobbiamo chiarirne modalità, limiti e controlli, senza lasciare intendere che il risultato si conserverà indipendentemente dal comportamento del paziente.

Infine, tutto il team deve conoscere la decisione. Appuntamenti e comunicazioni devono riflettere il passaggio dalla terapia attiva alla contenzione. Il paziente deve sapere che cosa è terminato e quale assistenza continuerà.

Perché questo protocollo funziona

- **Impegno verificabile**

La finestra di recupero trasforma una promessa generica in un comportamento definito. Il paziente conosce ciò che gli viene richiesto, il periodo nel quale mantenerlo e il momento della verifica. Anche l'ortodontista dispone di un termine al quale rivalutare il caso, evitando che l'ultima possibilità si prolunghi senza una decisione.

- **Valutazione clinica senza ricerca della confessione**

Il confronto tra fitting, scansioni e movimento ottenuto permette di affrontare il progresso del trattamento senza concentrare la conversazione sulla sincerità del paziente. Le sue dichiarazioni contribuiscono alla ricostruzione, ma la decisione richiede una verifica clinica.

I dati devono essere interpretati considerando anche le possibili cause biologiche e biomeccaniche: il mancato movimento non dimostra automaticamente una collaborazione insufficiente.

- **Coerenza delle conseguenze**

Se ogni termine viene spostato e ogni verifica produce un'altra ripartenza, la conseguenza annunciata perde significato. Prendere una decisione alla scadenza concordata rende credibili i confini del trattamento.

Questo vale anche per l'ortodontista: avere definito prima le alternative lo aiuta a evitare che la difficoltà della conversazione conduca a concedere automaticamente un'altra serie.

- **Alternative comprensibili**

Presentare le diverse possibilità aiuta il paziente a comprendere che il percorso può cambiare. Possiamo continuare con gli allineatori quando il recupero è sufficiente, valutare un'altra metodica oppure concludere quando clinicamente appropriato.

La chiarezza delle alternative permette al paziente di esprimere preferenze e priorità. L'ortodontista mantiene la responsabilità di individuare le opzioni proponibili e di spiegarne benefici e limiti.

Investimento consapevole

Quando una nuova fase comporta un costo, chiarirlo in anticipo rende espliciti il lavoro richiesto e le condizioni della ripartenza. Il paziente può valutare quanto il risultato sia importante per lui e quale impegno sia disposto ad assumersi.

Il pagamento non garantisce una maggiore collaborazione. Il nuovo investimento deve accompagnare un piano concreto, con comportamenti richiesti e criteri di verifica.

Continuità della cura

Spiegare che cosa continuerà dopo la conclusione aiuta a ridurre il timore di essere abbandonati. Contenzione, controlli e indicazioni appropriate rendono concreta la continuità dell'assistenza.

La documentazione conserva il significato della decisione; la comunicazione al team evita che appuntamenti o messaggi incoerenti lascino il trattamento aperto nella percezione del paziente.

Un trattamento che rimane aperto senza riuscire più a progredire non consuma soltanto tempo e risorse. A poco a poco comincia a consumare anche le persone che continuano a portarlo avanti.

BIBLIOGRAFIA

Gross AM, Samson G, Dierkes M. Patient cooperation in treatment with removable appliances: a model of patient noncompliance with treatment implications. *American Journal of Orthodontics.* 1985;87(5):392–397.

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine.* 2012;27(10):1361–1367.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Utilizzo una comunicazione diretta, centrata sulla decisione e sulle alternative:

> *«Il trattamento non sta producendo un progresso sufficiente e non considero utile ripetere un'altra serie nelle stesse condizioni. Possiamo valutare una metodica diversa oppure, se la situazione clinica lo consente, concludere la fase attiva e proteggere il risultato con una contenzione appropriata.»*

Metto in evidenza i criteri della scelta e il beneficio prevedibile, evitando spiegazioni dispersive.

I

Influente

Riconosco l'entusiasmo delle ripartenze e riporto l'attenzione sulla continuità:

> *«Ogni volta ripartiamo con molta motivazione, ma poi diventa difficile mantenere la routine. Prima di ricominciare dobbiamo scegliere un percorso che tu riesca a sostenere anche dopo le prime settimane.»*

Mantengo un tono positivo e collego la motivazione a un piano concreto e verificabile.

S

Stabile

Sottolineo la continuità dell'assistenza e accompagno la decisione:

> *«Continueremo a occuparci della tua situazione. Ora dobbiamo valutare se cambiare metodica oppure concludere questa fase, proteggendo quanto ottenuto e programmando i controlli necessari.»*

Lascio spazio alle domande e chiarisco quali aspetti della cura continueranno dopo la conclusione.

C

Coscienzioso

Utilizzo dati, confronto e criteri:

> *«Abbiamo confrontato le scansioni, il fitting e i movimenti ottenuti. Il progresso rimane insufficiente rispetto agli obiettivi residui. Ti mostro quanto raggiunto, quanto incompleto e le alternative disponibili, con i rispettivi limiti.»*

Rendo trasparenti gli elementi che hanno portato alla proposta e distinguo i dati osservati dalle previsioni.

CAPITOLO 16

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Quando il trattamento rimane in stallo e occorre decidere se proseguire, cambiare metodica oppure concludere.
OBIETTIVO	Prendere una decisione clinicamente appropriata e garantire la continuità dell'assistenza.
COSA FARE	1. Rivalutare programmazione, risposta clinica e collaborazione, distinguendo difficoltà temporanee e comportamenti persistenti. 2. Verificare che le istruzioni siano comprensibili e coerenti per tutto il team. 3. Quando indicato, concordare una finestra di recupero con comportamenti, durata, criteri di verifica e alternative. 4. Valutare il cambiamento attraverso fitting e movimenti ottenuti: una nuova promessa non basta. 5. Proseguire se le condizioni migliorano; valutare un'altra metodica se gli obiettivi rimangono indicati; concludere quando appropriato, accettando soltanto compromessi clinicamente sostenibili. 6. Documentare obiettivi raggiunti e incompleti, alternative e scelta del paziente; chiarire eventuali nuovi costi. 7. Se si conclude, rimuovere gli elementi della terapia attiva, predisporre la contenzione e programmare i controlli. Per collaborazione insufficiente, il protocollo prevede il passaggio diretto alla contenzione, senza stabilizzazione. 8. Allineare appuntamenti e comunicazioni del team alla decisione.
COSA VERIFICARE	Cause dello stallo, risposta al recupero, fattibilità delle alternative, accettabilità del compromesso e comprensione del percorso successivo. Concludere la fase attiva non significa interrompere l'assistenza.

CAPITOLO

17

Il costo che non avevamo ancora contato

«Alla mente deve essere concesso riposo: dopo essersi riposata si rialzerà migliore e più acuta.»

— SENECA

Ci sono giornate in cui tutto sembra essere andato bene. Hai iniziato puntuale, hai visto ottanta pazienti, hai risolto problemi, consegnato nuovi allineatori, controllato trattamenti che stanno procedendo esattamente come avevi programmato e incontrato genitori soddisfatti, ragazzi che collaborano e adulti entusiasti del loro sorriso. Magari sei persino riuscito a finire quasi in orario, che in una giornata del genere può già essere considerata una piccola vittoria.

Poi chiudi la porta dello studio, saluti lo staff, sali in macchina e torni a casa, ed è proprio in quel momento che succede una cosa strana: durante quella giornata

hai visto ottanta pazienti e con la stragrande maggioranza di loro tutto è andato bene, ma nella tua testa non ci sono loro. Ci sono quei due o tre che hanno assorbito una quantità di energia completamente sproporzionata rispetto al tempo che hai trascorso con loro.

C'è quello che ti ha assicurato di avere utilizzato gli allineatori con perfetta regolarità, mentre il fitting raccontava una storia completamente diversa; quello che per l'ennesima volta non ha portato con sé le mascherine e ti ha costretto a ricostruire quello che potrebbe essere successo nelle ultime settimane; quello che, dopo mesi di collaborazione discutibile, pretende una nuova rifinitura come se fosse la naturale prosecuzione del trattamento. Oppure c'è quella paziente che ha appena concluso il trattamento, con un risultato che consideri clinicamente eccellente, che davanti alle fotografie e alla scansione ammette che sul monitor i denti sembrano perfettamente dritti, ma poi aggiunge che quando si guarda allo specchio continua a vedere qualcosa che non le piace.

Sono tutti usciti dallo studio da un pezzo, ma qualcuno di loro è salito in macchina con te.

Questa è probabilmente una delle conseguenze della scarsa collaborazione di cui si parla meno. Nei capitoli precedenti abbiamo provato a misurarne molte altre, parlando di tempo, appuntamenti, scansioni, rifiniture, materiali, costi e ore di lavoro dello staff. Abbiamo visto come una serie aggiuntiva di allineatori non sia semplicemente una scatola che arriva in studio e come dietro ogni trattamento che deve essere ripreso esista una quantità di lavoro invisibile che difficilmente compare nei nostri conti.

C'è però un costo che fino a questo momento non abbiamo ancora contato, perché non compare nel gestionale, non possiamo inserirlo nel bilancio dello studio e nessuno ci presenta una fattura alla fine del mese: è l'**energia mentale** che consumiamo ogni volta che dobbiamo affrontare nuovamente situazioni che avremmo preferito non dover gestire. Ogni paziente che richiede spiegazioni ripetute, ogni appuntamento nel quale dobbiamo ricostruire ciò che è realmente accaduto, ogni promessa di collaborazione che sappiamo essere già stata fatta altre volte, ogni richiesta che consideriamo irragionevole e ogni decisione che siamo costretti a prendere nuovamente consuma una piccola parte delle nostre risorse.

Una singola situazione di questo tipo significa poco e fa semplicemente parte del nostro lavoro. Il problema nasce dalla ripetizione e, soprattutto, dalla sproporzione. Non sono necessariamente gli ottanta pazienti di una giornata a consumarci: settanta o settantacinque di loro possono lasciarci più energia di quanta ne avessimo al mattino, perché vedere un trattamento che procede bene, un bambino contento o

un paziente che finalmente sorride rappresenta una delle ragioni per cui continuiamo ad amare questo lavoro. Possono essere invece quei due o tre pazienti che, pur occupando una piccola parte dell'agenda, riescono a occupare una parte enorme dei nostri pensieri. Quando questo meccanismo si ripete per settimane, mesi e anni, quello che sembrava soltanto un fastidio quotidiano può diventare qualcosa di molto diverso.

La letteratura odontoiatrica studia da molti anni lo stress professionale e il burnout e sarebbe semplicistico, oltre che scientificamente scorretto, cercarne una singola causa. Le ore lavorate, la pressione del tempo, gli aspetti economici, la gestione dello studio, i rapporti con i collaboratori, le responsabilità cliniche e amministrative sono soltanto alcuni dei fattori che possono contribuire al carico professionale. Tra questi, però, compare ripetutamente qualcosa che riguarda direttamente il tema di questo libro: la difficoltà nella relazione con alcuni pazienti.

Gli studi condotti sul dental team hanno mostrato come i cosiddetti difficult patients possano rappresentare una vera e propria richiesta lavorativa e come una maggiore esposizione a questo tipo di relazioni sia associata a esaurimento emotivo e burnout. In uno studio condotto su più di seicento dentisti, i professionisti stimavano addirittura che circa un quarto dei propri pazienti potesse essere considerato, in qualche modo, problematico o difficile da gestire, e la percezione di avere una maggiore quota di questi pazienti mostrava una relazione particolarmente significativa con il burnout.

Questo non significa naturalmente che un paziente difficile provochi il burnout, e ancora meno che ogni paziente scarsamente collaborante debba essere considerato un paziente difficile. Sarebbe una conclusione che la letteratura non permette di sostenere e che non avrebbe alcun senso nella nostra pratica quotidiana, perché la maggior parte dei pazienti che dimentica un elastico, perde qualche ora di utilizzo o attraversa un periodo nel quale collabora meno non rappresenterà mai un problema significativo per noi.

Il punto diventa interessante quando determinate situazioni smettono di essere occasionali e iniziano a ripetersi, richiedendo continuamente tempo, attenzione, decisioni, negoziazioni e talvolta gestione del conflitto. A quel punto non sono più soltanto eventi clinici, ma diventano parte del carico lavorativo, perché un allineatore che non viene utilizzato non significa soltanto alcune ore in meno sulla bocca del paziente: può tradursi in un appuntamento più lungo, una nuova spiegazione, una scansione non prevista, una modifica dell'agenda, una telefonata della segreteria, un confronto con un genitore o con il paziente, una nuova pianificazione e,

qualche volta, una discussione su chi debba sostenere il costo di ciò che è necessario fare.

Un comportamento apparentemente semplice può quindi generare una cascata di conseguenze che coinvolge molte persone e consuma una quantità di risorse enormemente superiore a quella che vediamo guardando soltanto la bocca del paziente.

Prima ancora che il problema arrivi davanti a noi, qualcuno può aver dovuto rispondere al telefono, trovare un nuovo appuntamento in un'agenda già piena, richiamare il paziente che non si è presentato o ricordargli ciò che era stato concordato. In molti casi è proprio la segreteria a ricevere per prima l'insoddisfazione, la protesta o la frustrazione del paziente, quando ancora noi non sappiamo nemmeno che esiste un problema.

La letteratura dedicata al dental team mostra infatti come receptionist, assistenti, igienisti, practice manager e clinici possano essere esposti in maniera diversa alle conseguenze delle relazioni difficili con i pazienti. Gli studi qualitativi descrivono qualcosa che probabilmente molti di noi hanno osservato senza mai dargli un nome preciso: la tensione generata da un singolo paziente può propagarsi all'interno dello studio. La segretaria riceve una telefonata difficile e ne parla con l'assistente, l'assistente avverte il medico prima dell'appuntamento, il medico entra nella stanza sapendo già che dovrà affrontare una conversazione complessa e, se l'appuntamento dura più del previsto, il ritardo finisce per trasferirsi anche ai pazienti successivi.

In questo modo un problema nato nella bocca di una persona può arrivare a modificare la giornata di molte altre, ed è proprio per questo che proteggere il team non può significare semplicemente insegnargli a sopportare meglio i pazienti difficili. Significa soprattutto evitare, quando è possibile, che ogni situazione venga affrontata come se fosse la prima volta che accade.

Affrontare ogni situazione da capo significa chiedere al team di cercare una risposta e al medico di prendere nuovamente una decisione. Credo che una parte importante della fatica nasca proprio qui: oltre a gestire le conseguenze del comportamento del paziente, dobbiamo ogni volta stabilire come procedere. Il paziente non ha utilizzato gli allineatori e dobbiamo stabilire se farlo continuare o fermarci; non ha utilizzato gli elastici e dobbiamo capire quanto possiamo fidarci di ciò che ci racconta; il fitting non è corretto su un solo dente e dobbiamo scegliere se eseguire immediatamente una nuova scansione o proseguire; è sparito per un anno e oggi telefona dicendo che vuole ricominciare, quindi dobbiamo decidere da dove ripartire e quali costi dovrà sostenere; ha già effettuato diverse rifiniture e continua a

chiedere di modificare dettagli che clinicamente consideriamo irrilevanti, costringendoci ancora una volta a stabilire dove sia il limite.

Presi singolarmente sono problemi semplici e un professionista con esperienza è perfettamente in grado di risolverli. Il problema nasce quando dobbiamo risolverli centinaia di volte, ricordandoci magari come avevamo deciso sei mesi prima con un paziente simile, spiegando allo staff perché questa volta stiamo facendo diversamente e domandandoci successivamente se non sarebbe stato meglio scegliere un'altra strada.

È qui che diventa interessante un modello molto utilizzato nella letteratura sullo stress lavorativo, il Job Demands–Resources model, che distingue, semplificando molto, tra le richieste che il lavoro ci pone continuamente, le job demands, e le risorse che abbiamo a disposizione per affrontarle, le job resources. Le prime richiedono e consumano energia, mentre le seconde aiutano a gestirle mantenendo controllo, motivazione ed efficacia. Questo modello è stato studiato anche specificamente nei dentisti e alcuni studi longitudinali condotti su migliaia di professionisti hanno mostrato la relazione tra elevate richieste lavorative e burnout e, dall'altra parte, il ruolo positivo delle risorse lavorative nel sostenere l'engagement professionale.

Leggendo questi lavori mi sono reso conto che, pur senza voler attribuire al termine un significato scientifico che gli studi non hanno direttamente dimostrato, nella nostra pratica quotidiana possiamo considerare anche un protocollo come una risorsa: se una situazione si ripete e abbiamo già deciso come affrontarla, non siamo costretti a ricominciare ogni volta da zero.

Ecco perché esistono i protocolli di questo libro

Arrivati a questo punto possiamo finalmente guardarci indietro e osservare con una prospettiva diversa tutto quello che abbiamo costruito nelle pagine precedenti. Se avete letto questo libro dall'inizio avete incontrato molti protocolli, molti script e probabilmente anche qualche regola che, almeno inizialmente, potrebbe esservi sembrata rigida: abbiamo parlato del paziente che non utilizza gli allineatori, di quello che non utilizza gli elastici, di quello che perde il fitting o non utilizza la contenzione, di quello che sparisce e poi ritorna dopo molto tempo, di quello che necessita di una rifinitura fisiologica e di quello che invece ci costringe a ripetere una fase del trattamento perché non ha collaborato, fino ad arrivare al paziente che continua a chiedere qualcosa quando noi pensiamo di avere già raggiunto il risultato.

Per ognuna di queste situazioni abbiamo cercato di stabilire prima cosa fare, non perché vogliamo trasformare la medicina in un regolamento e neppure perché tutti i pazienti debbano essere trattati nello stesso modo. Un protocollo non deve mai sostituire il giudizio del medico e ci saranno sempre situazioni nelle quali sarà corretto fare un'eccezione; la differenza fondamentale è che quell'eccezione dovrebbe essere una nostra scelta consapevole, non la conseguenza del fatto che non avevamo deciso cosa fare.

Dopo tanti anni di lavoro questa distinzione per me è diventata fondamentale, perché un protocollo non mi dice soltanto come gestire il paziente, ma mi evita di dover reinventare ogni volta la gestione dello stesso problema. Allo stesso modo, uno script non serve soltanto a trovare le parole giuste: serve a fare in modo che quelle parole non dipendano dal mio livello di stanchezza, dall'ora della giornata, dal fatto che io sia in ritardo o da quanto quel paziente sia riuscito a innervosirmi, e permette soprattutto allo studio di parlare una lingua comune.

Se la segreteria sa già cosa succede quando un paziente sparisce, non deve venire ogni volta a chiedermelo; se il team conosce il modo in cui gestiamo una rifinitura dovuta a mancata collaborazione, non deve interpretare la situazione; se il paziente conosce dall'inizio le conseguenze di determinati comportamenti, la conversazione successiva diventa più semplice perché non stiamo inventando una regola nel momento in cui il problema si presenta, ma stiamo applicando qualcosa che avevamo già condiviso.

Tutto questo non elimina i pazienti difficili e non impedirà a qualcuno di non collaborare, ma può eliminare una parte importante della fatica necessaria per gestirli. Ed è forse questo il motivo per cui, arrivato alla fine del libro, considero gli script e i protocolli non soltanto strumenti organizzativi o clinici, ma una forma di protezione: permettono al pilota e all'equipaggio di sapere cosa fare anche quando il passeggero decide di comportarsi in un modo che non avevamo sperato.

Questa protezione comincia anche dal riconoscere i limiti del nostro controllo. Con gli allineatori abbiamo sviluppato strumenti straordinari per pianificare il movimento dentale: pianifichiamo decimi di millimetro, gradi di torque, intrusioni, espansioni, sequenze, attachment e staging, passando ore davanti a una simulazione nel tentativo di prevedere ciò che accadrà mesi dopo nella bocca di una persona.

Possiamo progettare il trattamento migliore possibile, ma non possiamo utilizzare gli allineatori al posto del paziente; possiamo spiegare quanto siano importanti gli elastici, ma non possiamo essere con lui ogni sera per controllare che li abbia messi; possiamo ricordargli gli appuntamenti, ma non possiamo obbligarlo a presentarsi; possiamo mostrargli fotografie, scansioni e risultati, ma non possiamo decidere al

posto suo se sarà soddisfatto e, soprattutto, non possiamo costringerlo a raccontarci sempre esattamente quello che è successo.

Credevo che diventare più bravo significasse riuscire a controllare sempre più cose e, almeno in parte, continuo a pensarlo, perché l'esperienza clinica serve esattamente ad aumentare la nostra capacità di prevedere, prevenire e gestire ciò che può accadere. Esiste però un'altra forma di esperienza, che probabilmente arriva più lentamente: imparare a riconoscere quali cose non potremo mai controllare e smettere di consumare energie nel tentativo di farlo.

Quando ho iniziato a scrivere questo libro pensavo che sarebbe stato soprattutto un libro sulla collaborazione del paziente. Arrivato alla fine mi sono accorto che è diventato anche un libro su di noi e su ciò che possiamo fare per rendere più semplice un trattamento che, per sua natura, dipende in misura importante dal comportamento di un'altra persona.

Tutti gli script, le regole, i costi, i protocolli e le strategie raccontati nelle pagine precedenti non hanno l'obiettivo di punire chi non collabora e neppure quello di costruire uno studio nel quale non esistano eccezioni. Servono a creare confini chiari, responsabilità comprensibili e conseguenze prevedibili, in modo che il rapporto con il paziente possa rimanere il più possibile sereno anche quando qualcosa non procede come avevamo programmato. Servono certamente a proteggere il risultato clinico, il tempo dello studio e il lavoro del team, ma dopo aver scritto questo libro credo che servano anche a proteggere qualcosa che per molti anni ho dato quasi per scontato: il piacere di fare questo lavoro.

Perché il rischio, alla lunga, non è soltanto perdere qualche ora o dover ordinare qualche allineatore in più. Il rischio è permettere a una percentuale molto piccola dei nostri pazienti di occupare una percentuale troppo grande della nostra energia, fino al punto di dimenticare che la stragrande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato durante quella stessa giornata ci ha dato soddisfazione, si è fidata di noi, ha collaborato e magari ci ha ricordato esattamente perché abbiamo scelto di fare questo mestiere.

Dopo ottanta pazienti, allora, vorrei riuscire a tornare a casa ricordandomi soprattutto di loro. Non perché gli altri non esistano o perché i problemi debbano essere ignorati, ma perché quei problemi devono avere un luogo, un momento e una risposta. Quando abbiamo costruito un sistema capace di darla, possiamo ridurre il peso che continuiamo a portarci a casa anche dopo che il nostro lavoro è finito.

Forse il vero successo di tutti i protocolli raccontati in questo libro non si misura soltanto nel numero di rifiniture che ci permettono di evitare, nel tempo che restituiscono all'agenda o nei costi che riescono a contenere. Si misura anche nelle

decisioni che non dobbiamo più prendere, nelle discussioni che non dobbiamo più improvvisare, nelle telefonate che lo staff sa già come gestire e nella tranquillità con cui possiamo accettare che esista una parte del trattamento che non dipenderà mai completamente da noi.

Alla fine, forse, tutto questo libro può essere riassunto proprio così: non possiamo impedire al paziente di dimenticare, di non collaborare, di sparire, di cambiare idea o di raccontarci una versione dei fatti diversa dalla realtà. Possiamo però decidere in anticipo cosa fare quando succederà, proteggendo il trattamento, il nostro studio, le persone che lavorano con noi e, soprattutto, il piacere di continuare a fare questo lavoro.

Perché non possiamo impedire al paziente di mentire, ma possiamo evitare che la sua bugia venga a casa con noi.

BIBLIOGRAFIA

Alvenfors A, Velic M, Marklund B, Kylén S, Lingström P, Bernson J. “Difficult” dental patients: a grounded theory study of dental staff’s experiences. BDJ Open. 2022;8:24.

Blinkhorn AS. Stress and the dental team: a qualitative investigation of the causes of stress in general dental practice. Dent Update. 1992;19(9):385–387.

Goetz K, Schuldei R, Steinhäuser J. Working conditions, job satisfaction and challenging encounters in dentistry: a cross-sectional study. Int Dent J. 2019;69(1):44–49.

Gorter RC, Albrecht G, Hoogstraten J, Eijkman MAJ. Work place characteristics, work stress and burnout among Dutch dentists. Eur J Oral Sci. 1998;106(6):999–1005.

Gorter RC, Freeman R. Burnout and engagement in relation with job demands and resources among dental staff in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol. 2011;39(1):87–95.

Hakanen JJ, Bakker AB, Demerouti E. How dentists cope with their job demands and stay engaged: the moderating role of job resources. Eur J Oral Sci. 2005;113(6):479–487.

Hakanen JJ, Schaufeli WB, Ahola K. The Job Demands-Resources model: a three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work Stress. 2008;22(3):224–241.

Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry. 2016;15(2):103–111.

Panagioti M, Panagopoulou E, Bower P, et al. Controlled interventions to reduce burnout in physicians: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2017;177(2):195–205.

Wilson RF, Coward PY, Capewell J, Laidler TL, Rigby AC, Shaw TJ. Perceived sources of occupational stress in general dental practitioners. Br Dent J. 1998;184(10):499–502.